

普通人都能懂的

人生的智慧源头

与妈妈的 SDE



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

普通人都能懂的

人生的智慧源头

与妈妈的 SDE

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

出版信息

书名 《人生的智慧源头——与妈妈的 SDE》

著者 王德生

执笔 复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与统稿

出版 德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡

编号 德麦国际专著第 227 号

ISBN 979-8-90690-415-7

定价 US\$25.00

开本 170 mm × 240 mm（16 开）

字数 约 20 万字

版次 2026 年 10 月第 1 版

完稿 2026 年 10 月 5 日

AI 协作声明：本书的判断、口径与承重命题由王德生（口述）给出；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿，并经其审定。

证据说明：书中科学事实标注证据等级，分〔强〕〔中〕〔有争议〕〔解释〕；〔核〕〔待核〕表示原始文献尚待逐条核对，正式引用前请以原文为准。每章末附“本章证据账”，全书另有附录一、附录二汇总。

人物说明：书中的苏晴、江远及其他陪读人物均为虚构，情节为说明道理而设，不对应任何真实的人。

健康说明：本书讲的是一种看孩子、陪孩子的方式，不是医疗建议。个体的孕产、育儿与发育问题，请遵医嘱。

全书结构：八编三十章，另有五项附录；前三编讲智慧从哪里起头，中间两编讲 0 到 3 岁与“器具”，后三编讲妈妈、父亲与各种家庭怎样做。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生，SDE（显露 Show · 差异序列 Difference · 特征纠缠 Entanglement）本体论的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）首席执行官。生长于中国农村，1990 年进入湘潭大学，后获中国科学院计算数学博士学位，曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。

他的思想走过四站：三视角（2017 年起）、321 智慧系统（2022 年起）、SIO 本体论（2024 年起）、SDE 本体论（2026 年起）。

本书是“普通人能懂”系列中写给妈妈、也写给爸爸的一本。

前言

先问一个小问题

先问你一个小问题：一个人的智慧，是从哪一天开始的？

大多数人会说，是从孩子睁开眼睛、看见世界的那一天。

本书想请你把这个答案放一放。

刚出生的孩子，视力很弱，远处的东西几乎是一团模糊。可是他一出生，就认得妈妈的声音，也认得妈妈的心跳。这些本事是哪里来的？是在睁眼之前，在子宫里，一点一点练出来的。

练的方式很朴素：触到，被触到，听到，被听到。一推一回，一问一答。本书把这样的“来回”看作智慧最早的单位。

这个说法，来自王德生博士的 SDE 发生学。本书用的是它最朴素的一层：分出不同，接成一条路，再回应并改变下一步遇到的不同。

写这本书，有三个原则。

第一，每一个科学事实，都标出证据有多硬。硬的说硬，软的说软，没把握的老实写“待核”。

第二，不吓人，也不怪人。妈妈已经够累了，本书里没有一句话，是用来让谁愧疚的。

第三，能做的事，要具体到今天晚上就能试。每天十分钟，一只手，一把嗓子，就够了。

还有一件事要先讲清楚：基因给的，只是器具。器具不同，不等于智慧不同。一个孩子生来腿脚不便，或者看不见、听不见，不等于他的智慧就差。这两件事，本书用一整章来讲。

愿这本书，让你在睁眼之前，就先看见孩子。

导 读

这本书有八编、三十章。你不必从头读到尾。

你正怀着孩子：先读第一编，再读第二编的第 5、6 章，然后直接去第六编。第六编是三步法：给差异，看显露，稳环境。每天十分钟就够。

你的孩子已经出生：先读第一编的第 3 章，再读第三编，然后去第七编。第七编按月龄分章，从 0 到 6 个月，一直到 2 到 3 岁。

你是孩子的爸爸：直接读第八编。爸爸有两个位置：先成为妈妈的 E，再成为自己和孩子之间的那条回路。

你是祖辈，或是收养的家长、单亲家长：先读第 30 章，再回头读你要用的那几章。

你想看证据：每章末尾有“本章证据账”，附录一、附录二把全书的说法按证据强弱收在一起。

书里有几样固定的东西，认得了读起来会顺。

章末有一个“放回日子里”，是把这一章的道理，放回苏晴和江远的日子里。

章末还有一个“带走的话”，是这一章最要紧的一句，你只带走它也行。

正文里的〔强〕〔中〕〔有争议〕〔解释〕，是证据标签。〔强〕是多项研究一致；〔中〕是有研究支持，样本或口径有局限；〔有争议〕是还没有定论；〔解释〕是本书的理论读法，不是实验结论。

〔核〕和〔待核〕，是作者留给自己的作业：原始文献还要对一遍。

最后，每章末都有一句“个体情况请遵医嘱”。它不是客套。孩子各有各的样子，医生看得到本书看不到的东西。

目 录

前言 先问一个小问题	1
导读	3
第一编 看错了起点：睁眼之前，已经发生了很多事	7
第 1 章 我们都以为智慧从睁眼开始	8
第 2 章 笛卡尔、洛克、胡塞尔：“看”的传统漏掉了什么	23
第 3 章 触和听先到场：看，是后来的一种侧重显露	38
第二编 子宫里的九个月：第一条回路	54
第 4 章 受精卵的第一场对话：还没有神经，已经有了来回	55
第 5 章 触觉 SDE：一推一回，身体的地图是这样画出来的	75
第 6 章 听觉 SDE：在水里学会“话是有调子的”	95
第 7 章 胎儿不是被动的：他在改变妈妈，妈妈也在被稳稳地托住	115
第三编 出生是换场：从水里到空气里	136
第 8 章 出生是一次换场：从水里到空气里	137
第 9 章 认得妈妈：声音、心跳、气味，和袋鼠式护理	152
第 10 章 他怎么接得上外面的世界：一套预习过的本事，和一个不能少的人	168
第四编 0 到 3 岁：回路最宽的三年	183
第 11 章 被回应：0 到 3 岁，智慧是一个“你来我往”的游戏	184
第 12 章 话是怎么“泡”进去的：面对面，节律，和一本书	203
第 13 章 依恋：“足够好”到底有多好，主要照料者可以是谁	222
第 14 章 断了会怎样，补得回吗：从孤儿院的孩子说起	242
第五编 器具、公平与奠基：基因、不同的孩子，和一个要接住母亲的社会	261

第 15 章 基因给的是器具：它重要，可它不是智慧本身	262
第 16 章 器具不同，智慧同样发生：盲、聋、腿脚不便的人，和他们的妈妈	280
第 17 章 奠基，不是命定：以及，一个社会该怎样接住母亲	298
第六编 做子宫里的妈妈：三步法	316
第 18 章 子宫里的妈妈怎么做：三步法，和先要稳住的身体	317
第 19 章 第一步，给差异：每天十分钟，一只手，一把嗓子	336
第 20 章 第二步，看显露：读懂胎动，也读懂你自己	356
第 21 章 第三步，稳环境：把心稳住，并且放下那张“不必做”的单子	376
第七编 做 0 到 3 岁的妈妈：三步法，一天一天用	395
第 22 章 孩子出生以后：三步法换个样子，继续用	396
第 23 章 0 到 6 个月：抱，喂，哄，和第一个微笑	413
第 24 章 6 到 12 个月：爬出去，又回头看 you 一眼	431
第 25 章 1 到 2 岁：走，说，和第一个“不”	448
第 26 章 2 到 3 岁，和一章写给“做不到完美”的妈妈	464
第八编 父亲在 E 里：两个位置，各种家庭	481
第 27 章 父亲在哪里：两个位置，一个不能少，一个不能替	482
第 28 章 成为母亲的 E：一张父亲的每日清单	501
第 29 章 成为自己的回路：父亲和孩子之间的那条路	520
第 30 章 每个家都不一样：单亲、祖辈、远行、收养，和这本书的最后一句话	538
附录一 全书核心说法的证据账	557
附录二 尚待核对的事项	561
附录三 “个体情况请遵医嘱”总说明	563
附录四 几个词的小词典	564
附录五 版权页补充说明	566

第一编

看错了起点：睁眼之前，已经发生了很多事

这一编三章，从一套黑白卡片讲起。

第1章问一个很小的问题：刚出生的孩子，睁开眼睛，能看见什么？第2章回到哲学里去，看笛卡尔、洛克和胡塞尔，怎样把“看”放到了智慧的起点，又漏掉了什么。第3章回到子宫，看在睁眼之前，孩子用什么通道，开始了最早的来回。

三章走完，你会看到：“看”是最后到场的那一个。

第1章

我们都以为智慧从睁眼开始

◆ 一、一套黑白卡

苏晴怀孕二十八周的那个周末，同事送来一份礼物。

一个扁扁的盒子，里面是一套黑白卡片，印着圆圈、条纹和棋盘格。盒盖上有一行字：“新生儿视觉启蒙，出生第一天就开始。”

同事说得很认真：“我家那个就是第一天开始看的，现在认字特别早。你别等，一等就输了。”

苏晴把卡片摊在沙发上，一张一张看。黑的很黑，白的很白，边缘硬邦邦的。她三十一岁，在一家公司做会计，习惯了算账。她算了算：孩子出生后，醒着的时间不多，要是第一天就开始，一天能看几张？看多久？

算着算着，她发现一件事：自己其实不知道，刚出生的孩子到底看得清什么。

晚上，丈夫江远下班回来。他三十三岁，做软件，信数据。苏晴把盒子递给他。他翻了翻说明书，念出一句：“婴儿一出生就睁眼观察世界，视觉是智力发展的起点。”

念完，两个人都没出声。

这句话他们都听过，听了很多年，从来没有人怀疑过。电视里这么说，育儿号里这么说，连街口早教中心的横幅上也这么写。一个孩子来到世上，睁开眼，看见光，看见妈妈的脸，智慧就从这里开始了。

本章只做一件事：把这句话拿出来，掂一掂。

◆ 二、“起跑线”的故事

你要是这几年养过孩子，对“起跑线”三个字不会陌生。

商场里的早教班，月龄从“零岁”起报。闪卡、识字卡、点读笔，三个月的婴儿也有“视觉训练”课。广告词只有一句：不要让孩子输在起跑线上。

这一波焦虑里，有一样真东西，值得先认真对待：人生最早的那几年，确实要紧。大脑在最初几年里长得最快，早期的照料、说话、回应，对一个人后来的情绪、语言和与人相处的方式，有长远的影响。这是发展科学里相当稳固的结论。〔强〕本书整本书，都站在这个结论上。

可是焦虑把这个结论说歪了。

“早”被理解成“早点开始教”，“教”被理解成“给他看、让他认”。于是一个本来很有道理的发现，早年要紧，变成了一张课程表：让婴儿尽早睁大眼睛，吸收更多的画面。

本书要说的是，早年要紧，没错。可要紧的不是“多给他看”。要紧的是另一些东西，而且比“看”更早。

要讲清楚这件事，得先把“看”这个起点，从神坛上请下来。下面从一句大家都熟悉的话开始。

◆ 三、这句话有多深

先别急着说它错。它能流传这么久，一定有它的道理。

你可以先留意一下，我们平时怎么夸一个人聪明。说他有“见识”，说他“眼光”好，“看得远”，“看得透”。他提出的想法，叫“看法”“见解”“高见”。一件事想明白了，我们说“我看明白了”。一个人糊涂，我们说他“有眼无珠”“看不清形势”。

不是说汉语里没有“听”。“听懂了”“闻道”都是好词。不过你想想：说一个人“听话”，夸的多半是乖；说一个人“看得透”，夸的才是智慧。

别的语言里也一样。英语说“I see”，意思是“我懂了”；说“insight”，字面是“向里看”；说“point of view”，字面是“看的位置”。“理念”这个词在希腊语里的老祖宗，据词源学家的说法，本来就是“被看见的样子”；“理论”一词的老祖宗，意思是“观看”。

哲学家也这样说。亚里士多德在《形而上学》开头讲，人天生想要知道，证据是我们爱用感觉，“尤其爱看”，因为看最能让我们分辨出事物之间的许多不同（980a）。〔核：大意〕笛卡尔在《屈光学》第一讲里说，我们的生活全靠感觉来引路，而视觉是感觉里最高贵、最广泛的一种。〔核：大意〕

还有一个很实在的理由，让我们觉得“看”最要紧。人脑皮层里，有相当大的一块，是专门处理视觉信息的。多数人醒着的时候，最离不开的也是眼睛：走路要看，吃饭要看，认人要看，读书要看。一个人一天里的日子，大半是“看”的日子。

于是我们很自然地想：既然现在最依赖它，那它一定也是最早的。

所以“智慧从看开始”不是一句随口说的话。它是两千多年里反复被说、被写、被默认的一个想法。它住在我们的词语里，也住在我们教孩子的方法里：给他看图，给他看卡，给他看世界。

可，一个想法流传得久，不等于它是对的。要掂一掂它，最直接的办法是回到源头，去问一个很小的问题。

◆ 四、一个很小的问题：刚出生的孩子，看见了什么

假设你站在产房里。孩子刚被抱出来，哭了几声，睁开了眼。

他看见了什么？

很多人以为，他看见的和我们看见的差不多，只是不认识而已。事实不是这样。

人的眼睛在出生时，部件都已经在了，可是还没长好。眼底负责看清细节的那一小块，叫黄斑，要在出生后几个月才慢慢成熟。视觉信号要经过的中转站和大脑后部的视觉区，也要在出生后接受大量真正的画面，才能调整好。研究视觉发育的人有一个常见的说法：人的视觉系统，大部分是在出生之后才发育的。〔强〕

具体到数字，各家的测法不同，数字略有出入，但方向一致：新生儿的视力很低，大约在0.05上下，用视力表的话说，相当于成人的几十分之一。他能看清的距离也很近，大约二十来厘米，差不多是妈妈抱着他喂奶时，她的脸到他的眼睛之间的那段距离。他看到的多半是明和暗、深浅不一的灰色，细节、颜色都是模糊的。〔中：不同研究数字略有出入〕

到两个月的时候，视力明显好一些，到四个月，大约能到0.3。要接近成人的水平，还要更久。〔中〕

那套黑白卡片，是不是骗人的？也不是。对比强烈的黑白图案，是新生儿看得最清楚的一类东西，卡片做这个设计，有它的依据。

还有一件事，常被拿来作为“看是起点”的证据：新生儿好像天生爱看人脸。有研究发现，出生才几分钟到几天的婴儿，更愿意转头去追随一个类似人脸的图案，而不是一堆乱摆的图案。〔中：经典发现，后来的重复结果并不完全一致〕

这个发现很有趣，它说明孩子的眼睛和大脑，已经为“看人”预备好了一块地方。可它能证明的，也只是“预备好了”。预备好，是说一台机器已经装好，可以开机；它不能说明，这台机器就是整个人的起点。

可是请注意，“新生儿能看见黑白图案”，和“智慧从看开始”，是两件完全不同的事。前一件是说他的眼睛能接收一点东西。后一件是说，一个人的智慧，从接收这点东西起才算起步。

他在睁眼之前，已经活了九个月。

还有一类证据，说明“看”这件事，主要是靠出生以后一天天的使用，才调好的。

二十世纪六十年代，两位神经科学家休贝尔和维厄瑟尔用小猫做实验：小猫出生后不久，把一只眼睛暂时缝合，几个月后再拆开。那只眼睛本身完好，不过大脑里已经不会用它了。他们因为这一类工作，获得了1981年的诺贝尔生理学或医学奖。〔核〕后来对人的观察也一致：先天性白内障的孩子，如果拖到很晚才手术，视力往往没法完全恢复。〔强〕

这说明，“看”这套本事，本身就是后来练出来的，不是练习之前就有的底子。

那么问题来了：是什么，在它之前，让婴儿能练得起来？

◆ 五、一个检验：天生看不见的人怎么办

不妨把“智慧从看开始”这句话，放到一个最简单的案例上试一试：天生看不见的人。

如果智慧的起点，是睁开眼睛、看见世界，那么一个生下来就看不见的人，起点就是缺的，后面的一切都该缺一块。

事实正相反。天生失明，或者一岁左右失明的人，学语言、学数学、学音乐、写文章、做研究，都可以做到最高水平。十八世纪的英国有一位尼古拉斯·桑德森，一岁左右因为天花失明，后来成了剑桥大学的卢卡斯数学教授，给学生讲过牛顿的光学。〔核：据传记〕法国的狄德罗写过一封很有名的《论盲人书》（1749），主角之一就是他。

再看另一个人：海伦·凯勒。她一岁七个月时因病，同时失去了视力和听力，七岁之前几乎没有语言。1887 年，老师安妮·沙利文把水泵里流出来的水浇在她一只手上，在另一只手的掌心里拼写出“水”这个词。孩子忽然明白了：每一样东西都有名字。这是教育史上最有一个场景。〔核：据传记〕

要说清楚一点：海伦在一岁半之前，是有视力和听力的，所以这个例子并不能证明“什么都不需要”。不过它至少说明一件事：当看和听都用不上的时候，一个人的手掌心，也可以成为通往智慧的门。

所以，“看”不是通往智慧的唯一一道门，更不是必经的那一道。它只是其中的一扇。

可为什么，两千多年来，哲学家们都把这一扇门，当成了正门？这是下一章要讲的。

◆ 六、子宫里是什么样：不是漆黑，可也近乎漆黑

那么在这九个月里，胎儿有没有“看”过？

先说光。子宫是暗的。母亲的皮肤、肌肉和子宫壁，把外面的光挡掉了绝大部分。有一件事可以帮你理解：医院的新生儿重症监护室里，对早产的孩子，现在的做法是要遮光，保护他们的眼睛。因为他们的眼睛还没发育到可以承受强光的程度，在这个阶段，保护比刺激更要紧。研究视觉发育的专家的看法是：足月出生之前，胎儿并不需要来自外界的视觉刺激。〔强〕

再说眼睛本身。胎儿的眼睑在孕早期就闭合起来，要到孕二十六到二十八周前后才重新分开。孕三十周前后，瞳孔开始对光有反应。〔中：各来源的周数略有出入〕所以在孕晚期，如果有一束强光照在母亲腹部，透进去，胎儿也许能感到明暗的变化。仅此而已。

还有一个有意思的研究，需要说清楚它的地位。2017 年有一组研究者报告，孕晚期的胎儿，似乎会朝着类似人脸的光点图案转头。这个结果很吸引人，可是它还需要更多独立的重复，目前只能说是一个线索，不是定论。〔有争议〕

另外有一类发现，更值得留意。有研究者用胎儿磁共振扫描发现，在没有任何图像进来的时候，胎儿的眼球会自己动。而且这些眼动，和大脑里管看的

区域以及额叶的活动是联在一起的。〔中〕这就好像一台机器在没有信号的时候，自己先空转预热。

把这些放在一起，你会看到一幅很清楚的画面：在九个月里，“看”这条线是在预热，而不是在工作。眼睛、神经、大脑的相关区域在一点点搭起来，不过真正的图像，要等出生以后才大量涌进来。

那么，要是“智慧从看开始”这句话是对的，这九个月里，孩子的智慧岂不是一片空白？

事实上不是。这一点，要到第 3 章才讲得清楚。眼下先记住一句话：看，是最后到场的那一个。

在子宫里，别的东西倒是一直在：温暖的、被水托着的、有节奏地晃动的，四面都有轻轻的压力。那是一个被包着的世界。孩子在里面不是飘着的，而是一直被什么东西挨着、托着、晃着。

这又是另一条线索，要放到第 3 章去讲。

◆ 七、这里的“智慧”，指的是什么

讲到这儿，你可能想问：你们说的“智慧”，到底指什么？

别急着把它理解成智商，也别把它理解成会背多少诗、认多少字。认字早，是一种能力；智慧，是另一层更底下的东西。

本书用的是王德生博士提出的发生学，里面有一套方法，叫SDE（显露、差异序列、特征纠缠的合称）。这套方法的出发点是：一个人的智慧，不是装进去的，是发生出来的。

用大白话讲，它的意思是说这样：

在一团乱的世界里，先要能分出“不同”。冷和暖不同，响和轻不同，饿和饱不同。这是第一步，叫分出差异。

然后要能把前后的“不同”接成一条路。哭了，有人来；有人来，身上暖了；暖了，不哭了。一件接一件，前面的会带出后面的，这就接成了一条路。

最后，要能顺着这条路回应世界，而你的回应，又会改变接下来遇到的东西。你一哭，妈妈就来，这是你用声音改变了世界；妈妈来了，你闻到她的气味，你的哭声就缓下来，这又是世界改变了你。

分出不同，接成路，回应之后又改变了下一步所遇到的不同。这个来回，就是本书里所说的“智慧”的最小单位。一个人一辈子的智慧，不管多复杂，都是从这个最小的来回，一层一层长出来的。〔解释：这是本书的理论说法，不是实验直接测出的事实。〕

为什么要这样定义？有一个理由很实在：它得是所有人都有的东西。一个盲人，一个聋人，一个手脚不方便的人，一个说话很晚的孩子，都得在这个定义里，找得到自己的位置。如果把智慧的起点，定在某一个通道上，比如“看”，那么没有这个通道的人，就被排除在外了。这既不符合事实，也不公平。

所以本书选了一个“不绑定通道”的最小单位。通道可以换，来回不能少。

现在你可以回头看“智慧从看开始”这句话了。如果智慧的最小单位，是“分出不同、接成路、回应并改变”，那么它根本不需要眼睛。一个闭着眼睛的胎儿，只要有能分出“不同”的通道，有能回应的小动作，有一个会回应他的世界，这个来回就可以开始。

再举一个更日常的例子。

半夜，一个两个月大的婴儿饿醒了。他不知道“饿”这个词，可他有一种很难受的感觉，和刚才的舒服不一样，这是第一个“不同”。他哭起来，声音一出来，又是第二个“不同”：他听见了自己。过了一会儿，脚步声由远到近，有人把他抱了起来，他闻到熟悉的气味，嘴边碰到了乳头。难受消失了。

这一个来回里，有“不同”（难受和舒服），有“路”（哭、脚步、抱、吃，一件接一件），有“回应改变了世界”（哭了，世界就变了）。孩子什么都没“看”。他甚至可能一直闭着眼睛。

这里还要把“发生”这个词说清楚。“发生”和“发现”不一样。发现，是说东西早就在那里，你把它找出来；发生，是说它本来不在，在某些条件下，真的从无到有地长出来了。本书的立场是：智慧是发生出来的，不是早就装在孩子身上、等他睁眼去发现的。

最后提醒三件小事，免得读岔了。一，这里说的智慧，不是分数，也不是高低排名。二，本书不说基因没有作用，这个话题第15章会讲。三，本书讲的所有做法，都不是为了让孩子“更聪明一点”，而是为了把这个来回稳住。稳住了，智慧自己会长。

下一章，我们会看到，哲学家们是怎样一步一步，把“看”放到了智慧的起点上的。第三章，我们会看到，这个来回其实更早就开始了，用的是别的通道。

◆ 八、两个常见的疑问

讲到这里，常有人问两句话。

第一句：“既然视觉主要是出生以后才发育的，那是不是说，不要给婴儿看东西？”

不是。光、颜色、妈妈的脸，是婴儿正常环境里本来就有的东西，让他看，一点问题也没有。本章要拆的，不是“看”，而是“看是智慧的起点”这个说法。孩子该看什么，就让他自然地看；不必为了“开发智力”，专门加料。

第二句：“那套黑白卡，给孩子看会不会有害？”

目前没有可靠的证据，说明短时间地让婴儿看一看对比强烈的图案，会造成伤害；也没有可靠的证据，说明这样做能提高智力。〔中：缺少高质量的对照研究〕更要紧的，是孩子当时的状态：他醒着、安静、愿意看，你就陪他看一会儿；他转开头、闭上眼、皱起眉，那就是“今天够了”。读懂这些信号，比卡片本身要紧得多。这一点，第七编会细讲。

◆ 九、本书怎样对待证据

在往下走之前，要先交代一件事：本书是一本讲“怎么办”的书，所以对证据要格外小心。

凡是事实性的说法，本书在后面都标一个小记号。〔强〕的意思是，多项研究的结论一致，可以放心用；〔中〕的意思是，有研究支持，但样本不大、数字有出入，或者还需要重复；〔有争议〕的意思是，有人这样报告，也有人不同意；〔解释〕的意思是，这是本书的理论说法，不是实验直接测出来的。

这样做，是为了让你一眼分得清：哪些是科学已经比较确定的，哪些是我们的看法。两类东西都有价值，可是不能混在一起。

每一章的最后，都有一张“证据账”，列出这一章用到的主要论断、证据的等级和出处。你不用每一条都去查，不过它们在那里，你随时可以去查。

◆ 十、放回日子里

苏晴把黑白卡片放进了抽屉。

她没有扔，只是不着急了。她跟江远说：“孩子出生以后，我们可以拿出来给他看，他要是喜欢，就多看一会儿。可是这个东西，不是什么非得第一天做的事。”

江远点点头。他在手机上查了几个资料，又问了一句：“那我们现在能做什么？”

苏晴想了想。她把手放在肚子上，说了一句话：“今天下班晚了，累了。”

没有动静。过了一会儿，肚子里轻轻地顶了一下。

她不知道这一下是不是对她那句话的回应。她也不敢这样讲。研究里也没有谁能保证，每一次胎动都是对某一句话的反应。不过她忽然觉得，这个晚上，和刚才算卡片的那个她，有点不一样。

后来，江远给岳母打了电话，问她当年怀苏晴的时候，都做了些什么。外婆在电话那头笑了：“那时候哪有什么胎教？天天走路，给你爸织毛衣，嘴里哼着‘月亮走我也走’。”

苏晴在旁边听着，眼圈有点热。

你也可以试一件小事，不用花钱，也不用准备任何东西：这几天，找个机会，问问家里的老人，你出生之前，妈妈每天都在做什么，哼什么，听什么，吃什么。哪怕他们记不清了，问的这一下，也是一次往回走的路。

那个周末的夜里，江远翻出了孕期的小册子，在“胎教”那一页停了很久。他读到的，有说“多放音乐”的，有说“别放太响”的，互相矛盾。

他把册子合上，对苏晴说：“我们不如先搞清楚，孩子在里面，到底在经历什么。”

苏晴笑了：“你不会又要列表吧？”

“列。”他说，“可是这回，先弄清楚问题。”

这本书，就是从这一晚开始的。

接下来的路，是这样走的：第 2 章，看哲学家们怎样把“看”放到了起点上；第 3 章，看孩子在子宫里，用什么通道，开始了最早的来回；然后第二编，把子宫里的九个月，一段一段地讲细；第三编写出生；第四编写头三年；第五编讲基因、器具和公平；最后三编，回到苏晴和江远这样的人身上，讲母亲怎么做、父亲怎么做。

每一步，都尽量用事实说话。事实不够的地方，会老老实实标出来。

带走的话

智慧不是从睁眼开始的。孩子睁眼之前，已经在别的通道里“练”了很久。

◆ 本章证据账

论断	证据等级	出处
人的视觉系统大部分在出生后发育；新生儿视力很低，约0.05上下，聚焦距离二十来厘米	强（数字略有出入）	Graven & Browne, 2008, Visual Development in the Human Fetus, Infant, and Young Child；婴儿视觉发育综述
足月前胎儿不需要外来视觉刺激；早产儿保育强调遮光保护	强	同上
胎儿眼睑约在孕26至28周分开，孕30周前后瞳孔对光有反应	中（各来源周数略有出入）	胎儿视觉发育综述〔待核：原始文献〕
孕晚期胎儿可能朝向类人脸光点	有争议（需重复）	2017 年一项研究，见相关综述〔待核〕
胎儿眼动与视觉区、额区的活动相联	中	胎儿功能磁共振研究（Frontiers 相关论文，PMC4183095）
亚里士多德：人爱感觉，尤其爱看	原文	《形而上学》A卷1章，980a，罗斯英译本〔核：大意〕
笛卡尔：视觉是最高贵、最广泛的感觉	原文	《屈光学》第一讲，Cottingham英译本〔核：大意〕
汉语、英语里关于“看”的词多用来夸智慧	本书的观察，不是实验结论	—
“智慧=分出不同、接成路、回应并改变”	本书的理论解释	王德生博士的SDE发生学
新生儿更愿意追随类似人脸的图案	中（后来的重复结果不完全一致）	Goren 等，1975；Johnson 等，1991
小猫出生后暂时遮盖一只眼，该眼的视觉功能受损；先天白内障迟治，视力难完全恢复	强	Hubel & Wiesel, 1960 年代，1981 年诺贝尔奖；先天白内障临床研究

论断	证据等级	出处
桑德森一岁左右失明，后任剑桥卢卡斯数学教授；狄德罗《论盲人书》1749	据传记	传记资料〔核：大意〕
海伦·凯勒1887年在水泵边领悟“词”的意义	据传记	凯勒自传及传记资料〔核：大意〕
缺少对照研究：黑白卡短时观看既无证据有害，也无证据提高智力	中（缺口）	综合判断，〔待核：是否有新近研究〕

个体的孕产、育儿与视力问题，请遵医嘱。

第 2 章

笛卡尔、洛克、胡塞尔：“看”的传统漏掉了什么

◆ 一、一块蜡

江远读大学的时候，选过一门哲学课，只上了一个学期，别的都忘了，唯独记得一块蜡。

老师在黑板上画了一块蜂蜡，刚从蜂巢里取出来：还留着一点蜜的甜味，一点花的香气，颜色是淡黄的，有一定的形状和大小。它硬硬的，凉凉的，你拿手指敲一敲，它会发出一点声音。

然后老师把这块蜡拿到火边。味道散了，香气没了，颜色变了，形状塌了，它变大，变成了一摊烫手的液体，敲它也不再有声音。

老师问全班：“现在，还是同一块蜡吗？”

大家说：“是。”

“凭什么说是？”老师又问，“你的眼睛看到的，变了；你的鼻子闻到的，变了；你的手摸到的，变了。你的感觉，一样都没剩下。你凭什么还说它是那一块？”

教室里安静了几秒。

这是笛卡尔《第一哲学沉思集》第二沉思里的著名一段。他的答案是：认出这是同一块蜡的，不是眼睛，不是手，也不是想象，而是心灵自己单独完成的一次“审视”。〔核：大意，见第二沉思〕

江远当时觉得这个答案漂亮，记了很多年。今天，他有了一个当时没有的疑问。

他在想：那课堂上，老师说的是“看到的变了，闻到的变了，摸到的变了”。感觉有好几种。可是最后，笛卡尔给出的那个“心灵的审视”，用的是一个什么词？

“审视”。这是一个看的词。

◆ 二、笛卡尔：从一个已经站好的“我”出发

我们先把笛卡尔这个人，放回他自己的位置上看。

笛卡尔生在十六世纪末，他那个时代的欧洲，刚刚发现过去几百年里确信不疑的许多东西，一件一件地站不住。地球不是宇宙的中心，书本上说的和望远镜里看到的不一样。他想给知识找一块不会塌的地基。

他的办法是：先怀疑，怀疑一切可以怀疑的，看最后剩下什么。

他在第一沉思里说，他此刻坐在炉火边，穿着冬天的睡袍，手里拿着一张纸。他问自己：这些，真的能确定吗？也许他在做梦。梦里也有炉火，也有纸。〔核：大意，见第一沉思〕他还说，到现在为止，他认为最真的东西，都是从感觉里来的，或者经过感觉得来的，可是感觉有时会骗人。

于是他把感觉放到了怀疑的名单上。留下来的，是一个正在怀疑的“我”：我在想，所以我在。

还有一个小细节，值得说一说。笛卡尔在《谈谈方法》第二部分里回忆过一段往事。1619年的冬天，他在德国，天气太冷，他整天待在一间带炉子的暖

房里，没有人打扰。就在那里，他开始把这些想法，一条一条想清楚。〔核：大意〕

你看，那个孤零零的“思想者”，是被炉火烘着的。温暖，是触觉给他的。他没有把这一点写进他的体系，不过他的体系，就是在这样一个暖暖的房间里想出来的。

这个动作，对后来的哲学影响很大。它做了两件事。

第一件，它让一个孤零零的“我”站到了起点上。这个“我”先于世界，先于他人，也先于身体。身体要靠后面一步一步证明，才能请回来。

第二件，它把“怎样认识”的问题，变成了“怎样看得清楚”。笛卡尔反复说，真的东西，是“清楚而分明”地被心灵看到的東西。他还说，人心里有一道“自然之光”。“光”“清楚”“分明”，都是视觉的词。〔核：大意〕

再看一个有意思的地方。笛卡尔在《屈光学》的开头说，视觉是五种感觉里最高贵、最广泛的一种。〔核：大意，见前一章〕可是他在同一本书里，解释光怎样进入眼睛时，用的比方，是一个盲人手里的拐杖。盲人靠拐杖的一端碰到东西，通过拐杖，“摸”到前面的路。他说，光进入我们眼睛的方式，就像那样。

你看，他用触觉，来解释视觉。

这不是在挑他的毛病。他是一位了不起的思想家，这些话有他的用意。不过这个细节让我们看到一件事：就连在最偏爱“看”的人那里，“碰”也一直躲在后面，当作理解“看”的钥匙。

还有一点要补上，这一点对本书特别重要：笛卡尔怎么看待人生最早的那一段？

他在《哲学原理》等著作里不止一次地讲，我们的许多错误，来自童年的偏见。孩子最初的那几年，心灵紧紧地被身体拴着，只会随着感觉走，于是留下了许多没经过检验的看法，需要日后一点点清理。〔待核：《哲学原理》第一部分第71条前后，大意〕

所以，在笛卡尔那里，生命最早的时期，是要被“清理”的错误的来源，不是智慧的根基。

这和本书的想法，正好相反。本书想说的是：生命最早的那一段，恰好是智慧的地基。

可在讲这个以前，我们要先公平一点：笛卡尔看到了很重要的一件事。感觉确实会骗人，认识确实需要判断。他提出的“同一块蜡”这个问题，也是一个真问题：感觉一直在变，我们为什么还能认出“同一个”？这个问题到今天仍然值得问。本书后面会用到它。

可是他从哪里起步，是个问题。他从一个已经站好的、醒着的、会思考的“我”起步。在这个“我”之前，发生了什么，他没有问。

◆ 三、洛克：离婴儿最近的一位，却顺手把门关上了

比笛卡尔晚半个世纪，英国出了一位和他唱反调的人，约翰·洛克。

笛卡尔说，人心里有天生的观念。洛克说，没有。他在《人类理解论》里写下一个后来人人都知道的比方：人出生的时候，心灵像一张白纸，上面什么字都没有。那它是如何有了观念和知识的呢？他的回答只有一个词：从经验里来。〔核：大意，见第二卷第一章〕

“白纸”这个比方，影响了几百年的教育。孩子是一张白纸，你写什么，他就是什么。

不过你要是真去读洛克，会发现一件很少有人提的事：洛克比我们想象中，更靠近子宫。

在《人类理解论》里，他不止一次地写到过子宫里的孩子。他说，在子宫里，孩子大概也有一点点观念，也许是饥饿的、口渴的、温暖的、有点疼的。他推测，孩子通过在子宫里与周围的东西接触，在出生之前，就得到了几个观念，其中饥饿和温暖，大概是最早的。〔核：大意，见第一卷第四章，第二卷第九章第5节前后〕

注意这个顺序：饥饿，温暖。这不是看到的，是身体里感到的，是触和热。

他又说，出生以后，最早印上的，是最先遇到的那些感觉的性质，其中光，不是最不要紧的一个。〔核：大意〕

可紧接着，他在同一章里写了一句让人心里一沉的话：哪些观念最先来，既不明显，也不要紧。〔核：大意，第二卷第九章第7节〕

你看，洛克把门推开了一条缝，让我们看到了子宫里的孩子，又随手把门带上了：这件事“不要紧”。

为什么他觉得不要紧？因为他想要证明的，是孩子没有天生的观念，所有的东西都要靠后天经验得来。他觉得，只要证明了这一点，哪个先来，哪个后到，没有必要深究。

可是对本书来说，这一点很要紧。

洛克本人学过医，当过别人家的家庭医生。他后来写过一本讲教育的书，叫《教育漫话》（1693）。书的第一句，引了一句古罗马的老话，大意是：健全的精神，要在健全的身体里。〔核：大意〕整本书的开头几章，讲的都是孩子的身体：穿什么、吃什么、睡什么。

所以洛克不是不关心身体。他关心。不过在他的认识论里，身体只是“经验”的入口；到了谈“智慧怎么来”的时候，他谈的，是一张白纸，不是一个有身体、有来历的人。

还有一件事，是洛克和一位朋友通信时碰到的。都柏林的政治家威廉·莫利纽克斯给洛克写信，提出一个问题：设想一个人，生下来就失明，用手摸学会了分辨立方体和球。假如有一天他的眼睛突然治好了，在不摸的情况下，他单凭眼睛，能分出哪个是立方体，哪个是球吗？

洛克的回答是：不能。他认为，这个人在第一次看到的时候，不会立刻认出来，要靠经验，才能把“看到的”和“摸到的”连起来。〔核：大意，第二卷第九章第8节〕

这个问题被叫作“莫利纽克斯问题”，争论了三百多年。2011年，有一组研究者终于找到了机会做实验。

他们和印度的一个公益项目合作，这个项目给先天失明但可以治愈的孩子做手术。研究者让几位刚刚复明的孩子，先用手摸一个东西，再在几个只能“看”的东西里，认出哪个是刚才摸过的。结果，孩子们在刚复明的那一刻，几乎认不出来，成绩只比乱猜好一点点。

可，这种“看”和“摸”之间的联系，在很短的时间里，大约几天，就迅速建立起来了。〔强：来源是一项发表在《自然·神经科学》上的研究；不过受试者只有几位，样本很小〕

这个结果，很有意思。它说的是：“看”和“摸”之间的连接，不是睁眼就有的，要靠经验一点点接起来。而在接起来之前，触觉那一边，是早就存在的。

于是我们回头看洛克的那张白纸。

“白纸”这个比方，本身就是一个视觉的比方：纸，是用来写、用来读的。更要紧的是，它暗含的意思是：出生之前，什么都没有；一切，从出生以后写上去。

可是我们在第 1 章里已经看到，等到孩子睁开眼睛的时候，他已经在这个世界里活了九个月。到第 3 章，我们会看到，在这九个月里，他不是一张白纸：他的纸上，已经有了字。新生儿能认出妈妈的声音，就是证据之一。

◆ 四、胡塞尔：他很近了，却停在“看”

再往后走两百多年，来到二十世纪初的德国，有一位哲学家，叫埃德蒙德·胡塞尔。

胡塞尔想做的事，和笛卡尔有点像：给哲学和科学，找一块不用怀疑的地基。不过他的办法不同。他说：不要再争论“世界到底是什么”，先回到我们直接经历的东西本身，一件事如何向我们显现，就如何去描述它。这个口号，叫“回到事情本身”。

在他的《观念》第一卷里，有一条他自己称为“一切原则的原则”的东西。意思是：每一个“原本给予的直观”，都是知识合法的来源；原原本本地呈现在我们面前的东西，应该如实地接受下来，只是不要超出它被呈现的范围。〔核：大意，《观念》第一卷第24节〕

“直观”这个词，德语原文，字面上就有“看”的意思。他的另一个著名说法，叫“本质直观”，也就是“看到本质”。他最看重的认识状态，叫“明见”：一件东西，亲眼看见一样，清清楚楚地摆在那里。

所以，在胡塞尔这里，“看”几乎成了认识的标准形态。

可读他的人，要公平地知道一件事：胡塞尔对触觉，其实下过很深的功夫。

在《观念》第二卷里，他举了一个小例子：你的右手去摸你的左手。这时候，有一件很奇特的事发生：同一个动作里，右手是“摸的一方”，左手是“被摸的一方”。你可以让它们互换：左手去摸右手。同一只手，一会儿是主动的，一会儿是被动的。

胡塞尔说，这种“双重感觉”，是触觉独有的。你没法用眼睛“看自己”看出同样的效果：我看我的手，我的手并不同时“看”我。他据此提出，我们之所以会有一个“我的身体”，会觉得这副身体是“我的”，而不仅仅是一件摆在眼前的物体，靠的是触觉的这种双重性。〔核：大意，《观念》第二卷第36—37节〕

这是一个了不起的发现。它说：“我”的最早的一块地基，是靠触觉搭起来的。

可是，胡塞尔把这个洞见，主要用在了“身体怎么成为我的身体”上。他整个体系的基调，仍然是：一个醒着的、有意识的我，面对着一个正在向它显现的世界，认识的最高形态，是“明见”。

后来的法国哲学家梅洛-庞蒂，把胡塞尔的这条线，往前推了一大步。他认为，“触”和“看”其实不是各管各的：看的时候，眼睛也在“摸”，摸的时候，手里也有“看”。身体，才是我们和世界相遇的地方。〔核：大意，据研究文献〕这个方向，和本书很接近。不过他的出发点，同样是一个已经长大的身体。

晚年的胡塞尔，的确开始往回走。他提出了“发生现象学”，开始问：这个意识，是怎样一层一层长出来的？他想追问意识的来路。这一步，非常接近本书要问的问题。可他的出发点，仍然是一个成年人的、已经成形的意识，往回推。他从这个意识里，“回溯”到更早的层次，却没有真的去看出生前的那九个月，没有去看一个母亲和一个胎儿之间，发生了什么。

◆ 五、他们三个人，漏掉了什么

不过在往下讲之前，要把这三位各自留下的“真东西”，认认真真地记下来。笛卡尔留下的是：感觉要经过判断，才成为认识。洛克留下的是：认识离不开经验。胡塞尔留下的是：身体不是一件东西，是“我”的一部分。这三样，本书全都要用。

莱布尼茨当年回应洛克，说过一句有名的话：心灵里没有哪样东西不是先在感觉里的，“除了心灵自己”。〔核：大意，《人类理智新论》第二卷第一章〕这句话，也可以反着读：感觉，确实是起点，可是它得遇到一个能接住它的“自己”。这个“自己”，从哪里来？下面几章，会一步一步回答。

把这三位放在一起，可以看出一条线。

笛卡尔：一个想着的“我”。洛克：一张等着被写的白纸。胡塞尔：一个正在“明见”的意识。他们的立场差别很大，吵得很凶，不过他们有三样东西，是共同的。

第一，他们都从一个已经成形的人出发，一个醒着的、会判断的人，哪怕这个人是一张“白纸”。在这个人出现之前的那一段时间，他们要么不问，要么挥一挥手，说一句“不要紧”。

第二，他们都把“看”当作认识的标准样子。看，是和世界保持距离的：一个“看者”，一个“被看的東西”。这种认识，天然带着“我在这里，东西在那里”的格局。可是这个格局，本身就是后来才形成的。

第三，他们笔下的认识者，都是一个人，孤零零的。一个“我”，面对一个世界。

说句公道话，这几位的“盲点”，是有来历的。他们写书的时候，都是成年人，都坐在书桌前，用眼睛读书，用手握笔写字。他们每天的日子，本身就是“看”的日子。一个人很难看到自己脚下的那块地，他踩着它，却不会低头。

所以这不是三位哲学家的错，是一种位置的限制：站在已经长大的地方，往回看，只看得到“已经成形的东西”，看不到成形之前的那段路。

这三样，就是“看的传统”漏掉的三块。

第一块，是时间：出生之前的九个月。

第二块，是通道：触，和听。我们在前面看到，笛卡尔拿盲人拐杖解释视觉；洛克把饥饿和温暖当作最早的观念；胡塞尔发现触觉的双重性。三位哲学家，都不止一次地碰到过触觉。不过每一次，他们都把它当作一个旁证，没有把它当作起点。

至于听，漏得更彻底。在这个传统里，听常常被归到“别人的话”里，当作知识的传递，不是知识的来源。

可在另一个传统里，情况正相反。

你可以想一想：汉语里，对一个人智慧的最高称呼，是什么字？是“圣”，繁体写作“聖”。

这个字的底下，是一个人，上面，是一只“耳”和一个“口”。《说文解字》里说：“聖，通也，从耳。”东汉的《风俗通义》解释得更清楚：“聖者，聲也，言聞聲知情。”意思是，听到一个声音，就知道里面的情形，这样的人，就叫“聖”。〔核〕

孔子讲自己的一生：“六十而耳顺。”〔核：《论语·为政》〕一个人到了六十岁，才算听什么都顺了。

也就是说：在这个传统里，智慧的最高形态，是靠“耳”来写的。

当然，这不是说中国的传统就对，西方的传统就错。每一个传统，各有各的偏重。重要的是，我们看到：“智慧从看开始”这件事，不是唯一的想法。它是一个偏重，一个传统里的偏重。

第三块，是人。这一块最要紧，也最少有人提起。

笛卡尔的“我”、洛克的“白纸”、胡塞尔的“意识”，都是一个独自的人。他们没有想过：一个人最早遇到的世界，不是一个堆满东西的世界，而是另一个人。一个人，用身体把他包着，用声音哄着，用心跳陪着。

本书的看法是这样的：“我”，不是先有一个站好的“我”，再去接触世界。“我”，是在和另一个人，最先是母亲，一来一回的接触里，一点点长出来的。〔解释：这是本书的理论说法〕这件事，三位哲学家都没有留下位置。

◆ 六、这不是咬文嚼字

你可能会想：起点放在哪儿，不就是个说法吗？为什么要这样较真？

因为起点放在哪儿，后面的做法就跟着走。

把起点放在“一个已经醒着、会看的人”身上，教育就容易变成：给他看，给他认，然后考他看懂了没有。孩子成了一个“接收信息的容器”，大人的任务，是往里装。

把起点放在“一个来回”上，教育就会变成另一件事：陪他来回。他伸手，你接住；他哭，你应一声；他咿呀，你学一句。孩子不是容器，是来回里的另一半。〔解释：这是本书的理论说法〕

还有一件事，也很有意思。在这三位哲学家的体系里，母亲几乎不出场。笛卡尔的体系里，有上帝，有“我”，有物体，没有母亲。洛克写了孩子，写了乳母和保姆，可是那都是为了说明“经验怎样塑造人”，而不是为了说明“人怎样在与一个人的关系里长出来”。

连笛卡尔自己，也留下过一点线索。他在一封信里承认，自己为什么偏偏喜欢眼睛有点斜视的女子：因为小时候，他爱过一个斜视的小女孩，那种印

象，一直留在他身上。〔待核：1647 年致沙尼书信，大意〕你看，在这位主张“怀疑一切”的哲学家身上，也有一个早年的印记，在他没有察觉的时候，起着作用。

这个小故事，不是要挖苦他。它只是提醒我们：早年的东西，比我们的体系，更早地在我们身上起作用。

◆ 七、放回日子里

那天晚上，江远给苏晴讲了那块蜡的故事。苏晴听完，问了一个很实际的问题：“那这跟我们有什么关系？”

江远想了想，说：“关系就是，这些大人物都假定，孩子是从睁眼那一刻才开始的。我们那份册子，也是这么假定的。”

“所以呢？”

“所以我想试一件事。”

他走到客厅，关了灯，让苏晴坐在沙发上，让她闭上眼睛，安静地待五分钟，什么都不做，只注意：听到了什么，身上碰到了什么。

起先，什么也没有。过了一会儿，苏晴说：“我听到冰箱的声音，还有楼上的水管。”

又过了一会儿：“坐垫有点硬，肚子有点沉，空调的风吹在小腿上。”

再过一会儿，她睁开了眼睛，说了一句话：“原来不用眼睛，也有这么多东西。”

你也可以试试这五分钟。不用准备，不用工具。找一个安静的时段，闭上眼睛，什么都不做，只数一数：你能听到几种声音，身上能感到几处碰触。数完以后，你会发现：你一直在用的，其实不止眼睛。

这些通道，你在出生以前，就已经在用了。

带走的话

哲学家把智慧的起点，放在了一个已经醒着、已经在看的人身上。可是在这个人出现之前，还有九个月，和另一个人。

◆ 本章证据账

论断	证据等级	出处
笛卡尔的“蜡块”论证；结论是“心灵单独的审视”，不是看、摸或想象	原文	《第一哲学沉思集》第二沉思，Cottingham英译本〔核：大意〕
笛卡尔坐在炉火边、穿睡袍、手拿纸；感觉会骗人	原文	第一沉思〔核：大意〕
笛卡尔用盲人拐杖比方光的传播	原文	《屈光学》第一讲〔核：大意〕
笛卡尔视童年偏见为错误来源	原文	《哲学原理》第一部分第71条前后〔待核：条目号〕
洛克：白纸；子宫里可能已有饥饿、温暖等观念；哪些观念最先来“既不明显也不要紧”	原文	《人类理解论》第一卷第四章，第二卷第一章、第九章第5至7节〔核：大意〕
莫利纽克斯问题：洛克认为复明的人不能立即凭视觉认出触摸过的形状	原文	《人类理解论》第二卷第九章第8节〔核：大意〕
新近复明的孩子，一开始不能把触摸到的形状与看到的形状对应起来，但这种联系几天内迅速建立	强（受试者仅数位，样本小）	Held 等，2011，《自然·神经科学》14卷5期，551至553页
	原文	

论断	证据等级	出处
胡塞尔：“一切原则的原则”；直观是知识的合法来源		《观念》第一卷第24节，Kersten 英译本〔核：大意〕
胡塞尔：双重感觉为触觉所独有，与“我的身体”的构成有关	原文	《观念》第二卷第36至37节〔核：大意〕
胡塞尔晚年提出发生现象学，追问意识如何层层形成	中（研究文献的一般说法）	胡塞尔研究文献〔待核：具体出处〕
《说文解字》：聖，通也，从耳；《风俗通义》：聖者，聲也，言聞聲知情	原文	《说文解字》卷十二；《风俗通义》〔核〕
“六十而耳顺”	原文	《论语·为政》〔核〕
本书的判断：“我”在与母亲的来回里长出来，而不是先于世界存在	本书的理论解释	王德生博士的SDE发生学
笛卡尔1619年冬在德国暖房中独处思考	原文	《谈谈方法》第二部分〔核：大意〕
洛克《教育漫话》首句引“健全的精神寓于健全的身体”，前几章谈身体	原文	《教育漫话》1693〔核：大意〕
梅洛-庞蒂把双重感觉推广到各感觉之间的交织	中（研究文献的说法）	Moran, Between Vision and Touch〔核：大意〕
莱布尼茨：心灵里没有什么不先在感觉里，“除了心灵自己”	原文	《人类理智新论》第二卷第一章〔核：大意〕
笛卡尔承认自己偏爱斜视女子源于童年印象	原文	1647年致沙尼书信〔待核：大意〕

个体的孕产与育儿问题，请遵医嘱。

第3章

触和听先到场：看，是后来的一种侧重显露

◆ 一、二十周的那张图

苏晴怀孕二十周的时候，去医院做了一次大排畸超声。

屏幕上是一团灰灰白白的影子，医生用鼠标点了点：“这是头，这是脊柱，这是心脏，四个腔都有。”

她看得入神。忽然，医生笑了：“你看，宝宝在吃手。”

屏幕上，那团影子里的一只小手，慢慢地举到脸边，嘴先张开了，手才碰上去。

江远在旁边凑得很近，小声问：“它怎么知道手要来？嘴为什么先张开？”

医生说：“这个月份的宝宝，常常这样。”

回家的路上，江远一直在想这件事。后来他查了资料，发现这不是他一个人的惊讶。有研究者用超声观察过：孕十九周前后的胎儿，在手快要碰到嘴的时候，嘴会提前张开，好像它“预先知道”手要到哪儿去。〔中：多项小样本观察研究〕

一个还没睁过眼睛的孩子，已经在做“手到嘴边”这件需要协调的事。

这一章，要讲的就是在睁眼之前，孩子在经历什么。

◆ 二、触觉：最先到场的那一个

先说触觉。

在所有感觉里，触觉是胎儿最早发育起来的。大约在孕七到八周，胎儿还只有一颗花生米大小的时候，如果有东西轻轻碰到他的嘴唇四周，他会把头偏开。这是目前可以观察到的、最早的一种对碰触的反应。〔强：多项研究一致〕

接下来，这份敏感，像水波一样，从口周往外扩散。到孕十到十一周，手掌对触碰有了反应。到十三、十四周，身体的大部分地方，已经有了反应。更细致的研究认为，要到孕三十二周前后，几乎全身对很轻的触碰，比如一根羽毛的轻扫，都很敏感。〔中：不同研究给的周数有出入，方向一致〕

再看胎儿身处的环境。他一刻不停地被碰着：羊水包着他，子宫壁贴着他，脐带绕着他，胎盘挨着他。他自己也在不停地动，自己碰自己。孕二十到二十二周前后，有研究在超声里看到：胎儿的两只手会碰在一起，或者交叉。他的手还会去抓脐带。〔中〕

到孕后期，自己碰自己的次数，越来越多。有研究者认为，这可能是因为皮肤越来越敏感了。〔中〕

还有一个很有意思的发现：在孕早期，胎儿遇到碰触，倾向于躲开；到后来，则更多地迎上去。〔中：来源是综述性介绍，原始文献待核〕

除了皮肤的碰触，还有一种“碰”，是身体的晃动。胎儿漂在羊水里，母亲每走一步，每坐下、起身、翻身，都会让他被轻轻地晃一下。管平衡和位置的器官，也在孕中期开始工作。〔中〕

你可以回头想想，第1章里，苏晴的母亲说，当年怀她的时候，“天天走路”。这四个字，在这里有了新的分量：天天走路，对胎儿来说，是天天被一只看不见的手，有节奏地摇着。

这就带来了一个问题：母亲的碰触，胎儿有没有反应？

有。有研究让孕妇用手轻轻抚摸自己的腹部，同时用超声记录胎儿的动作。结果发现，在孕二十一到三十三周之间，胎儿在母亲抚摸腹部的时候，手臂、头和嘴的动作增多，心率也有变化。这些反应，比听母亲说话时更明显。

〔中：样本量不大，需要更多研究〕

我们要谨慎地读这些结果。它们不能说明“抚摸可以让孩子更聪明”。它们只说明一件事：胎儿能感到外面传进来的碰触，并且会作出区别的反应。这个“区别的反应”，就够了。

现在，请你回想一下上一章里的胡塞尔。

他在《观念》第二卷里说，一只手去摸另一只手，会发生一件触觉独有的事：同一个动作里，一只手是摸的，另一只手是被摸的，而且可以互换。他说，我们觉得“这是我的身体”，靠的就是触觉的这种双重性。〔核：大意，见上一章〕

胎儿的两只手在孕二十周前后，就开始互相碰了。

这是一种说法，请别当成定论：在孕二十几周的子宫里，“我的身体”的最早雏形，也许就在这样一次一次的“摸”与“被摸”里，搭起来了。〔解释：这是本书的理论说法，不是实验直接测出的事实〕

胡塞尔是在一间书房里，凭自己的体验，发现了这件事。而胎儿，在子宫里，不用任何人教，每天都在做。

◆ 三、听觉：一个被水和肌肉“调低”的世界

再说听觉。

胎儿的耳朵，是在孕早期开始成形的。可是要真正“听见”，还要等神经和大脑的相关区域长好。目前最早的、可靠的对声音的反应，大约出现在孕十九周前后；孕二十四到二十八周之间，胎儿对外界的声音，会比较稳定地作出反应，比如动一下，或者心率发生变化。一般认为，听觉系统大约在孕二十五周前后开始“上岗”。〔中：不同来源周数略有出入〕

有一个说法值得记住：从孕二十五周，到出生后五六个月，是听觉系统的神经部分发育最关键的一段时间。〔中：综述性说法〕

那么，胎儿在子宫里，到底听到了什么？

不是我们听到的这个世界。

子宫像一个“低通滤波器”：它让低的声音容易通过，把高的声音大大压低。几百赫兹以上的声音，被削弱很多。结果是：一个个的字音，听不清了，可是说话的旋律和节奏，保留了下来：哪里高，哪里低，哪里快，哪里慢，哪里停。研究者把这叫作“韵律”。〔强〕

所以，胎儿听到的，是这样的一个世界：

最底下，是母亲的心跳，一下接一下，稳稳地敲着。再往上，是血流的声音，呼吸的起伏，肠胃偶尔的咕噜声。再往上，是母亲说话的声音：它不是从外面传进来的，是在母亲的身体里直接震动过来的，所以比外面的声音更清楚。有测量显示，子宫内母亲自己的声音，被增强了五分贝左右，而外面男人和女人的声音，反而被削弱了两三分贝。〔中〕

再往外，才是外面世界的声音：门响、电视、别人说话，隔着肚皮、隔着水，闷闷的。

这个背景，不是一成不变的。母亲走路的时候，心跳会加快，呼吸会变深；她说话的时候，声带的震动，整个身体都会传导；她睡着了，一切又沉下去。胎儿听到的，不是一堵恒定的声音墙，而是一个跟着母亲的一天，起起落落的节律。

这样的世界，没有清楚的字，却有清楚的节拍和起伏。你可以想象一下，在一个鼓声一直不断的房间里，隔着一堵厚厚的墙，听到隔壁传来的人声。听不清说什么，不过听得出那人是高兴，是着急，还是在哄人。

这就是触觉之外的第二条路：听觉的路。

它给胎儿的第一批东西，是节奏。心跳的节奏，呼吸的节奏，母亲说话的节奏。有研究者提出，在子宫里反复听到心跳这种稳定的节律，可能为日后孩子跟着节奏动作、同别人配合着说话、对视的能力，打下了基础。〔中：这是一个有依据的推测，尚在研究中〕

◆ 四、出生之前，就认得妈妈

好，现在来看一个很惊人的证据。

1980年，美国两位心理学家德卡斯帕和菲弗，做了一个实验。他们找来出生才几十个小时到两三天的新生儿，给每个孩子含一只特别的奶嘴。奶嘴不出奶，不过孩子吸它的快慢方式，会决定耳机里放出谁的声音。孩子一种快慢，放出妈妈读故事的声音；另一种快慢，放出另一位女士读同一个故事的声音。

没有谁教过这些孩子。不过很快，孩子学会了用那种快慢，去换妈妈的声音。他们更愿意听妈妈。〔强：已被多次重复，经典研究〕

这些孩子，出生才没几天。他们和妈妈，在外面的世界里，才相处了几个小时。能做到这一点，说明在出生之前，他们就已经把妈妈的声音，记在心里了。

后来有人做了更巧妙的实验。1986 年，德卡斯帕和斯彭斯，请十几位孕妇，在怀孕最后六周半的时间里，每天读两遍同一段《戴帽子的猫》。算下来，每个孩子在出生之前，总共听了大约五个小时。孩子出生以后，吸奶嘴，换故事。结果，孩子们更愿意听出生前听过的那一段故事，不管读的是妈妈，还是另一位女士。〔中：样本小，但后来有类似的研究支持〕

这说明什么？说明孩子在子宫里，记住的不只是“妈妈的声音”，还有一段话的节奏和起伏。

还有一个很有意思的发现。研究者做了两个版本的妈妈的声音：一个是原样的；另一个，经过处理，只留下低频，听起来闷闷的，像隔着肚皮听到的那样。新生儿更喜欢哪一个？更喜欢后一个。〔中〕

也就是说，孩子更偏爱“子宫里的声音”，而不是“空气里的声音”。

在出生以前，是不是就已经有这种区分了？2003 年，加拿大的基西莱夫斯基和同事，请六十位足月的孕妇参加。研究者用扬声器在腹部上方，给胎儿播放录音：一半放妈妈读诗的声音，一半放陌生女人读同一首诗的声音。同时，他们记录胎儿的心率。

结果，妈妈的声音，让胎儿的心率上升；陌生人的声音，让心率下降。研究者的结论是：足月的胎儿，能够区分妈妈的声音和陌生人的声音。〔中：多

个实验室有过类似发现，但心率变化的方向，在不同研究里并不一致，所以这项结论要谨慎地读]

对语言，也有类似的发现。新生儿更爱听母语，而不是外语。研究者认为，这是因为母语的韵律，他们在子宫里，已经听了好几个月。〔中〕

还有一个更让人意外的发现：新生儿的哭声，带着母语的“腔调”。2009年，德国的研究者比较了法国和德国新生儿的哭声。他们发现，法国新生儿的哭声，旋律多是先低后高；德国新生儿的，则多是先高后低。这恰好和各自母语里常见的语调走向一致。〔中：来自一项发表在《当代生物学》上的研究，样本不大，仍待重复〕研究者的解释是：孩子在子宫里，已经学到了母亲说话的旋律，出生以后，连哭，都带着它。

那父亲的声音呢？有研究发现，足月的胎儿和新生儿，对父亲的声音，也会有反应，只是和对母亲声音的反应，不完全一样，母亲的声音反应更明显。

〔中〕研究者的解释是：母亲的声音，除了通过空气，还通过她自己的身体直接传进去，所以更清楚。

这不是母亲和父亲之间的一场比赛。它只是在说一个事实：在出生以前，母亲的声音，是离孩子最近的那一个。父亲的声音，也能传进去，只是隔得远一些。后面的第八编，会专门讲父亲怎样在这个过程中，站到他该站的位置上。

我们再往早走一步。如果早产，孩子提前被“请”到外面的世界，会怎样？

在重症监护室里，早产儿听到的，是仪器的滴滴声、人来人往的高频声音，没有母亲的心跳，也没有母亲的声音。

2015 年，美国波士顿的一项研究，让一组孕二十五到三十二周出生的早产儿，每天听一段经过处理的、像是从子宫里传出来的妈妈的声音和心跳。几周以后，这组孩子的大脑里，管听觉的区域，比没听这些声音的孩子，更大一些。〔中：这是一项早产儿研究，样本不大，需要重复〕

所以我们可以很有把握地说：在睁眼之前很久，孩子的世界，已经被心跳、被一个人的声音，一遍一遍地写过了。洛克的那张“白纸”，在出生的那一天，已经写满了。

◆ 五、味和嗅：也比“看”早

触和听之外，还有两条小路，也比“看”早，值得顺便说一句：味觉和嗅觉。

羊水不是无味的水。母亲吃进去的东西，其中的一些味道，会进入羊水。有研究让孕妇在孕期和哺乳期喝胡萝卜汁，后来发现，这些孩子在开始吃辅食的时候，对胡萝卜味的谷物，接受得更好。〔中：样本不大，来自一项发表在《儿科学》杂志上的研究，细节待核〕也有研究发现，新生儿更喜欢自己母亲羊水的气味。〔中〕

这些发现的意思是：孩子出生的时候，嘴里和鼻子里，已经带着母亲饮食的“口味”，这是他最早的“家的味道”。

所以我们可以把这一节的话说完整一点：在睁眼之前，最先到场的是触，其次是听，还有味和嗅；而“看”，最后才来。

◆ 六、一个有名的词：胎教

说到这里，你可能想到一个词：胎教。

中国的古人，对这件事很早就有注意。西汉刘向编的《列女传》里，讲到周文王的母亲太任，怀孕的时候，“目不视恶色，耳不听淫声，口不出敖言”，后来生下文王，“生而明圣”。〔核：《列女传·母仪传·周室三母》〕书里还总结了一句：“人生而肖万物者，皆其母感于物。”意思是，孩子像什么，都是因为母亲在怀孕时被什么感染了。

古人看到了一件真的事：母亲怀孕的时候，经历的一切，会以某种方式，传到孩子身上。

可，具体“怎样传”“传什么”“有没有用”，古人不知道，我们今天，也需要谨慎。

先说有证据的一面。母亲在怀孕期间的状态：睡眠、营养、长期的压力、是否被支持，会影响胎儿的发育，这一点有较多的研究支持。〔强〕胎儿能够听到母亲的声音，能记住节奏，也是有证据的。

古人看到的東西，里面有一半是真的：母亲怀孕时的状态，确实会影响孩子。古人说“目不视恶色，耳不听淫声”，强调的是母亲要有一个安稳、清静的心境。这个意思，和今天研究里“母亲的睡眠、压力、支持，会影响胎儿”的结论，方向是一致的。可是古人给出的具体办法，比如看什么、听什么，就不一定经得起今天的检验了。

再说证据弱的一面。“听莫扎特，孩子会更聪明”，这个说法流传很广。它的来源，是1993年发表在《自然》杂志上的一项研究：大学生听了十分钟莫扎特的曲子之后，在一项空间推理测验里的成绩，暂时略有提高。那是大学生，不是胎儿，效果是短暂的，后来多次重复，也没有得到稳定的结论。

〔核：Rauscher等，1993；后续元分析〔待核〕〕把它变成“给胎儿听莫扎特会提高智商”，是传话传歪了的结果。

还有一件需要小心的事：不要把耳机或扬声器直接贴在肚子上。声音过大，对胎儿的内耳不好。〔中：来自综述性建议〕个体怎么做，请听产科医生的意见。

所以，本书在这个问题上的立场，和市面上很多“胎教”不一样：我们不主张“给胎儿加料”，不主张“灌输”。我们主张的，是把母子之间已经有的那个来回稳住。第六编会讲具体怎么做。

◆ 七、“看”，是后来才加进来的一种显露

现在，我们可以回答前面留下的那个问题了。

如果出生之前，一个孩子就已经分得出不同，接得成路，有回应，也有改变，那这个来回，是用什么通道进行的？是触，是听。不是看。

本书里，有一个词，叫“显露”。大白话的意思是：世界在你面前，露出样子来。

同一个世界，可以用不同的方式露出来：用触，露出冷暖、软硬、轻重、内外；用听，露出节奏、远近、高低、起伏；用看，露出形状、颜色、距离。

在出生之前，露出来的，主要是触和听。出生之后，看加了进来，并且越来越多，最后成了成年人最爱用的一种。不过，它是最后到场的那一个。

出生以后，这几条通道，是一起到场的。想一想一个新生儿吃奶的那一刻：他的嘴碰到母亲的皮肤和乳头，是触；他听到她的心跳和她的声音，是

听；他看到她的脸，而这张脸，恰好就在他最能看清的二十来厘米的距离上，是看。

三条通道，合成了一次喂奶。在这里面，“看”，是插进已经存在的触和听里面的，不是先它们而来的。

所以，本书对“看”的看法，是这样的：

“看”是显露的一种方式，一种侧重。它不是源头。〔解释：这是本书的理论说法〕

为什么这件事要紧？因为“看”有一个特点：它让我们和东西，隔着一段距离。你看一个苹果，你在这儿，苹果在那儿。这种“我在这里，东西在那里”的格局，叫“主客分明”。哲学里的很多麻烦，都是从这个格局里长出来的。

可在子宫里，没有这个格局。胎儿和母亲，贴在一起，没有距离。你很难说，哪一刻是“我”，哪一刻是“你”。“我”和“你”的分野，是在接触、在节律、在一来一回里，慢慢分出来的。

所以，我们才说，看，是在已经有了的发生之后，的一种侧重显露。把它当作起点，是把一个晚到的方式，当成了源头。

到这里，我们可以给这一章的两个新词，下一个大白话的定义了：

“触觉SDE”，指的是通过触觉进行的那个来回。孩子分出冷暖、轻重、内外的不同，把一次碰触接上下一次碰触，再用踢、转头、吮吸去回应。这些回应，又改变了接下来碰到的东西。

“听觉SDE”，指的是通过听觉进行的那个来回。孩子分出节奏的快慢、声音的远近高低，把心跳一下一下接起来，把话语的起伏连成一段，再用动一动、心率的变化去回应。这些回应，又让母亲的声音和状态发生变化。

这两个来回，都是在子宫里，从孕七八周到出生，一点一点发生的。

◆ 八、把它们排在一条线上

到这里，信息比较多，不妨把它们排在一条线上，看看顺序。

下面这张表，把前面几节里的发现，按孕周排了一遍。各项研究给出的周数略有出入，表里取的是常见的范围，请当作一张“大致的地图”，不要当作精确的时刻表。

孕周（约）	大约发生了什么	主要通道
7至8周	碰触口周，头会偏开	触
10至11周	手掌对碰触有反应	触
13至14周	身体大部分地方有反应	触
19周	手到嘴边前，嘴先张开；开始有对声音的最早反应	触、听
20至22周	双手互碰，抓脐带	触
24至28周	对外界声音的反应变得稳定，约25周听觉开始“上岗”	听
26至28周	眼睑重新分开	看（预备）
约30周	瞳孔对光有反应	看（预备）
32至34周	对母亲的声音，心率出现有区别的反应	听
足月	能区分母亲和陌生女人的声音；出生后偏爱母亲的声音	听

把这张表从头看到尾：触在最前面，听紧跟着，看最后才加进来，而且在子宫里，“看”只是预备，没有真正的画面。

〔中：表中各行均有研究支持，但各来源的具体周数不同〕

◆ 九、放回日子里

苏晴孕三十周的产检，医生交代了一件事：数胎动。

“每天找个固定的时间，安静躺着，数一数。”医生说，“不用跟别人比，你就看自己的孩子，大概每天什么样。要是比平时明显少了，别等，马上联系医院。”

回到家，苏晴照着做了。第一天，她数了半小时，数不出什么规律。第二天，她发现，每天晚饭后，孩子都会动得多一些。第三天，江远下班回来，把手轻轻地放在她的肚子上，没有说话，就静静地待着。

十分钟以后，孩子在他的手心下面，顶了一下。

江远愣了好一会儿，说了一句：“他知道是我。”

苏晴没有反驳他。

可是她心里很清楚：研究里并没有证据，能证明孩子“知道是他”。也许只是孩子刚好动了一下。她没有把这句话说破，因为她明白，对这个晚上的江远来说，这一下，是一件很重要的事。

江远后来跟苏晴说，他以前一直觉得，在孩子出生以前，自己能做的事很少。现在他换了一个想法：他至少可以成为那个让妈妈安稳的人。

苏晴没接话，只是把他的手，拉得更紧了一点。

你也可以在这个意义上，试一个很小的做法，不需要任何工具：

找一个胎动比较活跃的时段，安静坐着，把手放在腹部，静静地待十分钟。不要提问，也不要期待什么，只是看看，有没有动，往哪边动，动的时候，你自己的身体是什么感觉。没有动，不要紧；每个孩子都有自己的节律。

如果你不是孕妇，也可以试：对着身边怀孕的人，问一句，“今天孩子动得怎么样？”这一句问话，就是在帮她，把这个来回稳住。

带走的话

孩子最先学会的，是被触到、被唱到。最先到场的是触和听，最后到场的是看。

◆ 本章证据账

论断	证据等级	出处
触觉是胎儿最早发育的感觉；约孕7至8周，碰触口周会引起头部偏转	强	Hooker, 1952; Piontelli, 2010, 2015; Hadders-Algra 等综述
手掌约孕10至11周有反应；身体多处约13至14周有反应；约32周几乎全身敏感	中（各研究周数不同）	Derbyshire, 2008; Hooker, 1952; Humphrey & Hooker, 1959
孕20至22周胎儿双手互碰、手摸脐带	中	Piontelli, 2010; Fagard 等, 2018
孕19周前后，手到嘴边之前嘴先张开	中（小样本观察）	Myowa-Yamakoshi & Takeshita, 2006; Reissland 等, 2014
母亲抚摸腹部，胎儿手、头、嘴的动作增多	中（样本不大）	Marx & Nagy, 2015, 2017
胎儿最早对声音的反应约在孕19周，24至28周较稳定，约25周听觉系统开始工作	中（周数略有出入）	Hepper & Shahidullah, 1992; 听觉发育综述

强 / 中

论断	证据等级	出处
子宫对高频声音有衰减，节奏与起伏得以保留；母亲自己的声音在子宫内比外来声音更突出		Gerhardt & Abrams, 2000; Spence & DeCasper, 1987; Richards 等, 1992
新生儿偏爱母亲的声音	强（经典，多次重复）	DeCasper & Fifer, 1980, Science 208
新生儿偏爱孕期听过的一段故事	中（样本小）	DeCasper & Spence, 1986
足月胎儿对母亲与陌生人声音的心率反应不同（方向在各研究中不一致）	中	Kisilevsky 等, 2003, Psychological Science; Voegtline 等, 2013
新生儿偏爱经低通滤波、近似“子宫内”的母亲声音	中	Fifer & Moon, 1995
早产儿听处理过的母亲声音和心跳录音，听觉相关脑区更大	中（样本不大）	Webb 等, 2015, PNAS
《列女传》太任胎教	原文	《列女传·母仪传·周室三母》〔核〕
“莫扎特效应”最初针对大学生、效果短暂，后续重复结果不稳	强（原研究）；后续元分析〔待核〕	Rauscher 等, 1993, Nature
母亲孕期的睡眠、营养、长期压力与支持，影响胎儿发育	强	孕期保健相关研究，将在第六编逐项列出
看是显露的一种侧重，不是源头；“触觉SDE”“听觉SDE”的说法	本书的理论解释	王德生博士的SDE发生学

关于孕期声音、触碰与胎动，个体情况请遵医嘱。胎动明显减少时，请及时联系医院。

母亲走路等晃动带来平衡觉的刺激；平衡器官孕中期开始工作	中	胎儿感觉发育综述〔待核：具体周数〕
	中	Lee & Kisilevsky, 2014

母亲走路等晃动带来平衡觉的刺激；平衡器官孕中期开始工作	中	胎儿感觉发育综述〔待核：具体周数〕
胎儿与新生儿对父亲的声音也有反应，对母亲声音反应更明显		
新生儿哭声旋律带有母语特点（法国与德国新生儿对比）	中（样本不大）	Mampe 等，2009, Current Biology
孕期母亲的饮食味道可传入羊水，影响婴儿日后接受该味道	中（样本不大）	Mennella 等，2001, Pediatrics〔待核：细节〕
新生儿偏爱自己母亲羊水的气味	中	Schaal、Marlier 等，1998〔待核：出处〕

本编总判断：智慧的起点，不是睁开眼睛、看见世界，而是在睁眼之前很久，就在触和听里，同另一个人，开始的那一个来回。

下一编，我们走进子宫，一段一段地看，这九个月里，这个来回是怎样一点点铺开的。

第二编

子宫里的九个月：第一条回路

这一编四章，讲睁眼之前的九个月里，孩子和母亲之间，怎样走出第一条回路。

第 4 章讲最早的事：连神经都还没有的时候，来回已经开始。第 5 章讲触觉，第 6 章讲听觉。第 7 章讲孩子并不被动，他在改变母亲，母亲也需要被稳稳地托住。

四章走完，你会看到：智慧的第一条路，是在水里、在黑暗里、在一个人身体里，一点一点走出来的。

第 4 章

受精卵的第一场对话：还没有神经，已经有了来回

◆ 一、两道杠

苏晴是在一个周二的早上知道的。

那天她的月经晚了十一天。她在卫生间里蹲了很久，拿着一根小小的试纸，看着上面慢慢浮出来的两道杠。第二道很淡，她把试纸凑到窗边，对着光看了又看。

她没有喊江远。她先坐在马桶盖上，把手放在肚子上，坐了差不多五分钟。

后来她跟江远说起这五分钟，说：“我就觉得里面有个东西已经在。可是我什么也感觉不到。”

她说得对，也不对。

对的是，那个时候里面确实已经有了一个新的生命。不对的是，说“什么也感觉不到”只讲了一半。她感觉不到，不等于里面没有事情在发生。恰恰相反，在她坐在马桶盖上的这五分钟之前，已经有一场对话进行了差不多两个星期。

这场对话的一方是一个比针尖还小的细胞团。另一方是她的身体。

这一章就讲这场对话。

◆ 二、先把话说在前头

写这一章之前，本书要先把一件事讲清楚。

前面的章节说过，本书用“智慧”这个词指的是一件很小的事：能分出不同，把不同接成路，再回应，并改变下一步遇到的不同。

按这个说法，要有“智慧”，总得有个能分出不同的东西。

而这个时候的受精卵没有眼睛，没有耳朵，没有皮肤，连神经都还没有。它是一个细胞，后来是几个细胞，再后来是一团细胞。它不会“摸”，也不会“听”。

所以本书不会说“受精卵已经有触觉和听觉了”。那样说是错的。

本书要说的是另一件事：触觉和听觉不是凭空出现的。它们要长出来，要在一个环境里长出来。而这个“长”的过程，从受精那一刻起就已经是一场来回。

先有来回，后有触和听。这是本书对这一章的立场。请你记住这个先后。

这个说法一部分有实验撑着，一部分是本书的理论读法。下面讲的时候我会分开标。

◆ 三、受精之后的十天

先讲事实。

一个卵子和一个精子相遇，合成一个细胞，这就是受精卵。它的遗传物质一半来自母亲，一半来自父亲。〔强〕

受精大多发生在输卵管里。受精卵不会停在那里不动。它一边分裂，一边顺着输卵管慢慢往子宫走。分成两个、四个、八个、十六个，到第四五天成了一团有几十个细胞的小球，叫胚泡。〔强〕

这一路大约要走五六天。

这几天受精卵没有“食物”。它靠的是卵子里原来带着的那点储备，和输卵管、子宫里分泌的液体。这些液体里有糖，有蛋白质，有生长因子。〔强：生殖生物学教科书内容〕

换句话说，从第一天起它就是在“被养着”的。

到了第六七天，胚泡贴到子宫内膜上，开始往里钻。这件事叫着床，要花几天才完成。〔强〕

请注意，着床不是单方面的事。

一边是胚泡。它会分泌一些化学信号去“告诉”母亲的身体：我来了。其中最有名的一种叫人绒毛膜促性腺激素，简称 hCG。你用的那根验孕试纸测的就是它。〔强〕

另一边是子宫内膜。它不是一块被动的“沙发”。在排卵之后，在黄体酮的作用下，它自己会发生变化：变得厚实，血管增多，细胞分泌出各种营养物质和信号分子，等着胚泡到来。研究发现，内膜在这个时期能够“挑”胚泡：质量差的胚泡不容易着床。〔中：这方面的研究还在发展中，机制没有完全弄清〕

所以着床是两边都在“说话”，也都在“听”。

母亲身体里的“听”是靠激素和细胞表面的受体。胚泡里的“说”是靠hCG这一类信号。母亲身体收到信号会作出回应：黄体继续工作，继续分泌黄体酮，月经不来了，子宫内膜不脱落。

这一环要是断了，比如hCG信号不够强，黄体就会萎缩，月经就会来，怀孕就中断。〔强〕

苏晴那天早上的两道杠就是这个来回走通了的证据。

◆ 四、先弄清一件小事：孕周是怎么算出来的

你在产检本上看到的“孕周”，和受精的日子，不是同一个算法。

医生算孕周，是从末次月经的第一天开始数的。那一天你还没有怀孕。

〔强：产科通行的算法〕

排卵大多在下次月经前两周左右。卵子排出来之后，能等精子的时间不长，大约一天上下。〔强：生殖生理基础内容，个体差异大〕

所以真正受精的日子，往往已经是“孕2周”前后。苏晴验出两道杠的时候，医生说她“孕4周多”。受精卵其实才在世上待了两个星期出头。

这样算有一个好处：大部分人记得住末次月经，记不住受精那一天。

它也有一个小麻烦：你读到“孕6周”的时候，要在心里减去两周。孩子真正的“年龄”，比孕周小两周左右。〔强〕

请你顺手记住：本书后面说“孕20周”，都是按医生的算法。

再讲一个常被问到的事：验孕试纸为什么要等月经推迟才准？

因为试纸测的是尿里的 hCG。胚泡着床之后才开始分泌它，量涨到一定程度，试纸才测得出来。〔强〕

测得太早，可能只有一道很淡的线，或者什么也没有。这时不用慌，过几天再测，或者去医院抽血查 hCG。〔中：灵敏度因试纸和个人而异，请以医生复查为准〕

hCG 在孕早期涨得很快，大约两三天就能翻一倍。医生会看几次结果的变化，不会只盯着一个数。〔中：翻倍的速度因人而异，请遵医嘱〕

◆ 五、胚泡里的两拨人

那团叫胚泡的小球，里面并不是一模一样的细胞。

它分成两拨。外面一层，叫滋养层，负责钻进子宫内膜，将来搭出胎盘。里面挤在一边的一小团，叫内细胞团，将来才长成胚胎本身。〔强：胚胎学教科书内容〕

这个分工很有意思。最先出力的，不是将来的“孩子”，而是负责搭房子的外层细胞。

hCG 就是外层细胞分泌的。所以那根试纸，测的其实是胎盘的“前身”在说话。〔强〕

你可以把它想成盖一栋楼。最先上工地的，是搭脚手架的人。楼本身，要等脚手架立稳了才开始长。〔解释：比方，帮助理解〕

这件事对本书的意义是：从一开始，这个孩子就有一部分细胞，专门用来和母亲对话。他没有先长好自己，再去找人。他是一边长，一边和母亲接上的。〔解释：本书的读法〕

◆ 六、黄体把接力棒交给胎盘

hCG 的任务，是告诉黄体：别退休，再干几周。

黄体是排卵之后卵泡留下的一小团组织。它分泌黄体酮，护着子宫内膜。

〔强〕

黄体撑不了九个月。大约到孕 7 到 10 周，胎盘长得足够大，开始自己分泌黄体酮。这像接力赛，第一棒把棒交给第二棒。〔强：黄体到胎盘的交接，具体孕周因人而异〕

胎盘的主体，是由受精卵外层的细胞长出来的。〔强：胚胎学教科书内容〕也就是说，这个孩子自己造出了养他的那个器官。

交接的这几周，是不少人最不舒服的几周：疲倦，想睡，乳房胀，尿频，容易恶心。〔强：孕早期常见反应，与激素变化有关〕

这些反应常被说成“娇气”。其实是身体在换棒。

所以孕早期想多睡一会儿，不是偷懒。这是身体在做一件看不见的大工程。

苏晴那几周中午总想趴在桌上睡二十分钟。她一开始觉得羞愧，后来索性订了闹钟。

◆ 七、子宫内膜这间“房间”，是怎么备好的

胚泡到达的时候，子宫内膜必须已经准备好了。这件事靠的是排卵之后那两周的节奏。

排卵之前，内膜在雌激素的作用下慢慢变厚。排卵之后，黄体开始分泌黄体酮，内膜变得更松软，腺体更活跃，能分泌营养的东西。〔强：月经周期生理，教科书内容〕

内膜肯“接收”胚泡的时间很短，只有几天，叫着床窗口期。过了这几天，内膜就不再那么欢迎。〔强：生殖生理共识，具体天数个体差异大〕

如果没有胚泡来，黄体大约在排卵后两周萎缩，黄体酮掉下去，内膜脱落，月经就来了。〔强〕

你可以把内膜想成订好的酒店房间。房间要在客人到的前一天备好，客人迟到太多，房间就退掉了。〔解释：比方〕

着床成功以后，内膜里的细胞还会进一步变化，变成专门养胚胎的“蜕膜”。〔强：教科书内容〕这是母亲的身体主动做的，不是被动等着。

所以你看，这个孩子的第一个“家”，是母亲的身体和胚泡一起装修出来的。

◆ 八、这算不算“智慧”

你可能会问：这只是化学反应，算什么“智慧”？

问得好。本书的回答是：它不算“智慧”，它算“智慧的前身”。

我们不妨用一个办法把它分开。

第一，有没有“分出不同”？有。母亲的身体要分得出“这是一个有信号的胚泡”，还是“没有信号的普通细胞团”。胚泡也要分得出“这里是合适的内膜”，还是“不合适的地方”。〔解释〕

第二，有没有“接成路”？有。信号从胚泡到母体，再回到胚泡，一环扣一环。着床成功后胎盘开始形成，这条路越走越宽。〔强：事实；解释：用“接成路”来读它〕

第三，有没有“回应并改变下一步遇到的不同”？有。母体的回应改变了胚泡下一步遇到的环境：有了血供，有了营养，有了免疫上的“容忍”。

〔强：事实〕

三条都沾边。可是这里没有神经，没有“感觉”，没有任何“知道”的成分。所以我们不叫它“智慧”。

本书把这一层叫作“化学层面的来回”。它不是触觉，也不是听觉，它是触觉和听觉得以出现之前那块铺在地下的石板。〔解释：这是本书的概念，不是医学术语〕

为什么要专门讲这一层？

因为它说明了一件事：这个孩子从来就不是一个“独自”长大的东西。他的第一步就需要另一个人的身体和他“对上话”。

这件事在人生的最开头没有第二种可能。

◆ 九、母亲的身体，为他“学会”了一件很难的事

接下来要讲一件很了不起的事，一般人很少想到。

从遗传上讲，胎儿一半的基因来自父亲。对母亲的免疫系统来说，这个胎儿有一半是“外来的”。

按理说，免疫系统是要攻击“外来物”的。移植一个别人的肾给你，你的身体会排斥，要吃一辈子的抗排异药。可是母亲的身体对这个“半外来”的胎儿不但不排斥，还要养九个月。

这是怎么回事？

医学界到今天也没有把它完全讲透。能讲的大概有这几条：

一是胎盘外层的细胞有一种特别的“身份牌”，让母亲的免疫细胞不容易认出它是“外人”。〔中：机制研究较多，细节在更新〕

二是在子宫内膜这个地方有一些特别的免疫细胞，叫子宫自然杀伤细胞。它们不去“杀”，反而帮着胎盘的血管长好。〔中〕

三是母亲的整个免疫状态在孕期会发生调整，不是“关掉”，而是“重新校准”。所以孕妇对有些病更容易中招，对有些自身免疫病症状反而会缓解。〔中〕

这里我们不必记住细节。你只要记住一点：母亲的身体从第一天起就在做一件需要“分出不同、再作出区别回应”的精细工作。她没有想，也没有决定。她的身体替她做了。

这是一种说不出口的“智慧”。可它不是孩子的智慧，而是母亲身体的。

孩子的智慧是接在它后面长出来的。

◆ 十、神经是什么时候出现的

前面一直说“还没有神经”。那神经是什么时候来的？

受精后第三周前后，胚胎背侧的一层细胞开始增厚，形成神经板。随后它卷起来，合拢成一根管子，叫神经管。〔强：胚胎学教科书内容〕

神经管将来长成脑和脊髓。它大约在受精后四周前后闭合，换成孕周，大约是孕6周。〔强：具体时间有个体差异〕

这个时间很早。很多人还没来得及做第一次产检，神经管已经合上了。

这就是为什么医生建议备孕时就开始补叶酸。叶酸能降低神经管缺陷的风险。〔强：指南共识，具体剂量请遵医嘱〕

你可以把它想成盖房子。地基和承重墙，要在你还没搬进样板间的时候就砌好。

到了孕8周前后，神经管的前端已经鼓成几个小泡，将来分成大脑的不同部分。〔强〕

有了神经管，不等于有了“感觉”。感觉要靠神经细胞长出突起，彼此连上，还要和身体各处的感受器接上。这要再过好几周，甚至几个月。〔强：神经发育的大致顺序〕

所以本书的立场没有变：先有来回，后有触和听。神经是在这场来回里一点一点长出来的。〔解释：本书的读法〕

◆ 十一、他们之间，还有细胞在互相“串门”

还有一个更让人意外的发现。

怀孕期间，胎儿的少量细胞会通过胎盘进到母亲的血液里，有些还会留在母亲的身体里很多年。反过来，母亲的少量细胞也会进到胎儿的身体里。这种

现象叫“微嵌合”。〔中：多项研究已经证实存在，对健康的意义还在研究中，不要过度解读〕

有研究在已经去世的母亲的组织里找到了带有男性染色体的细胞，推测是她当年所生儿子的细胞。〔中：个别研究；样本数有限，待核〕

这个发现说明了什么，现在还没有定论。有人认为这些细胞可能对母亲的修复有帮助，也有人认为它和某些疾病有关。

本书不下结论。本书只借它说一件很朴素的事：母亲和孩子之间，从身体上讲，不是“一个在里面，一个在外面”。他们之间有来回，有交换，有留下的痕迹。

这就是为什么本书要把“与妈妈的 SDE”作为人生智慧的源头来讲。因为在这里，“与妈妈”是字面上的意思。

◆ 十二、基因不是写好的剧本

讲到这里，一定会有人问：既然孩子有自己的基因，那么他是什么样的人，不是早就由基因定了吗？

这是一个很重要的问题，也是很多人心里的疑惑。我们认真来答。

基因是一套“配方”。可是配方不等于菜。同一份配方，在不同的灶台上，用不同的火候，做出来的菜会不一样。

科学上有一个很有名的例子，叫“荷兰饥饿之冬”。

1944 年冬天到 1945 年春天，纳粹封锁了荷兰西部，当地人遇到了严重的饥荒，每天只能吃到几百卡路里的食物。那时有一批女性正好怀着孕。后来的

研究者追踪了这批孩子的一生。〔强：这是历史上有记录的事件，后续追踪研究很多〕

他们发现，在孕早期遇到饥荒的孩子成年后肥胖、心血管病的风险更高。在孕晚期遇到饥荒的孩子更容易出现糖耐量异常。〔强：多项研究，不同阶段结果有差异〕

这些孩子的基因和没经历过饥荒的人没有什么不同。区别在于：在那几个月里，他们子宫里的“环境”传给他们一个信号：外面的食物很少，要省着用。他们的身体就按这个信号做了调整，而且一直保持到成年。〔解释：这是学界常用的解释，叫“节俭表型假说”，仍有争论〕

这样的现象后来在不同领域被叫作“健康与疾病的发育起源”。研究者发现，孕期的环境会通过一些化学标记影响基因“开”还是“关”，而不改变基因本身的“字母”。这种机制叫表观遗传。〔中：机制已有大量证据，人类中因果关系还在研究，不同结果并不完全一致〕

对本书最重要的是这句话：

同一套基因在不同的子宫环境里会“表达”出不同的样子。

所以说“基因决定一切”是不对的。说“基因没有任何作用”也是不对的。比较稳妥的说法是本书一直在用的这一句：基因提供材料、工具，环境提供使用它的条件。两个都在，才有一个人。

有一点要说清楚：荷兰饥饿之冬的研究主要讲的是身体健康，不是智商。关于饥荒对智力的影响，研究结果并不一致，有的发现影响很小，有的发现在某些方面有差异。〔中：结果不一致，不要把它当成“孕期受苦孩子会变笨”的证据〕

本书引它只为说明一件事：子宫是环境，不是“容器”。

◆ 十三、可是，母亲不必为此紧张

写在这儿，本书担心有一类读者会心里一紧：那我孕期吃得不够好、睡得不够好，是不是就把孩子害了？

不是。请你放下这个念头。

荷兰饥饿之冬是一场长达几个月的、极端的饥荒。它不是“今天少吃了一顿”，也不是“最近加班睡得晚”。

绝大多数的普通孕期，母亲的身体都有很强的缓冲能力。胎盘会优先把营养送给胎儿。母亲自己会先“吃亏”。这是身体的设计，不是你的失误。

〔强：胎盘的转运和母体缓冲是生理学共识〕

本书后面讲方法的几编都不是在要求母亲“做对一切”。它们只是在说：有几件事做了对孩子有帮助；有几件事不做也没关系。

在这一章里你只需要带走一件事：你的身体在你还不知道的时候已经在替你们两个做事了。

你不是从“知道怀孕”那一天才开始做妈妈的。你的身体比你早。

◆ 十四、林姐的两个孩子

苏晴孕 7 周的时候，在茶水间碰到同部门的林姐。林姐有两个孩子，一个九岁，一个四岁。

苏晴说起自己还在纠结咖啡的事。

林姐说：“我怀老大的时候，每天一杯咖啡，没事。怀老二的时候，我一口都不碰，也没事。”

苏晴笑：“那到底碰不碰好？”

林姐想了想：“我只能说我自己的两个孩子。你别拿我当证据，去问你的医生。”

这一段对话里，林姐说对了两件事。

第一，一个人的经历，不能当成规律。她的两个孩子都好，不能证明咖啡无害，也不能证明不喝才安全。

第二，要问专业的人。咖啡因的常见建议，前面已经讲过：每天 200 毫克以内。〔中：多国指南取这个数，请遵医嘱〕

身边人的故事，可以拿来安慰自己。不要拿来下结论。〔解释：本书的读法〕

◆ 十五、怎么看这件事：三个问题

读到孕早期的各种说法，你可以拿三个问题去量一量。

第一个问题：这件事发生的时候，有没有神经？

没有神经，就别说“他感觉到了”。要说，只能说“化学上有来回”。

第二个问题：这是单向的，还是来回的？

“母亲的营养给了孩子”是单向的说法。着床的时候，胚泡也在发信号，母体也在回应，这才是来回。〔强：着床是双向的信号交流，见本章前文〕

第三个问题：这是事实，还是读法？

“胚胎分泌 hCG”是事实。“这是智慧的前身”是本书的读法。本书一直把两者分开标，你也可以这样去读任何一本书。

拿这三个问题，再去看网上那些“胎儿三周就能感受妈妈的情绪”的说法，你大概就知道该打几折了。〔解释：这是读法建议，不是医学结论〕

再给你一个小比方。

着床有点像一家公司招人。公司要先把工位备好，把账号开好。新人要递材料，也要自己找到位置钻进去。

双方都配合上了，才算入职成功。没有哪一方只是干等着。〔解释：比方，只用来帮助理解〕

◆ 十六、第一次 B 超：那一粒闪动的光

孕 6 周多，苏晴和江远去做第一次 B 超。

医生把探头放上去。屏幕上有一个黑色的小圈，圈里有一粒小小的亮点，一下一下地闪。

医生说：“看到了，胎芽，还有胎心。”

江远伸长脖子：“那个闪的就是心跳？”

“对。孕 6 周左右，一般就能看到。”〔强：产科常见知识，可见胎心搏动的孕周略有个体差异〕

苏晴盯着那粒光，问：“他知道我们在看他吗？”

医生笑了：“他现在连耳朵都还没有。”

走出诊室，江远有点泄气。苏晴却说：“没事。至少他的心已经在跳了。”

她把B超单叠好，放进包里。

这一幕里有一个小提醒。心在跳，不等于有感觉。早期的心跳，是心肌细胞自己的节律，神经还没有来管它。〔强：胚胎学常识〕

不过来回已经在做它该做的事：hCG在涨，黄体在撑，胎盘在搭。

你不用对着那粒光说话。你只需要把自己照顾好。他下一步遇到的“不同”，现在就是你的身体。

◆ 十七、常见的几个问题

问：我还没确认怀孕的那几天，喝了酒，吃了感冒药，会不会已经害了孩子？

先别自责。刚受精的前两周，常讲的规律是“全或无”：要么影响大到胚胎无法继续，要么多数情况下继续发育。〔中：这是教科书常用的说法，并非对所有物质都成立〕

不同的药和酒，情况不一样。请把吃了什么、吃了多少、是哪几天，告诉医生，让医生判断。从知道怀孕那天起，酒就不要再碰。〔强：目前没有已知的安全饮酒量，多国指南一致建议孕期不饮酒〕

问：验孕棒的第二道线很淡，是真的吗？

多数时候，淡的第二道线也说明尿里有hCG。〔中：灵敏度因试纸而异〕可能是测得早，也可能是尿液稀。隔两三天再测，或者去医院抽血。

早孕期也有怀孕无法继续的情况。这类情况不算少见，常与胚胎本身的染色体问题有关，多数不是母亲做错了什么。〔强〕

问：孩子的性格和聪明程度，是不是受精那一刻就定了？

不是。基因像配方，不是做好的菜。〔强〕目前没有哪一项检查，能在孕早期告诉你孩子将来的性格或智商。〔强〕孩子往后的路，要在许多来回里走出来。

问：我现在对着肚子说话，他听得到吗？

现在听不到。听觉要到孕中期才开始工作。〔强：见第 3 章、第 6 章〕

不过你说话，对你自己有用。它能让你慢下来，也能让伴侣一起加入。想说就说，不想说也没有关系。

问：着床的时候有点出血，是不是有问题？

有些人在着床前后会见到少量淡色的出血。很多时候不是坏事。〔中：这个说法常见，但不是所有早孕出血都是这个原因〕

出血的原因有很多。量多，颜色鲜红，或者伴有腹痛，请马上去医院。〔强〕

问：爸爸在这个阶段能做什么？

做你的“E”。陪你去产检，替你挡掉一些焦虑，查信息的时候一起看靠谱的来源。〔解释：本书的读法〕

他此时碰不到孩子，却可以碰到那个养着孩子的人。

◆ 十八、放回日子里

苏晴知道自己怀孕是在第五周。

她的反应和很多人一样：先高兴，再担心。她开始上网查，看到的東西五花八門，有人說不能吃這個，有人說不能碰那個。她查着查着手心都出汗了。

那天晚上江遠回來，看她盯着手機，臉色不對。他把手機拿過去，說：“先別看了。”

蘇晴說：“我昨天還喝了半杯咖啡。”

江遠說：“半杯咖啡不會怎樣。”

他說得沒錯。關於咖啡因，目前常見的建議是每天控制在 200 毫克以內，大約一到兩杯普通的咖啡。〔中：多個國家的指南取這個數，個別研究認為應更低，請遵醫囑〕

可是江遠這句話真正起作用的地方不是那個數字。

是他“把手機拿走”那個動作。

他替她把那股往下掉的焦慮截住了。

這一點後面會專門講。現在你只要記住：對一個剛剛知道懷孕的女人來說，身邊有人說一句“先別看了，我們一起去問醫生”，比一百條網上的注意事項更有用。

這是第一次出現了“E 里的父親”。他還沒有直接碰到孩子，可他已經在做一件很重要的事：讓這條母親和孩子的來回在一個更穩的環境里走。

带走的话

孩子第一次来回不在睁眼的时候，不在落地的时候，也不在会听、会摸的时候。它在两道杠出现之前，在一个比针尖还小的细胞团和母亲的身体之间。那时候没有触，也没有听。可是来回已经开始了。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
受精后约六七天着床，hCG 通知母体维持黄体	〔强〕	生殖生物学基础内容
子宫内膜能“挑选”胚泡	〔中〕	研究持续，机制未完全清楚
母体对半外来胎儿的免疫容忍机制	〔中〕	方向清楚，细节在更新
微嵌合：母子细胞互相进入对方体内	〔中〕	存在已证实，健康意义未定；“已故母亲体内找到儿子细胞”待核
荷兰饥饿之冬与后代成年健康	〔强〕	对象是代谢和心血管风险，不是智商
表观遗传介导孕期环境影响	〔中〕	机制有证据，人类因果仍在研究
咖啡因每天约 200 毫克以内	〔中〕	各国指南取值略有差异，请遵医嘱
化学层面的来回是“智慧的前身”	〔解释〕	本书的概念，不是医学结论
受精卵“已经有触觉和听觉”	不成立	本书明确不这样说：此时没有神经
孕周从末次月经第一天起算，真实受精约在孕 2 周前后	〔强〕	产科通行算法，个体差异大
验孕试纸测 hCG，测得太早可能偏淡或阴性	〔强〕	灵敏度因试纸而异，请以医生复查为准
孕早期 hCG 两三天约翻一倍	〔中〕	因人而异，看趋势不看单次数值
孕 7 到 10 周胎盘接替黄体分泌黄体酮	〔强〕	具体孕周因人而异

说法	证据级别	说明
胎盘主体由受精卵外层细胞发育而来	〔强〕	胚胎学教科书内容
孕早期疲倦、乳房胀、尿频与激素变化有关	〔强〕	常见反应
神经管约在孕 6 周闭合，将来长成脑和脊髓	〔强〕	个体差异；有神经管不等于有感觉
备孕补叶酸可降低神经管缺陷风险	〔强〕	剂量请遵医嘱
孕 6 周左右 B 超可见胎心搏动	〔强〕	孕周略有个体差异；早期心跳是心肌自身节律
受精后前两周“全或无”的说法	〔中〕	教科书常用，不对所有物质成立
孕期没有已知的安全饮酒量	〔强〕	多国指南一致
早孕期妊娠丢失常与胚胎染色体问题有关	〔强〕	多数不是母亲的过错
孕早期无法由检查预知孩子将来的性格和智商	〔强〕	基因不是写好的剧本
着床前后可见少量淡色出血	〔中〕	出血量多、鲜红、腹痛请立即就医
胚泡分滋养层和内细胞团，前者长成胎盘，后者长成胚胎	〔强〕	胚胎学教科书内容
hCG 由滋养层细胞分泌	〔强〕	教科书内容
排卵后黄体酮使内膜转为适合着床的状态，着床窗口期只有几天	〔强〕	具体天数个体差异大
无怀孕时黄体约两周后萎缩、月经来潮	〔强〕	月经周期生理
着床后内膜变为蜕膜	〔强〕	教科书内容
一个人的育儿经历不能当成规律	〔解释〕	本书的读法

个体情况，比如咖啡、药物、饮食和孕期不适，请遵医嘱。

第 5 章

触觉 SDE：一推一回，身体的地图是这样画出来的

◆ 一、第一脚

苏晴第一次感到胎动是在怀孕十九周的一个傍晚。

她正靠在沙发上看剧。肚子里忽然有一下，很轻，像有一条小鱼在水里尾巴一甩，碰到了鱼缸的玻璃。

她一下子坐直了，把剧暂停。

等了好一会儿，没有再动。她以为是自己的错觉。三分钟后，又来了一下。

她拿起手机，给江远发消息：“动了。”

江远回得很快：“真的？我能摸到吗？”

她说：“现在还不行，太轻了，只有我自己能感到。”

这是很多初产妈妈的经历。胎儿其实在更早的时候就已经在动了，在孕七八周超声里就能看到。只是那时他太小，动得太轻，母亲感觉不到。要到十八到二十周前后，初产的母亲才第一次“摸到”。〔强：产科常见知识，第一次感到胎动的孕周因人而异，经产妇往往更早〕

这一章讲的是这个“动”背后的事。

◆ 二、触觉是怎么一点一点长出来的

在所有的感觉里，触觉是最早长出来的。〔强：胚胎学和发育心理学的共识〕

胎儿对碰触最早有反应的地方，是嘴唇周围。大约在孕 9 周前后，轻碰口周的皮肤，胎儿就会把头转开或者动一下。〔中：早年的观察研究，具体周数待核〕

接下来是脸，然后是手心、脚底。再往后，躯干和四肢的皮肤也一片一片地“亮”起来。到了孕中期，全身大部分皮肤都有反应。〔中：多来自早年的观察，具体周数因文献不同略有出入，待核〕

这个顺序有点意思。最先醒来的，是离嘴最近、将来最要紧的地方。嘴要吃奶，手要抓握，脚要站立。

孕中期以后，超声常常能看到胎儿把手送到嘴边，吸吮手指。〔强：产科超声常见所见〕

你可以想想，这是一件多么省事的“自学”。手能摸到嘴，嘴能碰到手，一个动作里，两边的感觉同时到来。

这些动作不是母亲教的，也没有谁在旁边指导。它们是身体自己在水里“练”出来的。〔解释：本书的读法〕

◆ 三、羊水里的触觉世界

要读懂胎儿的触觉，得先想想他泡在什么里面。

他泡在羊水里。羊水温度稳定，和母亲的体温差不多。〔强：生理学常识〕

羊水有浮力。胎儿的手脚在里面不用对抗重力，一蹬就能动很远，一收又很轻松。〔强：物理常识，对胎儿活动自由度的作用是合理的推论〕

羊水也有“阻尼”。你在游泳池里甩手，会感到有一点阻力。胎儿的每一次动，都会碰到这样一层软软的阻力。这让他的动作自带一点“反馈”。〔解释：本书的比方〕

羊水还有一个用处：它是胎儿的“减震垫”。母亲走路、坐下、被轻轻碰到，传到胎儿身上的冲击都会被它缓一缓。〔强：羊水的保护作用，医学教科书内容〕

胎儿还会吞咽羊水，也会把尿排进羊水里。〔强：产科常识〕这是一个循环。他在这个循环里练习吞咽和呼吸样的动作。

所以子宫里的触觉世界，是一个温暖、有浮力、有轻轻阻力的世界。

它不像我们躺在床上那么“实”，更像在温水里漂着。每一次碰到边界，边界都是软的。〔解释：比方，帮助想象〕

出生之后，这一切会突然变掉。第三编讲出生的时候，会再回来说这件事。

◆ 四、动，是一种“说话”

很多人把胎动只当成“孩子在里面活着”的信号。这没有错。可是它还有一层意思值得讲出来。

你想想，他每动一下会发生什么？

他的脚蹬出去，碰到子宫壁。子宫壁是软的，有弹性，会顶回来。这一顶，他的脚底就“接到”了一个消息：这里有东西，有点硬，有点弹。

他的手划出去，碰到脐带，或者碰到自己的脸。每一次他的手指就接到一个不同的消息：这是软的，这是滑的，这是热的。

他翻身，身体各个部位被羊水轻轻地压着，又松开。

这一动一碰，一碰一变，就是触觉 SDE 的最小单位：我动，我接到不同，我的下一次动跟着改了。

请你记住这个结构，它在后面很多章节里会反复出现：

动一下，得到一个不同；根据这个不同，再动一下；又得到一个不同。

一来一回，一回一来。

这不是比喻，这是对胎儿在子宫里实际在做的事情的描述。〔中：行为观察有证据，把它读成“SDE 最小单位”是本书的解释〕

◆ 五、为什么说它不是“可有可无的动”

有人也许觉得：胎儿动不动是他自己的事，跟发育没多大关系。

事实恰恰相反。

医学上有一种很少见的情况，叫“胎儿运动不能序列征”。简单讲，就是因为各种原因，胎儿在子宫里几乎不能动，或者动得很少。〔强：医学上已有明确描述〕

这样的胎儿出生后常会发现：关节僵硬，手脚弯曲固定，不能伸直；肺发育不好；下巴小；脸部和骨骼有变形。〔强〕

为什么会这样？因为关节、骨头、肌肉是要在“动”里面长成的。关节长在那儿，需要被活动才能长出正确的形状。肺里的小气囊需要胎儿做呼吸样的运动才会成熟。〔强：动物实验和人类病例均支持〕

也就是说，动不只是动。动是身体在“塑造自己”。

这一点对本书很重要。因为它说明：

在孩子的身体里，没有哪一个部分是凭一份基因的“配方”就自己长好的。每一个部分都要靠“动，得到反馈，再调整”的这个来回才能长对。

这个来回如果断了，身体就会长歪。

这是触觉 SDE 的第一层意义：它不只是“感觉”，它参与了“造身体”。

◆ 六、身体的地图

第二层意义是“身体地图”。

大脑里有一块区域专门管身体的感觉。身体的每个部位在这块区域里都有它对应的位置。手指的位置很大，脚趾的位置也不小，后背的位置则很小。这样的对应图通常被叫作“身体感觉地图”。〔强：神经科学教科书内容〕

这张地图不是出生时画好的，而是慢慢“画”出来的。

孩子在子宫里，嘴碰到手，手碰到脚，脚蹬到墙，身体的各个部位一次又一次地被激活。每激活一次，大脑里对应的位置就多一点点“连线”。

有研究者发现，早产儿的大脑对碰触的反应方式和足月儿不一样；而在新生儿重症监护室里，早期的碰触方式会影响后来的神经发育。〔中：研究很多，但结果并不完全一致，因果关系仍在探讨〕

我们现在还不知道这张地图的每一个细节是怎么画出来的。可是方向很清楚：是“动”和“被碰”在一起画。

这一点也解释了一个很有意思的现象：你闭着眼睛仍然知道你的手在哪里，脚在哪里。你不用看。这种“不看也知道自己的身体在哪”的能力叫本体感觉。它是人最基本的“我在这里”的感觉，来源之一就是在子宫里一点点“摸”出来的。〔解释：本体感觉的发育来源，目前缺少直接的人类证据，这是推论〕

◆ 七、为什么有人早感到胎动，有人晚感到

苏晴 19 周感到胎动，她的同事林姐却说，自己 22 周才感觉到。

这正常吗？正常。

第一次感到胎动的孕周，差异很大。有几个常见的原因。〔强：产科常识〕

一是第几胎。生过孩子的母亲，已经知道那种感觉是什么样的，往往更早认出来。

二是胎盘的位置。如果胎盘长在子宫前壁，夹在胎儿和腹壁之间，胎动会被隔掉一部分，感觉得更晚、更轻。〔强：产科常识〕

三是身体的状况。腹壁比较厚的人，感到胎动可能晚一点。

四是你的注意力。白天忙起来，轻微的动静容易漏掉。晚上安静躺下，就容易觉察。

最初的胎动，很多人形容成“气泡”“蝴蝶扇翅膀”“小鱼摆尾”。

〔强：产科常见的描述〕有人起初会把它当成肠子在蠕动。

怎么区分？有一个小办法：连着几天，在差不多的时候，在同一块位置，感到类似的轻点或翻动，它就可能是胎动。越往后，动作越明显，越容易认。

所以你不必在 18 周的第一天就紧张地“盯着”肚子。到 24 周前后还没有明确的感觉，可以在产检时告诉医生。〔中：各医院的提示孕周略有不同，请遵医嘱〕

◆ 八、自己碰自己，和碰到别人

第三层意义，也是最有意思的一层，是“分出我和不是我”。

你可以想想：胎儿的手碰到自己的脸和碰到子宫壁有什么不同？

碰到自己的脸是一件“双重”的事：手有感觉，脸也有感觉。两边都有信号回来。

碰到子宫壁是一件“单重”的事：手有感觉，可是子宫壁不会“感觉”到手。

这个区别在上一编里我们借胡塞尔讲过：自己摸自己和摸别的东西，感觉不一样。

有一项很著名的研究用超声观察了孕十四周到三十四周的胎儿。研究者发现，胎儿的手去碰自己的脸和去碰子宫壁，动作是不一样的。碰自己的脸，动作更轻、更慢、更准；碰子宫壁则更直接、更有力。〔中：小样本研究，结果有启发性〕

还有一个更让人动容的研究。

研究者观察了双胞胎。他们发现，在孕十四周以后，双胞胎中的一个会去碰另一个。这种“碰”和碰自己的动作也不一样：更慢，更小心，更像是

在“找”什么。〔中：来自意大利研究团队的小样本超声研究，发表在 PLOS ONE, 2010 年，具体细节待核〕

这些动作对孩子来说到底意味着什么？我们不知道。不过有一点可以说：

在他还没见过任何东西的时候，他已经在“分”了：这是我，这是别的。这是软的，这是硬的。这是我的手，这是另一个人的身体。

这种“分”不是学来的，也不是教的。它在“碰”里发生。

◆ 九、怎么看“一推一回”：一个完整的例子

“一推一回”这个说法，用一个例子拆开讲，就清楚了。

设想孕 26 周的一个傍晚。胎儿的脚蹬了一下，碰到子宫壁。

第一步，看谁动了。是胎儿自己发起的动作。

第二步，看他碰到了什么。碰到的是软而有弹性的子宫壁。壁顶了一下，这个“顶”，就是他得到的“不同”。

第三步，看他的下一次动作有没有变。如果下一脚轻一点，或者换了个方向，就说明上一次的“不同”改变了下一步。

这三步合起来，就是一个最小的“一推一回”。

如果这时母亲把手放上去，就多了一层：母亲给了他另一种“不同”。他的下一脚，又可能跟着再变。

注意，这里没有一步需要“懂”。不需要胎儿懂这是什么，也不需要母亲懂胎儿要什么。来回本身，就在发生。〔解释：这是本书对一推一回的读法，每一步在行为上有观察基础，但“下一脚跟着改变”的因果，直接证据有限〕

这个读法，你可以拿去看任何一次胎动。

不过也别每一下都去分析。大部分时间，这些来回是自己在发生的。你只需要偶尔留意。

◆ 十、出生以后还留着的“触觉本事”

子宫里练过的触觉，有一部分在出生时已经能用了。

最有名的两个，是觅食反射和抓握反射。

轻轻碰一下新生儿的脸颊，他会把头转向被碰的那一边，张开嘴找。这叫觅食反射。〔强：新生儿检查的常规项目〕这和前面说的“嘴周围最早有反应”正好接上。

把一根手指放进新生儿的手心，他会一把握住。这叫抓握反射。〔强〕这个动作在胎儿期就已经出现了。〔中：具体出现的孕周待核〕

这些反射不是“学会”的。它们是身体在水里练好，带出来的。〔解释：本书的读法〕

等孩子慢慢长大，这些反射会逐渐消失，换成他自己有意识的动作。

〔强：反射消失的时间表是儿科常识，个体差异大〕

所以你在新生儿病房里，看到护士把一根手指放到他手心，不要觉得这是在“逗”。

这是在检查他的触觉回路是不是通的。也是他在出生后，第一次对你的“回”。

◆ 十一、温度和压力：触觉里另外两样东西

触觉不只是“碰”。温度和压力，也属于触觉这个大家族。

胎儿的体温，一般比母亲的体温高一点点。〔中：测量研究提示高零点几度，数值待核〕热量是靠胎盘和脐带的血流，慢慢送到母亲那里散掉的。

所以母亲的体温，对胎儿很重要。母亲发烧，胎儿的体温也会跟着升高。
〔强：生理学常识〕

孕早期的高热，和一些不良结局有关联，所以孕期发烧，尤其是高热，请及时就医，不要硬扛。〔中：观察研究，请遵医嘱〕

前面说过的热水澡、桑拿，就是为了这个原因要小心。

压力也一样。母亲坐着，腹腔里的压力和站着不同。母亲吃饱了，压力又不同。这些变化很缓慢，像潮水一样，一涨一落。〔解释：本书的比方〕

你可以把它想象成：胎儿每天都泡在一片有温度、有潮汐的水里。他不是“感觉到”这些，他是在这些变化里一边长，一边调整。〔解释：本书的读法〕

◆ 十二、母亲，是他触觉世界里最大的“别人”

那么对胎儿来说，谁是他触觉世界里最重要的“别人”？

是母亲的身体。

我们不妨一样一样数一数母亲给了他什么样的碰触：

第一，是节律。母亲的心跳每分钟六七十到九十次，隔着腹壁和羊水一下一下地震动着他。母亲走路时一步一步地摇。母亲呼吸时一进一出，腹腔微微

地涨落。这些都是有规律的、一刻不停的触觉节律。〔中：母体声音和震动的测量研究较多，对胎儿触觉影响的直接证据有限〕

第二，是姿势变化。母亲坐下、起身、翻身、弯腰，这些动作让胎儿的“位置感”一次次被调整。

第三，是抚摸。母亲把手放在肚子上，轻轻地按，轻轻地拍。前面讲过的研究显示，在孕二十几周以后胎儿对此会有反应。

第四，是压力的变化。母亲吃饭，饥饱；母亲紧张时肌肉收紧；母亲放松时肌肉松弛。这些都会让子宫里的“压力环境”发生变化。

这些“碰”不是母亲专门“做”给胎儿的。它们是母亲过日子的副产品。

这一点请你一定记住。因为后面第六编讲方法的时候你会发现：做子宫里的妈妈，最重要的不是“多做什么”，而是“把日子过得稳”。

稳的日子里，有节律的碰触就自然在那儿了。

◆ 十三、那个会“回”的孩子

再讲一件事，让这一章的意思完整起来。

前面一直在说母亲给胎儿碰触。可是胎儿也在给母亲“碰触”。

苏晴第一次感到胎动是十九周。到了二十六周，她有一天晚上躺在床上，肚子里的孩子用力踢了一下，肚皮上鼓起了一个小包。

她哭笑不得地把江远叫过来：“你快摸，他踢我。”

江远把手放上去，等了几秒钟。

什么也没有。

他有点着急：“怎么不动了？”

苏晴说：“你别急，你把手放着，别动。”

又等了一会儿。

忽然，手掌下面顶起了一个小小的东西。轻轻的，又很实在。

江远愣住了。他保持着那个姿势，一动不动，足足过了一分钟。然后他说了一句：“我好像被他打了个招呼。”

这个场景在很多家庭里都会发生。

本书要在这里指出它的意思：

孩子踢了母亲，母亲被踢到，有了反应：笑，或者皱眉，或者把手放上去，或者换个姿势。母亲的这个回应又会传回去，改变孩子下一次遇到的不同：手放上去，压力变了；换姿势，空间变了；母亲出声，声音变了。

孩子再踢，再得到一个新的不同。

这样一来，孩子不是只被“给”碰触。他也在“造”碰触。

这就叫来回。〔解释：本书的理论读法。胎动引发母亲行为改变，有观察基础，但母亲的回应如何反过来影响胎儿，直接证据不多〕

这一点会在第7章再展开讲。

◆ 十四、如果孩子提前来了

有一些孩子，不等足月就出生了。

这些孩子本来还应该在水里漂几周。他们被放进保温箱，周围是仪器的声音，身上贴着监护的线。

这时候，触觉的“来回”可以在子宫外接上。最有名的办法叫“袋鼠式护理”：让婴儿只穿尿布，直接趴在母亲或父亲的胸口，皮肤贴着皮肤。〔强：世界卫生组织等机构推荐，对病情稳定的早产儿和低出生体重儿有明确好处〕

做的时候，要在医护人员的指导下进行。

研究发现，袋鼠式护理有助于体温稳定、哺乳和降低严重感染的风险。〔强：多项研究和综述一致〕它对孩子长远发展的影响，研究结果不尽一致。〔中〕

本书在这里想说的是：如果你的孩子提前来了，不是你的错。你的手、你的胸口，仍然是他最熟悉的“来回”。

◆ 十五、孕 30 周，那一晚的睡姿

苏晴孕 30 周以后，睡觉成了一件难事。

她平躺着，肚子里的孩子就会踢得特别用力，还会顶出一个小包。她翻向左边，孩子又安静下来。

一天夜里，她被踢醒了，推了推旁边的江远：“他在抗议。”

江远迷迷糊糊地说：“抗议什么？”

“抗议我躺平了。”

江远一下清醒了，坐起来，帮她把枕头垫在腰后，又拿了一个抱枕给她夹在两腿中间。

“医生说，孕晚期最好侧着睡。”他说。

苏晴换成左侧卧。过了几分钟，孩子的动作慢慢柔下来。

这个场景里有一个常见的提醒。孕晚期，很多指南建议侧卧睡。平躺时增大的子宫可能压到大血管，有些人会觉得头晕、气短。〔中：多项观察研究，建议各国略有不同，请遵医嘱〕

不必每晚都严格守着一个姿势。睡着睡着翻到平躺，醒了再换回来，就可以。

孩子的动，有时就是一个很具体的“回”：他在告诉你，这个姿势让他不舒服。你的回，就是翻个身。

这样一来一回，不需要任何技术。

◆ 十六、常见的几个问题

问：已经 20 周了，还没感到胎动，要紧吗？

不一定。第一次感到胎动的孕周差异很大，前壁胎盘的人会更晚。〔强〕不过 20 周以后，如果产检的超声一切正常，只是自己感觉不到，医生通常会让你继续观察。你可以在下次产检时把这个情况告诉医生。〔中：各医院处理略有不同，请遵医嘱〕

问：胎动有时候很猛，甚至有点疼，正常吗？

偶尔的一两下用力，常见。孩子的脚顶到肋骨、膀胱或者宫颈附近，母亲就会觉得疼。〔强：产科常见的主诉〕可以换个姿势，或者轻轻把手放上去。如果疼痛持续，伴随出血或者规律的腹痛，要及时就医。〔强〕

问：摸肚子，会不会引起脐带绕颈？

目前没有证据显示，抚摸肚子会造成脐带绕颈。〔中：没有找到支持这种说法的证据〕脐带绕颈本身相当常见，很多孩子绕着脐带出生，大部分没有问题。〔强：产科常识〕产检里医生会关注，你不用因为这个，不敢碰肚子。

问：孩子老在动，是不是在“锻炼”？

胎儿的动，对关节、肌肉和肺的发育有用，这一点前面讲过。〔强〕不过你不用去“督促”他多动。他自己有节律。你要留意的，是他平时的节律有没有突然变化。〔强：产科常识，具体见第 20 章〕

问：肚子一阵一阵变硬，是宫缩吗？

孕中后期，很多人会感到肚子偶尔变硬，几十秒到一两分钟就缓解，没有规律，不太疼。这常是“假性宫缩”。〔强：产科常识〕如果变硬越来越频繁、有规律、越来越疼，或者伴随出血、羊水流出，请马上去医院。〔强〕

问：爸爸摸不到胎动，是不是孩子不认他？

不是。胎动要到孕 24 到 28 周以后，外面才容易摸到，位置、胎盘、孩子是不是醒着，都有关系。〔中：个体差异大〕孩子认不认得，目前没有证据。可是爸爸每天的那一会儿，对他自己是有用的：他慢慢从“旁观者”变成“参与者”。〔解释：本书的读法〕

◆ 十七、几件和触碰有关的安全小事

问：坐车要系安全带吗？会不会压到孩子？

要系。系对了不会压到孩子。肩带从肩膀斜过胸口，中间留在两乳之间。腰带放在肚子下面，贴着髋骨，不要压在肚子上。〔强：交通安全和产科的通行建议〕

不系安全带，一旦急刹或者碰撞，对母亲和孩子都更危险。〔强〕

问：肚子被撞了一下，要去医院吗？

轻轻碰一下，多数没事。可是如果撞得比较重，或者出现腹痛、出血、羊水流出、胎动明显变化，请马上去医院。〔强：产科常见的建议〕

拿不准的时候，打电话问医生，比自己忍着更稳妥。

◆ 十八、孕期按摩和水疗，可以吗

问：想去做孕妇按摩，可以吗？

一般来说，由受过孕妇按摩训练的人做背部、肩颈的轻柔放松，多数是安全的。〔中：多为经验性建议，证据有限，请先问医生〕

不要按摩腹部。有些穴位和精油，孕期要避免，请提前告诉按摩师你怀孕了。〔中〕

如果医生告知你有前置胎盘、先兆流产或先兆早产，请先不要去。〔强〕

问：泡脚、泡澡、温泉，可以吗？

温水泡脚、淋浴，一般没有问题。水温不要太烫，时间不要太长。温泉和桑拿，孕期建议避开，因为体温升高过多有风险。〔中：与第 19 章的建议一致，请遵医嘱〕

◆ 十九、放回日子里

苏晴和江远后来养成了一个小习惯。

每天晚上睡觉前，十分钟。苏晴靠着床头，江远坐在床边。他把手放在她肚子上，不说话，只是放着。

有时候孩子会动，有时候不动。不动也没关系。

有一次苏晴问他：“你觉得他知道是你吗？”

江远想了想，说：“我不知道。可是我觉得他知道有一个东西是每天这个时候来的。”

这句话说得很准。

目前没有证据能证明胎儿“认得”父亲的手。可是有一件事是可以说的：每天同一个时间，同一个动作，同一种轻重，对胎儿来说就是一个有规律的“不同”。有规律就容易被接成路。

这就是触觉 SDE 的一个最小的实践。它不需要任何设备，不需要买什么，不需要学什么。

只要“同一个时间，同一只手，放着”。

这一点详细的做法放在第六编。这里只提一句，让你知道理论是怎么落到日子里去的。

带走的话

孩子在子宫里不是只在“长”。他在“动”，在“碰”，在“被碰”，在“回”。他的身体是在一推一回里一点一点画出来的。这一推一回就是触觉 SDE。它先于眼睛，先于话语，先于一切。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
初产妈妈约 18—20 周第一次感到胎动	〔强〕	个体差异大，经产妇往往更早
胎儿运动不能，会导致关节挛缩、肺发育不良	〔强〕	临床与动物实验均支持
大脑有身体感觉地图	〔强〕	神经科学基础知识
地图在发育中靠“动与被碰”画成	〔中〕	动物证据较多，人类胎儿直接证据有限
胎儿碰自己和碰子宫壁动作不同	〔中〕	小样本超声研究，具体文献待核
双胞胎之间的“碰”动作更谨慎	〔中〕	小样本研究，具体文献待核
孕 21 周以后胎儿对母亲抚摸腹部有反应	〔中〕	样本不大
母亲心跳、走路给胎儿有节律的触觉	〔中〕	测量有，对发育影响的直接证据有限
本体感觉来自子宫内的“摸”出来	〔解释〕	推论，缺直接证据
胎动与母亲回应形成“来回”	〔解释〕	本书的理论读法
触觉是最早发育的感觉，从口周开始，先脸后手再到躯干四肢	〔强〕	大方向共识；具体周数多来自早年观察，待核
孕中期超声常见胎儿吸吮手指	〔强〕	产科超声常见所见
羊水温度稳定、有浮力、能缓冲冲击	〔强〕	生理学常识
胎儿吞咽羊水并排尿入羊水	〔强〕	产科常识
子宫内的触觉世界“温暖、有浮力、有阻力”	〔解释〕	本书的比方
首次感到胎动的孕周受胎次、胎盘位置、体型影响，前壁胎盘者更晚	〔强〕	产科常识
“气泡”“蝴蝶扇翅”是常见的胎动描述	〔强〕	产科常见描述

说法	证据级别	说明
24 周前后仍无明确胎动，可在产检时告知医生	〔中〕	各医院提示孕周不同，请遵医嘱
“一推一回”的三步读法及其因果	〔解释〕	行为有观察基础，因果直接证据有限
袋鼠式护理对稳定的早产儿有明确好处	〔强〕	须在医护指导下进行
袋鼠式护理对孩子长远发展的影响	〔中〕	结果不尽一致
孕晚期建议侧卧睡	〔中〕	观察研究，各国建议略有不同，请遵医嘱
抚摸肚子会引起脐带绕颈	〔中〕	未见证据支持这一说法
脐带绕颈相当常见，多数无碍	〔强〕	产科常识
假性宫缩无规律、不太疼；规律加重需就医	〔强〕	产科常识
胎动于孕 24 到 28 周后体外较易触及	〔中〕	个体差异大
觅食反射、抓握反射是新生儿的常规检查项	〔强〕	儿科常识
抓握反射在胎儿期已出现	〔中〕	具体孕周待核
新生儿的反射随成长逐渐消失，换成自主动作	〔强〕	时间表因人而异
触觉反射是在水里练好后带出来的	〔解释〕	本书的读法
孕期系安全带：肩带过胸口，腰带在肚子下方贴髋骨	〔强〕	通行建议
腹部受较重撞击或伴腹痛、出血、胎动变化需就医	〔强〕	请遵医嘱
胎儿体温略高于母亲	〔中〕	数值待核
母亲发烧时胎儿体温随之升高	〔强〕	生理学常识
孕早期高热与不良结局有关联	〔中〕	观察研究，发烧请及时就医
孕妇按摩，由受过训练者做背肩放松多数安全	〔中〕	证据有限，请先问医生

说法	证据级别	说明
孕期避免按摩腹部，避开部分穴位和精油	〔中〕	预防性建议
前置胎盘、先兆流产、先兆早产者不宜按摩	〔强〕	请遵医嘱
温泉、桑拿孕期建议避开	〔中〕	与第 19 章建议一致

个体情况，比如胎动减少、腹痛、出血等，请及时就医，遵医嘱。

第 6 章

听觉 SDE：在水里学会“话是有调子的”

◆ 一、地铁里的哼唱

苏晴怀孕二十八周的时候，每天坐地铁上班，四十分钟。

地铁里很吵。她戴着耳机，耳机里放的是很轻的纯音乐。有一天，音乐里的一段旋律让她不自觉地跟着哼了起来。她哼得很小声，嘴唇几乎没动。

肚子里的孩子轻轻动了一下。

她停下来。孩子也停了。她又哼，孩子又动。

她低头看了看周围，没有人注意她。她在地铁的角落里，把手放在肚子上，笑了一下。

晚上回家，她把这件事讲给江远。江远说：“你是不是想多了？”

苏晴说：“可能。”

这件事后来她自己也不太确定。胎动本来就是一阵一阵的，也许只是巧合。

可是这一章要讲的恰好是一件不太像巧合的事：在子宫里，孩子的耳朵听见了什么，学会了什么。

◆ 二、先回顾一下，再往前走

第 3 章已经讲过胎儿听觉的基本事实。为了让这一章接得上，先用几句话回顾一下：

孕十九周前后，胎儿开始对声音有反应。到二十四到二十八周，反应稳定下来。〔中〕

子宫里的声音世界像隔着一堵墙听隔壁的聚会：低音能传进来，高音被挡掉大半。所以胎儿听到最清楚的是节奏、起伏、轻重，不是一个个清晰的字。
〔中〕

母亲的声音最特别。它除了从空气里传进来，还会通过母亲自己的骨头和身体直接传到子宫。所以母亲的声音对胎儿来说是最响的，也是最稳定的。
〔中：解释为主，直接测量有限〕

这一章我们往前走一步，不再问“能不能听见”，而是问：听见了之后发生了什么？

◆ 三、声音是怎么进到子宫里的

要想知道胎儿听到了什么，先看声音要走哪几站。

外面的声音，要先穿过母亲的腹壁和子宫壁，再穿过羊水，才到胎儿的耳朵。每过一站，都会被削弱一些。〔强：声学常识〕

高音最容易被挡掉。低音，比如男人的说话声、鼓点、车的轰鸣，最容易穿过来。〔中：测量研究支持，数值因研究而异〕

所以胎儿听到的外界声音，像隔着一层厚棉被在听。内容模糊，调子还在。

还有一条路，是母亲自己的声音。母亲说话时，声带的振动会沿着骨头和身体直接传到子宫。〔中：解释为主，直接测量有限〕这条路几乎没有衰减。所以母亲的声音，在胎儿耳朵里最响。

子宫里也不是安静的。母亲的心跳，血流的“呼呼”声，肠子的咕噜声，一直在响。〔强：产科常识，用多普勒听胎心时就能听到这类背景音〕

对胎儿来说，这片背景音就像我们住在大马路边的人听惯了车声。它是“底噪”，母亲的说话声、笑声、咳嗽声，都是在底噪上起伏的“前景”。〔解释：比方〕

这样看，胎儿学到的第一件事，也许是在底噪里，分出“前景”。

这是本书的读法，没有直接的实验可以证明。〔解释〕

◆ 四、耳朵是怎么长出来的

耳朵是一件分几层长的东西。

内耳里有一个像蜗牛壳的结构，叫耳蜗。声音的振动在这里被变成神经的信号。耳蜗的基本结构，在孕中期就已经长得差不多。〔强：胚胎学和耳科学基础内容〕

信号再通过听神经，送到脑干和大脑的听觉区域。这一段的连线，一直要发育到出生之后。〔强：听觉通路在婴儿期继续成熟〕

所以孕 24 到 28 周，胎儿“有反应”，不等于他的听觉已经成熟。这是一台刚开机、还在升级的机器。〔中：反应出现的孕周，各研究略有不同〕

有两件事，值得每一对父母知道。

第一，几乎所有医院都会给新生儿做听力筛查，通常在出生后几天内做。〔强：多国已普遍开展〕先天性听力问题并不算特别罕见，早发现，早帮助，对孩子的语言发展很重要。〔中〕

第二，孕期的某些感染，比如巨细胞病毒，是儿童先天性听力损失的原因之一。〔强：医学共识〕勤洗手，尤其是接触幼儿的唾液和尿布之后，是常见的预防建议。〔中：请遵医嘱〕

请注意，这些不是要你紧张，也不是要你自责。多数孩子的听力是好的，筛查只是多一层保险。

◆ 五、第一件事：学会“这个不用管”

先讲一件听起来不起眼、其实很重要的事，叫习惯化。

做法是这样的：研究者在孕妇的肚皮上放一个小的振动发声器，发出一声短促的响声。胎儿会被吓到，身体猛地一动。过几秒钟再来一声，胎儿又动一下，不过动得小了一点。再来，再来，到了第四五声，胎儿几乎不再动了。

〔强：这个现象在多个研究中重复，孕 30 周以后更稳定〕

这就是习惯化：第一次听到，觉得是个“不同”，要紧张。多听几次，发现没什么，就把它“忽略”了。

接着研究者做第二步：换一种声音，或者隔一段时间再放回原来的声音。胎儿又动了。这说明他不是累了，而是“认出”了那是新的声音，或者“记得”那是旧的声音。〔中〕

这听起来简单，其实是 SDE 里一件基本的事：分出“新的不同”和“旧的不同”。

新的值得注意。旧的可以放过。

这就是“选择”的开始。一个孩子如果什么声音都要紧张，他会累死。他需要学会“这个不用管”。

而学会“不用管”这件事，是在子宫里用最简单的办法开始的。

◆ 六、“有反应”“认得”“听懂”，是三级台阶

读到胎儿听觉的研究，最容易犯的一个错，是把三件事混成一件。

第一级，“有反应”。胎儿被声音惊了一下，或者心率变了。这只说明声音传到了，神经起了反应。

第二级，“认得”。胎儿对旧声音反应小，对新声音反应大，或者出生后偏爱孕期听过的声音。这说明他记住了某些特征。

第三级，“听懂”。他知道词是什么意思，知道你在说什么。

本章讲的所有研究，最多走到第二级。第三级，目前没有任何证据。

〔强：研究结论的通行读法〕

你可以把它想成隔着墙听隔壁的聚会。你能听出里面有人在笑，能听出不是你认识的人在说话，可是你听不清说了什么。

所以每次看到“胎儿听得懂你的话”这类标题，请心里划掉。胎儿能做的，是熟悉你的调子。〔解释：本书的读法〕

这样看，你不必担心“我说的话孩子听不懂，是不是白说了”。他本来就不是靠懂在学。

◆ 七、习惯化：你自己也经历过

习惯化听起来像实验室里的词。其实你每天都在经历它。

住进新家的第一晚，冰箱的嗡嗡声，你听得特别清楚。过了几天，你就不再注意它了。

有一天，冰箱停了。你反而会突然醒过来，觉得屋里哪里不对。

这是习惯化的两面。重复的东西，被“放过”。变化的东西，被“抓住”。〔解释：用日常经验来类比〕

胎儿在子宫里做的，是同样的事。重复的底噪，他放过。突然的新声音，他抓住。

这个本事看起来小，可是少了它，他每一下心跳、每一次胃的咕噜声，都会让他紧张。

所以习惯化不是“迟钝”，是一种很聪明的省力办法。〔解释：本书的读法〕

你在后面的章节会看到，孩子出生以后学的第一批东西，很多还是在练同一个本事：什么该放过，什么该盯住。

◆ 八、第二件事：记住了一些“调子”

比习惯化更进一步的是真正的记忆。

最有名的一项研究是 1986 年由德卡斯珀和斯宾塞做的。他们让怀孕最后六周的母亲每天大声朗读同一个童话故事，大约两遍。那是苏斯博士的《帽子上的猫》。到孩子出生后，研究者给新生儿一个特制的奶嘴，让他们通过吸奶嘴的快慢来选择听“妈妈在孕期读过的那个故事”，还是“另一个没读过的新故事”。〔核：1986 年，DeCasper & Spence，见第 3 章〕

结果是，大多数新生儿选了听“孕期读过的那个”。〔强：经典研究，后来有重复，样本不大〕

还有一项更晚近的研究是在芬兰做的。研究者让孕妇在孕后期每天听一个有几个“假词”的录音。孩子出生后用脑电图去测，发现这些孩子对那些“假词”的变化反应更明显。〔中：2013 年，Partanen 等，小样本，细节待核〕

再说说语言的“调子”。

一项发表在 2009 年的研究比较了德国和法国新生儿的哭声。研究者发现，德国新生儿哭起来音调是从高往低走的，法国新生儿则是从低往高走的。这两种走向恰好和各自母语里说话的“调子”相似。〔中：Mampe 等，2009，样本不大，不同研究者有不同的解读〕

2013 年，另一个研究团队给出生才几个小时的婴儿放了母语和外语的元音，发现婴儿对外语的元音注意的时间更长。他们的解释是：孩子在子宫里已经听过母语的声音，对它已经“熟”了，所以外语更“新”。〔中：Moon 等，2013，样本不大，结论有争议〕

这几个研究加在一起能说明一件事：

孩子在出生之前没有学会“说话”，也没有学会“词”。他学会的是“调子”：高低、快慢、停顿、起伏。他对母亲的话是“熟悉”，而不是“听懂”。

这一点很重要，下面解释。

◆ 九、为什么“调子”那么重要

你可能会觉得“调子”是个次要的东西，真正重要的是“词”和“意思”。

事实正相反。

我们回想一下，一个人说话，最先传给对方的不是内容，是“腔调”。比如一句话“你来了”，高高兴兴地说和冷冰冰地说，意思完全不同。语言学家把这种东西叫“韵律”。

对婴儿来说，韵律是他最先学会读的东西。

出生之后，母亲对婴儿说话会不自觉地调整：声音变高，节奏变慢，起伏变大，常常重复。这种说话的方式叫“婴儿导向语”，俗称“妈妈语”。

〔强：跨语言的多个研究一致〕

婴儿偏爱这种说话方式。研究发现，给新生儿选择，他们更愿意听“妈妈语”，而不是成年人之间的说话。〔强〕

这中间有一条线索：孩子在子宫里听惯了母亲声音的起伏；出生后，母亲用起伏更大的声音跟他说话，两端对上了。

这就是听觉 SDE 的结构：

在子宫里，孩子练的是“分出调子的不同”。出生以后，母亲的声音给他提供了更多可分的“不同”。他一分就有回应；母亲一回应就又给了新的“不同”。

所以听觉的 SDE 不是单向的“听”，而是“听一分一回一再听”的圈。

◆ 十、胎儿也在“回”

说“回”是有根据的。

第 3 章提到过，在孕晚期，母亲出声说话，胎儿的心率会有变化，这种变化母亲的声音比陌生人的声音更明显。〔中：Kisilevsky 等，2003，样本较小〕

更有意思的是，这种“回”是双向的：母亲和胎儿的心率会在某些时刻出现同步。

有一项 2020 年前后发表的研究，用测量设备同时记录了孕妇和胎儿的心跳。研究者发现，母亲和胎儿的心率会出现协调的变化，特别是在母亲安静、放松、慢慢呼吸的时候。〔中：小样本，结论还需要重复验证〕

这个发现不能说明“母子心灵相通”。它只是提示：在身体的层面，母亲和胎儿是彼此“听得到”的。

这样看，苏晴在地铁里哼唱，孩子动了一下，也许不是巧合，也许是。我们没有办法知道。

可是可以说的是：母亲发出的声音不是对一个“空”的肚子说话。是在和一个会听、会记、会回应的人说话。

◆ 十一、不用买什么，不用学什么

讲到这儿，很多读者会想：那我该给孩子听什么？莫扎特，还是古诗？

这是一个商业上很热闹的话题，本书必须说清楚。

第 3 章讲过，所谓“莫扎特效应”是 1993 年一项关于大学生短时空间推理能力的小研究，后来被媒体放大成“听莫扎特能让孩子变聪明”。多项后续研究和综述发现，这个效应很小，甚至没有。〔强：已被多篇后续研究检验〕

对胎儿则更缺乏直接证据。没有哪一项可靠的研究证明在孕期给胎儿放某种音乐，孩子的智商就会提高。

而且有一点要特别提醒：不要把音箱、耳机直接贴在肚皮上放。肚皮上的声音可能比你想的要响。一些研究测量了贴近腹部放音时子宫内的声压，发现

可能达到较高的水平。出于谨慎，目前的建议是：不要把发声设备直接放到肚皮上。〔中：测量研究有限，各国建议略有差异，请遵医嘱〕

那么该怎么办？

最稳妥的办法是：过你的日子，说你的话。

你做饭的时候念叨两句。你走路的时候随口哼哼。你跟丈夫聊天，笑起来。你给自己读一本书，哪怕不是给孩子读的。

这些就足够了。

因为胎儿学的不是内容。他学的是“有一个人在不停地说话；这个人的声音是我最熟悉的”。

不必专门“胎教”。过日子就是最好的胎教。这句话本书后面还会说。

◆ 十二、噪声：一个需要认真对待的事

有一件事是需要认真的：噪声。

长期处在很吵的环境里，比如工厂车间、施工现场，对孕妇和胎儿可能有不利影响。一些职业噪声的研究发现，孕期长时间暴露在高噪声下，和早产、低出生体重有一定关联；对孩子后来的听力也可能有影响。〔中：研究结果不完全一致，因果关系仍在研究〕

如果你的工作是这样的，建议和医生、单位商量，调整岗位，或者做好防护。

偶尔的吵，比如演唱会，一次一两个小时，有可能没有明显影响。不过音量太大的现场，建议孕期尽量避开，或者站在远离音箱的位置。〔中：缺乏直接证据，出于预防性建议〕

这不是在吓唬你。它只是一个“预防性”的小提醒。

◆ 十三、出生以后：为什么一听妈妈的声音就安静

产房里有一个常见的场景。孩子刚出生，又哭又闹。母亲说了一句话，他忽然安静下来，转过头找声音。

这不是电影里的桥段。多项研究发现，新生儿对母亲的声音比对陌生女性的声音反应更明显，也更愿意听。〔强：多项研究一致〕

这和前面讲的子宫里的经历对得上：他在水里听了好几个月这个声音，出生后一听，是“熟的”。

熟悉的东西，让人安心。这个道理，对新生儿和对成年人都成立。〔解释：本书的读法〕

那爸爸的声音呢？有一些研究发现，新生儿对父亲的声音也有反应，不过结果不如对母亲的声音稳定。〔中：研究少，样本小，待核〕

所以爸爸不用灰心。孩子对爸爸的声音熟悉得慢一点，可是熟悉是可以长出来的。出生以后，每天抱着他说话，就是在长。

◆ 十四、婚宴上的那三个小时

苏晴孕 30 周的时候，要去参加一个同事的婚宴。

场地很大，舞台上架着两排音箱，有乐队，有主持人。苏晴一进门就皱了眉。

江远低声问：“要不要不去？”

苏晴想了想：“礼金已经送了，去露个脸，我们坐远一点。”

他们选了最后一桌，离音箱最远，旁边是一扇通向走廊的门。开场一小时，音乐太响，苏晴就借口去走廊透气。

她站在走廊里，手放在肚子上。孩子动了一下。她没有多想，对着肚子轻轻说：“吵吧？我们待一会儿就走。”

婚宴吃到一半，两人就回家了。

这个场景里，苏晴做的几件事，都很实在：

选了离音箱最远的位置。需要的时候离开。没有因为担心而全程紧张。

前面讲过，偶尔一两个小时的吵，多数没有明显影响。不过音量太大的场合，建议站远一点，不要待太久。〔中：预防性建议，直接证据有限〕

不要因为偶尔去了一次，就怪自己。这件事不需要内疚。

◆ 十五、婆婆的方言

江远的妈妈从老家来住了一个月。她说话带着很浓的方言。

有一天，苏晴听到婆婆在客厅里，对着她的肚子说话。说的是方言，一个字苏晴也没听懂。

婆婆说完，抬头看见苏晴，有点不好意思：“我说的你们城里人听不懂，是不是不好？”

苏晴愣了一下，赶紧说：“不是，您说，他爱听。”

晚上她问江远：“我们是不是应该让妈改说普通话？”

江远想了想：“你觉得她用普通话说话，会自然吗？”

苏晴摇头。

“那就别改。”

这一段里，江远说对了。前面讲过，婴儿偏好的是母语的调子。〔中：Moon 等 2013 年的研究，有争议，见前文〕调子是长在一个人的日常说话里的。一个人换一种不自然的话，说出来的调子也会变得僵。

不必为了“标准”，改掉你最自然的话。

方言、外语、两种语言混着说，都可以。孩子要熟悉的，是“有一个人，用她最自然的声音，在跟我说话”。〔解释：本书的读法〕

◆ 十六、出生以后，听觉往哪里长

这一章讲的，是出生之前的故事。出生以后，听觉还要接着长。

孩子出生后几个月，会学着判断声音从哪里来，听到有人叫他，会转过头去找。〔强：婴儿发育里程碑，月龄因人而异〕

到了六个月前后，很多孩子开始咿咿呀呀地“说话”，其实是在练嘴型和调子。〔强：婴儿发育里程碑〕

多项研究发现，在六到十二个月之间，婴儿对自己母语里的声音越来越敏感，对母语里不用来区分意思的声音差别，则越来越不敏感。〔强：多项研究一致〕

这个变化，可以看成是孩子的耳朵在“选边”。它选的是他每天听到最多的那种声音。

你会发现，这和本章前面讲的是同一条线：在子宫里熟悉调子，出生后熟悉音节，再往后熟悉词和意思。〔解释：本书的读法〕

每一步，都是在上一步的基础上，有来有往地长出来的。

所以你在孕期做的事，不是在“抢跑”，也不需要“提前教”。只是让这条线，从一个稳的起点出发。

◆ 十七、三件不加负担的小事

如果你想把听觉这件事做进日子里，又不想多出一项任务，可以试试这三件。

第一件，出声读你自己想读的东西。小说、新闻、菜谱都行。每次几分钟，用平常的声音。

第二件，在路上哼歌。走路的时候，洗碗的时候，随口哼两句。不必成调。

第三件，叫他的小名。每天几次，在你想起来的时候。

这三件事有一个共同点：它们都不是为“孩子”专门准备的。它们本来就是你的日子，只是你知道孩子在听。

至于不想做的时候，就不做。孩子听的是你一直以来的声音，不是你某天有没有“完成任务”。〔解释：本书的读法〕

◆ 十八、他睡着的时候，听得到吗

胎儿一天里大部分时间在睡。〔中：胎儿有睡眠和活动周期，具体比例待核，见第 19 章〕

睡着的时候，听觉并不会全关。较大的声音，也可能把他惊醒。〔中：研究提示声音刺激可引起胎动和心率变化，样本不大〕

这件事有两个实际的提醒。

第一，不用特意在他醒着的时候才说话。你过自己的日子，他醒时听到，睡时也可能偶尔听到。

第二，不用去“叫醒”他。想让他动一动，说话、哼歌，就够了。不要摇晃肚子，也不要仪器。〔中：与第 19 章的安全建议一致〕

他睡他的，你过你的。这就是两个人共处的方式。

◆ 十九、常见的几个问题

问：孕期到底放什么音乐好？

没有哪一种音乐被证明能提高孩子的智商。〔强：见前文莫扎特效应部分〕你喜欢的、让你放松的，就是好音乐。音量适中，放在房间里，不要贴着肚皮。

问：我嗓门大，会不会吓到孩子？

平常的说话音量，不会。声音传到子宫时已经被削弱了很多。〔中：声学测量支持，数值因情况而异〕偶尔大笑、大叫一声，孩子可能会动一下，这是正常的反应，不是伤害。如果经常处在吵架大喊的环境里，要处理的是环境本身，不只是嗓门。〔解释：本书的读法〕

问：我们家说两种语言，孩子会混吗？

多项研究发现，在双语环境里长大的婴儿，很早就能分出两种语言的不同。〔中：多项研究，具体年龄因研究而异〕你不用刻意把两种话分开，也不用选一种。各说各的自然话，就好。

问：我戴耳机听音乐，会不会伤到孩子？

耳机的声音是进你的耳朵，不是直接进肚子。孩子听到的，是你身体传过去的、被削弱了的部分。〔中：声学上合理，直接测量有限〕不过音量开太大，对你自己的听力不好。以旁边的人能和你正常说话为宜。〔中：通行的护耳建议〕

问：孩子对大的响声反应很大，是不是听力有问题？

胎儿被突然的巨响惊到，动一下，很常见。〔中〕这不能说明他的听力有问题。真正判断听力的，是出生后的新生儿听力筛查。〔强〕

问：我自己听力不好，或者是聋人，还能做“听觉 SDE”吗？

能。声音只是“来回”的一种方式。母亲的心跳、触碰、说话时身体的振动，都是孩子能感到的。〔解释：本书的读法〕

出生以后，聋人父母的孩子，在手语环境里学语言，进度和听人家庭的孩子学口语相近。〔中：多项研究，具体因孩子的听力和环境而异〕多数聋人父母的孩子，听力是正常的。〔中〕关键仍然是：有一个人，稳定地、有来有往地和他交流。

◆ 二十、放回日子里

苏晴那天回到家，没有再买什么胎教音乐。

她只是每天晚上洗完澡以后靠着床头，随口给肚子里的孩子讲一天的事。

“今天地铁里又挤。今天同事请我们吃了一个特别咸的蛋糕。今天你爸爸给我煮了面，里面放了两个荷包蛋。”

她讲得很随意，像在讲给一个听得懂的人。

有时候她讲着讲着自己就笑了。

江远在旁边，一开始觉得有点好笑。后来他也加入了。他说：“今天我写了一个特别烦的 bug，写了一整天。”

苏晴说：“你对它讲，它不会解 bug。”

江远说：“没关系，它会听我的腔调。”

这句话是半开玩笑，可是意思没有错：孩子听的是腔调。

腔调里有什么？有一个人在平静地、不着急地和他说话。

这就是听觉 SDE 的起点。

带走的话

子宫里的孩子听不懂话，可是他会记“调子”。他学会的第一件事，是母亲的声音，是一个可以信任的、一直在的声音。不必买什么，不必学什么。过日子，说话，就够了。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
胎儿声音习惯化（重复刺激后反应减弱，换声音后恢复）	〔强〕	多个研究重复，孕 30 周后更稳定

说法	证据级别	说明
孕晚期反复听同一个故事，新生儿偏好该故事	〔强〕	DeCasper & Spence, 1986, 样本不大
胎儿期听过的假词，新生儿脑电有区别反应	〔中〕	Partanen 等, 2013, 小样本, 细节待核
新生儿哭声旋律带有母语特征	〔中〕	Mampe 等, 2009, 有不同解读
新生儿对母语元音与外语元音注意不同	〔中〕	Moon 等, 2013, 有争议
婴儿偏爱“妈妈语”	〔强〕	多语言研究一致
胎儿对母亲声音心率反应更明显	〔中〕	Kisilevsky 等, 2003, 样本较小
母胎心率可出现协调变化	〔中〕	小样本, 尚需重复, 具体文献待核
孕期放莫扎特提高孩子智商	〔证据弱〕	无可靠证据, 本书不推荐
音箱贴肚皮可能声压过高	〔中〕	预防性建议, 请遵医嘱
长期高噪声职业暴露与不良结局相关	〔中〕	结果不完全一致
低频声更容易穿过腹壁和羊水, 高频被削弱	〔中〕	测量研究支持, 数值因研究而异
母亲自身的声音可经骨和身体直接传入, 最响	〔中〕	解释为主, 直接测量有限
子宫内有母亲心跳、血流声等背景音	〔强〕	产科常识
胎儿在底噪中分出“前景”	〔解释〕	本书的读法, 无直接实验
耳蜗基本结构孕中期已成形, 听觉通路出生后继续成熟	〔强〕	胚胎学与耳科学基础内容
孕 24 到 28 周的反应不等于听觉已成熟	〔中〕	反应出现孕周因研究略异
新生儿普遍做听力筛查, 先天听力问题并非特别罕见	〔强〕	多国已普遍开展; “并非罕见”较笼统

说法	证据级别	说明
孕期巨细胞病毒感染是先天听力损失原因之一，勤洗手是常见预防建议	〔强〕	预防建议请遵医嘱
胎儿听觉研究最多证明“有反应”“认得”，没有证明“听懂”	〔强〕	研究结论的通行读法
新生儿对母亲声音反应强于陌生女声	〔强〕	多项研究一致
新生儿对父亲声音有反应，但不如对母亲稳定	〔中〕	研究少、样本小，待核
偶尔一两小时的嘈杂场合多数无明显影响，大音量场合宜远离音箱	〔中〕	预防性建议，直接证据有限
平常说话音量不会吓到胎儿	〔中〕	声学测量支持，因情况而异
双语环境的婴儿很早就能分出两种语言	〔中〕	多项研究，具体年龄因研究而异
突然巨响使胎儿动一下很常见，不说明听力问题	〔中〕	听力以出生后筛查为准
聋人父母的孩子在手语环境中学语言的进度与听人家庭学口语相近	〔中〕	因孩子听力和环境而异
多数聋人父母的孩子听力正常	〔中〕	流行病学常见说法，待核
婴儿能判断声音来源、约六个月咿呀学语	〔强〕	发育里程碑，月龄因人而异
六到十二个月婴儿对母语声音更敏感，对母语不用的差别渐不敏感	〔强〕	多项研究一致
孕期的声音经历是后续语言发展的稳定起点	〔解释〕	本书的读法，不是“提前教”
习惯化类比日常经验（冰箱声）	〔解释〕	类比，不是实验证据
胎儿有睡眠和活动周期，睡眠中较大声响可引起反应	〔中〕	样本不大，具体比例待核
不要摇晃肚子或用仪器“叫醒”胎儿	〔中〕	预防性建议，与第 19 章一致
平常说话音量下传到胎儿的声音已被削弱，耳机声音不直接进入子宫	〔中〕	声学上合理，直接测量有限
耳机音量以旁人能正常交谈为宜	〔中〕	通行的护耳建议

个体情况，比如孕期听力问题、工作环境噪声，请遵医嘱。

第 7 章

胎儿不是被动的：他在改变妈妈，妈妈也在被稳稳地托住

◆ 一、一碗面和三天的吐

苏晴孕吐最厉害的那几周是怀孕第八到十一周。

她吐得有多厉害？早上起来，刷牙吐一次。闻到油烟味，吐一次。喝水有时也吐。江远下班带回来的饭，她闻了一口，转身就冲进卫生间。

有一天，她吐完，靠在卫生间的墙上，对江远说：“我是不是很没用。”

江远说：“你在养一个人。”

这话说得没头没脑，可是苏晴愣了一下。

后来她想，也许他说得对。

这一章要讲的就是“孩子不是被动地被养”。他在改变母亲，也在被母亲改变。这一来一回是第 4 章、第 5 章、第 6 章里一直在说的那件事，现在要把它说完整。

◆ 二、孕吐：是孩子在“说话”吗

先讲孕吐。

孕吐是很多孕妇都会经历的事。大约七成左右的孕妇会有恶心、呕吐。最严重的一种叫妊娠剧吐，要住院治疗。〔强：流行病学常见数字，不同研究比例略有差异〕

过去很长时间没有人说得清孕吐是怎么回事。有人说是激素，有人说是心理。

近年来有一个比较清晰的发现：胎儿和胎盘会分泌一种叫 GDF15 的蛋白质，进入母亲的血液。这种蛋白会作用于母亲脑干里和恶心有关的区域。

〔中：2018 年以后多项研究，包括遗传学研究，指向它与孕吐相关，机制仍在进一步研究〕

更有意思的是，研究发现，怀孕前体内 GDF15 水平较低的女性，孕期更容易出现严重的呕吐。怀孕前这种蛋白水平较高的人，反而更不容易严重呕吐。这提示：母亲的身体在怀孕之前的“适应”水平也很重要。〔中：2023 年前后的研究，具体文献待核〕

这些发现目前还在发展，我们不用记得太细。要带走的有两点：

第一，孕吐不是“你太娇气”，也不是“你想太多”。它有实实在在的身体原因，其中有来自孩子那一边的信号。

第二，孩子从这么早的时候起就在通过身体“告诉”母亲：我来了，要照顾我。

这就是“胎儿在改变母亲”的第一个例子。

◆ 三、孕吐怎么熬：几件小事

孕吐是一件很实际的苦。本书不讲大道理，只讲几件常被建议的小事。

先说一个让人安心的事实：孕吐多数在孕 9 周前后最厉害，大多到孕 14 到 16 周开始缓解。〔强：产科常见的时间规律，个体差异大〕

有的人会拖得更久，也有人从头到尾不太吐。

下面几件小事，是很多医生会给的建议。〔中：多为经验性建议，效果因人而异，请遵医嘱〕

一，少量多餐。别等饿了再吃，空腹时胃酸多，更容易吐。

二，起床前先吃两片苏打饼干，躺着缓一缓再起身。

三，吃让你不反胃的东西，不必强迫自己吃“有营养的”。孕早期胎儿还小，需要的不多，母亲身体里有储备。〔中：孕早期短期进食少，多数情况不影响胎儿，请遵医嘱〕

四，生姜、柠檬片、清凉的小口汤水，对一部分人有帮助。〔中：对轻度恶心有些研究支持，结果不完全一致〕

五，有的医生会建议加用维生素 B6，这要医生开。〔中：常见处理，请遵医嘱〕

什么时候该去医院？

如果几乎吃什么吐什么，喝水也吐，尿很少、颜色很深，体重明显下降，头晕无力，就不要硬撑。这可能是妊娠剧吐，需要治疗，常常要输液补水。

〔强：产科共识〕

妊娠剧吐是病，不是意志力的问题。

苏晴第 9 周那天，连着吐了一整个上午，中午喝一口水也吐。江远下班一看她脸色发白，直接开车送去了医院。

医生说：“你来得对。”

◆ 四、他改变了母亲的很多事

孕吐之外还有很多。

孩子在改变母亲的血糖。胎盘会分泌一些激素，让母亲对胰岛素不那么敏感，这样更多的葡萄糖就留在母亲血里，能送给胎儿。〔强：生理学共识〕

孩子在改变母亲的血管。孕期母亲的血容量会增加将近一半。心脏要多干活。〔强〕

孩子在改变母亲的睡眠。到孕晚期，胎儿自己有了“睡”和“醒”的节律。他醒着、动着的时候，母亲躺下就不容易睡着。〔中：胎儿有休息—活动周期，这个有较多研究；它影响母亲睡眠的直接证据有限〕

孩子在改变母亲的情绪。孕期激素的变化让很多母亲更容易哭，更容易敏感，也有一些母亲变得更能共情，更容易被婴儿的脸、婴儿的声音触动。〔中〕

孩子甚至在改变母亲的大脑。有一项很有名的研究用磁共振对比了怀孕前后女性的大脑。它发现怀孕后母亲大脑里有些区域的灰质体积变小了，而且这种变化可以保持至少两年。研究者的解释是：这不是“变笨”，而是大脑在做“精修”，让母亲更能读懂孩子的信号。〔中：Hoekzema 等，2017，样本不大，对“精修”的解释，仍然有讨论〕

我们要小心读这个结果。不要理解成“怀孕让你的大脑坏了”，也不要理解成“怀孕让你的大脑更聪明了”。它说的是：怀孕是一件把母亲身体和大脑都重新调整的事。

这就是第5章里讲过的“我推你一下，你回我一下”的另一面：孩子也在“推”母亲，母亲的身体在“回”。

◆ 五、母亲的身体，换了一套“家具”

怀孕不只是肚子大了。母亲的身体，几乎每个系统都在调整。

打个比方。家里要添一位新成员，不是只多放一张床。厨房要扩容，电路要加粗，卫生间要多排班。〔解释：比方〕

下面挑几项常见的，用白话讲。〔强：生理学教科书内容，具体幅度因人而异〕

心脏。血量增加了，心要多泵血。静息心率通常比孕前快一些，爬楼梯容易喘。

肾脏。过滤的量增加了，跑厕所的次数也跟着多起来。

呼吸。孕期的激素让人呼吸得更深更快。所以很多孕妇觉得“气不够用”，其实是身体在多换气。

关节。一种叫松弛素的激素，让韧带变松。腰、耻骨、骨盆都会酸，走路可能像“鸭子”。

子宫。从拳头大，长到足月时占满整个腹腔，比孕前大了许多倍。〔强〕

这些变化，不是毛病，是身体的“增容”。

当然，也有些变化是需要看医生的信号：突然严重的头痛，眼前发黑，脸和手突然肿得厉害，持续的腹痛或出血。〔强：产科常见的警示症状，请及时就医〕

◆ 六、血糖这件事：为什么孕 24 周要喝糖水

前面说过，胎盘激素会让母亲对胰岛素不那么敏感，好让更多糖留给胎儿。

大多数人的胰腺能跟上，多分泌一些胰岛素，血糖就稳得住。有一部分人跟不上，血糖就会偏高，这叫妊娠期糖尿病。〔强：生理学和产科共识〕

所以医生会在孕 24 到 28 周之间，让你喝一杯糖水，再抽血看血糖。〔强：多国指南的常规筛查，具体做法请遵医嘱〕

这个检查，不是在怀疑你“吃糖太多”。它是在看一件事：你的身体，有没有被孕期的激素压到跟不上。

查出来偏高，也不是你的错。多数人可以靠调整饮食、适度运动和监测，把血糖管住，少数人需要用药。〔强：指南共识〕

这个情形和第 4 章讲的是一回事：母亲的身体在替孩子做一件很大的调整，有的人调得顺，有的人需要一点帮助。

苏晴孕 25 周那天，空腹去喝糖水。她半小时前还在紧张，结果出来是正常的。她拍着胸口说：“我以为我天天吃蛋糕，要完蛋了。”

江远在旁边笑：“蛋糕还是少吃。”

◆ 七、睡不好，是孩子在“闹”吗

孕期睡眠变差，几乎是通则。

早期是尿多、恶心、乳房胀。中期好一些。晚期，肚子大了，翻身难，腿抽筋，夜里要起好几次。〔强：产科常见的情况〕

有人归咎于“孩子夜里爱动”。这有一点道理，却不是全部。〔中：胎儿的活动周期和母亲睡眠，直接证据有限〕

更多时候，是母亲的身体本身变了：激素、体位、尿频，都在打断睡眠。

几件小事可以试试。

一，侧着睡，在腰后和两腿间垫枕头。〔中：通行的舒适建议〕

二，晚饭后少喝水，白天多喝。

三，睡前固定做一件让你放松的事，比如前面讲过的“十分钟”。

四，睡不着也不要盯着时间。躺着休息，也算休息。〔解释：本书的读法〕

有一件事要告诉医生：如果你打鼾变得很响，夜里憋醒，白天困得要命，要提一提。孕期有一部分人会出现睡眠呼吸的问题。〔中：研究提示孕期睡眠呼吸障碍有一定比例，请遵医嘱〕

◆ 八、母亲这一边的“回”

那么母亲这一边是怎么“回”的？

前面说的都是身体层面的回。接下来讲心理层面的。

心理学里有一个概念叫“母胎依恋”。意思是，母亲在孕期对肚子里的孩子形成的情感联系：想他，跟他说话，摸他，想象他长什么样，为他做准备。

〔强：这个概念已有较成熟的量表和大量研究〕

研究发现，母胎依恋强的母亲往往更注意自己的健康，比如更少吸烟、饮酒，更愿意按时产检。产后也更容易和孩子建立起良好的互动。〔中：多项相关研究，不是因果证明，也有一些研究结果不一致〕

这个“依恋”是怎么来的？

很多研究指出，其中一个重要的来源就是胎动。

感到胎动是一个转折点。有了胎动，孩子从一个“知道的事”变成了一个“感到的人”。很多母亲是从这个时候起开始给孩子起小名，开始跟他说话。〔中：访谈和问卷研究较多〕

看到超声图像也是一个重要的节点。研究发现，看到超声对不少母亲和父亲会增强对胎儿的情感联系。〔中：研究结果不完全一致〕

所以在这一章里，我们可以画出一个完整的圈：

孩子动，母亲感到。母亲感到，母亲出声、触摸、调整。母亲出声、触摸、调整，孩子再遇到新的不同。孩子再动。

这样一圈一圈，就是母子之间的第一条“SDE 回路”。

◆ 九、数胎动：一个很具体的“回”

这里有一个很具体的做法，叫“数胎动”。

怀孕二十八周以后，医生常建议孕妇每天固定一个时间，静下来，数一数孩子的动作。一般的做法是：选一个孩子比较活跃的时间，比如饭后，侧躺，手放在肚子上，记录从开始到孩子动了十次需要多长时间。〔强：这是产科常见的建议，具体方法各医院略有不同，请遵医嘱〕

数胎动首先是为了安全。如果胎动明显减少，比如两个小时没有达到十次，或者和平时比明显减少，就要及时去医院。〔强〕

不过在本书里，数胎动还有另一层意思：

它让母亲每天有一个固定的时间把注意力放在孩子身上。

一个女人每天要做很多事：上班，做饭，处理各种烦心事。这些事都会把她的注意力从孩子身上拉开。数胎动就是一个固定的“对上”的时刻。

这个“对上”对孩子来说是什么？是每天同一个时候，母亲的手来了，母亲的注意来了。

对母亲来说，则是每天有一个短短的时间，她“听”到了孩子。

安全加上联系。这就是数胎动在 SDE 里的位置。

◆ 十、情绪：怎么分“正常的波动”和“需要帮助”

孕期情绪不稳，是很常见的。激素变化，睡不好，担心，身体不适，都会让人更容易哭、更容易烦。〔强：围产期常见情况〕

大多数波动，几天会过去。

可是有一部分人，会掉进更深的状态。这在医学上叫围产期抑郁或焦虑，它不算罕见，不是“矫情”，也不是意志薄弱。〔强：指南共识〕

怎么区分？你可以看三件事。

第一，时间。低落持续超过两周，几乎每天都是。

第二，范围。对平时喜欢的事，也提不起兴趣。

第三，影响。吃不下、睡不着，或者睡得特别多；反复自责；觉得自己不配做妈妈。

如果有这些，请告诉产检的医生，或者你信任的人。医生会用简短的问卷和谈话来评估。〔中：常用的是爱丁堡等量表，具体由医生决定〕

如果出现了伤害自己的念头，请当天就联系医生或身边的人，不要独自扛着。〔强：指南共识〕

这个求助，不是承认失败。它是“把一个撑不住的人，托住”的第一步。

◆ 十一、下一次产检，可以问医生的五件事

很多孕妇从诊室出来，才想起有话没问。这里给你一个可以带进去的单子。

一，我这一阶段，身体最需要留意什么。

二，我现在吃的东西、药、保健品，有没有要调整的。

三，哪些症状出现了，要马上来医院，哪些可以先观察。

四，我的胎动大约从什么时候开始数，怎么数。

五，我的情绪不太好的时候，可以找谁。

这五件事，都不需要你懂医学。你只需要把它写在手机里，带着去。〔解释：本书的建议，不是医学指南〕

如果有伴侣，让他一起去，一起问。一个人记不住的话，两个人能记住。

◆ 十二、压力：说一件很重要，又必须说得小心的事

写到这儿必须谈谈压力。

这是本书里最需要小心写的一个话题，因为很多母亲听到“压力会影响孩子”会立刻自责。请你先看这一段，再往下读。

事实是这样的：

很多研究发现，母亲在孕期如果长期处在很大的焦虑、抑郁或压力里，孩子出生后在情绪、行为、压力反应方面出现问题的概率会略高一些。〔中：大量观察性研究，效应量不大，不同研究结果有差异，难以排除遗传和产后环境的影响〕

可能的机制有这几种：

一是应激激素。母亲的压力会使皮质醇升高。胎盘里有一种酶叫 11β -HSD2，会把一部分皮质醇转化掉，不让它全部传给胎儿。不过这个“屏障”不是百分之百有效的。〔中：机制有证据，人类中的影响程度仍有争论〕

二是母亲的行为。压力大的母亲往往睡得少，吃得不规律，更容易抽烟喝酒。

三是子宫里的血流和炎症状态。〔中〕

注意看上面的几个词：“略高”“效应量不大”“难以排除”。

这几个词是认真的。绝大多数经历过压力的母亲，孩子都长得很好。压力不是“把孩子害了”的判决书。

本书想说的是另一件事：

压力不是母亲的责任，是母亲所处环境的状况。

一个孕妇，如果在家里被丈夫忽视，被婆婆指责；在单位被要求加班，被暗示“怀孕影响工作”；在路上没有人让座；在医院排队两小时，看病五分钟。这样的压力不是她“管理不好情绪”的结果，是她所处的“E”没有接住她。

研究也指出了这一点：

好的伴侣支持、好的社会支持可以降低孕期的焦虑和抑郁，也可以降低压力对孩子的影响。〔中：多项研究支持，具体效应大小因研究而异〕

对于已经出现明显焦虑、抑郁的孕妇，心理治疗和适当的专业帮助也是有效的。〔强：指南共识，具体治疗请遵医嘱〕

所以请把这一节的结论记成：

母亲的压力是整个家庭、整个社会要一起接的事。不是她一个人要扛着的事。

这个结论在第17章和第27章还会有更具体的展开。

◆ 十三、爸爸这边也在变

“孩子在改变母亲”，这是本章的主线。可是别忘了，家里还有一个人。

爸爸也在被改变。

有研究发现，部分男性在孩子出生后，睾酮水平会有所下降，一般认为这与更多地参与照料有关。〔中：小样本研究，机制仍在研究〕

也有研究发现，不少父亲在伴侣怀孕期间和产后，会出现焦虑甚至抑郁，只是比例一般低于母亲，也更少被注意到。〔中：多项研究，结果不完全一致〕

还有一种说法，叫“拟孕综合征”：个别准爸爸会跟着出现恶心、体重增加、食欲变化。〔中：有记录，原因没有定论〕

这些都在说同一件事：怀孕不是一个人的事。一个家里添了新成员，每个人都在重新校准。〔解释：本书的读法〕

爸爸不是只有“帮忙”这一个角色。他自己也需要被问一句：你还好吗。

◆ 十四、茶水间的姜糖

苏晴孕 10 周，每天上午十点，会准时恶心一次。

她开始躲着同事。别人去吃早餐，她说“我不饿”。有人问她要不要咖啡，她摆手。

有一天，林姐路过她的工位，不动声色地往她抽屉里放了几颗东西。

苏晴拿出来一看，是生姜糖。

林姐在她旁边，小声说：“我也吐过。你不用解释，吐的时候就去卫生间，我帮你挡一下。”

苏晴眼睛一下子红了。她这一个月，第一次觉得有人看见了她。

这个场景里，林姐什么大道理也没说。她做了两件事：说了一句“我也吐过”，给了一点实实在在的东西。

对一个孕吐的人来说，“有人看见了”，本身就是减负。

这就是后面讲环境的章节里，“托住”的一个很小的样子。〔解释：本书的读法〕

◆ 十五、深夜里，江远说了一句“我有点怕”

苏晴孕31周的一个晚上，凌晨一点。

她被尿憋醒，起身时发现江远没有睡。他靠在床头，手机屏幕的光照着他的脸。

“还不睡？”

江远把手机放下，沉默了一会儿，说：“我有点怕。”

“怕什么？”

“怕生的时候出事。怕我不会当爸爸。怕我们的钱不够。我今晚把论坛上那些帖子都翻了一遍，越看越怕。”

苏晴没有劝他“别怕”。她在床边坐下来，说：“我也怕。”

两个人在黑暗里坐了好一会儿。

后来江远说：“明天我们去问问医生，生的时候我能做什么。”

苏晴点头：“好。”

这一段，没有解决任何一个“怕”。可是它做了一件事：把一个人的怕，变成两个人的怕。

两个人的怕，比一个人的怕轻。〔解释：本书的读法〕

这也是“托住”的意思。它不分谁托谁，是互相托。

◆ 十六、母亲的大脑在“精修”，怎么理解

前面提到，怀孕后母亲大脑里有些区域的灰质体积变小。很多人看到这里会心里一紧。

这里补几句，让你读得更稳。

第一，体积变小，不等于功能变差。青春期时大脑也会修剪不用的连接，变得更高效。〔强：神经发育常识〕

第二，那项研究里，变化集中在和理解他人、社会认知有关的区域。研究者认为，这与母亲更能读懂孩子的信号有关。〔中：Hoekzema 等，2017，解释有讨论〕

第三，没有证据表明这种变化会让母亲变笨。很多母亲在孕期和产后会觉得“记性差”“脑子糊”，这与睡眠不足、压力、事情多都有关系。〔中：多项研究，结果不完全一致〕

所以这个发现，可以读作：母亲的大脑，在为一件很大的新任务做准备。
〔解释：本书的读法〕

你不需要为它做任何事。你只需要睡好一点，吃好一点，被人托住一点。

◆ 十七、常见的几个问题

问：孕吐很厉害，吃不下，孩子会不会缺营养？

孕早期胎儿还很小，需要的营养不多，母亲身体里有储备。多数情况下，短期吃得少不影响孩子。〔中：请遵医嘱〕不过如果持续吃不进东西、体重明显下降，要尽早看医生，因为这时要保护的也有你自己。〔强〕

问：我一点也不吐，是不是孩子不好？

不是。有相当一部分孕妇没有明显的孕吐。没有孕吐，不能说明孩子有问题。〔强：产科常识〕孕早期的状况，要靠产检和超声来判断，不靠吐不吐。

问：我总想哭，脾气也大，是我性格有问题吗？

多数情况下不是。孕期激素变化，加上睡眠和压力，让情绪更容易波动。〔强〕可是如果低落持续两周以上，或者影响吃睡，就请告诉医生。〔强：见前文〕

问：我感觉不到对孩子的“爱”，只觉得累，是不是不合格？

不是。母胎依恋因人而异，有的人早早就有，有的人要到胎动明显了，甚至孩子出生以后才慢慢长出来。〔中：多项研究显示依恋随孕周逐步变化，个体差异大〕感情是可以慢慢长的，不是一开始就有或没有。

问：工作太累，该不该请假？

没有统一答案。要看你的岗位、身体状况和医生的意见。〔解释：本书的读法〕一些观察研究发现，长时间站立、夜班、过度劳累，与早产等不良结局可能有关联，但结果不完全一致。〔中〕

可以和医生、单位一起商量，看看能不能调整强度。这不是“矫情”，是把自己放进了需要被照顾的人里。

问：我不想被碰，爸爸还能做什么？

尊重你的感受，是第一件事。他可以做的事情有很多，不一定要碰：做饭，洗碗，陪你产检，听你说话，替你回绝不必要的应酬。〔解释：本书的读法〕

孩子需要的，是你被托住。这不一定靠手。

◆ 十八、放回日子里

苏晴孕二十九周的时候，公司有一个很重要的项目。

她是财务负责人，月底要结账，每天都要加班。她回到家往往已经十点多。

有一天晚上，她洗完澡，坐在床边，忽然开始哭。

江远吓了一跳，赶紧坐过来：“怎么了？”

她说：“我觉得我什么都做不好。上班做不好，当妈也做不好。我今天一天都没怎么想孩子。”

江远没有说“别想太多”。

他想了想，说：“你今天加班到十点，我来摸摸他。”

他把手放到苏晴的肚子上，等了一会儿，轻轻地说：“妈妈今天很累了，是我们的功臣。你踢她两脚，让她知道你在。”

肚子里真的动了一下。

苏晴在哭中笑出了声。

这一幕在 SDE 里有几层意思：

第一，江远没有否定她的感受，也没有讲道理。他接住了她。

第二，他没有“替”她当妈，而是让孩子和母亲重新对上。

第三，他让孩子的那一下“动”成为母亲的一个“回”。

这一下比一百句“你已经很棒了”更有用。

这是 E 里的父亲在做的事。

◆ 十九、本编小结

走完这四章，我们可以把第二编用几句话收起来：

第4章说，来回在神经出现之前就已经开始了。母亲的身体先于母亲的意识和孩子对上了话。

第5章说，触觉的SDE是“动—被碰—再动”。孩子的身体，包括关节、肺、身体的地图，都是在这个来回里画出来的。

第6章说，听觉的SDE是“听—分—回—再听”。孩子学到的是母亲声音的调子，不是词。

第7章说，孩子不是被动的。他在改变母亲，母亲也在回应。这个圈需要一个稳的环境才转得顺。

接下来的第三编要讲的是：出生是一次换场。

那个在水里，听着低沉的声音，被一圈一圈的触碰包着的孩子，忽然到了一个完全不同的地方。他怎么接得上？

带走的话

孩子在子宫里不是被动地等着被养。他在改变母亲的身体，改变母亲的心，也让母亲的世界围着他转动。母亲在回应他，同时母亲也需要被稳稳地托住。托住母亲的是整个家，整个社会。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
约七成孕妇有孕吐	〔强〕	不同研究比例略有差异
胎儿和胎盘分泌的 GDF15 与孕吐相关	〔中〕	2018 年以后多项研究，机制仍在研究；孕前水平的研究待核
胎盘激素使母亲胰岛素敏感性降低以供给胎儿	〔强〕	生理学共识
孕期母亲血容量增加近一半	〔强〕	生理学共识
怀孕后母亲大脑灰质体积变化可持续至少两年	〔中〕	Hoekzema 等，2017，小样本；“精修”是解释
母胎依恋与母亲健康行为、产后互动相关	〔中〕	相关研究，不是因果
胎动、超声增强父母对胎儿的联系	〔中〕	结果不完全一致
28 周后数胎动，减少需就医	〔强〕	具体方法请遵医嘱
孕期长期焦虑抑郁与孩子情绪行为风险略增相关	〔中〕	效应量不大，难排除遗传和产后因素
胎盘 11 β -HSD2 部分屏蔽母体皮质醇	〔中〕	屏障并非完全有效
伴侣和社会支持可缓解孕期焦虑	〔中〕	多项研究，效应因研究而异
孩子与母亲形成第一条 SDE 回路	〔解释〕	本书的理论读法
孕吐多在孕 9 周前后最重，多数孕 14 到 16 周缓解	〔强〕	个体差异大
少量多餐、起床前吃饼干等孕吐应对建议	〔中〕	经验性建议，因人而异，请遵医嘱
孕早期短期进食少，多数情况不影响胎儿	〔中〕	请遵医嘱；持续吃不进需就医
生姜、柠檬对轻度恶心有帮助	〔中〕	研究结果不完全一致
维生素 B6 可用于缓解孕吐	〔中〕	须医生指导

说法	证据级别	说明
妊娠剧吐需就医治疗，常需补液	〔强〕	产科共识
孕期心率加快、呼吸加深、尿频、韧带松弛	〔强〕	生理学教科书内容，幅度因人而异
足月子宫比孕前大许多倍	〔强〕	生理学常识
剧烈头痛、眼花、突发水肿、持续腹痛或出血需及时就医	〔强〕	产科警示症状
围产期抑郁、焦虑不算罕见，不是意志薄弱	〔强〕	指南共识
医生常用简短量表评估情绪	〔中〕	具体由医生决定
出现伤害自己的念头应当天求助	〔强〕	指南共识
部分男性在孩子出生后睾酮水平下降	〔中〕	小样本，机制仍在研究
不少父亲在伴侣孕期和产后出现焦虑、抑郁，比例一般低于母亲	〔中〕	多项研究，结果不完全一致
个别准爸爸出现“拟孕综合征”	〔中〕	有记录，原因无定论
母胎依恋随孕周变化，因人而异	〔中〕	个体差异大
长时间站立、夜班、过劳与早产等结局可能有关联	〔中〕	观察研究，结果不完全一致
家人的支持让母亲更容易被托住	〔解释〕	本书的读法
妊娠期糖尿病：胎盘激素致胰岛素抵抗，部分人血糖偏高	〔强〕	产科共识
孕24到28周常规做糖耐量筛查	〔强〕	具体做法请遵医嘱
妊娠期糖尿病多数可靠饮食、运动和监测控制，少数需用药	〔强〕	指南共识
孕期睡眠变差，早期因尿频恶心，晚期因体位和腿抽筋	〔强〕	产科常见情况
胎儿的活动周期影响母亲睡眠	〔中〕	直接证据有限

说法	证据级别	说明
侧睡并垫枕头的建议	〔中〕	通行的舒适建议
孕期有一部分人出现睡眠呼吸障碍	〔中〕	请遵医嘱
孕期灰质变化不等于功能变差，且与睡眠、压力等共同影响“记性差”	〔中〕	研究结果不完全一致
青春期大脑也会修剪连接以提高效率	〔强〕	神经发育常识

个体情况，比如孕吐严重、情绪低落、焦虑、胎动减少，请及时就医，遵医嘱。

第三编

出生是换场：从水里到空气里

这一编三章，讲孩子从子宫到世界的这一次大换场。

第 8 章讲换场有多陡，早产儿遇到了什么。第 9 章讲新生儿认得什么，以及袋鼠式护理。第 10 章讲孩子带来的本事，和那个不能少的人。

三章走完，你会看到：出生不是起点，而是一个接续。

第 8 章

出生是一次换场：从水里到空气里

◆ 一、三十七周零二天

苏晴是在孕三十七周零两天进的产房。

那天凌晨三点她醒了，觉得肚子一阵一阵地紧。她没有叫醒江远，先躺着数了半个小时，间隔不是很规律。到四点半，她轻轻推了推身边的人：“可能要去了。”

江远一骨碌坐起来，头发翘着，找了半天拖鞋，一只在床底下，一只在门口。

后来苏晴常笑他。可是那天凌晨她自己也没笑。

她知道，接下来的十几个小时，对肚子里的那个孩子来说，是他这辈子遇到的第一件大事：换场。

从一个暖暖的、软软的、全天候的、有节律的世界，到一个冷的、亮的、有风的、什么都要靠自己的世界。

这一编三章讲的就是这次换场。

这一章先讲换场本身有多大，多难。

◆ 二、一次什么样的搬家

先想象一下，孩子在子宫里是什么样的日子。

温度：恒定，大约三十七度，和母亲的体温差不多。他不用自己保温。

〔强〕

氧气：由脐带送来。他不用自己呼吸，肺里是水。〔强〕

食物：由脐带送来。他不用自己找吃的，不会饿，也不会渴。〔强〕

重力：漂在羊水里，浮力抵消了大部分重力。他的身体不用承担自己的重量。〔强：生理学常识〕

声音：隔着一层肌肉和水，低沉，模糊，有节律。母亲的心跳是背景。母亲的声音是最响的那一个。〔中〕

光线：很暗，偶尔有一点点透进来的红光。〔中：第1章讲过〕

触觉：一直被包着，被轻轻地压着。四面都有边。

再看，出生以后，这些一下子全变了：

温度：房间里大约二十四五度，比子宫里低十几度。他全身湿漉漉的，开始失热。〔强〕

氧气：脐带很快停止供氧，他必须在几十秒内自己吸进第一口空气，把肺里的水挤出去。〔强〕

食物：他开始会饿，要找奶吃。

重力：他的身体突然变得很重，头要有人托着。

声音：一下子变得很响，很清楚，很尖。

光线：一下子很亮。

触觉：四面的“边”没有了。他被放在一个大的、空的空间里。

这个搬家在人的一生里几乎是最陡的一次变化。

好在这个搬家不是什么都没准备。他在子宫里练了很多事。

◆ 三、第一口气

最难的一件事是第一口呼吸。

在子宫里，胎儿的肺是充满液体的。他会做“呼吸样”的动作，这对肺的发育很重要，可是并不真的吸气。〔强〕

出生的时候有几件事在同时发生：

一是产道的挤压把肺里一部分的液体挤出来了。

二是一阵很强的激素“风暴”。分娩前后，母亲和胎儿的体内儿茶酚胺水平很高，这促使肺里的液体加快吸收，也让孩子在出生后处于一种清醒、警觉的状态。〔强：这是产科和新生儿科的基础内容〕

三是外面的冷、光、触、声是一连串强烈的刺激。这些刺激会触发呼吸的启动。

于是在出生后的几十秒里，孩子张开嘴，吸进第一口气，哭出第一声。
〔强〕

这是一个多么大的转折：在这之前他九个月没有真的呼吸过。在这之后他一辈子都不能停下来。

很多人第一次看到产房里孩子的哭会觉得心酸。可是从生理上讲，这一声哭是好消息。它说明肺打开了。

◆ 四、产房里会发生什么

很多人对产房的想象来自电视剧。真实的产房没有那么急，也没有那么戏剧。

下面按最常见的次序，把整个过程讲一遍。不同医院的做法略有差别，请以你所在医院的安排为准。〔中：各医院流程 and 规定不同〕

先说产程。产程是指从有规律的宫缩开始，到孩子和胎盘都娩出的整个过程。产科学教科书把它分成三段。〔强：产科学基础内容〕

可以把它想成爬一座山。三段路各有各的走法。

第一段叫第一产程。从规律宫缩开始，到宫口开全为止。这是最长的一段。初产妇常常要十来个小时，也可能更长或更短。〔强：个体差异很大，不必和别人比时间〕

这一段里宫缩一阵一阵，宫颈慢慢变薄、打开。医护会隔一段时间听一次胎心，查一次宫口。你可以按医院的规定走动、换姿势、喝水，也可以请家人陪着。〔中：能不能进食、走动，几个人陪产，各院规定不同〕

第二段叫第二产程。从宫口开全到孩子出生。初产妇常常要一两个小时上下，也可能更久。助产士会告诉你什么时候用力，什么时候先缓一缓。〔中〕

孩子出来以后进入第三段。第三产程是从孩子娩出到胎盘娩出，通常在半小时之内完成。〔强〕

孩子出生以后，医护会马上看几样东西：哭得响不响，肤色，四肢的张力，心率，呼吸。常用的办法叫阿普加评分，在出生后 1 分钟和 5 分钟各评一次，满分 10 分。〔强：新生儿科常规〕

分数低不代表孩子将来一定有问题。它是在告诉医护：这个孩子现在需不需要帮一把。〔强：它反映的是出生当时的状态，单次分数不能用来预测某个孩子的长期结局〕

脐带怎么处理，各地也有讨论。不少指南建议，孩子状态稳定时不要急着马上夹断脐带，稍等片刻。这样孩子能多得一部分血液，铁的储备会好一些。

〔中：具体等多久，各国指南略有不同，也要看孩子当时的状态〕

整个过程里，你可能觉得医护的动作很快，话也很少。那多半是因为他们在专心看你和孩子的指标。你随时可以问：“现在是什么情况？”

◆ 五、顺产与剖宫产：不要“互相审判”

讲到出生，不能不提到一个话题：顺产和剖宫产。

很多母亲会为这件事自责。顺产不成，剖了，觉得“没有给孩子最好的开始”。反过来，也有人因为选择了顺产，觉得“比剖的人更伟大”。

本书要说清楚几件事：

第一，一些研究发现，经阴道分娩的孩子和剖宫产的孩子，在肠道菌群、某些免疫指标、某些激素水平上有统计上的差异。〔中：有不少观察性研究，差异是否有长期的临床意义，仍有争议〕

第二，关于顺产和剖宫产对孩子后来智力和性格的影响，现有的证据很不一致。大部分研究在控制了家庭环境等因素后，差异很小或没有差异。〔中：结果不一致〕

第三，有些剖宫产是为了保护母亲和孩子的生命。这样的选择是正确的选择。

所以本书的立场是：

出生的方式不是“智慧起点”的判决书。无论哪一种方式出生，真正重要的是出生之后孩子遇到了什么。

这一点后面的两章会具体讲。

◆ 六、产前可以问医护的几件事

很多父母到了产房才发现，有好多事没问过。下面这张单子，可以在产检时一条一条问。

一，这家医院的陪产规定是什么，几个人可以进来。

二，如果母子都平稳，出生后能不能马上把孩子放在我胸口。

三，脐带什么时候夹。

四，疼得受不了的时候，有哪些止痛的办法，各有什么利弊。

五，如果要转成剖宫产，丈夫能不能在场，术中和术后能不能尽早抱孩子。

六，产后孩子能不能和我住在一起。

七，如果孩子要去新生儿科，什么时候能看到他，能不能摸他。

这几条没有标准答案，各医院不同。问的目的不是“争取”，是心里有数。〔解释：本书的建议〕

医护如果回答“这一条要看当时的情况”，那通常是实话。分娩是一个不断变化的过程，最后的决定要以母子平安为先。〔强：产科的基本原则〕

◆ 七、出生计划：怎么谈，才不内疚

有些医院鼓励父母在产前写一张“出生计划”：希望谁陪着，希望怎么镇痛，希望产后怎么接触孩子。〔中：不同国家和医院做法不同〕

这张纸很有用。不过要用对。

苏晴在孕 34 周的一个晚上，和江远一起写了一张。写到一半，她停来说：“万一做不到呢？”

下次产检，她把这句话原样说给助产士听。助产士笑了笑：“这张纸是愿望单，不是合同。愿望单的意思是我们一起尽量，做不到的时候也不是谁的错。”

苏晴回家后，在纸的最上面添了一行字：以我们俩和孩子平安为第一。

这个小故事想说的是：出生计划最好的用处，是让你和医护提前说上话。它不是考卷。

下面几个说法，可以帮你不内疚。

第一，产程里有很多事情谁也没法提前定。孩子的位置，宫缩的力度，胎心的变化，都可能让计划改变。〔强：产科常识〕

第二，计划改变不等于你没做好。改变往往是医护在替你和孩子避开风险。

第三，如果计划没能实现，事后可以请医护安排一次谈话，把当时发生了什么听清楚。很多人心里的结，是因为不知道“为什么”。〔解释：本书的建议〕

◆ 八、江远在产房里的“工作”

产房里最容易被忘记的人，是陪产的那一位。

江远一进产房就紧张得手心出汗。助产士看了他一眼，给了他三件事：握住苏晴的手，递水，看着墙上的钟报时间。

他觉得这算不上什么“工作”。助产士说：“你站在她看得见的地方，她就知道有人在。这就是你的工作。”

后来苏晴说，她记不清那天很多事，却记得有一只手一直没有松开。

陪产的人不需要懂产科。稳着，在场，听医护的话，就够了。〔解释：本书的看法，是否陪产要看医院规定和家庭意愿〕

◆ 九、早产儿：换场换得太早

现在要讲一个特别的群体：早产儿。

满三十七周以前出生的孩子叫早产儿。孕周越小越难。三十二周以前出生的叫极早产儿；二十八周以前出生的叫超早产儿。〔强：世界卫生组织的分类，不同国家略有差异〕

对早产儿，我们用本书的视角可以看到什么？

可以看到，他们是被提前“搬出”子宫的孩子。

他们的触觉和听觉在子宫里原本可以继续练到四十周。可是在二十八到三十二周的时候，他们被送进了保温箱。

保温箱里是什么环境？

声音：监护仪的“滴滴”声，保温箱的马达声，开关门声，仪器报警声。这些声音常常是持续的、高频的、不规则的。研究测量过，新生儿重症监护室里的噪声往往比推荐的标准还要高。〔中：多项测量研究，不同医院差异很大〕

而且母亲的声音没有了。母亲的心跳没有了。

光线：二十四小时开着灯，或者很亮。

触觉：这是最关键的。早产儿在重症监护室里需要频繁的医疗操作：抽血，打针，吸痰，调整体位，贴电极。很多时候他们收到的触碰是“痛的”，不是“温柔的”。〔中：有研究统计，极早产儿在住院期间，要经历几十到几百次的有创操作，具体数字因医院而异〕

对一个本来应该在水里被轻轻地包着的孩子，这是一个多么不同的世界。

◆ 十、这样的孩子，后来会怎么样

很多人关心：早产儿以后会怎么样？

根据大规模的追踪研究，总体来说：

孕周越小，出生体重越低，后来在学习、注意力、运动协调、情绪方面出现困难的比例，平均而言会更高一些。〔强：多项大型队列研究〕

可是这是“平均而言”。个体之间差别很大。很多早产儿长大以后，学习、工作、生活都没有问题。

还有一个很重要的发现：重症监护室里的环境不是命中注定的。

研究者在一些医院里试着改变保温箱里的环境：降低噪声，调暗灯光，集中操作，让孩子有一段不被打扰的睡眠；允许父母多进来抚触、抱、说话，甚至做袋鼠式护理（下一章讲）。

这样做之后，一些研究发现孩子在神经发育上的表现有改善。〔中：研究证据有逐步积累，并非所有指标都一致〕

这说明：换场换得早是一个重大的挑战，可是换场之后遇到什么仍然有很大的余地。

这个“余地”是本书后面要讲的核心。

◆ 十一、周女士在三十一周的那一天

周女士是在孕 31 周的那天被送进医院的。

医生说，孩子要提前出来了。她躺在推床上，一遍一遍地问：“是不是我哪里做错了？是不是上周搬了那箱东西？”

医生蹲下来看着她：“早产的原因很复杂，大多数时候找不到一个单一的原因。你不要在这里找自己的错。”〔强：早产是多因素的结果，常常查不出单一原因〕

周女士后来说，这是那几天里听到的最有用的一句话。

本书借这个故事想说的是：早产不是谁的过错。它是孩子提前换场，需要一个更周到的接应。

◆ 十二、第 3 章里的那个研究，在这里的意义

第 3 章里我们提到过一项 2015 年发表的研究（Webb 等）。研究者给住在重症监护室里的早产儿每天放母亲在孕期时录下的声音：心跳和母亲说话的声音，每次一段时间。结果发现，这些孩子的听觉皮层比对照组发育得更好。

〔中：样本较小，具体效应仍需要重复，见第 3 章〕

这个研究放在这里再看是什么意思？

它说明，在孩子从子宫里被“提前”拿走的情况下，如果能把一部分子宫里的“声音”还给他，对神经发育有帮助。

这是一个很了不起的思路：

不是“用更高级的东西去代替母亲”，而是“尽可能把母亲给过的东西还给孩子”。

本书的整个方法论都是沿着这条线走的。

◆ 十三、常见的几个问题

问：疼得受不了，可以要求止痛吗？

答：可以提出来。分娩的疼痛因人而异，有多种镇痛办法，椎管内镇痛是常用的一种，要由医生评估后实施。目前多数研究没有发现它对孩子的长期发育有明确的不良影响，研究仍在继续。〔中：具体利弊请和产科、麻醉科医生商量〕

问：医生建议催产或引产，是不是“不自然”，会伤到孩子吗？

答：有医学指征的时候，引产是为了降低母子的风险。它是一种治疗手段，不是对自然的背叛。要不要做、什么时候做，请把理由问清楚。〔中：引产的指征和时机因人而异，请遵医嘱〕

问：剖宫产的孩子，以后会不会和我不亲？

答：没有可靠的证据说明剖宫产会让母子关系变差。后面两章会讲，亲不亲主要看出生之后日子里的陪伴。〔中：研究不多，多数没有发现稳定的差异〕

问：孩子出生后没有马上哭，是不是出事了？

答：有的孩子需要医护帮几分钟，比如擦干、轻轻刺激、清理口鼻，必要时给一点氧气。多数孩子很快就好起来。〔强：新生儿复苏是产房的常规准备〕

那几分钟里医护的动作会很快。你看着会害怕，那是他们在照流程做事。

问：产程很长，是不是我不行？

答：不是。初产妇的产程本来就长，个体差异也大。〔强〕产程慢不代表你或孩子做得不好。医护会根据你和胎心的情况，决定要不要帮一把。

问：过了预产期还没动静，要不要自己想办法催？

答：预产期只是一个估算的日期，正好那天出生的孩子只是少数。〔强：产科常识〕过了预产期，医生会增加检查，看胎盘和羊水的情况，再决定是继续等还是引产。请不要自己用偏方催。〔中：做法因国家和医院而异，请遵医嘱〕

问：为什么孩子一出生就要先擦干、戴上小帽子？

答：刚出生的孩子浑身湿漉漉的，水分蒸发会带走很多热量，他自己还没有能力保温。擦干、包好，再贴到母亲胸口，是最常见的保暖办法。〔强：新生儿保暖是产房和新生儿科的基本要求〕

问：剪脐带的时候，孩子会痛吗？

答：不会。脐带里没有神经，剪的时候孩子和母亲都没有痛感。〔强：解剖学常识〕

◆ 十四、放回日子里

苏晴的孩子是足月出生的。

产后第二天，她和同病房的另一个母亲聊天。那个母亲姓周，她的孩子是三十一周出生的，在新生儿科住了五十多天，刚刚出院。

周女士说起那五十多天，眼圈有点红。

她说：“最开始我只能隔着保温箱看。护士说他很脆弱，别碰。我就站在那儿，手放在箱子上，不敢动。”

“后来有一天，一个护士跟我说，你可以把手伸进去，轻轻按在他头上，不要动，也不要摸。我就照做了。”

“他本来在动，在哭。我手一放上去，他慢慢地安静了。”

她停了一下：“那一刻我才觉得，我是他妈妈。”

苏晴没有说话，轻轻地握住了她的手。

这个故事不是为了催人泪下。它想说的是：

即使是最脆弱的情况下，母亲的手仍然是一个有分量的“E”。

这一点不是“感情”，是实打实的事。在下一章我们就讲一个更具体的做法：袋鼠式护理。

带走的话

出生，是孩子这辈子遇到的第一次大换场：从水到空气，从暗到亮，从被包着到被放下。他能撑过去，是因为他在子宫里已经练过。换场换得早的孩子，需要把子宫里的东西尽量还给他。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
子宫温度恒定约 37 度，新生儿出生后体温流失	〔强〕	生理学基础
产道挤压和激素变化促使肺液吸收、启动呼吸	〔强〕	产科、新生儿科基础内容
阴道分娩与剖宫产在菌群、免疫指标上有差异	〔中〕	长期临床意义有争议
分娩方式对智力、性格的长期影响很小	〔中〕	结果不一致，多数研究控制家庭因素后差异小
新生儿重症监护室噪声常高于推荐标准	〔中〕	医院差异大
早产儿住院期间要经历大量有创操作	〔中〕	具体数字因医院而异
孕周越小，后来学习、注意、运动困难的平均比例越高	〔强〕	平均而言，个体差异大
改善监护室环境、增加父母参与，对神经发育有帮助	〔中〕	证据在积累，指标不完全一致
为早产儿播放母亲声音和心跳，听觉皮层发育更好	〔中〕	Webb 等，2015，小样本

说法	证据级别	说明
产程分三段，初产妇第一产程常需十来个小时	〔强〕	产科学基础，个体差异大
第三产程通常在半小时内完成	〔强〕	产科学基础
阿普加评分在出生后 1 分钟和 5 分钟评估	〔强〕	反映当时状态，不能单独预测长期结局
状态稳定时稍等再夹脐带，铁储备可能更好	〔中〕	各国指南的等待时间不同
陪产、进食、走动等规定因院而异	〔中〕	以所在医院为准
分娩过程多变，计划可能改变，以母子平安为先	〔强〕	产科基本原则
出生计划是沟通工具，不是考卷	〔解释〕	本书的建议
早产多为多因素，常查不出单一原因	〔强〕	母亲不必自责
椎管内镇痛未发现对孩子长期发育有明确不良影响	〔中〕	研究仍在继续，请与医生商量
有指征时引产是为降低风险	〔中〕	指征和时机因人而异
剖宫产与母子亲密程度无稳定差异	〔中〕	研究不多
新生儿复苏是产房常规准备	〔强〕	少数孩子出生时需要帮助
预产期只是估算，过期后医生增加监测	〔强〕	具体做法请遵医嘱
新生儿湿润易散热，擦干保暖是产房基本要求	〔强〕	新生儿科常规
脐带中没有神经，剪断时无痛感	〔强〕	解剖学常识
陪产者的“在场”本身有价值	〔解释〕	本书的看法，是否陪产以医院规定为准

个体情况，比如分娩方式的选择、早产儿的护理，请遵医嘱。

第9章

认得妈妈：声音、心跳、气味，和袋鼠式护理

◆ 一、胸口上的那一个小时

苏晴的孩子是上午九点十二分出生的。

护士用一块温热的毛巾把他擦了几下，然后把他放在了苏晴的胸口上。

他浑身是红的、皱的，头发湿湿地贴着。他在哭，哭得很用力，小拳头攥着。

苏晴把一只手托在他的背上，另一只手不知道往哪儿放。

她没有说话。

可是几十秒之后，孩子的哭声慢慢变小了。他的头在她胸口上转了转，嘴巴张开，像是在找什么。

江远站在旁边，眼睛红着，手里拿着手机，却忘了拍。

护士在一旁轻声说：“好，让他在这儿待一会儿，一个小时左右，不要打扰。”

这一个小时在新生儿科里有一个名字，叫“黄金一小时”。

这一章就讲这一个小时，和接下来的几天里孩子是怎么“认得”母亲的。

◆ 二、他认得什么

先回答一个问题：新生儿认得母亲吗？

要看你问的是什么“认”。

如果问的是：他能不能看着一张脸说“这是妈妈”？目前的证据是不能。新生儿的视力很弱，第 1 章讲过。〔强〕

可是如果问的是：他对母亲有没有一种“更熟悉”的反应？有，而且是多个通道的。

声音。第 3 章和第 6 章讲过，新生儿更偏爱母亲的声音，而不是陌生女人的声音。〔强：1980 年 DeCasper & Fifer，后来有多个重复研究〕

气味。这是一个很有意思的通道。

有一项瑞典的研究，让出生才几天的母乳喂养的新生儿在两块胸垫之间选择：一块是自己母亲的，一块是另一位哺乳期母亲的。大多数孩子把头转向了自己母亲的那一块。〔中：Varendi 等，20 世纪 90 年代，样本不大，细节待核〕

还有研究发现，羊水的气味和母乳的气味有一些相似的成分。孩子在子宫里已经“闻”过羊水，出生后对类似的气味更容易有积极的反应。〔中：来源是综述性介绍，原始文献待核〕

心跳。孩子把耳朵贴在母亲的左胸口，听的就是他在子宫里听了九个月的那个节律。不少研究发现，把新生儿放在母亲胸口比放在别处，孩子更容易安静，心率、呼吸、体温更容易稳下来。〔中〕

触觉。母亲皮肤的温度约三十六七度，和子宫的温度接近。母亲的皮肤软，暖，有一点点湿润。孩子贴上去，全身都是熟悉的“被包着”的感觉。

你看，这几个通道几乎都是在子宫里已经“预习”过的。

所以更准确的说法是：新生儿不是认得母亲的“脸”，而是认得母亲的“声音、心跳、气味、体温”。他认得的是“一整个熟悉的环境”。

◆ 三、他会自己找

在黄金一小时里，还有一个很值得讲的现象。

如果把刚出生的孩子放在母亲的腹部，不去打扰，也不去推他，很多孩子会在三十到九十分钟里自己慢慢往上爬。爬向乳房，找到乳头，自己含上去，吸起奶来。这个过程叫“乳房爬行”。〔中：瑞典团队在 1987 年的研究以后，被多次观察到，不是每个孩子都能做到，时间有个体差异〕

这是怎么回事？

研究者认为，孩子靠的是几个线索：

一是气味。乳晕上的小腺体会分泌一种有气味的液体，孩子对这种气味很敏感。

二是触觉。他的手会去碰母亲的皮肤，他的嘴会去探。

三是视觉。乳晕的颜色比周围深，对比强。第 1 章里讲过，新生儿对黑白对比最敏感。〔中：这个解释是推测，不是已经被验证的因果〕

这一个现象很符合本书的主张：

孩子不是被动地“等着被喂”。他在“找”。他用的是在子宫里练过的那些能力：触、嗅、动，还有刚刚到场的、一点点的视觉。

母亲所做的事不是“教”他，而是“不打扰”，并且“在那儿”。

在这个意义上，母亲的“E”不是指要做很多事，而是指：稳着，暖着，不走开。

◆ 四、袋鼠式护理：一个很简单，却很有分量的办法

现在我们要讲一个在新生儿医学里很重要的方法：袋鼠式护理。

这个办法起源于 1970 年代末的哥伦比亚首都波哥大。当时那家医院保温箱不够，早产儿死亡率很高。医生们想了一个办法：让母亲把只穿着尿布的早产儿直接贴在自己赤裸的胸口上，用衣服裹住，整天抱着。像袋鼠一样。

〔核：这是该方法的公认起源，具体年份和人物细节待核〕

结果出乎意料：孩子的存活率和住保温箱的相比没有变差，甚至更好。

这种方法后来在全世界做了大量的研究。

2021 年，世界卫生组织协调了一项大型研究。研究在印度、加纳、马拉维、坦桑尼亚、尼日利亚的医院里进行。对象是出生体重在 1 公斤到 1.8 公斤之间的婴儿。

研究比较两种做法。一组是一出生、尚未稳定时就开始持续的袋鼠式护理。另一组是先在保温箱里稳定，再转入袋鼠式护理。结果前者的死亡率比后者低了约四分之一。〔强：发表于《新英格兰医学杂志》2021 年，大型随机对照试验；具体数字请以原文为准〕

还有一项系统综述汇总了多项研究，发现袋鼠式护理可以降低低出生体重婴儿的死亡率，降低严重感染的风险，有助于母乳喂养，有助于体温稳定。

〔强：Cochrane 综述等〕

袋鼠式护理里到底有什么在起作用？

从医学上说有这几条：

一是保暖。母亲的胸口是一个活的、会调节的“保温箱”。研究发现，母亲的皮肤温度会随着孩子体温的变化自动调节，孩子冷的时候升高，热的时候降低。〔中：个别小样本研究发现，机制仍在探讨〕

二是稳定呼吸和心跳。

三是促进母乳喂养。

四是减少感染。母亲身上的菌群对孩子来说是“熟悉”的，会占据孩子皮肤上的位置，减少有害细菌的机会。〔中〕

而从本书的角度还有第五条：

五是把子宫里的“触、声、心跳、体温”的节律还给孩子。

这一点正好是第8章结尾时讲的原则：把母亲给过的东西还给孩子。

◆ 五、父亲也可以

袋鼠式护理不是只有母亲才能做。

很多研究发现，父亲或者其他的照料者赤裸胸口贴着孩子，也可以让孩子的体温、心率、呼吸稳定下来。在母亲因剖宫产、身体虚弱不能马上抱孩子的时候，父亲的皮肤接触对孩子很有帮助。〔中：多项研究，对长期结局的影响，证据在积累〕

还有研究发现，做过袋鼠式护理的父亲和孩子之间的情感联系更强，在孩子出生后几个月里更多地参与育儿。〔中：观察性研究为主，难以排除“本来就更愿意参与的父亲，更愿意做袋鼠式护理”这种可能〕

这里有一个很重要的位置：

母亲如果因为各种原因不能马上和孩子接触，孩子并不会就这样“错过”。有别的人可以接上。

这一点在后面第 13 章和第 14 章讲“主要照料者可以是谁”的时候会再展开。

◆ 六、一个需要说清楚的地方：不要过度承诺

讲到这里需要小心。

很多网络文章会把“出生后的皮肤接触”说得很神奇，好像错过了黄金一小时，孩子的一生就受了影响。

这是不对的。

目前的证据只能支持以下几件事：

对早产儿和低出生体重儿，袋鼠式护理可以降低死亡和感染的风险。

〔强〕

对足月儿，出生后立即的皮肤接触对母乳喂养的启动、对孩子体温和血糖的稳定有帮助。〔中：多项研究，Cochrane 综述有这方面的结论，证据强度中等〕

至于“黄金一小时”对孩子长期的智力、情绪、母子关系有多大影响，目前的证据不够充分，也不够一致。〔中：有一些研究发现，早期皮肤接触对母子互动有一定的积极影响，可是效果持续时间不确定〕

所以如果你因为剖宫产、孩子需要治疗、母亲需要抢救而错过了黄金一小时，请你不要自责。

孩子的 SDE 不是一个小时里就“定了”的。它是后面一天一天、一个月一个月累起来的。

这个原则会贯穿本书：

“好的开始”是有用的；可是“好的持续”更有用。“开始错过了”是可以补的。

◆ 七、出生后第一周：一张可以照着做的单子

前面讲了道理。这一节把第一周的做法排成几条。你不用全做到，挑做得到的做就好。

一，皮肤接触。

母子状况平稳时，可以让孩子只穿尿布，趴在你的胸口，用一条干毯子盖住他的背。时间能长就长，不到一小时也有用。〔中：多个指南推荐，对足月儿的益处主要在喂养启动和体温稳定〕

接触的时候要有人看着。孩子的口鼻不能被遮住，脸朝向一侧，下巴不能压在胸口。你太困的时候，请家人接手。〔中：极少数孩子在出生后头几个小时会出现呼吸问题，所以要有人留意〕

二，喂养。

新生儿饿了，会先有早期信号：舔嘴唇，嘴巴一动一动，头转来转去，手往嘴边送。哭是晚期信号。〔中：母乳喂养指导中常见的说法〕

所以最好在他还没哭的时候就喂。这样他不会又饿又急，你也比较好配合。

前几天的初乳量少而浓，对刚出生的孩子是够的。〔强：母乳喂养基础知识〕常见的建议是 24 小时里喂 8 到 12 次左右。〔中：各指南的说法略有不同〕

孩子出生后几天体重会下降一点，之后回升，多数在两周左右回到出生体重。〔中：有个体差异，请以儿科医生的评估为准〕

如果你没有选母乳，或者奶暂时不够，也一样可以贴着孩子喂。抱着他，看着他，让他听到你的声音。这些不会因为一只奶瓶而消失。〔解释〕

三，气味。

孩子对气味敏感，前面讲过。所以头几周，尽量少用气味浓烈的香水和洗护用品。你自己的味道，就是他最熟悉的味道。〔解释：由孩子的气味偏好推出的建议，没有直接试验〕

不用为这个少洗澡。你正常洗澡，他照样认得你，因为他同时在用声音、心跳和体温认你。〔解释〕

四，声音。

贴近他的时候，低声说话，叫他的名字，哼你孕期哼过的曲子。这是第 6 章讲过的偏好的延续。〔中〕

音量像平常说话就好。电视和手机的声音先放到一边。〔解释〕

五，睡觉。

新生儿一天里大部分时间在睡，加起来常有十几个小时，分成很多小段。

〔强：儿科常识，个体差异大〕

安全睡眠请听儿科医生的。一般建议让孩子仰着睡，睡在平整较硬的床面上，床里不放松软的枕头、被子和玩具。〔强：儿科学会的常见建议，各国略有差异，请遵医嘱〕

六，访客和家人。

第一周的访客请尽量少一点，短一点。来的人先洗手，感冒、发热、腹泻的人先不要来。新生儿的免疫系统还没有长成，接触的人越杂，感染的机会越多。〔强：新生儿感染预防的常规建议〕

你可以把这件事交给丈夫去说。“现在孩子和妈妈需要休息”，这是一句完全站得住的话。〔解释〕

◆ 八、剖宫产之后，或者和孩子分开的时候

不是每个家庭的第一周都能照上面做。下面讲两种常见的情况。

先说剖宫产。

剖宫产不是皮肤接触的障碍。不少医院在手术室里就能让孩子贴在母亲的胸口或脸侧，前提是母子状况允许，也要看医院的条件。〔中：有研究表明剖宫产后皮肤接触可行，各院做法不同〕

如果手术室里没能做到，等你回到病房、麻醉过去以后，可以补上。在这之前，请父亲先接。〔解释〕

喂奶的姿势可以请护士帮忙调整。侧躺，或者把孩子夹在手臂旁边，都能让他不压到伤口。〔中：常见的护理做法〕

剖宫产以后，下奶常常晚一点。这是常见的情况，不是你的奶“不行”。
〔中：有研究发现剖宫产后乳汁增多的时间平均略晚，个体差异大〕

再说和孩子分开。

孩子在新生儿科的时候，护士会告诉你什么时候可以摸，怎么摸。常见的做法是把手稳稳地放在孩子身上，不来回抚摸。因为早产儿对轻轻的抚摸可能反应过度，稳稳的手反而让他安静。〔中：新生儿科的常见做法〕

你可以把一小块布贴身放几个小时，再带去放在孩子身边，让他闻到你。
〔中：不少新生儿科这样做，证据多来自小研究〕

你可以在床边轻声对他说话，读几页书，哼歌。要先问护士允许。〔中〕

你也可以把奶挤出来送去。母乳对早产儿有较多的好处，医护会告诉你怎么挤、怎么存。〔中：多项研究，具体做法请听新生儿科〕

如果你挤不出来，或者选了别的办法，也不用自责。你来了，你在，这件事本身就是接应。〔解释〕

还有一件事：你自己要吃饭，要睡觉。你垮了，孩子的接应就少了一个人。〔解释〕

◆ 九、周女士第一次抱孩子

周女士第一次把孩子抱在胸口上，是在孩子出生后的第二周。

那天护士把椅子搬到保温箱旁边，帮她解开衣服。孩子身上还贴着电极和细管子。护士一点一点把他从箱子里抱出来，放在她的胸口。

周女士浑身僵着，连气都不敢大声喘。

护士说：“你不用做什么，你就坐着。”

过了十来分钟，她的肩膀才松下来。孩子的呼吸也慢慢匀了。

这个故事想说的是：接应有时候不需要做任何事。在场，稳着，暖着，就已经是在做。

◆ 十、常见的几个问题

问：孩子出生后一小时内没有吸上奶，是不是错过了？

答：不是。不少孩子需要更长的时间，或者更多次尝试。请护士或哺乳顾问帮你调整姿势。〔中：母乳喂养的启动有个体差异〕

问：孩子放下就哭，一抱就好，是不是被惯坏了？

答：前几个月不用担心这个。他刚离开一个“永远被包着”的地方，想要贴着人是正常的。下一章会讲这一点。〔中：见第10章，证据以观察性研究为主〕

问：我太累了，能不能抱着孩子在沙发上睡？

答：不要。大人困倦时抱着孩子睡在沙发或扶手椅上，风险比睡在床上更高。如果实在撑不住，请把孩子放回他自己的床上，或者请家人接手。〔强：儿科学会的安全睡眠建议〕

问：爸爸没有奶，能做什么？

答：能做很多。皮肤接触，换尿布，洗澡，拍嗝，夜里接手一次喂奶后的哄睡。这些都能让孩子认得他的体温和声音。〔中：多为观察性研究和临床经验〕

问：孩子是配方奶喂大的，会不会和我不亲？

答：没有可靠的证据说明喂养方式本身决定亲不亲。亲近来自喂的时候的怀抱、眼神和声音。〔中：多数研究在控制家庭因素后差异小〕

问：早产儿也能像足月儿一样做皮肤接触吗？

答：多数能，要先由新生儿科医生评估他当时稳不稳。稳的时候，护士会帮你。〔强：袋鼠式护理的推荐对象正是早产儿和低出生体重儿〕

问：奶水很少，孩子会不会饿着？

答：前几天的奶量本来就少，孩子的胃也很小，这是正常的。〔强：母乳喂养基础知识〕真正要留意的是他的尿布和精神：每天有足够的湿尿布，醒着时有精神，就是好迹象。如果你担心，请找哺乳顾问或儿科医生看一下。

〔中：具体判断标准请以医护为准〕

◆ 十一、苏晴的夜里：《晚安，月亮》

产后第二天的夜里，苏晴抱着孩子，坐在床沿上喂奶。

孩子吃完，眼睛半睁着，不肯睡。她随手拿起床头那本薄薄的绘本，就是孕期读过的那一本，低声一页一页念起来。

念到第三页，孩子的眼皮慢慢合上了。

苏晴不敢说这是孩子“认得”这本书。这件事没有办法证明。也许只是夜深了，他吃饱了，他困了。

不过她自己觉得安心。那个熟悉的调子，是她和孩子之间留下来的一条线。

本书借这个小场景提醒你：你不必证明孩子认得什么。把熟悉的东西继续给他，你和他就都稳了一点。〔解释：本书的看法，不是实验结论〕

◆ 十二、放回日子里

苏晴的孩子出生的第三天，夜里哭得特别厉害。

那是产后第三天，孩子的体重比出生时降了一点，这是新生儿常见的生理性体重下降。护士来看过，说一切正常。

可是他还是哭。苏晴抱起来，喂奶，他吃一会儿，松开，又哭。换尿布，不是。拍嗝，不是。

她累得眼泪都要下来了。

这时候江远把孩子接了过去。他把自己的上衣脱了，只穿一件背心，把只包着一块小毯子的孩子贴在自己赤裸的胸口上，用手托着。

他说：“你睡一会儿，我抱。”

孩子在他的胸口上哭了几声，慢慢地安静了。

他的头贴着江远的左胸口，听着一个不是母亲的心跳。可是同样是一个有节律的、热的、稳的心跳。

苏晴躺在床上，睡着了。

那一晚，江远抱着孩子坐在靠椅上，坐了两个多小时，腿都麻了，没有动。

第二天，苏晴问他：“你怎么想到这样抱的？”

他说：“护士教的。她说，爸爸也可以。”

这一幕在 SDE 里意义很大：

孩子第一次发现，除了母亲，还有一个人也是“稳的”。这是第二条回路的萌芽。

可是这条回路不是替代第一条，而是在第一条累了的时候托住它。

带走的话

新生儿认得的不是母亲的脸，而是她的声音、心跳、气味和体温。这些是他在子宫里已经熟悉的东西。把这些东西在出生后尽量地还给他，是最朴素也最有效的开始。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
新生儿偏爱母亲的声音	〔强〕	DeCasper & Fifer, 1980, 后有多项研究重复
新生儿对母亲胸垫气味有偏好	〔中〕	Varendi 等, 细节待核
羊水和母乳气味有相似成分	〔中〕	综述性介绍, 原始文献待核
新生儿贴母亲胸口更容易稳定	〔中〕	多项研究
乳房爬行	〔中〕	多次观察到, 不是每个孩子都能做到
袋鼠式护理起源于哥伦比亚	〔核〕	公认起源, 细节待核
出生即开始的袋鼠式护理使体重 1—1.8 公斤 婴儿死亡率下降约四分之一	〔强〕	NEJM, 2021, WHO 协调的随机试验, 数字以原文为准
袋鼠式护理降低低出生体重儿死亡和感染	〔强〕	Cochrane 综述等
母亲皮肤温度随婴儿体温变化	〔中〕	小样本, 机制待研究

说法	证据级别	说明
父亲的皮肤接触同样有帮助	〔中〕	多为观察性研究
足月儿出生后立即皮肤接触有助于喂养启动	〔中〕	有综述支持
母子平稳时尽早皮肤接触，对喂养启动和体温稳定有帮助	〔中〕	多个指南推荐
皮肤接触时需有人留意孩子口鼻与呼吸	〔中〕	极少数孩子早期有呼吸问题
早期饥饿信号先于哭泣	〔中〕	母乳喂养指导的常见说法
初乳量少而浓，对新生儿足够	〔强〕	母乳喂养基础知识
常见建议 24 小时喂 8 到 12 次	〔中〕	各指南说法略有不同
新生儿体重先降后升，多在两周左右回到出生体重	〔中〕	个体差异，请遵医嘱
少用浓香洗护用品，保留母亲自身气味	〔解释〕	由气味偏好推出，无直接试验
新生儿一天睡十几个小时，分多段	〔强〕	儿科常识，个体差异大
仰睡、平整较硬床面、不放松软物	〔强〕	儿科学会建议，请遵医嘱
剖宫产后皮肤接触可行	〔中〕	各院做法不同
剖宫产后下奶平均略晚	〔中〕	个体差异大
早产儿稳稳放手比来回抚摸更易安静	〔中〕	新生儿科常见做法
带有母亲气味的布放在孩子身边	〔中〕	多来自小研究
挤奶送去对早产儿有较多好处	〔中〕	请听新生儿科指导
抱着孩子睡沙发风险高于睡床	〔强〕	儿科学会安全睡眠建议
喂养方式本身不决定亲近程度	〔中〕	多数研究控制家庭因素后差异小
早产儿可在评估稳定后做袋鼠式护理	〔强〕	本章前文证据
父亲也可以做皮肤接触并让孩子稳定	〔中〕	见前文，多为观察性研究

说法	证据级别	说明
第一周少接待访客，来访者先洗手，生病者暂不来	〔强〕	新生儿感染预防常规建议
熟悉的绘本和调子是亲子间的“一条线”	〔解释〕	本书的看法，不是实验结论
前几天奶量少属正常，看尿布与精神状态	〔强〕	具体标准以医护为准

个体情况，比如母亲或孩子需要抢救、早产儿的护理方式，请遵医嘱。

第 10 章

他怎么接得上外面的世界：一套预习过的本事，和一个不能少的人

◆ 一、凌晨两点的哭

孩子出生后的第十天，苏晴和江远第一次真正地觉得“撑不住”。

凌晨两点，孩子哭。喂奶，吃了一点，不吃了。换尿布，是干的。抱起来，他把脸扭向一边，哭得更凶。

江远在地上走来走去，抱着孩子晃。他一边晃一边说：“他到底要什么？”

苏晴靠着床头，脑子里一片空白：“我也不知道。”

两个人对着一个十天大的孩子手足无措。

这一幕很多新手父母都会经历。

这一章要回答一个问题：一个这么小的孩子，什么都不会，怎么就能“接得上”这个世界？

答案有两部分：一部分在孩子身上，是他带来的一套本事。另一部分在孩子身外，是一个不能少的人。

◆ 二、他带来了什么

先看孩子带来的这一部分。

新生儿常被说成“什么都不会”。这不准确。他会的东西不少。下面选几样和本书有关的，一样一样说。

第一，反射。

你把一根手指放进新生儿的手心，他会握住。这叫抓握反射。你轻轻碰他的脸颊，他会把头转向你碰的那一边，张开嘴，这叫觅食反射。你把东西放到他的嘴里，他会吸，这叫吸吮反射。〔强：新生儿检查的基础内容〕

这几个反射都是触觉的。你看，它们不是“学来的”，是子宫里已经练过的。吸吮在孕十五周左右已经能在超声里看到。〔中〕

这些反射对孩子的意义是什么？是让他一出生就能和一个人“接上”：你的手指，他握着；你的乳房，他含着。握和含都是“来回”的开头。

第二，注意。

新生儿醒着的时候不多，可是醒着的时候他会盯着东西看。他看得最清楚的距离大约在二三十厘米，差不多是抱着孩子喂奶时母亲的脸到孩子眼睛的距离。〔中：这个距离的说法，在新生儿视觉研究中常被提到，具体数值各家略有不同〕

第 1 章讲过，他的视力很弱，看不清细节，对黑白对比的东西更敏感。他对移动的东西也更容易注意。

关于新生儿是否天生偏爱“像人脸的图案”，学界有过很多讨论。有的研究发现，出生几十分钟的新生儿对有“两只眼睛、一个嘴”布局的图案，比对打乱布局的图案注意得更久。也有研究者对这个发现有不同的解释，认为他们偏好的是图案的某种整体特征，不是“脸”本身。〔有争议：Johnson 等的经典研究，后来有多个重复和不同解读〕

本书的立场是：不依赖这个发现。就算它是真的，我们也只能说孩子对“人脸”这一类刺激有一点点倾向。不能说他已经“认得人”。

第三，对声音的反应。

这是第 6 章讲过的：他偏爱母亲的声音，偏爱起伏大、节奏慢的“妈妈语”。

第四，一件有争议的事：模仿。

曾经有一个很著名的研究，声称刚出生几十分钟到几天的新生儿会模仿大人吐舌头、张嘴巴。这件事在心理学界影响很大，很多教科书都写了。

不过 2016 年有一个大型研究，在澳大利亚追踪了一百多名新生儿。在出生后第一周到第九周之间多次测试，对十几种不同的动作，包括吐舌头，没有发现稳定的模仿。原来做过相关研究的团队随后又对这个研究提出了批评，认为测试方法有问题。争论至今没有完全平息。〔有争议：Oostenbroek 等 2016，以及 Meltzoff 等 2018 的重新分析〕

本书不倚仗“新生儿天生会模仿”这件事。因为就算它不成立，下面要讲的也同样成立。

◆ 三、一张小表：新生儿的几样本事

前面一样一样讲过了。这里收成一张小表，方便你对照着看。

本事	你能看到什么	大概什么时候淡去	证据
抓握反射	手指放进手心，他会握住	约 5 到 6 个月	〔强〕
觅食反射	碰他的脸颊，头转过去，张开嘴	约 3 到 4 个月	〔强〕
吸吮反射	嘴里有东西就吸	慢慢变成有意识的吸	〔强〕

本事	你能看到什么	大概什么时候淡去	证据
惊吓反射	突然的响动或失去支撑，两臂张开再抱回来	约 4 到 6 个月	〔强〕
踏步反射	被扶着站在平面上，两脚会交替动	约 2 个月前后	〔中〕
偏爱熟悉的人声	听到熟悉的声音会安静下来	不消失，会更丰富	〔强〕
尝味	对甜味反应偏正面，对苦味会皱眉	一直都在	〔中〕
痛觉	针刺会哭，皱眉，心跳加快	一直都在	〔强〕

消失的时间有个体差异，早产儿要按矫正月龄来看。反射该淡去的时候还在，或者总是一侧强、一侧弱，请让儿科医生看一下。〔强：新生儿神经检查的常规内容，请遵医嘱〕

这些本事有一个共同点：它们不是谁教的，是孩子自己带来的。

可以拿手机来打个比方。孩子像一部出厂时已经装好基础功能的手机，一通电就能用。可是里面没有你的通讯录。通讯录要靠往后的日子，一个一个存进去。〔解释：本书的比喻〕

◆ 四、他最重要的一项本事：会“发信号”

好，我们把这些能力往后放。看孩子带来的最重要的一项本事是什么。

是哭。

哭不是“不乖”，不是“闹”，不是“无理取闹”。

哭是他唯一的、最有效的“显露”。他饿了、冷了、痛了、困了、被吓到了、太闹腾了，都用哭来告诉另一个人。

对一个刚出生的孩子来说，这是一项了不起的生存本事。他不会说，不会指，不会动，可是他会哭，而且哭声会让大人几乎无法不管。

研究发现，婴儿的哭声会引发成年人的生理反应。成年人听到婴儿的哭声，心率、皮肤电反应都会发生变化。这种反应不是母亲独有的，父亲和没有孩子的成年人也会有。〔中：多个实验室研究〕

所以哭是 SDE 里的一个“显露”：孩子把他内部的“不同”显出来，递给外面。

然后需要有人接。

◆ 五、怎么“读”一天里的信号

回到凌晨两点的那个问题：他到底要什么？

新生儿不会说话，可是他一天里的状态是有规律的，也有信号。读懂一点，你会少猜很多次。

先看状态。常见的分法有五六种，本书只留四种。〔中：新生儿行为评估里常用状态分类，各家分法略有不同〕

深睡。一动不动，呼吸均匀，吵不醒。这时候不用叫他，也不用把他抱起来。

浅睡。眼皮底下的眼珠在动，会皱眉、抽动、哼唧。这常常不是醒了，不要马上去抱。〔强：新生儿有活跃睡眠，表现为动作和声音〕

安静清醒。眼睛睁得亮亮的，身体不太动，盯着东西看。这是最适合“来回”的几分钟。

哭闹。他在告诉你有什么不舒服，或者已经太累了。

再看信号。孩子想靠近的时候，眼睛亮，盯着你，手放松，嘴巴轻轻动，身体是软的。

孩子想歇一歇的时候，会转开头，打哈欠，打嗝，手指张开伸直，眼神飘走，皮肤发红发花，最后是哭。〔中：新生儿行为观察中的常见描述，个体差异大，不是诊断标准〕

看到想歇的信号，就放慢，放轻，减少刺激，抱着不动。

下面是一张一天的小表，只当参考。

时段	常见的样子	你可以怎么做
刚喂完	满足，常有几分钟安静清醒	对他说话，让他看你的脸
醒了一阵以后	打哈欠，揉眼睛，眼神发直	他困了，放低声音，包好，哄睡
夜里	浅睡时哼唧，醒来要吃奶	先等几十秒，看是真醒还是浅睡
傍晚	不少孩子这段时间哭闹更多	抱着走动，灯暗一点，少刺激

傍晚哭闹偏多，很多家庭有这样的观察，原因并不完全清楚。〔中〕

孩子的哭闹大约在出生后 2 周左右开始增多，6 到 8 周前后最多，之后慢慢减少。〔中：多项研究，具体周数各家略有不同〕

哭的时候可以按这个次序试：饿不饿，尿布湿不湿，冷不冷热不热，困不困，是不是太吵太亮，是不是只想被抱着。次序没有对错，试到哪一样都行。

有几种情况不要在家里猜，请马上就医：3 个月以内的孩子体温达到 38 度以上；喂不进东西；叫不醒；呼吸费力；肤色发青，或者黄得明显加重。

〔强：儿科常规建议，请遵医嘱〕

◆ 六、那个不能少的人

这是这一章的核心。

孩子带来的这一套本事是一套“预习”。可是预习不是考试。真正让他“接上”这个世界的是第二部分：外面有人接着。

我们设想一下，没有这个人会怎么样？

孩子饿了，哭，没有人来。他会继续哭，哭到累，然后睡去，或者因为太累、太无助而安静下来。下一次饿了再哭，仍然没有人来。

他在这里接到的“不同”是什么？不是“我哭，有人来”，而是“我哭，什么也不变”。

一次两次不要紧。如果每天、每周、每月都是这样，会发生什么？后面第 12 章和第 13 章会讲到底会发生什么。现在只要知道一件事：

回应不是“礼貌”，不是“溺爱”，是孩子学习“我做的事会改变外面的世界”的材料。

这是 SDE 里最基本的一环：我发出一个不同，外面回应了，下一次我遇到的不同就变了。

如果这一环断了，孩子就失去了最早的、最基本的“我能够”的证据。

那么需要怎样的“回应”呢？

是不是孩子一哭就必须抱起来，不能让他哭一秒钟？

不是。

后面的第 13 章会细讲。这里先说一个很多新手父母担心的问题：

“抱多了，会不会宠坏他？”

对于前几个月的孩子，答案是：不会。

早期的一些研究，比如 1970 年代心理学家们做过的追踪观察，发现了一个现象。在第一年里，更及时回应婴儿哭泣的母亲，孩子在第一年的后半年里哭得反而更少，更能用别的方式表达需求。〔中：Bell & Ainsworth, 1972, 样本很小，后来有过争议和重新分析，不能当成定论〕

后来更多的研究倾向于认为，在婴儿期，对哭泣的敏感回应和安全型依恋有关联；不存在“抱多了就宠坏”的证据。〔中：不同研究结论大体一致，但因果关系较难证明〕

从这个意义上说，前几个月不需要担心“宠坏”这个问题。

◆ 七、第四个孕期

有一个说法近年来很流行：新生儿的头三个月叫“第四孕期”。

意思是：孩子虽然出生了，可是他在很多方面还没有准备好面对外面的世界，仍然需要子宫里那样的条件：暖，被包着，有节律，有声音，随时被喂。

这个说法不是一个严格的医学术语，不过它很准确地抓住了一件事：新生儿是一个在子宫外面、却还在“延续子宫”的孩子。

为什么？有一种常见的解释是：人的大脑比较大，而产道受骨盆的限制，所以人类的婴儿出生时比很多哺乳动物更“不成熟”。〔中：这是进化生物学里的一种假说，叫“产科困境”，也有不同意见〕

所以在头几个月里有一件事很重要：尽量让孩子的世界不要“陡”。

这是什么意思？

把孩子裹得紧一点，暖一点。让他听到熟悉的声音。让他在你怀里、在你胸口睡着。晃一晃，走一走，像母亲怀着他的时候那样。

这些做法在不同文化里都有。比如：包襁褓，抱着走，摇篮，哼歌。

不过有一点要注意：襁褓包得不对会影响髋关节发育，睡觉时也有窒息的风险。包的方式要请医护人员指导，不要自己随意。〔强：儿科学会均有相关建议，请遵医嘱〕

◆ 八、周女士带孩子回家的第一晚

周女士带着孩子回家的第一晚，几乎没有睡。

孩子出院时，从出生算起已经七周多了。可是儿科医生告诉她，看发育要按“矫正月龄”来算：从原本的预产期算起。〔强：早产儿的发育评估常用矫正月龄，通常用到 2 岁左右，具体请遵医嘱〕

按这个算法，他还没有到原本的预产期。

她问医生：“他怎么还不对我笑？”医生说：“按预产期算，他还没出生呢。你再等等。”

半夜孩子哭了。周女士把手稳稳地放在他的胸口上，一动不动，像在医院里那样。

孩子哭了一会儿，慢慢安静下来。

这个故事想说的是：医院里有效的做法，可以原样带回家。矫正月龄也提醒你，不要拿别人家的孩子来量自己的孩子。

◆ 九、苏晴的“信号本”

第二周起，苏晴在床头放了一个小本子。

她不写大道理，只记三样：几点醒，醒的时候是什么样，什么办法管用。

写到第七天，她发现了一个小规律：每天傍晚六点前后，孩子总要闹一阵；抱着在屋里慢慢走，把灯调暗，十来分钟就好。

她把这一页拿给江远看：“你看，他不是没有规律，是我们以前没记。”

江远说：“那以后六点我来。”

这个小本子没有教给他们任何新知识。它只做了一件事：把“猜”变成了“认得”。认得，就是回路接上的开始。〔解释：本书的看法，记录本只是一种帮助观察的小办法，不是必须〕

◆ 十、常见的几个问题

问：孩子每天傍晚哭得停不下来，是肠绞痛吗？

答：有一种说法叫婴儿肠绞痛。常用的经验标准是：健康的婴儿每天哭三小时以上，每周三天以上，持续三周以上。〔中：这是常用的经验标准，原因并不清楚〕多数孩子到 3 到 4 个月时会自己好转。〔中〕

先请儿科医生排除别的问题。你能做的是抱着，安抚，也要记得换人休息。

无论多烦，都不能摇晃孩子。如果快撑不住了，把他放在安全的床上，走开几分钟，喘口气再回来。〔强：这是预防婴儿摇晃的常规建议〕

问：新生儿一天要睡多久才正常？

答：常说一天睡十四到十七个小时左右，分成很多小段。〔中：个体差异很大，只当参考〕

问：他是不是对我笑了？

答：睡着时嘴角一动一动的笑，多半是反射。真正对人笑的“社会性微笑”，多在出生后 6 到 8 周前后出现。〔强：发育儿科学常识，早产儿按矫正月龄算〕

问：要不要让他自己哭一会儿，学会安静？

答：前几个月，孩子还没有能力靠“忍”来学会自己安静。多数儿科和发育方面的专业意见是，这个阶段哭了就回应。第 13 章会细讲。〔中：专业意见大体一致，证据主要是观察性研究〕

问：爸爸怎么抱都哄不住，是爸爸不行吗？

答：不是。不同的人抱法、气味、声音都不一样，孩子需要时间熟悉。换个人，换个姿势，是常见的办法。能有多“稳的人”，对孩子是好事。〔解释〕

问：我产后总想哭，是不是出了问题？

答：产后头两周情绪起伏、爱哭很常见，不少母亲都会经历，多数在两周内慢慢好转。〔强：产后情绪低落是常见现象〕

如果超过两周仍然很低落，吃不下睡不着，或者有伤害自己或孩子的念头，请马上找医生。这不是软弱，是一种常见的、可以治疗的状态。〔强：请遵医嘱〕

问：他总是打嗝、打喷嚏、下巴发抖，要紧吗？

答：新生儿打嗝、打喷嚏、下巴或手轻轻发抖都很常见，多数不要紧。

〔强：儿科常识〕如果抖动停不下来，抱住他的手脚也不停，或者同时有吃奶差、精神差、面色变化，请带他看医生。〔强：请遵医嘱〕

问：要不要给孩子用安抚奶嘴？

答：这是一个可以自己选的办法，不是必须。有的建议是：母乳喂养刚刚建立好之前先不用，用的话在睡觉时用，有助于降低婴儿猝死的风险。〔中：不同国家的指南略有不同，请听儿科医生的意见〕

◆ 十一、放回日子里：苏晴和江远，那个凌晨

回到那个凌晨两点。

苏晴和江远折腾了差不多一个小时。后来孩子哭累了，在江远怀里睡着了。

事后两个人都很沮丧。他们觉得自己什么都没做对。

可是如果我们用这一章的眼光再看一遍，就会发现：

孩子哭，有人来了。

孩子哭，有人抱了。

孩子哭，有人试了一样又一样：换尿布，喂奶，拍嗝，晃，走。

这一个小时里，孩子遇到的“不同”是：我一哭，有两个人围着我转。

他不知道你们试了什么，也不知道你们没猜对。他只是在这一个小时里反复地确认了一件事：我哭，会有人来。

这就够了。

“足够好的回应”不是“每一次都猜对”，而是“每一次都在”。

这个词本书在后面会反复使用。

这一章请你记住它。

◆ 十二、本编小结

第三编三章，到这里可以收起来：

第 8 章说，出生是一次大换场。孩子能撑过去，是因为他在子宫里练过了触、听、节律。换场换得早的孩子，需要把子宫里的东西尽量还给他。

第 9 章说，新生儿认得的不是母亲的脸，而是声音、心跳、气味、体温。袋鼠式护理是把这些东西还给孩子。

第 10 章说，孩子带来一套预习好的本事，最重要的是“哭”这个显露。而能让他接得上世界的，是外面有一个人接着。

这三章解释了为什么孩子出生那一刻不是起点，而是一个“接续”。

下一编讲的是 0 到 3 岁。那是这条回路最宽的一段路。

带走的话

孩子带来的是一套在子宫里预习过的本事。让他真正接上这个世界的，是外面有一个人，每次哭都有人来。足够好的回应，不是每次都猜对，而是每次都在。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
新生儿有抓握、觅食、吸吮反射	〔强〕	新生儿检查基础内容
吸吮动作在孕 15 周左右已可见	〔中〕	超声观察
新生儿视觉最清楚距离约 20—30 厘米	〔中〕	数值各家略有不同
新生儿天生偏爱脸样图案	〔有争议〕	有不同解释，本书不倚仗
新生儿天生会模仿吐舌	〔有争议〕	Oostenbroek 2016 与 Meltzoff 2018 争论，本书不倚仗
婴儿哭声引发成年人生理反应	〔中〕	多个实验室研究
及时回应哭泣与后来更少哭相关	〔中〕	Bell & Ainsworth 1972，样本小，有争议
婴儿期敏感回应与安全型依恋相关	〔中〕	相关为主，因果难证
产科困境假说解释人类婴儿“不成熟”	〔中〕	有不同意见
“第四孕期”概念	〔解释〕	非严格医学术语
襁褓使用需遵医护指导	〔强〕	髋关节与窒息风险，请遵医嘱
新生儿抓握反射约 5 到 6 个月淡去	〔强〕	神经检查常规，个体差异
觅食反射约 3 到 4 个月淡去	〔强〕	同上
惊吓反射约 4 到 6 个月淡去	〔强〕	同上
踏步反射约 2 个月前后淡去	〔中〕	个体差异大
新生儿对甜味反应偏正面	〔中〕	观察研究
新生儿有痛觉	〔强〕	儿科共识
反射不对称或该淡不淡需就诊	〔强〕	请遵医嘱
孩子像出厂预装功能的手机	〔解释〕	本书的比喻

说法	证据级别	说明
新生儿状态可分深睡、浅睡、安静清醒、哭闹	〔中〕	各家分法不同
浅睡时有动作和声音，不一定是醒	〔强〕	活跃睡眠，儿科常识
靠近与退开的信号	〔中〕	行为观察描述，非诊断标准
傍晚哭闹偏多	〔中〕	原因不完全清楚
哭闹 2 周前后增多，6 到 8 周前后最多	〔中〕	周数各家略有不同
3 个月内发热 38 度以上等需马上就医	〔强〕	儿科常规建议
早产儿发育评估用矫正月龄	〔强〕	通常用到 2 岁左右，请遵医嘱
肠绞痛的的经验标准与多在 3 到 4 个月好转	〔中〕	原因不清
不可摇晃婴儿，快撑不住时先放下	〔强〕	常规预防建议
新生儿一天睡十四到十七个小时左右	〔中〕	个体差异大
社会性微笑多在 6 到 8 周前后出现	〔强〕	早产儿按矫正月龄
前几个月哭了就回应	〔中〕	专业意见大体一致，证据多为观察性
产后情绪低落常见，多在两周内好转，持续需就医	〔强〕	请遵医嘱
新生儿打嗝、打喷嚏、下巴轻抖多属常见	〔强〕	儿科常识，抖动停不下来需就诊
睡眠时使用安抚奶嘴可能降低婴儿猝死风险	〔中〕	各国指南略有不同
记录醒睡与有效办法，可把猜测变成熟悉	〔解释〕	本书的看法，非必需

个体情况，比如新生儿哭闹、喂养、睡眠安全，请遵医嘱。

第 四 编

0 到 3 岁：回路最宽的三年

这一编四章，讲孩子出生后的三年，那条母子（或主要照料者）之间的回路，怎么一天一天变宽。

第 11 章讲“你来我往”，第 12 章讲话是怎么泡出来的，第 13 章讲依恋和“足够好”，以及主要照料者可以是谁，第 14 章讲最糟的情况会怎样，以及补得回。

四章走完，你会看到：0 到 3 岁是基础和平台，但不是命定。

第 11 章

被回应：0 到 3 岁，智慧是一个“你来我往”的游戏

◆ 一、一个勺子，和一张笑脸

孩子五个月大的时候，开始吃辅食。

那天，苏晴把一小勺米糊递到他嘴边。他张开嘴，含住，皱着眉头，吐出来一半，糊了一下巴。

她笑了，用勺子刮掉他下巴上的米糊，说：“哎呀，不好吃啊？”

孩子看着她，咧开没牙的嘴，也笑了。

她又舀一勺递过去。他张嘴吃，又吐一点，又抬眼看她。

她再笑，再说一句：“哎呀。”

这样一勺，一笑，一句“哎呀”，来来回回，十几个回合。

旁边的江远一直在看。他忽然说：“你们俩是在玩一个游戏。”

苏晴愣了一下：“什么游戏？”

“他吐一下，你笑一下，他再看你。你们在对。”

这句话说得很准。

从这一章开始，我们进入第四编：0 到 3 岁。这一编讲的就是这个游戏，怎么越玩越大，怎么变成一个人一生智慧的“平台”。

◆ 二、先看一个数字

有一个事实值得先说出来。

人的大脑出生时大约是成人大脑体积的四分之一。到一岁长到大约一多半。到三岁长到大约成人的百分之八十多。〔强：脑发育的基础数据，不同研究的具体比例略有差异〕

在这三年里，大脑里神经细胞之间的连接，也就是突触，数量会飞快增加。有研究估计，在婴儿时期，每秒钟可以新形成几十万甚至上百万个新的连接。〔中：这个数字常被引用，来自哈佛大学儿童发展中心的说明，原始文献不易核对，待核〕

后来会有一个“修剪”的过程：用得多的连接保留下来，加强；用得少的被慢慢拿掉。〔强：这个“先增后剪”，是神经发育的基本规律〕

请你记住这个规律，因为它是第 11 章到第 14 章里一个最基本的背景：

0 到 3 岁是大脑“增”得最快、也是“被经验塑形”最强的阶段。

可是这句话又常常被说过头，变成“三岁定终身”“错过三岁就完了”。本书要明确地说：这是过度解读。

比较准确的说法是：这个阶段大脑对经验特别敏感。经验在这个阶段留下的痕迹特别深。这就是为什么本书把 0 到 3 岁叫作“基础和平台”。

注意，是“基础”，不是“定数”。基础可以在上面再盖房子，也可以在后面修补。

◆ 三、什么样的经验，最要紧

那么什么样的经验对 0 到 3 岁的孩子最要紧？

是给他买早教班？是买教具？是放英语？是给他看识字卡片？

这些东西在市场上很热闹。可是在科学的证据里，排在前面的是一件很朴素的事：

有人对他的信号作出了回应。

这件事有一个名字，叫“你来我往”。英文里是“serve and return”，原来是网球的说法：一方发球，对方接球，再打回去。〔强：这是发展心理学里一个被广泛使用的比喻，源自哈佛大学儿童发展中心的科普材料〕

“你来我往”的最小单位是这样的：

孩子发出一个信号：看，指，咿咿呀呀，哭，笑，伸手。

大人接到这个信号，给出一个回应：看他，说话，笑，递东西，抱。

孩子接到这个回应，再发出下一个信号。

这个圈转一圈只要几秒钟。可是一天里能转几十圈、几百圈。几个月里转几万圈。

每转一圈，孩子都在学一件事：我做了什么，外面怎么变了。

这是本书说的“智慧”的最小单位。我们在第 1 章里给它下过定义：分出不同，接成路，回应并改变下一步遇到的不同。

一个孩子每天在和母亲或其他照料者的几百次“你来我往”里反复地练这个定义。

◆ 四、一个经典的实验：静止脸

要更直接地看到“你来我往”的重要性，有一个很有名的实验，叫“静止脸实验”。

做法是这样的：

母亲和婴儿面对面坐着，像平时一样互相玩。婴儿大概两三个月到一岁，坐在婴儿椅上。

先玩两分钟，一切正常：母亲笑，说话，做表情，婴儿也笑，发出声音，伸手。

然后研究者让母亲转过头去一会儿，再转回来。这次她脸上没有表情，一动不动，不说话，不回应，就这样对着婴儿坐大约两分钟。

这个时候婴儿会怎么做？

大多数婴儿会先试着“把妈妈拉回来”：他们笑，伸手，发声，指向，扭动身体。这些动作一个接一个，越来越急切。

如果母亲还是没有反应，婴儿会开始表现出不安：皱眉，别开脸，哭，或者安静下来，目光呆滞，身体缩着。

然后是实验的最后一步：母亲恢复正常，笑，说话，抱起孩子。大多数孩子在几十秒到几分钟里就逐步恢复，重新玩起来。〔强：这是 1970 年代起，由爱德华·特罗尼克等人开创的实验。几十年里被多次重复，在多种文化里都看到类似的反应。反应的强弱因孩子的年龄、气质和母亲的背景而不同〕

这个实验告诉我们几件事：

第一，婴儿从很小开始就期待着“有回应”。当这个期待落空，他们会很明显地不舒服。

第二，婴儿会主动地去修复这个“断掉的圈”。他们不是被动的。

第三，也是最重要的，一旦大人恢复回应，孩子大多数是可以恢复过来的。

请你特别注意第三条。这个实验只有两分钟，而且最后总是有“修复”的。它不是在说“你看，母亲一旦不回应，孩子就完了”。它说的是：回应是孩子期待的东西，修复是可行的。

◆ 五、“完美的回应”，并不存在

接下来要讲一个特别能让母亲松一口气的研究。

特罗尼克和他的同事在后来的研究里，仔细看了母亲和婴儿在正常玩耍时的录像，逐秒地分析。他们发现了一个很出人意料的事：

即使在关系很好、孩子很健康的母婴之间，两个人“对上了”的时间也只占一小部分。

大量的时间是“没对上”的：母亲想逗他，他想看别处；孩子想要，母亲没看懂；孩子笑了，母亲没接。〔中：Tronick & Gianino, 1986 年前后的分析。常被引用的说法是，对上的时间约占三成，其余是没对上或者正在修复。具体数字各研究有出入，待核〕

可是关键是，这些“没对上”很快会有“修复”：母亲发现了，换一个方式，孩子又接上了。

研究者认为，真正重要的不是“从不出错”，而是“出错之后能修复”。

这是一个很重要的发现，也是本书反复要讲的：

足够好，不是完美。

“没对上一修复”这个过程甚至可能对孩子有好处。因为在一次次的“没对上，又对上了”之中，孩子学到了：关系是可以出问题的，出了问题是可以回来的。〔解释：这是研究者的解释，有一些证据支持，直接的因果证据有限〕

你可以想想自己的生活：一个人如果从来没有经历过“吵了架，又和好”，他对“和好”这件事是没有信心的。

所以请每一位母亲先把这件事放下：你不需要每一次都对。你只需要在没对上之后回来。

◆ 六、“来回”是在建造什么

我们再问一个问题：这些“来回”到底在孩子的脑子里建造了什么？

大致有三样东西。

第一样是“我能够”。

孩子哭，有人来。孩子笑，有人笑。孩子伸手，有人给。这些经验累积起来，会形成一种最早的“自我效能感”：我做的事是有用的。这是后来一切主动学习的根。〔中：这是发展心理学的一个核心观点，大量研究支持，直接测量“婴儿的效能感”比较困难〕

第二样是“规律”。

孩子的世界一开始是乱的。可是有人每天在固定的时候喂他，抱他，哄他睡，和他说话。这些规律帮孩子把乱的世界分成一块一块，每一块有一个顺序：先这样，再那样。

这是时间感和“预期”的最早来源。

第三样是“情绪的调节”。

婴儿自己没有办法安慰自己。他的情绪一来，整个身体都被淹没。而母亲通过抱，通过声音，通过节奏，在帮他“降下来”。一次又一次之后，孩子渐渐学会了自己降。〔强：这个“共同调节—自我调节”的发展过程，是发展心理学的共识〕

所以你看，“来回”不是单纯的“感情”，而是在建造孩子一生的基础能力：效能感，时间感，情绪调节。

这三样每一样后来都会变成“智慧”的部分。

◆ 七、一天里的“来回”清单

前面讲了“来回”是什么。现在换一个问法：一天里有哪些时候，可以顺手来几个回合？

答案是：几乎每一个照料时刻都可以。你不需要另外挤出时间。

下面这张表，按一个五个月到一岁的孩子的作息来排。

时段	本来就要做的事	顺手的“来回”
早晨醒来	换尿布，穿衣服	他睁眼，你笑着叫他的名字。他蹬腿，你说“蹬蹬腿”
上午吃奶或辅食	喂	他张嘴你就喂。他别开脸，你就停，等他转回来
洗澡	水，毛巾	你说“水来了”，再把水轻轻淋到他脚上，看他的反应

时段	本来就要做的事	顺手的“来回”
下午玩耍	地垫，玩具	他递你接。你滚球他追。他不理你，你就先在旁边陪着
傍晚	做饭，家务	你一边做一边说话，隔一会儿回头看他一眼
睡前	哄睡	同一首歌，同一个顺序，同一句晚安

这张表里没有一栏写着“教”。

每一行都是你本来就要做的事。区别只在于：你做的时候，有没有留一个空，等他回一下。

再说一句关于“多少”的话。

本书没有“每天要来回几次”的标准数字。因为没有哪项研究给出过一个可靠的、人人适用的数字。〔中：研究多是比较不同家庭之间的差别，没有给出“最低次数”〕

你可以这样想：来回像存零钱。一次一小枚，当时看不出什么。几个月以后，是满满一罐。〔解释：这是比喻，不是实验结论〕

所以一次没接住不要紧。下一次再接就是了。

◆ 八、不同月龄，“来回”长什么样

同样是“来回”，不同月龄的孩子，发球的方式不一样。下面这张表，给你一个大致的对照。

月龄	孩子常见的“发球”	你可以怎么“接球”
0 到 3 个月	哭，盯着人脸看，两个月前后开始对人笑	看着他，说话，抱，及时回应哭声
4 到 6 个月	笑出声，咿呀，伸手够东西	学他的声音，等他再来，和他玩躲猫猫

月龄	孩子常见的“发球”	你可以怎么“接球”
7 到 12 个月	爬，指，递东西，认生，怕你离开	顺着他看，接他递来的东西，离开前说一声
1 到 2 岁	走，说单个的词，说“不”，要自己来	给他两个选择，等他自己试，说出他的感受
2 到 3 岁	说短句，爱问，发脾气，要“我自己”	允许他试，守住几条边界，发完脾气抱一抱

〔中：月龄只是常见的参考，各个孩子差别很大〕

两岁前后的孩子容易发脾气。这是很常见的现象。〔强：幼儿期的常见现象〕

一个常被提到的原因是：他想要的很多，会说的很少。话说不出来，情绪就先出来了。〔中：常见解释，不是唯一原因〕

这时“来回”的做法是：先把他的感受说出来。“你想要那个，没拿到，生气了。”

说完，抱一抱，等他缓下来。道理，可以晚一点再讲。

◆ 九、孩子的信号，怎么读

“来回”的第一步，是读懂他发来的是什么。

婴儿不会说话，信号全在身体和声音里。下面是常见的几类。

饥饿的信号。早的信号是张嘴，转头找，舔嘴唇，把手放到嘴边。大哭是晚的信号。〔中：喂养指导里的常见说法，个体差异大〕

疲倦的信号。揉眼睛，打哈欠，目光发直，变得烦躁，或者突然安静下来。〔中：个体差异大〕

想歇一歇的信号。把头转开，眼神移走，手握成拳，皱眉，身体向后仰。

〔中：个体差异大〕

想玩的信号。盯着你看，眼睛发亮，手脚一起动，发出声音。〔中：个体差异大〕

哭，也是一种信号。对新生儿来说，哭是他唯一的“大声说话”的办法。

多项观察研究发现，婴儿每天哭的总时间，在出生后六周左右最多，以后慢慢减少。〔中：不同孩子差别很大，具体周数因人而异〕

所以孩子头两三个月哭得多，不说明你做错了什么。

读信号有一个要点：读不准是常事。

饿，困，尿湿，太热，太冷，胀气，想被抱，都会让孩子哭。新手父母往往要试几样才找到。试一样，看他的反应，不对就换下一样。

这个“试，看，换”的过程，本身就是一次“来回”。〔解释：本书的看法〕

孩子也在学：我哭了，有人在想办法。

◆ 十、什么叫“要紧”，什么叫“不要紧”

好，讲到这儿，可能有读者心里又紧张起来了：“我家有时候忙，顾不上回应怎么办？”

这是一个很实际的问题。我们看一看证据怎么说。

第一，回应不是时时刻刻。孩子需要的是“大多数时候”有人在，有人回应，并且“修复”断掉的部分。〔中：这是依恋研究的共识，不同研究对“大多数”的量化，不一样〕

第二，回应不需要特别的“教”。日常的活动，比如换尿布、洗澡、吃饭、穿衣服、散步，都可以是“来回”的场景。

第三，不要把“回应”变成“表演”。有研究发现，过度刺激，比如大人一直对着孩子不停地说、笑、逗，不给他“歇”的空间，孩子会转头躲开，甚至哭。〔中：这和婴儿的“信号管理”有关，需要看孩子的状态〕

所以“来回”的节奏由孩子决定。他看过来，你就回。他躲开，你就停。

这样的“跟随”，下一章会讲得更细。

◆ 十一、再看一个夜晚：江远和那一声哭

孩子十个月大的一天夜里，苏晴重感冒，吃了药，睡得很沉。

江远在书房里改一段代码，第二天一早要上线。

十一点多，婴儿房传来哭声。他的手停在键盘上，心里想：再改完这一行。

这一行改了三分钟。

等他走进婴儿房，孩子已经哭得满脸通红。

江远把他抱起来，说：“爸爸来晚了。对不起，对不起。”

孩子在他肩上抽泣了一会儿，哭声慢慢小下去。江远摸了摸尿布，是湿的。他换了尿布，又抱着孩子在屋里走了几圈。

孩子安静下来，趴在他肩上睡着了。

第二天早上，江远对苏晴说：“昨晚我让他哭了三分钟才过去。”

苏晴问：“他后来睡着了吗？”

“睡着了。”

“那就好。”

这三分钟，在本书里算什么？

算一次“没对上”。后面有“来了”“道歉”“换尿布”“抱着走”，这是一次完整的“修复”。〔解释：用“没对上，修复”来读这个场景〕

孩子学到的是：我哭，会有人来。晚一点，也会来。

带走一句：晚了三分钟不是断了，来了才是接上了。

◆ 十二、再看一个下午：苏晴把手机放下来

孩子十一个月的一个下午，苏晴坐在地垫上，一只手刷着手机，一只手扶着孩子。

孩子拿起一个小鼓，朝她举了举。

她“嗯”了一声，眼睛没离开屏幕。

孩子又举了一次，还是没有回应。他把鼓放下，爬走了。

苏晴抬头，看见孩子的背影，心里一下子有点不是滋味。

她把手机扣在沙发上，爬过去，拿起那个小鼓，敲了两下：“咚咚。”

孩子回头，咧开嘴笑了，爬回来，也敲：“咚。”

这一次，她没有再拿手机。

苏晴后来对江远说：“我不是故意不理他。”

江远说：“我知道。他不是也回来了吗？”

本书想说：走神是人之常情。留意到了，转回来，就是修复。这件事不需要自责，只需要转回来。〔解释：本书的解读〕

◆ 十三、常见的几个问题

问：我上班，每天只有两三个小时能陪孩子，够吗？

答：本书没有一个“够”的数字。研究更看重的是你在场时的质量，不只是总时长。〔中：托育研究的大意，见第 13 章〕

下班后的那一段，可以只做一件事：放下手机，和他面对面十几分钟。他看你，你回他。他出声，你接。这就是一整套“来回”。

问：我手机刷得多，会不会影响他？

答：有观察研究发现，大人看手机分心的时候，对孩子信号的回应会变少，也会变慢。〔中：观察性研究，因果和程度仍在研究，待核〕

这不是说看手机就是坏母亲。静止脸实验里，两分钟没有回应，孩子仍然能恢复。〔强：见本章第四节〕

一个小办法：给自己定一段“手机不在手里”的时间，比如喂奶和玩耍的时候。其余时间随意。

问：孩子哭了，我不是每次都能马上去，怎么办？

答：这是常态，不是失败。孩子越小，越需要快一点的回应。随着月龄长大，他能等的时间会慢慢变长。〔中：发展心理学的一般看法，能等多久因人而异〕

你在厨房，可以出声说“妈妈在，马上来”。熟悉的声音本身，能让孩子稍微安定一点。〔解释：本书的说法〕

回来以后，抱一抱，说一句“让你等了”。这就是修复。

问：抱多了会不会惯坏？

答：目前没有可靠的证据说明，对婴儿及时地抱和安抚，会让他变得更爱哭或离不开人。〔有争议：早期有研究发现及时回应的婴儿后来哭得更少，后来的研究结论不完全一致〕

一岁以内的孩子，哭和要抱基本都是需要，不是“要求”。所以这个阶段，不必担心“惯”。

问：回应和溺爱，区别在哪里？

答：回应的是“需要”：饿了，困了，怕了，想靠近。溺爱是把每一个“要求”都满足，包括对他有害的，或者对别人不公平的。〔解释：这是本书的区分方式〕

两岁以后，孩子开始有“我要”。这时需要一些边界，比如不能打人，不能抢。

边界和温暖可以同时有。多项养育风格的研究发现，温暖加上清楚规则的家庭，孩子的适应往往更好。〔中：相关研究，家庭差别很大〕

问：我白天很累，没力气一直逗他，怎么办？

答：不用一直逗。“在”就够了。你坐在地垫上，他自己摆弄玩具，偶尔抬头看你一眼，你对他笑一下。这已经是一个来回。

婴儿也需要自己玩的时间。安静地摆弄东西，也是在学习。〔中：发展心理学的常见看法〕

别把“陪”理解成“表演”。前面说过，逗得太满，孩子反而会躲。

问：我怕自己小时候没被好好对待，不会回应孩子。

答：不用提前给自己下判决。成人依恋研究里有一个说法，叫“后来获得的安全”：有些小时候不太顺的人，后来因为稳定的伴侣、朋友或治疗，在关系里变得安稳。〔中：成人依恋研究的概念，细节待核〕

你对孩子的回应，是你和他一天天做出来的，不只由你的过去决定。

如果这件事常让你难受，找一位可信的人或专业人员聊聊，会有帮助。

〔解释：本书的建议〕

问：孩子老是看别处，不爱和我对视，是不是不喜欢我？

答：不一定。婴儿把头转开，常常是在“歇一歇”。面对面的互动对小婴儿来说很费力，他需要转开来调整一下。〔中：婴儿研究里对“转开视线”的常见解释〕

你可以等一会儿。他转回来，你再接上。

如果他长期不看人，叫名字也没有反应，请带他去儿童保健科看一看。

〔核：通行建议，大意如此〕

问：有两个孩子，我顾不过来怎么办？

答：不可能每一次都对上，这很正常。可以给每个孩子每天留一小段单独的时间，哪怕十分钟。〔解释：本书的建议〕

大一点的孩子可以做“小帮手”，比如递尿布，唱歌给弟弟妹妹听。他会觉得自己也在这个“来回”里。

两个孩子都需要的是：大多数时候有人在，错了回来修复。

◆ 十四、放回日子里：苏晴的“来回”

孩子七个月的时候，有一天在地上爬，爬到了沙发脚边，看到一个红色的小球。

他爬过去，抓起来，往嘴里塞。球太大，塞不进去，他试了几次，抬头看着苏晴。

苏晴在厨房洗碗，手上全是泡沫。她回头看了一眼：“哦，你找到球了呀？”

孩子又低头继续啃。

她又说：“那个球好玩吗？”

孩子举起球，朝她的方向晃了晃。

她把手在围裙上擦了擦，走过去，蹲下来：“给我看看。”

孩子把球递到她手里。她摸了摸，滚了一下，球滚到了孩子面前。

孩子笑了，追着球爬了过去。

整个过程不到三分钟。

这里面有多少次“来回”？

孩子发现球 — 看母亲 — 母亲说话 — 孩子举球 — 母亲走过来 — 孩子递球 — 母亲滚球 — 孩子追。

八九个回合。

这里面没有一次是“教学”。没有“这是红色”，没有“这是球”，也没有“球是圆的”。

可是孩子学到了很多：

他看，有人回应。他举，有人走过来。他递，有人接，有人把球还给他。

还有一件很重要的事：母亲在洗碗，她的手上有泡沫。她放下了手里的事来回应他。这一点孩子不一定知道，可是他感觉到了：我做了一件事，一个人从另一件事里转向我。

这是“被在乎”的最小的证据。

带走的话

0 到 3 岁的孩子不是在“学东西”，是在“你来我往”里一圈一圈地练“我做的事，会让世界变”。足够好，不是完美。没对上，没关系。回来，就好。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
大脑体积出生约四分之一，三岁约八成多	〔强〕	具体比例各研究略有不同
婴儿期突触快速增加，后有修剪	〔强〕	神经发育基本规律；“每秒新增数十万连接”待核
三岁定终身	〔过度解读〕	本书明确反对

说法	证据级别	说明
“你来我往”（serve and return）	〔强〕	发展心理学通用比喻，来自哈佛儿童发展中心科普
静止脸实验：婴儿期待回应，被打断会不安，恢复后多数能回来	〔强〕	1970 年代起多次重复；反应强弱因人而异
母婴“对上”的时间只占一部分，修复才重要	〔中〕	Tronick & Gianino；具体数字待核
“没对上一修复”对孩子有益	〔解释〕	有一定证据，直接因果有限
回应形成“我能够”的效能感	〔中〕	核心观点，难直接测量
共同调节发展为自我调节	〔强〕	发展心理学共识
过度刺激会使婴儿回避	〔中〕	观察研究
没有可靠的“每天来回几次”的标准数字	〔中〕	研究多为家庭之间的比较
“来回像存零钱”的比喻	〔解释〕	比喻，不是实验结论
饥饿、疲倦、想歇、想玩等信号的常见样子，大哭是晚的信号	〔中〕	喂养指导的常见说法，个体差异大
婴儿每天哭的总时间约六周前后最多，之后减少	〔中〕	观察研究，因人而异
“试、看、换”本身就是一次来回	〔解释〕	本书的看法
江远夜里晚到三分钟，是一次“没对上，修复”	〔解释〕	用本书的框架读场景
托育研究：在场时的质量比总时长更受看重	〔中〕	大意，见第 13 章
大人看手机分心时，对孩子信号的回应变少变慢	〔中〕	观察研究，因果和程度待核
随月龄增长，孩子能等待的时间变长	〔中〕	一般看法，因人而异
熟悉的声音能让孩子稍微安定	〔解释〕	本书的说法，无直接实验
及时抱不会惯坏婴儿	〔有争议〕	早期研究与后续结论不完全一致

说法	证据级别	说明
回应的是需要，溺爱是满足每个要求	〔解释〕	本书的区分方式
温暖加清楚规则的养育，孩子适应往往更好	〔中〕	相关研究，家庭差别大
婴儿自己安静地摆弄东西也是在学习	〔中〕	发展心理学常见看法
成人依恋研究中的“后来获得的安全”	〔中〕	概念来自成人依恋研究，细节待核
不同月龄的“发球”与“接球”对照	〔中〕	参考性质，个体差异大
两岁前后爱发脾气是常见现象	〔强〕	幼儿期常见现象
发脾气的常见原因之一是想要的多、会说的少	〔中〕	常见解释，不是唯一原因
走神后留意到并转回来就是修复	〔解释〕	本书对场景的解读
婴儿转开视线常是在歇一歇	〔中〕	婴儿研究的常见解释
孩子长期不看人、叫名字没反应，应咨询儿保	〔核〕	通行建议，大意如此
给每个孩子每天留一小段单独的时间	〔解释〕	本书的建议

个体情况，比如孩子发育迟缓、对声音和触碰特别敏感，请遵医嘱，必要时咨询儿童保健或发育行为专科。

第 12 章

话是怎么“泡”进去的：面对面，节律，和一本书

◆ 一、一个咿呀的早晨

孩子八个月大了。

一天早晨，苏晴把他抱到婴儿餐椅上，面对面坐着。她一边切香蕉，一边看他。

他忽然发出一串声音：“吧吧吧吧。”

她抬头，笑了：“吧吧吧吧？”

他又来：“吧吧吧吧吧。”

她也学：“吧吧吧吧吧？”

他笑得更厉害，伸出两只手在餐椅的托盘上拍：“噗噗噗。”

“噗噗噗？”她也拍了拍桌子。

这一个早晨，两个人，一个还不会说话，一个说的话没有意思，却你一句我一句聊了好几分钟。

这一章要讲的是：孩子的语言是怎么在这样的“聊”里一点一点“泡”出来的。

◆ 二、语言不是“教会”的

很多父母担心孩子说话晚，开始着急，买各种语言卡片、点读笔。

本书要先说一个朴素的事实：语言不是靠“教”学会的，是靠“泡”。

“泡”的意思是：孩子每天被一个有意思的、跟他有关的语言环境包着。

这里有几个关键词：

“有意思”，意思是说的话和他正在看的、玩的、做的事有关。

“跟他有关”，意思是这些话是对着他说的，不是在他旁边跟别人说的。

有研究发现，同样是听到语言，对着他说的话比在背景里听到的话对孩子的语言发展有用得多。

电视、广播里的话对婴儿学语言几乎没有什么帮助。〔中：Kuhl 等对婴儿学外语语音的实验。真人面对面的接触，能让婴儿学到外语的语音，同样内容的视频或录音则没有效果。这一研究常被引用，细节待核〕

这个发现很重要。它说明：

孩子学语言需要的不是“声音”，而是“一个人在跟我说话”。

◆ 三、“话轮”：比“多少个词”更要紧

关于孩子的语言环境，有一个很有名也很有争议的研究。

1995 年，哈特和里斯利两位美国学者记录了几十个家庭，在孩子 7 个月到 3 岁期间，父母跟孩子说了多少话。他们的发现是：不同家庭之间差别很大。

有的家庭孩子 4 岁时听到的词比另一些家庭的孩子多了几千万个。这个说法后来被概括成“三千万词差距”。〔有争议：这一研究的样本很小，只有四十几个家庭。“三千万”是推算出来的数字。后来的研究对它提出了很多质疑〕

近些年，一些研究者用更大的样本和更先进的设备重新测量。他们发现，不同家庭之间孩子听到的词数确实有差别，可是没有原来说的那么大，而且词的数量不是最关键的。

更关键的是“话轮”。

话轮就是一来一往：孩子发出声音，大人回应，孩子再发出，大人再回应。每一次来回算一个话轮。

2018 年，美国麻省理工学院的罗梅奥等人对 4 到 6 岁的孩子做了脑成像。他们发现，孩子在家里和成年人来回对话的次数越多，在听故事时，大脑里与语言有关的区域激活的程度越强。而这个结果和家里成年人说话的“总量”没有直接关系。〔中：Romeo 等，2018，样本约四十人，是相关研究，需要更多重复〕

后来另有研究团队做了干预研究，让有些家庭参加一个干预，目的是增加大人和孩子的话轮。结果发现话轮增加了，并且持续了一段时间。〔中：干预研究，样本不大，细节待核〕

请注意，这些研究样本都不大。它们不能说明“话轮越多，孩子就越聪明”。它们说明的是：

大人对着孩子说“很多话”，不如大人和孩子“你来我往地说话”。

这与第 11 章的“你来我往”完全对得上。

◆ 四、什么是“好”的说话

那么面对婴儿和一两岁的孩子，怎么说话是“好”的？

可以用几条很具体的办法：

第一，说“妈妈语”。

第 6 章讲过：声音高一点，节奏慢一点，起伏大一点，常常重复。这是几乎所有母亲不用学就会的方式。孩子喜欢这样的声音。研究发现，婴儿时期对“妈妈语”的反应更强，之后语言的发展也更好。〔中：相关研究较多，部分研究发现关联，也有研究发现，不同文化里“妈妈语”的使用频率，差别很大〕

第二，等一等。

你说一句话，停一下，看孩子，等他有反应。哪怕他只是动了动嘴，或者眨了眨眼，你再接着说。这个“等”就是留给孩子“回”的空间。

很多大人，特别是很会说话的大人，容易“说得太满”，孩子没有空隙，回不上。

第三，跟着他看的東西说。

这是很关键的一条。研究者发现，如果大人说的是孩子“此刻正在看的東西”，孩子学到词的速度明显更快。如果大人说的是別的東西，孩子很难把词和東西对上。〔中：多项研究支持，细节因年龄不同而异〕

这个现象叫“共同注意”：大人和孩子同时关注同一件東西，而且互相知道对方也在看。

孩子八九个月以后会发展出一种重要的能力：他会指，会顺着大人的眼睛去看大人看的東西。一岁前后，他会用手指指向他要的的東西，同时看着你，等你的反应。研究发现，一岁左右孩子“指”的能力和后来的语言发展有联系。〔中〕

所以在孩子玩球的时候，说“球”。他看着灯，你说“灯”。他在吃香蕉，你说“香蕉，甜的”。这样词是贴在东西上的。

第四，把他的话扩展一点点。

他指着狗说“汪”。你说：“对，是小狗，小狗在汪汪叫。”你用他说的当起点，往前多走一小步。不要太多，一小步。

第五，不要“考”他。

“这是什么？这是什么颜色？”如果天天问，孩子会累，也会躲。让对话像聊天，而不是考试。

◆ 五、数一数一个话轮的样子

话轮听起来有点抽象。这里用一段饭桌上的对话，来数一数。

孩子十八个月，面前是一碗面条。

孩子：“面。”

苏晴：“对，是面条。热的，吹一吹。”

孩子：“呼。”

苏晴：“呼——你吹得真好。再吹一下？”

孩子又吹了一口：“呼。”

苏晴：“凉了，吃吧。”

孩子：“吃。”

这一小段里，至少有三个完整的话轮。

看一看苏晴做了什么。

她用孩子说的词当起点，往前多走了一小步：“面”变成“面条，热的”。

她没有考他“这是什么颜色”。

她说完就停，等孩子回。

她把孩子的“呼”当成了一句话，接了下去。

这四件事，哪一件都不难。难的是平时容易忘：忙的时候，我们常常只顾着把饭喂完。

话轮不是越多越好。孩子累了，扭头了，就让他歇。〔解释：本书的建议，与前面“来回的节奏由孩子决定”一致〕

◆ 六、一天里的“聊”：哪些时间可以面对面

说话的“泡”，不需要另开一堂课。一天里有好几段现成的时间。

先说一个背景：婴儿刚出生时视力很弱，只能看清离脸不远的东西。随着月龄增加，视力提高得很快。〔强：儿童保健的基础知识〕

所以面对面的时候，脸靠近一些，让他看得清你。

下面这张表，把一天里常见的时刻列出来。

时间	怎么面对面	可以说什么
换尿布	他躺着，你俯下身，脸靠近他	“脚抬起来，一、二” “干净啦”
吃饭	面对面坐，不看手机	“香蕉，甜的” “还要吗”
洗澡	一手托着，一手撩水	“水，温温的” “洗洗小手”

时间	怎么面对面	可以说什么
推车散步	让他面朝你，偶尔蹲到他面前	“看，小狗” “风来了”
睡前	灯调暗，抱着或躺在旁边	一首固定的歌，一本小书

表里的话都很短。短，孩子才听得进去。

这里有两种“说”的办法，可以交替用。

一种是说你自己正在做的事：“我在切香蕉，切成一小块一小块。”

另一种是说他正在做的事：“你在拍桌子呀，噗噗噗。”

两种都是“跟着当下说”。当下的事和词贴在一起，词就容易被记住。

〔解释：这和前面“跟着他看的東西说”是同一个道理，是本书的归纳〕

如果你不爱说话，就用第一种。你每天做的事那么多，随口说出来就行。

◆ 七、话是怎么一步一步长出来的

大多数孩子说话的顺序，大致是下面这样。月龄只是粗略的参考。〔强：个体差异很大，同一年龄的正常孩子，可以差好几个月〕

大约月龄	常见的样子	你可以怎么接
2 到 3 个月	发出“啊”“呜”这样的咕咕声	他一出声你就回，学他的声音
6 到 9 个月	咿咿呀呀，重复的音节，比如“吧吧”“嘛嘛”	学他的音节，等他再来
9 到 12 个月	会指，会挥手，听得懂自己的名字	顺着手指看，说出东西的名字
1 岁前后	说出第一个有意思的词	高兴地重复，再加一个词
1 岁半前后	词一下子多起来，常被叫作“词汇爆发”	跟着他看的東西，多说名词和动作

大约月龄	常见的样子	你可以怎么接
2 岁前后	开始把两个词连起来，比如“妈妈抱”	扩展一点：“妈妈抱你，抱高高”
3 岁前后	能说简单的整句，别人大多听得懂	聊他的一天

这张表是常见的参考。各国的发育表略有差异。〔中〕“词汇爆发”不是每个孩子都有。〔中〕

说话晚的孩子很常见，大多数没事。不过有几种情况，建议带孩子去儿童保健科做一次评估：

一，对很响的声音没有反应，或者叫名字常常不回头。

二，一岁前后还不怎么咿呀，不指点，不挥手。

三，一岁半前后还没有单个有意思的词。

四，两岁前后还不会把两个词连起来。

五，原来会说的话，反而变少了。

〔核：这是常见发育筛查提示的大意，月龄各国略有差异，以儿保医生的评估为准〕

这些都不是“你做得不够”的证明。先查听力，再看别的。听力问题是语言发育迟缓的重要原因之一，先排除它是通行的做法。〔强：儿童保健的通行做法〕

◆ 八、读一本书

书在这个过程中有一个很特别的位置。

和孩子一起读书，是一个典型的“共同注意”的场景。书很薄，有大图，字很少。大人和孩子一起看着同一页，一起关注同一件东西。大人说话，孩子指，孩子发声，大人再说。

研究发现，从婴儿期就开始和孩子读书的家庭，孩子后来的语言能力和早期阅读能力往往更好。〔中：多项观察研究和干预研究，相关性明确，因果仍有争论，因为愿意读书的家庭，往往本来就有别的优势〕

美国儿科学会从 2014 年起建议父母从婴儿出生开始就每天和孩子一起读书。〔核：美国儿科学会 2014 年发表的政策声明，大意如此，具体措辞待核〕

读书的时候有一个小窍门：不一定要把字一个一个地念完。你可以指着图说：“看，这是一只小猫，它在睡觉。”孩子翻页太快也没关系，跟着他翻。书不是用来“读完”的，是用来“聊”的。

如果家里有人不识字，或者不习惯读书，也没关系。你可以讲故事，唱歌，念儿歌。重点不是书，而是“一个人和我一起看着同一个东西说话”。

◆ 九、怎么挑书，怎么读

前面说读书是“聊”，不是“读完”。这里把做法说细一点。

挑书有几条：

一，硬纸板的，翻得动，啃坏了也不心疼。

二，大图，一页一两样东西。

三，字少，句子有重复，孩子容易猜到下一句。

四，图和字对得上。

五，选他喜欢的东西：车，动物，吃的。

读的时候也有几条：

一，指着图读，字可以不念完。

二，一页停一下，等他指，等他出声。

三，孩子大一点以后，多问“它在做什么”，少问“这是什么”。

前一种问法，孩子要多说几个字。后一种，只要一个词。

这种读法常被叫作“对话式共读”。一些干预研究发现，它对幼儿的语言有帮助，效果属于中等或偏小。〔中：干预研究，细节待核〕

同一本书读很多遍，是好事。孩子喜欢重复，因为他能猜到下一页，猜中了很高兴。〔中：幼儿喜欢重复，是常见的观察〕

每次五到十分钟就够。他走开了，就让他走。

◆ 十、关于屏幕

讲到语言，就不能不说屏幕。

这是现在父母最焦虑的事之一。

目前世界卫生组织建议 1 岁以下的孩子不要接触屏幕；1 到 2 岁不建议看屏幕；2 到 4 岁每天不超过一小时，越少越好。〔核：WHO 2019 年发布的《5 岁以下儿童身体活动、久坐行为和睡眠指南》，大意如此，具体数字请以原文为准〕

美国儿科学会对 18 个月以下也是建议避免除视频通话外的屏幕使用。
〔核：AAP 2016 年政策声明，大意如此〕

为什么？

一个重要的原因是我们前面说的：对 2 岁以下的孩子，屏幕上的人不会“回应”他。

研究者发现一种叫“视频缺陷”的现象：2 岁以下的孩子从视频里学一件事，比从真人面对面学要差得多。〔中：多项实验研究支持，2 岁以后，这个差距逐渐缩小〕

另一个原因是时间。孩子看屏幕的时间，就是少了和真人“来回”的时间。

可是这里也要说清楚：

偶尔的屏幕不会“毁了孩子”。视频通话让孩子和远方的爷爷奶奶看到、听到，并且互相回应，是个例外，是好的。

如果你在很累的时候，需要让孩子看十分钟，去做一顿饭，不要为这件事自责。

本书的立场是：这一阶段尽量少，尽量陪着，尽量和真人“来回”。可不是“绝对不能”。

后面讲方法的几编会有更具体的建议。

◆ 十一、不止一种语言

还有一个问题很多家庭会遇到：家里有两种语言，或者爷爷奶奶说方言，父母说普通话，怎么办？

先说结论：不用担心。

研究发现，在双语环境里长大的孩子，说第一个词和第一句话的时间，和单语的孩子大致相同。也没有证据显示双语会造成“语言混乱”或者“智力受损”。〔中：多项研究，对“双语优势”的研究，有争议，但“没有损害”，比较一致〕

要注意的是“每一种语言都需要足够的、有质量的‘来回’”。如果孩子对一种语言只是偶尔听到，没有人跟他互动，他学这种语言就会比较慢。

一个建议：让每个人用自己最自然的语言和孩子说话。因为最自然的语言才有最自然的节律、情感和互动。

不必为了“教孩子普通话”，让爷爷奶奶用他们说得很不自然的话和孩子说话。

◆ 十二、两个场景：奶奶的儿歌，周女士的卡片

孩子一岁半的时候，有一天奶奶抱着他，在阳台上晒太阳。

奶奶用老家话，一边拍着他，一边念：“拉大锯，扯大锯，姥姥家，唱大戏。”

孩子听着，忽然伸出小手，也跟着一晃一晃。

奶奶念一句，停一下。他“嗯”一声。她再念，他又“嗯”。

苏晴站在门口，没有打断。

她本来担心，奶奶的老家话会让孩子以后说不好普通话。那天她想通了：这一句一停的调子，比任何标准发音都更像“聊天”。

后来她让奶奶继续用老家话。她和江远用普通话。孩子两样都在听。

带走一句：每个人用自己最自然的话，孩子不会“乱”。〔中：见前面“不止一种语言”一节〕

再看另一个场景。

周女士是苏晴小区里的邻居，儿子两岁，只会说“妈”“水”几个字。

她很着急。她在网上买了一套识字卡和一支点读笔，每天晚上拿着卡片问：“这是什么？这是什么？”

孩子看一眼，就把卡片推开。

有一天她在小区碰到苏晴，说起这件事，眼圈有点红。

苏晴没有讲道理，只问了一句：“你带他查过听力吗？”

周女士愣住了：“没有。我以为就是晚。”

她去了儿童保健科。医生先查了听力，结果正常。接着做了一次发育评估，建议她回家多做“跟着他看的東西说话”，三个月后复查。

她把卡片收进了抽屉。每天晚饭后，她带孩子在院子里，跟着他的手指说话。

三个月后复查，孩子会说的词多了一些，医生说继续观察。

本书不替任何一个孩子下结论。这个故事只想说一件事：说话晚的时候，先查听力和发育，再调整说话的方式。卡片和点读笔，排在后面。〔解释：这是本书建议的先后顺序〕

◆ 十三、常见的几个问题

问：孩子说话晚，要不要担心？

答：先看前面那张“需要评估的情况”清单。不在清单里的，多数不急。

一些说话晚的孩子，后来自己赶上了。也有一部分一直落后。早期很难把两种分开。〔中：多项随访研究，具体比例待核〕

所以与其干等，不如在清单里的任何一条出现时，去做一次评估。评估不是判决，是帮你看清楚。

问：爷爷奶奶说方言，我们说普通话，孩子上学以后普通话会不会差？

答：孩子上幼儿园和学校以后，接触普通话的时间会大大增加。〔中：常识性观察，因地区而异〕

家里的方言不会“占掉”普通话的位置。多项研究发现，双语孩子单看每一种语言的词汇，有时比单语孩子少一些，两种合起来并不少。〔中：多项研究，细节待核〕

让每个大人用最自然的话，就是最好的办法。

问：点读笔、早教 App 有用吗？

答：研究还不多。有研究比较纸质书和带声音的电子书，发现用电子书时，大人和孩子的对话往往更少。〔中：比较研究，细节待核〕

它们可以是玩具之一，不必完全拒绝。不过别让它们顶替“一个人和我说话”。

如果用，就坐在孩子旁边，一起按，一起说。2 岁以下，本书仍建议尽量少用。

问：孩子不爱听故事，怎么办？

答：一岁多的孩子，坐着不动听一本书，本来就难。幼儿的注意力持续时间很短。〔强：发展心理学的基本常识〕

可以一页一页读，读一页就走。可以只选他喜欢的那一类，比如车。可以让他自己翻页。

也可以不用书：念儿歌，唱歌，聊他刚做过的事。

问：我一个人带孩子，不知道一整天跟他说什么。

答：把你正在做的事说出来就行：“我在洗菜，菜是绿的。”不需要准备。

也不必一直说。说一会儿，停一会儿，看他的反应。

有些大人本来话就少，没有关系。你的声音和你在场，对孩子已经有意义。

问：孩子说错了字，要不要纠正？

答：不用当面纠正。孩子说“狗狗汪汪走”，你说“对，小狗走过去了”。

这样把正确的说法示范一遍，不责备，也不要求他重说。这种做法常被叫作“重述”。一些研究认为它对孩子学语法有帮助，不过证据比较零散。

〔中：研究零散，细节待核〕

等他准备好了，自己会改过来。

问：爸爸话少，有没有用？

答：有。多项研究发现，父亲对孩子说话的方式常常和母亲不同，对孩子的语言发展也有贡献。〔中：研究比母亲的少，细节待核〕

让爸爸在他擅长的时段里来：洗澡，身体游戏，翻书。话少不要紧，把他正在做的事说出来就行。

问：孩子总是指着东西“啊啊”，要不要让他说出来再给？

答：不要逼。先把东西给他，同时把词说出来：“要水？水。”

逼他开口，容易让他挫败，下次干脆不指了。〔解释：本书的看法，无直接实验〕

等他有了一点词，再多等一两秒，看他会不会自己说。

◆ 十四、放回日子里

孩子十五个月大的时候，有一天坐在地上，看着一只飞过的小鸟。

他指着窗外，发出一个声音：“啊。”

苏晴在旁边，顺着他的手指看过去：“哦，小鸟。”

孩子看着她。

她又说：“小鸟飞走了。”

孩子又指：“啊。”

她笑了：“对，飞走了。”

这是一次很平常的对话。可是里面有一个孩子的“指”，一个母亲的“看”，一个词“小鸟”，一个动作“飞走”，还有两个人一起看着同一个地方。

这就是语言最开始的样子。

带走的话

孩子的话不是教出来的，是泡出来的。泡，需要一个人和他面对面，看着他看的东 西，说话，等他回，再接着说。话轮比词数更要紧。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
真人面对面能让婴儿学到外语语音，同内容视频、录音则不能	〔中〕	Kuhl 等的实验，细节待核
哈特与里斯利的“三千万词差距”	〔有争议〕	样本小，数字为推算，后续研究有质疑
话轮多的孩子，语言脑区激活更强	〔中〕	Romeo 等，2018，小样本，相关研究
干预可增加亲子话轮	〔中〕	干预研究，样本不大，细节待核
“妈妈语”与更好的语言发展相关	〔中〕	跨文化频率差异大
跟着孩子注视的物体说话，词学得更快	〔中〕	多项研究
一岁左右“指”的能力与后来语言发展相关	〔中〕	相关研究

说法	证据级别	说明
早期共读与更好的语言和阅读能力相关	〔中〕	相关为主，因果有争议
美国儿科学会 2014 年建议从婴儿期开始共读	〔核：大意〕	措辞待核
WHO 对 5 岁以下屏幕时间的建议	〔核：大意〕	以原文为准
视频缺陷：2 岁以下从视频学得比真人差	〔中〕	多项实验，2 岁后差距缩小
双语不造成语言混乱或智力受损	〔中〕	“双语优势”有争议，“无损害”较一致
新生儿视力弱，只能看清近处，随月龄快速提高	〔强〕	儿童保健基础知识
“说自己做的事、说他做的事”能让词和当下的事贴在一起	〔解释〕	本书的归纳，与“跟着他看的东西说”同理
“对话式共读”对幼儿语言有帮助，效果中等或偏小	〔中〕	干预研究，细节待核
幼儿喜欢重复读同一本书，因为能预测下一页	〔中〕	常见观察
孩子说话的大致顺序和月龄，个体差异很大	〔强〕	同龄正常孩子可差好几个月
月龄表仅为参考，各国发育表略有差异；词汇爆发不是每个孩子都有	〔中〕	参考性质
需要评估的几种情况（无反应、不指点、无单词、不会连词、倒退）	〔核〕	大意，以儿保医生评估为准
听力问题是语言发育迟缓的重要原因，先排除	〔强〕	儿童保健通行做法
双语或方言环境，让每个大人用最自然的话	〔中〕	见“不止一种语言”一节
说话晚时，先查听力和发育，再调整说话方式，最后才是卡片和点读笔	〔解释〕	本书建议的先后顺序
部分说话晚的孩子后来赶上，部分持续落后，早期难分开	〔中〕	多项随访研究，比例待核
孩子上学后接触普通话的时间大大增加	〔中〕	常识性观察，因地区而异

说法	证据级别	说明
双语孩子单一语言词汇有时较少，两种合计不少	〔中〕	多项研究，细节待核
电子书比纸质书时，亲子对话往往更少	〔中〕	比较研究，细节待核
幼儿注意力持续时间很短	〔强〕	发展心理学基本常识
“重述”对孩子学语法有帮助	〔中〕	证据零散，细节待核
饭桌对话示例：扩展孩子的词、不考他、留空等他回	〔解释〕	本书对“话轮”做法的示范
父亲对孩子说话的方式常与母亲不同，对语言发展也有贡献	〔中〕	研究比母亲的少，细节待核
不逼孩子开口，先给东西同时说出词	〔解释〕	本书的看法，无直接实验

个体情况，比如孩子语言发育明显落后、听力问题，请遵医嘱，及时做听力和发育评估。

第 13 章

依恋：“足够好”到底有多好，主要照料者可以是谁

◆ 一、一个陌生人进了房间

孩子十四个月的时候，苏晴带他去参加了一个大学做的婴幼儿研究。

房间里有玩具，有两把椅子。一位研究生对苏晴说：“您带孩子在这儿玩一会儿就行。我们会有一位陌生人进来，您会短暂离开，然后回来。”

苏晴点点头。孩子在地毯上玩积木。

几分钟后，一位陌生的女士推门进来，坐在了另一把椅子上，对孩子笑了笑。

孩子抬头看了她一眼，立刻转头看苏晴。苏晴对他点点头，他继续玩，不过不时回头看苏晴。

然后苏晴被告知要离开房间。她站起来，对孩子说：“妈妈出去一下，一会儿就回来。”

孩子看着她走出门。门关上了。

他愣了一下，放下积木，朝门口爬了几步，哭了。陌生女士蹲下来，递给他一个玩具，他没有接，继续哭。

两分钟后，门开了。苏晴走进来。孩子爬过去，抱着她的腿，她把他抱起来。他把头埋在她的肩膀里，哭了几声，慢慢安静下来。几分钟后，他又回到地上继续玩。

苏晴在门外的一个小窗户后面看着这一切，眼眶有点红。

后来研究生告诉她：“您的孩子属于安全型依恋。”

这一章要讲的就是这个词：依恋。

◆ 二、依恋是什么

先把意思说清楚。

“依恋”这个词在日常生活里有一点“舍不得”的意思。可是在发展心理学里，它指的是一件很具体的事：

孩子和一个特定的人之间形成的一种情感纽带。当他害怕、受伤、疲惫、不舒服的时候，会找这个人，靠近这个人，从这个人那里得到安慰和安全感。

这个理论主要是英国的精神科医生约翰·鲍尔比在 20 世纪 50 年代以后提出来的。他的同事，美国心理学家玛丽·安斯沃思设计了上面我们看到的“陌生情境”实验，把依恋变成可以观察、可以分类的东西。〔核：鲍尔比和安斯沃思的奠基性贡献，是依恋理论的常识〕

鲍尔比的一个核心观点是：婴儿生来就有一套“寻求亲近”的本能，目的是保证自己的安全。哭、笑、伸手、跟随，都是这套本能的表现。而照料者的回应会决定孩子形成什么样的“内在模型”：我是不是值得被爱？别人是不是可靠的？

这个“内在模型”在 SDE 的语言里，就是第 11 章讲的，孩子从无数次“来回”里提炼出来的“规律”：我一哭有人来，所以世界是可以靠近的。

◆ 三、几种类型

在“陌生情境”里，安斯沃思发现孩子的反应大致分成几类：

安全型：母亲离开会不高兴，会找；母亲回来高兴，很快被安抚，然后又去玩。他把母亲当成一个“安全基地”：从这儿出发去探索，累了回来充电。
〔强〕

回避型：母亲离开好像没有太大反应；母亲回来也不太理，甚至回避。他表面上平静，生理指标往往显示他其实是紧张的。〔中〕

矛盾型（也叫抗拒型）：母亲离开很痛苦；母亲回来既想靠近，又推开、发脾气，很难安抚。〔中〕

后来其他研究者又加了一类：混乱型，孩子表现出矛盾、不连贯的行为，比如一边靠近一边害怕，常常见于受到虐待或照料者自己有严重创伤的孩子。
〔中〕

在普通家庭里，安全型大约占六成多，其他类型加起来大约占三成多。
〔中：这是在北美中产家庭样本里常见的比例，不同国家和人群，比例有差异，所以不要把它当成“正常”或“标准”〕

这里必须强调一件事：

这些“型”只是对孩子“某个时间、某个关系里”表现的描述，不是对孩子“性格”的判决。

同一个孩子对妈妈是安全型，对爸爸可能是另一种。孩子的依恋类型也会随着家庭环境的变化而变化。〔中：研究发现，在早期到成年之间，依恋类型有中等程度的稳定性，也有相当一部分人，发生了变化〕

所以本书不会给你的孩子“贴标签”。我们要问的是另一个问题：

什么样的回应更容易让孩子感到“安全”？

◆ 四、敏感性：比“爱”更具体的东西

安斯沃思的研究指出了一个关键词：敏感性。

她说，母亲对孩子的信号有没有敏感的反应，是孩子形成安全依恋的主要原因。

“敏感的反应”包括四个环节：

一，注意到孩子的信号。

二，正确地读懂它。

三，及时地回应。

四，回应的方式适合孩子当时的需要。

比如孩子哭了：注意到了，知道他是饿了，及时给了奶，而且是在他想要的节奏里喂。这就是敏感。

反过来，母亲没注意到，或者误读了（以为是困了，其实是饿了），或者回应得太晚，或者回应的方式不合适（孩子想要安静，大人一直逗），都不算敏感。

后来的研究汇总了几十个观察，发现“母亲敏感性”和“孩子的安全依恋”之间确实有关联，不过关联不是特别大，是中等程度。〔中：德·沃尔夫和范·艾曾道恩，1997 年的元分析，常被引用的相关系数，约在 0.24 左右，具体数字待核〕

这意味着什么？

意味着敏感性是一个重要因素，可是不是唯一的因素。孩子的天生气质，家庭的压力，母亲的心理状态，社会支持，这些都在起作用。

这里请你放下一件事：不要把孩子的依恋类型简单地看作“母亲做得好不好”的成绩单。

相关系数 0.24 意味着还有太多别的东西在共同起作用。

◆ 五、足够好的母亲

这一点，英国的儿科医生和精神分析学家唐纳德·温尼科特早在 20 世纪 50 年代就说过了。

他提出了一个很有名的概念，叫“足够好的母亲”。

他的意思是：

一个婴儿最开始需要母亲几乎完全地“适应”他：他一饿就有奶，他一哭就被抱起。这是为了让他有一种“全能”的感觉：我一想要，世界就来了。

可是一个“足够好”的母亲会慢慢地、一点点地“不完美”。她不再能每次都立刻到，她有时会晚一点，她有时会猜错。这些“失败”是小的，在婴儿能承受的范围里。所以婴儿慢慢学会了：世界不是围着我转的，可是它还是可

靠的。〔核：温尼科特的“足够好的母亲”，是他的核心概念，具体表述待核原文〕

这是一个重要的反转：

“不完美”不是缺陷，而是孩子成长的材料。

这句话把第 11 章里的“没对上，修复”用另一种语言再说了一遍。

所以本书对一个母亲最重要的一句话是：

“你不需要完美，你只需要足够好。”

足够好意味着：

大多数时候在，大多数时候回应，没回应或者错了，回来修复。

◆ 六、“足够好”长什么样：一张对照表

前面讲了敏感性的四个环节。抽象的话不好用，这里放进具体的场景。

下面的表里，中间一栏是“比较敏感”的做法，右边一栏是“没那么敏感，但也很常见”的做法。

两边都是真实家庭里每天会出现的样子。

场景	比较敏感	没那么敏感
孩子哭	看一眼，猜原因，试一样，再看他的反应	一律先塞奶嘴或递手机
孩子推开勺子	停一下，等他转回来	继续往嘴里送
孩子摔了	先抱一抱，再说“疼了吧”	马上说“不疼不疼，别哭”
孩子笑	也笑，和他玩一个回合	看到了，继续看手机
孩子怕生人	抱着他，让他看着生人慢慢熟	把他直接塞到生人手里

右边的做法，每个人都会有。一天里出现几次，不算什么。

差别在“大多数时候”。前面说过，“足够好”是大多数时候在，大多数时候回应，错了回来修复。〔中：依恋研究的共识，“大多数”没有精确的量化〕

右边的做法，也不等于不爱孩子。大多是累了，忙了，或者没人教过。

关于“不疼不疼”，多说一句。大人帮孩子把情绪说出名字，比如“你吓了一跳”“你不高兴了”，有助于孩子后来学会调节情绪。〔中：关于情绪谈话的研究，相关为主，细节待核〕

名字说出来，情绪就有了形状。这是个很小的动作，每天都能做。

◆ 七、没对上以后，怎么修复

前面说“足够好”的关键是修复。修复具体怎么做？可以用四步。

第一步，停下来。发现孩子不高兴了，先停手里的事，看他一眼。

第二步，说出来。“刚才妈妈没看懂你，你生气了。”话很短，不必解释很多。

第三步，抱一抱，或者碰一碰他。身体的接触，比话更快地让孩子安定下来。〔强：共同调节的基本道理，见第 11 章〕

第四步，换个办法。刚才是递勺子，这次换成等他自己拿。

这四步加起来，往往不到一分钟。

修复不需要等孩子“懂事”以后。婴儿听不懂你的话，听得懂你的语气和动作。〔中：婴儿对语调和表情很敏感，见前面几章〕

如果你发现，自己有时候太累，做不到这四步，也没有关系。做到一两步，已经是修复。

下一次再做，也不晚。

◆ 八、主要照料者，可以是谁

这一节是本书里很重要的一节。

前面我们一直说“母亲”。可是本书开头就讲过：这里的“母亲”不是指生物意义上的母亲，而是指“主要照料者”。

依恋研究在这个问题上有很明确的证据：

第一，孩子可以对多个人形成依恋。研究发现，大多数孩子对母亲、父亲、祖父母、保姆都可以形成依恋。不同的依恋对象在孩子心里有一个先后的顺序，但不是只能有一个。〔强：这是依恋研究里的基本发现〕

第二，依恋不取决于血缘，取决于“互动”。养父母、收养的母亲和孩子之间形成安全依恋的比例，和亲生父母大体上相当。条件是孩子被收养的时间不是太晚，而且收养之前没有遭受严重的剥夺。〔中：多项研究，对早期收养的孩子，比较一致〕

第三，父亲同样可以是主要照料者。研究发现，当父亲承担主要的照顾工作时，孩子和父亲之间同样会形成安全依恋。父亲和孩子玩耍的方式常常和母亲有所不同：更多的身体游戏，更多的“冒险”。这对孩子是另一种有价值的“来回”。〔中：Lamb 等的研究，以及后来多项研究〕

第四，祖父母也可以是很重要的照料者。在中国的很多家庭里，祖辈承担着相当大的照料工作。研究发现，如果祖辈能给孩子稳定的、敏感的反应，孩

子的依恋和发展可以是很好的。〔中：中国和其他国家的研究都有，质量参差，结果不完全一致〕

所以在 SDE 的语言里：

“母亲”这个位置是一个“功能”，不是一个“身份”。它的功能是：稳定地在，敏感地回应，修复。谁承担这个功能，谁就是孩子的“妈妈”。

可是这里有两点需要注意：

一是“稳定”。如果主要照料者频繁地换，今天是奶奶，明天是保姆，后天是外婆，孩子每次都要重新适应，每次都要重新“学”这个人的节律。这对孩子是一个负担。研究发现，婴儿期照料者更换频繁和后来的行为问题有关联。〔中：多项相关研究〕

二是“敏感”。如果祖辈因为身体、年龄、观念等原因，对孩子的信号不容易读懂，或者回应不及时，那么需要有另一个人来补。

在第四编的最后一章和后面的方法编里，这一点会再详细讲。

◆ 九、祖辈和父母，怎么分工

不少家庭是父母上班，祖辈白天带孩子。这时最容易出的问题，是“谁来管什么”不清楚。

有三条原则可以参考。

第一，白天主要带孩子的人，尽量固定。稳定本身就是孩子最需要的东西之一。

第二，孩子的吃饭和睡觉节奏，几个大人先对好一版，写在纸上，或者放进家庭群。大人的做法越一致，孩子越容易预期。〔解释：这是本书的建议，目的是让孩子的一天可预期〕

第三，各人有各人的“来回”时段，不用人人都做一遍。

谁	适合的“来回”时段	小提醒
妈妈	早晨，睡前，周末的玩耍	不必包办，也不必样样都做
爸爸	晚饭后的身体游戏，洗澡	孩子哭得凶，不等于不要你，多单独待一会儿
奶奶或外婆	白天的吃饭，散步，搭积木	不必变成早教老师，稳定在场就是价值
保姆	白天按固定的作息	把孩子的习惯写给她，定期沟通

还有一件很实际的事：大人之间的看法常常不一样。

有人觉得该抱，有人觉得别抱。有人觉得该喂，有人觉得该等。

这些分歧，尽量不要当着孩子的面争。多项研究发现，家里大人之间的冲突多，孩子的情绪困扰也往往更多。〔中：相关研究，冲突的程度和类型很重要〕

不是说大人不能有分歧。是说分歧先在孩子听不到的地方谈。

谈的时候，可以先问一句：“你觉得他现在需要什么？”这比“你这样不对”好用。〔解释：本书的建议〕

◆ 十、孩子上托班，会怎么样

很多家庭，孩子在一岁多就要送托班。母亲要上班，这是现实。

这个问题有一项很大的研究可以提供证据。美国国家儿童健康与人类发展研究所从 1991 年开始，追踪了一千多名儿童，从出生到青少年，研究早期的非母亲照料对孩子的影响。〔核：这是 NICHD 早期儿童保育与青少年发展研究，是该领域最大规模的研究之一〕

主要的发现是：

第一，影响孩子的主要是“母亲的敏感性”和“家庭环境”，其次才是“托育的质量”。托育本身对依恋没有明显的损害，只要母亲在家里是敏感的。〔强：多篇论文一致〕

第二，托育的质量是重要的。质量高的托育指的是：一个照料者带的孩子少，照料者受过训练，温暖，常回应，说话多。在这样的托育里，孩子的语言和认知发展略有优势。〔中：效应不大，需要谨慎解读〕

第三，每周在托育里的时间特别长，比如每周三十小时以上，在一些研究里与后来较多的行为问题有微弱的关联。〔中：效应很小，引起过不少争论，不应夸大〕

所以对要上班的母亲，这一节的信息是：

送托不是“把孩子的智慧丢给了别人”。重要的是选一个质量好的、照料者稳定的托育，并且在家里你和孩子仍然有高质量的“来回”。

◆ 十一、孩子哭着不让你走：分离焦虑和适应期

孩子哭着不让你走，是很多父母最难受的一刻。

先看一条大致的时间线。〔强：发展心理学的常见描述，个体差异很大〕

八个月前后，孩子开始“认生”，对陌生人变得警惕。

一岁到一岁半，你一离开视线，他就哭，这时最明显。

两岁以后，慢慢减轻。三岁前后，多数孩子能接受短暂的分开。〔中：因孩子而异，没有统一的时间表〕

为什么会这样？

一个常见的解释是：到了这个阶段，孩子已经知道“你不在，但你还存在”。以前你一走开，他就当你没了，不哭。现在他知道你在别处，就想你回来。〔中：与“客体永久性”概念相联系，是常见的解释〕

所以这条哭声，在某种意义上是进步。

那么送托班或换环境的头几周，怎么过？

一，提前熟悉。先带孩子去看几次，你陪着，待一会儿就回。

二，逐步延长。第一天一小时，之后慢慢加。

三，固定告别的动作。抱一下，说同一句话，比如“妈妈去上班，下午来接你”，挥手，然后走。〔解释：本书的建议，目的是让孩子能预期〕

四，不要偷偷溜走。孩子发现你不见了，下一次会更不敢放你走。〔解释：本书的看法，无直接实验〕

五，带一件熟悉的东西，比如小毛巾或小玩偶。温尼科特把这类东西叫“过渡客体”，它能帮孩子在分开的时候稳住自己。〔核：温尼科特的概念，大意如此〕

六，接回来先抱一抱。回家后孩子可能闹得厉害，那是他在外面撑了一天。〔解释：本书的看法〕

适应期大多需要一到几周。〔中：因孩子而异，没有统一的数字〕

如果几周后，他还是几乎每天剧烈地哭闹，吃睡明显变差，可以问问老师，也可以咨询儿童保健科。〔核：通行建议，大意如此〕

◆ 十二、一个送托班的早晨

苏晴的同事李姐，家里孩子一岁八个月，第一次送托班。

第一周，每天早上都是同一出：孩子抱着李姐的脖子，哭得浑身发抖。李姐在门口也哭，站在走廊上不肯走。

老师走过来，对她说：“您越舍不得，他越不敢放手。”

李姐有点生气，又有点心虚。

老师接着说：“您别急着走。我们定一个固定的告别：抱一下，说一句话，挥手，然后您走。我接过来。”

“说什么话？”

“就说，妈妈去上班，下午来接你。每天一样。”

李姐试了。第一天，孩子哭得更凶。第三天，孩子在她挥手的时候，把头埋进了老师的肩膀里。

第二周，孩子进教室以后，还会哭一两声，然后自己去拿玩具。

第三周的一个早晨，孩子对她说了一个字：“拜。”

李姐在车里坐了很久。她说，那一刻心里又酸又松。

本书想说：哭，不是你做错了。固定的告别，把一场“突然的分开”，变成了一个“有预告的分开”。〔解释：本书的解读〕

◆ 十三、常见的几个问题

问：孩子只黏妈妈，别人一抱就哭，怎么办？

答：八九个月以后，大多数孩子会变得“认生”，对熟悉的人和陌生人区别对待。这是发育的正常阶段。〔强：发展心理学的常见描述〕

别人要抱，先让妈妈在旁边，让孩子看着慢慢熟。不要硬把孩子塞过去。

孩子黏你，不等于别人带得不好。时间长了，多数孩子会对常带他的人也放松下来。〔中：多项观察，因人而异〕

问：分离焦虑是不是被我宠出来的？

答：不是。分离焦虑是发育的一部分，说明孩子已经认得你，也知道你不在。〔中：常见解释，见前面“客体永久性”〕

个别孩子更敏感，持续得更久一些，这和气质有关，不是你的错。〔中：气质研究的一般看法〕

问：保姆或祖辈要换人，怎么让孩子少受点影响？

答：换人有时不可避免。能做的是留一个“交接期”：让新旧两个人同时在几天，旧的带着新的一起做事，孩子看着他们互相信任。〔解释：这是常见的做法，不是实验结论〕

把孩子的习惯写给新来的人：小名，吃饭睡觉的时间，哄他的办法，他怕什么。

换了人以后，头几周孩子闹一些，是正常的。

问：依恋类型能不能改？

答：能。前面说过，依恋类型有中等程度的稳定性，也有不少人发生了变化。〔中：纵向研究，见本章第三节〕

孩子在新的、稳定的关系里，表现会跟着变。成人依恋研究里，有人小时候不太顺，后来因为稳定的伴侣或治疗，在关系里变得安稳。〔中：成人依恋研究的概念，细节待核〕

所以不要给孩子贴“某某型”的标签。

问：孩子对谁都亲，谁抱都不怕，是不是好事？

答：不一定是问题。有的孩子天生外向，爱笑爱找人。〔中：气质研究的一般看法〕

需要留意的是：对陌生人亲近得没有分寸，见谁都跟着走，又伴随别的困难。这时可以请儿童保健科的医生看一看。〔中：见第 14 章〕

八九个月以后，一点也不认生的孩子，也不一定有问题。多看他回到你身边时的样子。

问：孩子晚上要挨着我，不肯自己睡，会不会影响依恋？

答：睡眠怎么安排，各个家庭的做法差别很大，各国的文化也不同。
〔强：常识〕

关于“让孩子自己哭着入睡”会不会伤害依恋，目前研究的结论不一致，质量也参差。〔有争议〕

本书的建议是：选一个全家都能长期坚持、孩子也能慢慢适应的做法。婴儿的安全睡眠请遵医嘱，比如不要和大人睡在松软的床上。〔核：婴儿安全睡眠的通行建议，大意如此〕

问：我要出差几天，孩子会不会受影响？

答：短时间的分开，孩子大多能适应，前提是有稳定的、熟悉的人在照料。〔中：依恋研究的一般看法，因孩子的年龄和气质而异〕

出发前跟他说一声，哪怕他听不懂。每天可以视频通话一小会儿，让他看到你，听到你。

回来以后，先抱，先陪他玩，礼物放在后面。〔解释：本书的建议〕

他可能会黏你几天，或者闹一闹。这是他在“确认你回来了”，过几天会慢慢平稳。〔中：常见的临床观察〕

◆ 十四、放回日子里

孩子十八个月的时候，苏晴回去上班了。

孩子由奶奶白天带着。

奶奶是个很勤快的人，家里整理得干干净净，孩子的衣服每天换。可是她话不多，不太会“逗”孩子。

有一天，苏晴下班早，回到家，在门口听到里面很安静。

她推门进去，看到奶奶在厨房里择菜。孩子在客厅的垫子上自己玩，一个人搭积木，没有人在旁边。

那一刻她心里有点难过。

可是她没有马上说什么。

晚上她和江远讨论了这件事。

江远说：“妈那边，我们不能要求她变成另一个人。”

苏晴说：“我知道。可是我想……能不能每天让她抽一点时间，坐在孩子旁边一起搭一会儿。不用多，二十分钟。”

第二天，她跟奶奶说：“妈，您每天下午孩子睡完觉搭积木，您就坐在旁边看着他搭，他递给您，您就接着，不用多说话。”

奶奶说：“这样就行？”

苏晴说：“这样就行。”

这是一个很小的调整。它没有要求奶奶“变成一个会早教的奶奶”，只是在孩子的一天里给出一段“稳定的、有人在场的来回”。

这样的调整，在很多家庭里，都是可行的。

带走的话

依恋，不是谁生了孩子，而是谁稳定地在、敏感地回应、出错后回来。妈妈是一个位置，不是一个身份。足够好，就是好。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
依恋理论源自鲍尔比，陌生情境由安斯沃斯设计	〔核〕	依恋研究常识
安全型、回避型、矛盾型、混乱型的分类	〔强〕	分类系统被广泛使用
北美中产样本中约六成多为安全型	〔中〕	不同国家和人群比例有差异
依恋类型有中等程度稳定性，也会变化	〔中〕	纵向研究
母亲敏感性与安全依恋之间关联为中等程度	〔中〕	De Wolff & van IJzendoorn, 1997, 系数约 0.24，待核

说法	证据级别	说明
温尼科特“足够好的母亲”	〔核〕	具体表述待核原文
孩子可以对多个照料者形成依恋	〔强〕	依恋研究基本发现
收养母亲与孩子形成安全依恋的比例大体相当	〔中〕	对早期收养较一致
父亲作为主要照料者时同样形成安全依恋	〔中〕	多项研究
祖辈敏感照料下孩子可发展良好	〔中〕	研究质量参差
婴儿期照料者频繁更换与行为问题相关	〔中〕	相关研究
NICHD 研究：母亲敏感性和家庭环境比托育更重要	〔强〕	多篇论文一致
高质量托育有轻微语言认知优势	〔中〕	效应不大
托育时间过长与行为问题有微弱关联	〔中〕	效应很小，有争议
“足够好”是大多数时候在、大多数时候回应、错了修复	〔中〕	依恋研究共识，“大多数”无精确量化
大人帮孩子说出情绪的名字，有助于后来的情绪调节	〔中〕	情绪谈话研究，相关为主，细节待核
白天主带者固定、大人做法一致，让孩子一天可预期	〔解释〕	本书的建议
家里大人冲突多，孩子情绪困扰往往也多	〔中〕	相关研究，冲突的程度和类型很重要
认生始于约八个月，一岁到一岁半分离反应最明显，两岁后减轻	〔强〕	发展心理学常见描述，个体差异大
三岁前后多数孩子能接受短暂分开，适应期一到几周	〔中〕	因孩子而异，无统一数字
分离焦虑与“客体永久性”的发展相联系	〔中〕	常见解释
固定告别动作、不偷偷溜走、接回先抱	〔解释〕	本书的建议，无直接实验
温尼科特的“过渡客体”	〔核〕	大意如此，待核原文

说法	证据级别	说明
几周后仍剧烈哭闹、吃睡变差时咨询儿保	〔核〕	通行建议，大意如此
固定告别把“突然的分开”变成“有预告的分开”	〔解释〕	本书对场景的解读
八九个月以后孩子“认生”是发育的正常阶段	〔强〕	发展心理学常见描述
孩子对常带他的人，时间长了多数会放松	〔中〕	多项观察，因人而异
分离焦虑是发育现象，个别孩子更敏感与气质有关	〔中〕	常见解释与气质研究
换人时留交接期，把习惯写给新照料者	〔解释〕	常见做法，非实验结论
成人依恋研究中的“后来获得的安全”	〔中〕	概念来自成人依恋研究，细节待核
有的孩子天生外向，爱找人	〔中〕	气质研究的一般看法
不同家庭的睡眠安排差别很大	〔强〕	常识
让孩子自己哭着入睡是否伤害依恋，结论不一致	〔有争议〕	研究质量参差
婴儿安全睡眠的通行建议	〔核〕	大意如此，请遵医嘱
修复四步：停，说，抱，换办法	〔解释〕	本书的做法归纳
身体接触帮助孩子更快安定（共同调节）	〔强〕	发展心理学共识
婴儿对语调和表情敏感，听得懂语气和动作	〔中〕	见前面几章
短时间分开，有稳定熟悉的照料者在，孩子大多能适应	〔中〕	依恋研究的一般看法，因人而异
出差前说一声、视频通话、回来先抱	〔解释〕	本书的建议
分开后孩子可能黏人或闹几天，是在确认你回来	〔中〕	常见临床观察

个体情况，比如孩子分离焦虑特别严重、不愿接触人，请咨询儿童保健或发育行为专科。

第 14 章

断了会怎样，补得回吗：从孤儿院的孩子说起

◆ 一、一个很难写的章节

写这一章，本书犹豫了很久。

因为这一章要讲的是孩子在最糟糕的条件下会发生什么：没有人回应，没有人抱，没有人和他说话。

这样的故事读起来很沉重。更重要的是，容易让一些读者把它和自己的日子对号入座：

“我孩子三个月的时候我产后抑郁，抱得少。”

“我家孩子是奶奶带大的，一天到晚也没人跟他说话。”

“我那时候工作太忙，孩子一岁以前我几乎没怎么陪。”

请你在读这一章之前，先把这些放下。

本书要讲的是“极端的、长期的、全面的剥夺”。这和普通家庭里那些“有时候没做到”完全不是一回事。

本书讲这一章的目的有两个：

一是用最极端的例子看清楚：回应到底有多重要。

二是更重要的：看清楚，即使在这么糟糕的情况下，孩子仍然有很大的恢复空间。

◆ 二、一个叫“住院病”的现象

先从很早的观察说起。

20 世纪 40 年代，奥地利出生的美国精神分析学家勒内·斯皮茨观察了一些在育婴院里长大的婴儿。这些育婴院卫生条件很好，吃的、穿的都有保障，可是照料者很少。一个护士要管很多个孩子，没有时间抱、说话、逗。

斯皮茨报告说，一些孩子在这样的环境里出现了严重的发育迟缓、情绪低落、疾病多，甚至死亡率很高。他把这种现象叫“住院病”。〔中：斯皮茨的研究，方法学上有不少缺陷，比如样本少，对照不够严谨，结论的程度，后人有不同的看法，不过它推动了后来的大量研究和育婴院的改革〕

这个观察在当时产生了很大的冲击：一直以来，人们以为婴儿只要吃饱穿暖就好了。斯皮茨的工作让人们开始意识到，“被回应”也是婴儿的基本需要。

差不多同一个时期，美国心理学家哈里·哈洛做了一系列著名的猴子实验。他让小猴子从出生起就和母亲分开，由两个“代理妈妈”抚养：一个是铁丝做的，有奶瓶；另一个是用绒布包着的，没有奶瓶。

结果小猴子大部分时间都抱着绒布妈妈，只在饿的时候才去铁丝妈妈那里喝奶。〔强：这是心理学史上，最有名的实验之一，发表于 1950 年代〕

这个实验说明：对幼小的哺乳动物来说，“接触的温暖”不是奶的附属品，它是独立的、基本的需要。

不过这个实验在伦理上很有争议。后来长大的猴子出现了严重的社交障碍，不会交配，不会照顾自己的幼崽。今天的研究不会再这样做了。

本书引它，只是借它说明一个历史：科学是怎么一步一步认识到“回应和接触”的重要性的。

◆ 三、罗马尼亚的孤儿院

真正让这个问题变得“可研究”的，是 20 世纪 80 年代末罗马尼亚的一件事。

1989 年，罗马尼亚独裁者齐奥塞斯库倒台。外界这才发现，这个国家的孤儿院里有成千上万个孩子处在极端的剥夺之中：一个房间里几十个孩子，一两个照料者；孩子们被放在婴儿床里，几乎没有人抱，没有人说话，没有玩具，甚至吃饭也是匆忙地用奶瓶塞进嘴里。〔强：这是历史事实，有大量记录〕

后来西方国家，包括英国、加拿大、美国，收养了很多这些孩子。这就带来了一个前所未有的、可以追踪研究的机会。

这里要讲两个主要的研究。

第一个是英国的“英国与罗马尼亚被收养者研究”。研究者追踪了 100 多名在 4 岁以前被英国家庭收养的罗马尼亚孤儿，并且和英国国内被收养的孩子作对比。〔核：英国与罗马尼亚被收养者研究，简称 ERA，由迈克尔·拉特等人主持〕

他们发现了一个很有意思的规律：

在孤儿院里待的时间不到六个月的孩子，被收养以后，认知水平在 6 岁时基本赶上了英国国内被收养的孩子。而在孤儿院里待了六个月以上的孩子，被收养后在认知上仍然有一部分人落后于对照组，而且待得越久落后得越明显。

〔中：这是 ERA 研究的核心发现，具体的数字，在不同年龄的追踪里有出入，待核〕

另外，他们发现有一部分孩子出现了一种特殊的问题，叫“准孤独症特征”，表现为：社交困难，兴趣狭窄，刻板行为。还有一部分出现了“去抑制性社交参与”：对陌生人过分亲近，没有分寸，见到谁都愿意跟着走。〔中〕

第二个是美国的“布加勒斯特早期干预项目”。研究者在布加勒斯特选了 136 名在孤儿院里长大的孩子。孩子的年龄在六个月到三十一个月之间。研究者把他们随机分成两组：一组被安置到专门培训的寄养家庭里，另一组继续待在孤儿院里。

还有一组是在同一个城市里从来没有住过孤儿院的孩子，作对比。〔核：该项目由内森·纳尔逊、查尔斯·泽纳等人主持，具体数字，以原文为准〕

这个项目的价值在于“随机”。因为是随机分配，所以两组之间的差异可以更有力地归因于“家庭照料”和“机构照料”的区别。

结果是：

在 42 个月大时，从来没有住过孤儿院的孩子平均智商约为 109 左右；被安置到寄养家庭的孩子约 81 左右；继续待在孤儿院的孩子约 73 左右。〔中：这些数字常被引用，具体数值，以原文为准，待核〕

到了 8 岁、12 岁，甚至十几岁，被安置到寄养家庭的孩子在认知上仍然比继续留在孤儿院的孩子有显著的优势。〔强：多次追踪，一致的发现〕

而且被安置得越早，尤其是在两岁以前，恢复得越好。〔中：研究者的分析，不同指标，结果不完全一致，“两岁”不是一个严格的界线〕

另外，寄养的孩子在依恋、情绪、脑电活动等方面也有明显的改善。

〔中〕

◆ 四、两个重要的信息

这些研究给我们什么信息？

第一个信息是坏消息，也是证据：

长期的、全面的缺乏回应会对孩子造成真实的、可测量的伤害。伤害的范围包括认知、语言、情绪、社交、大脑发育。〔强〕

这再次证明了：“被回应”不是装饰，不是“教养风格”的偏好。它是孩子发展的基本条件。

第二个信息是好消息：

即使经历过这么严重的剥夺，只要孩子被放到一个稳定的、回应的家庭里，大多数会有大幅度的恢复。

被收养的罗马尼亚孩子在被收养时，很多都很虚弱，体重、身高远低于同龄孩子。可是几年后，很多孩子在身体上基本赶上了。在认知和情绪上，也有很多孩子恢复得相当好。〔中〕

这一点很重要。它说明，早期的剥夺不是“命定”。

◆ 五、“关键期”还是“敏感期”

讲到这里，需要澄清一个常见的误解。

很多人听说过“关键期”这个词，意思是：孩子的某种能力必须在某个特定的时间段里发展，错过了就再也补不回来了。

关键期这个说法在动物身上有一些例子，比如小鸭子的“印随”：小鸭子在孵出后的一段时间里，会对第一个看到的移动物体形成依附。

可是对人来说，大多数的发展没有这样严格的“关键期”，更准确的说法是“敏感期”。

敏感期的意思是：在这个时期，大脑对某种经验特别敏感，这个时期的经验效果特别强。过了这个时期仍然可以发展，只是需要更多的努力，效果可能弱一些。〔强：发展神经科学的主流观点〕

罗马尼亚孤儿的研究正好说明了这一点：被收养得越早，恢复得越好，这是“敏感”的证据。可是即使是较晚被收养的孩子也有明显的进步，这说明没有一个“一过就完”的界线。

这一点对所有的家长很重要：

不要因为孩子已经过了三岁，就觉得“晚了”。

大脑在整个童年，甚至整个一生里，都是有可塑性的。只是在 0 到 3 岁，它的可塑性是最大的。所以这个时候的“好的经验”最有效率，这个时候的“糟糕的经验”也最容易留下深刻的痕迹。

◆ 六、对普通家庭，这意味着什么

好，我们回到普通家庭。

罗马尼亚孤儿院的孩子处在极端的环境里：几乎没有任何个人化的回应，持续几个月，甚至几年。

而在普通的家庭里，即使是一个“不太会带孩子”的母亲，或者一个“忙得顾不上”的家庭，孩子得到的回应也比孤儿院里的孩子多得多。

所以把罗马尼亚孤儿的研究结果直接用在普通家庭上是不合适的。

可是从这些研究里，我们可以得到一个“方向”：

回应的“量”和“质”越高，孩子的发展越好。在一个很宽的范围里是“越多越好”的。可是超过“足够好”的某个门槛，边际的收益会递减。

换句话说：

对大部分的家庭，目标不是“最大化”回应，而是“超过那个门槛”，也就是“足够好”。

这个门槛具体在哪里，没有人能够精确地画出来。可是有几条大体可以用：

一是，孩子有一个或几个稳定的、相对固定的照料者。

二是，这些照料者大多数时候对孩子的信号能作出回应。

三是，孩子每天有一些“面对面”的互动：说话、玩耍、被抱。

四是，没有对孩子的虐待和严重的忽视。

如果这四条你的家大体做到了，请你放心。

◆ 七、有一些家庭，需要更多的帮助

可是也有一些家庭没有办法靠自己的力量做到这四条。

比如：母亲患有严重的产后抑郁；家里有长期的暴力；母亲是一个未成年人；家庭极端贫困，连吃饭都成问题；父母有成瘾问题。

对这样的家庭，指责没有任何用处。他们需要的是外面的支持。

研究发现，有一些干预项目对这样的家庭是有效的。比如：家访项目，让经过培训的护士或者家访员定期到家里，指导母亲如何回应孩子；针对母亲的抑郁的治疗；有针对性的亲子互动项目。〔中：有多个项目，如美国的“护士一家庭伙伴项目”，有随机对照试验，显示了在一些方面的积极效果，不同项目，效果不一，需要因地制宜〕

关于这些，本书在第 17 章还会讲“社会怎么接住母亲”。

◆ 八、补，是怎么补的

前面讲了“补得回”。这一节讲：研究和临床经验里，“补”靠的是什么。

先说一个提醒。罗马尼亚的孩子遇到的是极端的剥夺。普通家庭的孩子，不需要这样“补”。

本节写给两类读者：一类是领养或寄养孩子的家庭，一类是觉得自己曾经没做好、想知道还来不来得及的父母。

“补”有几样东西，反复出现。

一，一个稳定的人。布加勒斯特项目里，寄养家庭和孤儿院的差别，研究者认为，核心是有了固定的、个人化的照料者。〔中：研究者的解释，不是唯一的因素〕

二，重复的日常。吃饭，洗澡，睡觉，每天差不多的时间，差不多的顺序。孩子在重复里学会预期。〔解释：本书的归纳〕

三，时间。恢复很少是几天的事，常以月甚至年计。〔中：追踪研究显示改善是逐步的〕

四，耐心。孩子可能先“试”你：推开你，惹你生气，看你会不会走。

〔中：临床上的常见描述〕

五，不强迫亲近。让孩子带节奏，他靠近一步，你回应一步。〔解释：本书的建议〕

六，大人自己有支持。照料经历过剥夺的孩子，大人容易累。有人替你分担，才撑得久。〔中：临床经验和家访研究的共同看法〕

下面这张表，是领养和寄养家庭里常见的几种表现。

孩子的表现	可能在说什么	你可以做什么
不让抱，身体僵硬	还不习惯身体接触	先坐在旁边，递东西，等他自己靠近
藏食物	怕再次挨饿	在固定的地方放一小碗零食，让他知道随时有
见谁都跟着走	还没分清谁是“自己人”	家人固定带他，陌生人先不抱他，教他“先看看妈妈”
夜里醒来哭得很凶	不安全	你在身边，开一盏小灯，每次说同一句话
故意捣蛋，反复试探	在看你会不会离开	平静地守住边界，事后抱一抱，说“我还在”

这些表现在机构出来的孩子里常被报告，不是每个孩子都有。〔中〕

表里的第二栏是解释，不是定论。同一个表现，不同的孩子，原因可能不同。〔解释〕

还有一点要补充。被收养得晚的孩子，进步可能没有那么快，不过仍然有进步。〔中：与前面罗马尼亚研究的发现一致〕

◆ 九、读这类研究时，要小心的几件事

罗马尼亚的研究很有名，也很容易被用错。读的时候，请记住几件事。

第一，数字是群体的平均数，不是你家孩子的成绩单。书里引用的智商数字，说的是一大群孩子平均起来的样子。一个具体的孩子，可能比平均数好，也可能差一些。〔强：统计常识〕

第二，这些孩子的情况都很极端。他们的经历，和普通家庭里的“有时没顾上”，相差很远。

第三，孩子进孤儿院之前的情况，往往不一样。有的孩子出生时就偏小，母亲孕期的情况也不同。这些都会影响结果。〔中：研究者在报告里反复提到的局限〕

第四，相关不等于因果。布加勒斯特项目用了随机分组，因果的证据比较强。别的很多研究只是比较，不能确定原因。〔强：研究设计的基本常识〕

第五，“恢复”不等于“回到完全一样”。很多孩子恢复得很好，也有一部分孩子仍有困难。〔中：多次追踪的一致发现〕

读完这些，请把它们当作一面镜子，不要当作一份判决书。

镜子告诉你：回应很重要，补是可能的。判决书会说“已经晚了”。研究没有说过这句话。

◆ 十、一个领养家庭的头几个月

吴女士和丈夫领养了一个三岁的女孩，叫小满。小满之前在儿童福利机构住了两年多。

前三周，小满不让吴女士抱。你一靠近，她就站得笔直，眼睛看着地板。

晚上，吴女士发现她把饼干藏在枕头下面。

吴女士有点慌。她问了社工，社工说，这在从机构出来的孩子里并不少见。〔中：临床常见描述，并非人人都有〕

社工建议三件事：不要拿走饼干。每天固定同一个人，在同一个时间，给她洗澡，讲故事，哄睡。不要逼她叫妈妈。

吴女士照着做。她在客厅的矮柜上放了一个小碗，里面总有几块饼干。她对小满说：“这个随时可以拿，用完了妈妈再放。”

第四周，小满开始偷偷地看她。

第七周，小满把一本图画书拿到她面前，没有说话。

三个月后的一个夜里，吴女士在小满房间里坐着。小满伸出手，抓住了她的一根手指，睡着了。

吴女士说，那一刻她想了很久。

本书想说：这个孩子没有被“修好”。她是被一天一天陪着，慢慢长出了信任。

每个孩子的速度不一样。有的更快，有的更慢。快慢都不是你的成绩单。
〔解释：本书的看法〕

◆ 十一、再看一个例子：杨姐的“补法”

杨姐是苏晴的同事。她生完孩子后的头三个月，情绪一直很低。

她抱孩子的时候，常常没什么表情。孩子哭了，她要愣一会儿才去抱。

丈夫发现了，陪她去看了医生。医生说，这种情况需要治疗，不是“想开点”就能好的。

杨姐开始了治疗。家里的婆婆搬来住了一段时间，丈夫也每天早点回家。

几个月后，她的情绪慢慢好起来。她说：“我觉得对不起孩子，那几个月我几乎没怎么笑。”

医生对她说：“你现在能笑了，就从现在开始补。”

她给自己定了很小的目标：每天早上，抱着孩子在窗边站五分钟，说今天的天气。每天睡前，念一本最薄的书。

半年以后，孩子看见她，会扑过来，笑。

本书想说：那几个月已经过去了。孩子需要的，是你从现在开始的稳定。

〔解释：本书的解读〕

杨姐的故事不是“补完就一笔勾销”，也不是“错过就补不回”。它说的是：补，永远是从下一次开始。

◆ 十二、常见的几个问题

问：我曾经忽视过孩子，现在还能补吗？

答：能。请先分清：“有一段时间没做好”和本章讲的“长期全面的剥夺”不是一回事。

补的办法很朴素：从今天起，每天加几个稳定的“来回”。吃饭时放下手机，睡前讲几分钟话，接他放学时先抱一抱。

多项研究发现，关系变好以后，孩子的状态往往跟着改善，儿童期和青春期都是如此。〔中：相关研究，改善的程度因人而异〕

问：对大一点的孩子，要不要把过去的事说出来？

答：可以简单说。比如：“那段时间妈妈状态不好，没陪够你。现在好一些了，想多陪陪你。”

话要短，不求原谅，也不要把自己说成罪人。孩子听到的重点是：不是你不好，现在有人在。〔解释：本书的建议〕

问：产后抑郁那段时间的亲子互动，怎么补？

答：研究发现，母亲抑郁的时候，对孩子的回应往往变少，表情也变少。

〔中：多项观察研究〕治疗以后，互动常有改善，孩子的情况也有改善。

〔中：干预研究，细节待核〕

先治疗，这是第一步。同时让伴侣和家人分担一部分照料。

补的时候，不求多，求稳：每天几个短的面对面，哭了就抱。

这不是你的错。如果有伤害自己或孩子的念头，请马上联系医生，或者当地的心理危机热线。〔核：通行的安全建议〕

问：孩子是奶奶带大的，一天到晚没人跟他说话，怎么补？

答：先别指责奶奶。祖辈带孩子本来就很辛苦。

家里其他人可以每天固定一段，比如二十分钟，面对面地搭积木，翻书，散步，多说话，多等他回。

也请奶奶参加一部分。比如她择菜的时候，让孩子坐在旁边，她随口说说在做什么。

话轮增加以后，孩子的话往往会跟着多起来。〔中：话轮研究，见第 12 章〕

问：孩子已经三岁多了，还来得及吗？

答：来得及。本章前面说过，人类的发展多是“敏感期”，不是“关键期”。〔强：发展神经科学的主流观点〕

早一点当然更省力，晚一点也有进步。

所以不必为“晚了”自责。从今天开始就好。

问：什么时候该找专业人员？

答：下面几种情况，建议去找儿童保健科或发育行为专科：

一，孩子长期不看人，叫名字没反应，也不找你。

二，语言或动作明显落后。

三，孩子曾在机构或长期被忽视的环境里生活，行为让你拿不准。

四，你自己情绪很低，撑不住。〔核：通行建议，大意如此〕

找专业人员不是承认失败，是多一双眼睛。

问：怎么知道自己做得够不够好？

答：可以回到本章第六节的四条，慢慢对照。

还有三个很简单的自查：孩子受了伤或害怕时，会不会来找你。你回家时，他会不会眼睛一亮。你们之间，一天里有没有几次一起笑。〔解释：本书的自查，不是量表〕

三个里有两三个，大致说明你们之间的路是通的。不用每天打分，打分本身会让人更焦虑。

问：领养的孩子，要多久才会信任我？

答：没有统一的时间表。孩子被收养得越晚，早期剥夺越长，建立新的依恋往往需要越久。也有孩子在几周到几个月里就明显亲近起来。〔中：研究和临床经验，个体差异很大〕

把时间表放下，看方向：这个月比上个月，是不是多看了你一眼，多靠近了一点。

方向对了，慢也没关系。

◆ 十三、放回日子里

苏晴的一个朋友姓林，在一个儿童福利机构做志愿者。

有一天，苏晴听她讲起，她们机构里的一个小女孩，两岁多，是被遗弃的，在机构里待了一年半。

林说，那个孩子一开始不太会看人。你对她笑，她好像没有看到。你抱她，她身体是僵的。

后来机构做了一个调整：每个孩子固定一个“主要照料者”，一天里大部分的时间是这一个人抱、喂、说话、陪着。

几个月后，那个小女孩会在这个照料者进门时抬头，笑。

林说：“她其实一直在等一个人。”

这句话苏晴听了，很久没有说话。

这个故事不是为了催泪。它想说的是：

即使孩子曾经没有被回应，只要后来有人稳定地回应，那个“等着的东西”还在。

◆ 十四、本编小结

第四编四章，到这里可以收起来：

第 11 章说，0 到 3 岁，智慧是一个“你来我往”的游戏。足够好不是完美，没对上，回来就好。

第 12 章说，孩子的话是泡出来的：面对面，话轮，共同注意，一本书。

第 13 章说，依恋不是谁生了孩子，而是谁稳定地在、敏感地回应、出错后回来。妈妈是一个位置。

第 14 章说，极端的剥夺会造成真实的伤害，可是补得回。早期是敏感的，不是命定的。

接下来第五编要回答一个很多读者一直在等的问题：基因呢？

带走的话

最糟糕的条件也让我们看到：被回应是孩子发展的基本需要。可是最糟糕的条件之后，孩子仍然可以恢复。敏感，不是命定。后来的好日子是真的有用的。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
斯皮茨“住院病”观察	[中]	

说法	证据级别	说明
		方法学有缺陷，但推动了改革
哈洛的代理妈妈实验：接触的温暖是独立需要	〔强〕	1950 年代，伦理有争议
罗马尼亚孤儿院的极端剥夺	〔强〕	历史事实，有大量记录
ERA：6 个月内被收养的孩子认知基本赶上，超过 6 个月的部分落后	〔中〕	核心发现，具体数字待核
ERA：部分孩子出现准孤独症特征和去抑制性社交参与	〔中〕	多次报告
BEIP：随机分入寄养组的孩子认知明显好于继续机构照料组	〔强〕	随机对照，多次追踪
BEIP：42 个月时智商约 109、81、73	〔中〕	数值待核，以原文为准
越早离开机构恢复越好，两岁不是严格界线	〔中〕	不同指标结果不完全一致
人类多为敏感期而非严格关键期	〔强〕	发展神经科学主流观点
对普通家庭，目标是“足够好”，而不是最大化	〔解释〕	本书的概括，门槛无法精确画出
家访、抑郁治疗等干预对高风险家庭有帮助	〔中〕	如护士一家庭伙伴项目，效果因项目而异
寄养与机构的差别，核心是固定的、个人化的照料者	〔中〕	研究者的解释，不是唯一因素
重复的日常让孩子学会预期	〔解释〕	本书的归纳
恢复多以月甚至年计，是逐步的	〔中〕	追踪研究
孩子可能先“试”新照料者	〔中〕	临床常见描述
不强迫亲近，让孩子带节奏	〔解释〕	本书的建议
照料有剥夺经历的孩子，大人需要支持	〔中〕	

说法	证据级别	说明
		临床经验与家访研究的共同看法
机构出来的孩子常见不让抱、藏食物、对人没分寸等表现	〔中〕	常被报告，并非人人都有
表中“可能在说什么”一栏	〔解释〕	是解释，不是定论
晚被收养的孩子进步较慢，但仍有进步	〔中〕	与罗马尼亚研究的发现一致
领养家庭的信任是被一天一天陪出来的，速度因人而异	〔解释〕	本书对场景的解读
关系改善后，孩子的状态往往跟着改善，儿童期和青春期都有	〔中〕	相关研究，因人而异
对大一点的孩子简单承认过去，不求原谅	〔解释〕	本书的建议
母亲抑郁时，对孩子的回应和表情往往变少	〔中〕	多项观察研究
治疗后母婴互动常改善，孩子情况也改善	〔中〕	干预研究，细节待核
有伤害自己或孩子的念头，应马上联系医生或危机热线	〔核〕	通行的安全建议
话轮增加后，孩子的话往往跟着多起来	〔中〕	话轮研究，见第 12 章
人类多为敏感期而非关键期，晚一点也有进步	〔强〕	发展神经科学主流观点
需要专业评估的几种情况	〔核〕	通行建议，大意如此
智商数字是群体平均数，不能套用到具体的孩子	〔强〕	统计常识
孤儿院研究的局限：入院前情况不同、经历极端	〔中〕	研究者在报告中反复提及
随机分组的研究因果证据较强，只做比较的研究不能确定原因	〔强〕	研究设计的基本常识
恢复不等于回到完全一样，部分孩子仍有困难	〔中〕	多次追踪的一致发现

说法	证据级别	说明
产后情绪问题需要治疗，家人分担后逐步好转，补从当下开始	〔解释〕	本书对场景的解读
自查三问（受伤找你、回家眼亮、一起笑）	〔解释〕	本书的自查，不是量表
领养孩子建立新依恋的时间，随收养年龄和早期剥夺而异，无统一时间表	〔中〕	研究和临床经验，个体差异大

个体情况，比如产后抑郁、家庭暴力、成瘾等问题，请及时寻求专业帮助，遵医嘱。

第五编

器具、公平与奠基：基因、不同的孩子，和一个要接住母亲的社会

这一编三章，回答三个读者一定会问的问题：基因呢？有“不同”的孩子呢？早期没做好，还来得及吗？

第 15 章讲基因给的是器具，不是智慧本身。第 16 章讲盲、聋、腿脚不便的孩子，用别的通道，同样发生智慧。第 17 章讲奠基不是命定，以及社会怎样接住母亲。

三章走完，前面“为什么”就讲完了。下一编开始，讲“怎么做”。

第 15 章

基因给的是器具：它重要，可它不是智慧本身

◆ 一、一道绕不过去的题

写到这里，本书不能再绕了。

有一位读者看了前面的章节，很可能心里一直在问：

“你说了这么多，母亲怎么回应、孩子怎么学。可是我同事家的孩子三岁就背唐诗，我家的到现在还不爱说话。这难道不是基因的事？”

这是一个应该认真回答的问题。

如果本书只讲“环境、回应、母亲”，而假装基因不存在，那它就不是一本有“齐全的科学根据”的书。

所以这一章要把基因这件事摆到桌面上，讲清楚三件事：

第一，基因确实重要。

第二，基因重要在哪里，又不重要在哪里。

第三，基因和本书讲的“智慧”是什么关系。

◆ 二、基因确实重要：先把话说满

先说一件很多“后天决定论”的书不愿意说的事。

对一个群体来说，人和人在智力测验分数上的差异，有相当一部分可以用基因差异来解释。

最常用的研究办法是双胞胎研究：比较同卵双胞胎（基因几乎完全一样）和异卵双胞胎（基因平均一半相同）。如果同卵双胞胎之间的相似度比异卵的高得多，就说明基因在起作用。

这样的研究做了几十年，在很多国家，样本很大。大致的结论是：

在成年人里，智力测验分数的差异大约有六到八成可以由基因差异来“解释”。在儿童里，这个比例低一些，大约二到四成。随着年龄增长，这个比例会逐渐上升。〔中：多项双生子研究和综述，比如 Haworth 等 2010 年的大样本研究，9 岁时约四成，17 岁时约六成多，具体数字，不同研究有出入，待核〕

这个现象叫“威尔逊效应”：基因的“影响”反而随着年龄越来越大。

不过这里有两个很容易被误解的地方，一定要说清楚。

◆ 三、“遗传率”这个词，很容易被误读

第一个误解，是对“遗传率”的理解。

“遗传率为百分之五十”不是说“一个人的智力一半来自基因，一半来自环境”。

它的意思是：在某一个特定的群体里，某一个特定的时间，人们之间的差异有百分之五十可以用基因的差异来统计地解释。

这是一个“群体的统计量”，不是“个体的配比”。

用一个常用的比喻：

身高的遗传率很高，在营养充足的人群里大约百分之八十。可是过去一百多年里，世界上很多国家的人平均身高增加了十几厘米。这不是因为基因变了，而是因为营养好了，疾病少了。〔强：身高的遗传率，和平均身高的长期上升，都是有充分证据的事实〕

也就是说，一个性状的遗传率很高，不意味着它不能被环境改变。

同样的，“智力测验分数”在过去一百年里也在上升。这个现象叫“弗林效应”：在很多国家，平均每十年，智力测验的分数上升大约 3 分。这明显不是基因变化造成的。〔强：弗林效应，是被广泛重复的发现，近二三十年，在一些国家，出现了停滞或下降〕

所以第一个要记住的是：

遗传率描述的是“群体里差异的来源”，不是“个体的命运”，更不是“不可改变”。

◆ 四、基因和环境，不是“两个人在分蛋糕”

第二个误解，是把基因和环境当成两个独立的东西，各自出一份力。

实际上它们是缠在一起的。

有一种缠法叫“基因—环境相关”：

一个孩子天生对声音很敏感，爱听人说话。于是大人更多地跟他说话。于是他听到更多的话，学得更快。这时候很难说学得快是“基因”的功劳，还是“环境”的功劳，两者已经混在一起了。〔解释：这是行为遗传学里的一个常见概念，叫“诱发型基因—环境相关”〕

还有一种缠法：

在同一个家庭里，父母既给了孩子基因，也给了孩子环境。一个爱读书的父母，既把可能和阅读有关的基因传给了孩子，也在家里放满了书。这样的情况会让研究者很难分清到底是哪一个起了作用。〔解释：叫“被动型基因—环境相关”〕

还有一种缠法更有意思：

环境可以改变基因的遗传率。

2003 年，有一项很著名的研究。特克海默和同事分析了美国一批双胞胎的数据。他们发现，在贫困家庭里，孩子智力分数的差异主要由环境差异解释，基因的作用很小；而在富裕家庭里则相反，基因的作用更大。这个发现说明：在恶劣的环境里，孩子的潜能没有得到发挥，基因的差异就“显不出来”。

〔有争议：这个研究后来的重复结果不一致。在美国之外，一些国家没有发现同样的模式，所以只能当作“有启发”，不能当作定论〕

我们不需要深究这些细节。要记住的是一个简单的道理：

基因和环境是“一起做出”一个人的，不是“各出一半”。

◆ 五、基因能预测多少

现在有人会问：既然基因这么重要，现在科学能不能直接从基因预测一个孩子的智力？

这几年，随着基因测序的进步，科学家用几十万甚至上百万人的数据，找到了很多和教育程度、智力测验分数有关的基因位点。把这些位点加在一起，可以算出一个“多基因分数”。

这个分数能解释多少？

目前的结果是：在欧洲血统的人群里，用多基因分数能解释受教育年数差异的大约百分之十几，能解释智力测验分数差异的大约百分之五到十。〔中：2018 年前后的大规模研究，数字会随着样本增加和方法改进而变化，待核〕

这个比例比没有要强，可是离“预测一个孩子的未来”还差得很远。而且这个分数在不同人群里预测力差别很大，在非欧洲血统的人群里更弱。〔中〕

所以到今天，用基因去预测一个孩子的“聪明程度”是做不到的。如果有商业机构宣称可以通过基因检测告诉你孩子“适合学什么”“智商潜力有多高”，请你保持怀疑。

◆ 六、一个数字，该怎么读

前面说，多基因分数能解释智力测验分数差异的百分之五到十。这个数字，是多还是少？

先说它不是什么。

它不是说“这个孩子的智力有百分之五到十来自基因”。

它说的是：在一大群人里，把所有人的分数排开，这个基因分数能解释其中一小部分的高低差别。

可以把它想成一把很粗的尺子。

拿它量一整个班级的平均情况，有一点用。拿它量某一个孩子，误差大得几乎没法用。〔中：多基因分数在个体层面的预测很不准，是研究者普遍承认的局限〕

再看另一个性状：身高。

同样用多基因分数去预测身高，能解释的部分比智力大得多。〔中：身高是受基因影响很大、又容易测量的性状，细节待核〕

这说明：不同的性状，基因“好读”的程度不一样。

智力、受教育程度这类性状，牵涉的因素太多，家庭、学校、同伴、机会，全都缠在里面。

所以读这个数字，请记住两句话：

第一，它是群体的，不是你家孩子的。

第二，它会随着研究更新而变，今天的数字，不是最后的数字。〔中〕

◆ 七、本书的立场：基因是器具

好，讲了这么多，我们终于可以说清楚本书的立场了。

本书前面讲过一句话：基因提供一个“公平的器具”，包括材料、工具、环境。

让我们回头把这句话解释一下。

“器具”是什么意思？

好比一个人要做一桌饭。他有锅，有刀，有火，有食材。基因就是这些“锅、刀、火、食材”。

有的人的锅大一点，有的人的火旺一点，有的人的刀快一点。这些差异是真的，会影响做饭的“效率”和“方式”。

可是做出来的这一桌饭是好吃还是难吃，是丰盛还是单调，主要取决于做饭的人学到了什么，经历了什么，怎么用这些器具。

在这里我要补充一句，是本书的一个关键判断，请你仔细读：

“器具”的差异不等于“智慧”的差异。

这句话是什么意思？

我们在第 1 章里给“智慧”下了一个定义：分出不同，把不同接成路，回应并改变下一步遇到的不同。

“智慧”是一个“过程”，是一个“能力”，是“一个人和世界之间的来回”。它是用器具做出来的东西，而不是器具本身。

一个人视力差，是一种“器具”的差异。可是他的“智慧”可以通过听、通过摸、通过其他通道同样发生。这一点下一章会专门讲。

一个人记忆力好，也是一种“器具”的差异。不过“记得多”和“能把不同接成路”不是一回事。

“智商”是什么？它是用特定的测验测出来的、某些方面的“器具”水平的指标。它有用，在很多方面能预测学业和工作的表现。不过它不等于“智慧”。

本书不否定“智商”，也不贬低“智商”。本书只是不拿它当作“智慧”的定义。

◆ 八、器具和智慧：一张对照表

前面讲了不少话。这里用一张表，把“器具”和“智慧”分开放。

比较	器具	智慧
是什么	起点：材料、工具、环境	用器具和世界来回做出的能力

比较	器具	智慧
举例	视力、听力、记忆力、气质、平衡感	分出不同，接成路，回应并改变下一步
从哪来	基因，加上孕期里的条件	子宫里、0 到 3 岁和以后日子来的来回
能不能比	能比，各有各的用处	不适合排名，要看来回有没有断
能不能补	有的能补，比如眼镜、助听器	一生都在继续长

表里有一格要多说一句：器具不只来自基因。

孩子在子宫里的那几个月，营养、感染、酒精等因素，也在塑造他的起点。〔强：孕期饮酒会影响胎儿脑发育，严重营养不良和某些感染也会，是产科基本常识〕

这些条件很多时候不由母亲一个人说了算。空气、收入、医疗、工作，都在里面。所以本书不把它们记在母亲一个人的账上。〔解释〕

为什么要把器具和智慧分开？本书有三个理由。

第一，分开了，才不会把一张测验分数当成一个人的全部。

第二，分开了，才知道哪里可以动。器具有的能补，智慧靠来回一直长。

第三，分开了，才不会拿别家孩子的器具，去给自己的孩子打分。

再举一个小例子。

两个孩子学骑自行车。一个平衡感天生好，一个差一些。平衡感是器具。

好的那个，摔两次就骑稳了。差的那个，摔了十几次，膝盖青一块紫一块。

最后两个人都会骑。

靠的是什么？是摔了，看了，改了，再试。这就是“把不同接成路”。

器具决定快慢，来回决定会不会。

◆ 九、这对母亲，意味着什么

讲到这里，我们回到母亲。

第一，不要因为孩子的“器具”和别人的不一样而焦虑。

一个孩子说话晚，一个孩子数字敏感，一个孩子运动好，一个孩子爱发呆。这些很大程度上是“器具”的差异。每一种都可以发展出“智慧”。

第二，不要把“基因好”当成不努力的理由。

一个孩子即使天生“器具”很好，如果长期没有“来回”，没有被回应，他的智慧仍然发展不出来。罗马尼亚的孤儿就是一个极端的例子。

第三，不要把“基因差”当成放弃的理由。

“器具”只决定一个“范围”，而不是一个“点”。在这个范围里，环境可以让一个人走到上端，也可以让一个人停在下端。

研究者在这方面有一个有意思的发现：收养研究。

把一些孩子在很小的时候从贫困或者条件差的家庭转到条件好的收养家庭，追踪他们的智力分数。

发现平均而言，被收养的孩子比没有被收养、留在原来环境的兄弟姐妹分数高出不少。有一项汇总了多个研究的分析估计，这个差异在十几分的量级。

〔中：范·艾曾道恩等 2005 年的元分析，具体数字待核。收养家庭本身是有选择的，所以结果要谨慎解读〕

这说明：在同一套基因的情况下，环境仍然能起到实质性的作用。

所以一句话：

“器具”是你拿到的，不能选。“怎么用”是后天的，可以改。

◆ 十、关于“公平”这个词

最后讲讲本书里的“公平”这个词。

很多人听到“基因决定”，会觉得不公平：有的人天生就好，有的人天生就差。

本书换一个角度看这件事。

“器具”的差异是有的。不过“器具”不是“价值”。

没有哪一种器具是“全部好”或“全部差”的。

一个人擅长抽象的推理，另一个人擅长体察别人的情绪。一个人听觉敏锐，另一个人手很巧。每一种“器具”在不同的环境里有不同的价值。

“公平”的意思是：每个人都拿到了一套“能够发生智慧”的器具。每个人的器具不一样，不过都是够用的。

“智慧”是用这套器具和世界来回、来回、来回做出来的。

这个“做”是后天的。是每个人在子宫里，在 0 到 3 岁，在后来的所有日子里，一点一点做出来的。

所以不必比较“器具”。要看的是“来回”。

◆ 十一、孩子的几种“风格”，和你可以搭的手

“器具”的差异，放到日子里，常常表现为孩子的“风格”。下面是几种常见的样子。

孩子的风格	常见的表现	你可以怎么搭手
手的孩子	爱拆、爱摆弄，话不多	给安全的小件，在旁边陪着，偶尔问一句“这是什么”
嘴的孩子	爱说，爱问，爱模仿	多问“为什么”，也留一点安静的时间
眼的孩子	爱看，爱发呆，反应慢半拍	不催，陪他看，他看哪里你说哪里
腿的孩子	爱跑，爱爬，坐不住	带出去，让他把劲用在安全的地方

这张表是示意，不是分类，更不是给孩子“贴标签”。〔解释：本书的举例，同一个孩子常常是几种风格的混合，也会随年龄变〕

请注意最后一列。

每一行的做法，都是同一件事：跟着孩子的通道，去接他的来回。

不要把“手的孩子”拉去练说话，也不要把“嘴的孩子”按在桌前拼积木。

先接上他的路，再慢慢带他走别的路。

◆ 十二、再看一个家：江远和他的弟弟

江远有一个弟弟，叫江帆，比他小四岁。

兄弟俩一个爸，一个妈，在同一间屋子里长大。

哥哥小时候安静，爱拆东西。家里的收音机，被他拆过三台。弟弟爱说话，爱画画，放学路上能和卖菜的大爷聊半天。

他们的母亲常叹气：“一个娘生的，怎么差这么多？”

有一年春节，江远把这句话讲给苏晴听。苏晴问：“你觉得是怎么差的？”

江远想了很久，说：“我也不知道。不过我记得，我上小学那几年，家里很紧，爸妈都在外面忙。我一个人在家，只好自己找事做。”

“弟弟上学的时候，家里宽松些，奶奶也搬来了，屋里总有人说话。”

苏晴笑了：“那你们俩，住的其实不是同一个家。”

江远愣了一下，说：“好像是。”

这个小故事讲的是一件很普通的事。

同一对父母，给两个孩子的基因不完全一样，两个孩子碰上的日子也不一样。年纪不同，家里的光景不同，遇到的老师和朋友也不同。〔中：行为遗传学把这类“同一个家里各不相同的经历”叫作“非共享环境”，多项研究发现它对兄弟姐妹的性格差异贡献不小〕

所以母亲不必为“两个孩子不一样”而内疚。

不一样，是常态。

◆ 十三、五句常被说错的话

读到这里，你大概已经发现，关于基因，流行的说法常常说过了头。下面把几句最常听到的话，换成更准确的说法。

常听到的说法	更准确的说法	证据
“智商一半靠基因”	遗传率是群体里差异的统计，不是一个人的配比	〔强〕
“基因好的孩子不用管”	器具再好，没有来回，智慧也长不出来	〔强〕
“基因差的孩子没救了”	器具决定一个范围，不决定一个点，环境仍有实质作用	〔中〕
“基因检测能告诉你孩子的天赋”	目前没有可靠的依据	〔中〕
“孩子像谁，就是谁的基因”	外貌多半来自遗传，习惯多半是学来的	〔解释〕

这张表可以贴在冰箱上。

下次再有人说“这孩子就是基因不行”，你可以笑一笑，把表里的话轻轻说回去。

◆ 十四、常见的几个问题

问：孩子到底像谁？

答：外貌上，像父母的地方很多。身高、肤色、脸型，有很大一部分来自遗传。〔强：遗传学基本常识〕

脾气也有一部分来自遗传。多项双生子研究发现，气质有一定的遗传成分，具体比例各研究不同。〔中〕

说话的腔调、口头禅、做事的习惯，多半是在日子里学来的。〔解释：孩子大量通过模仿来学习，这是本书的读法〕

所以“像爸爸”“像妈妈”，常常既是基因，也是模仿。

问：能不能测基因，看孩子的潜力？

答：目前不能可靠地做到。前面讲过，多基因分数离“预测一个孩子”还差得很远。〔中〕

有一类基因检测确实有用，就是针对已知的遗传病或染色体异常，在医生指导下进行。〔强：医学遗传学常识〕

至于“智商潜力”“适合学什么”这类检测，请保持怀疑。〔中：缺少可靠的预测依据〕

做检测之前，先问问医生：这个检测能回答什么，不能回答什么。

问：双胞胎为什么也不一样？

答：同卵双胞胎的基因几乎一样，不是完全一样。〔中：发育过程中会出现少量差异〕

在子宫里，两个孩子的位置和分到的营养，也不一定相同。〔中：这是产科常识，双胞胎的子宫内条件并不总是一致〕

出生之后，各自碰上的人和事更不一样。大脑连接的形成里，还带着一些随机的成分。〔中：发育生物学的看法，对智力的具体贡献还不清楚〕

一句话：基因是起点，不是剧本。

问：天才是天生的吗？

答：老实说，学界没有一个干净的答案。

多项研究发现，很高的成就，既需要天赋，也需要长期的、有指导的练习。〔中〕

流行的“一万小时”说法，被不少研究者质疑，算不上定论。〔有争议〕

本书不说天才是天生的，也不说天才是练出来的。本书只说：器具给起点，来回给路程。〔解释〕

问：同一个家的兄弟姐妹，为什么差别这么大？

答：除了同卵双胞胎，兄弟姐妹平均只有一半的基因变异是相同的。

〔强：遗传学基本知识〕

再加上排行、年龄、朋友、老师都不同，每个孩子碰上的“家”也就不同。

有人说老大、老二的性格天生有规律，这类“出生顺序”的说法，研究结论并不一致，不宜说得太满。〔有争议〕

问：孩子说话晚，是不是基因的问题？

答：可能有关，也可能无关。说话晚的原因有很多。

有的孩子性格偏安静，有的孩子是手上的功夫先发展，也有的孩子需要听力或发育方面的帮助。〔中：这是儿童保健的常识，原因因人而异〕

所以第一步，请医生查一查听力。〔中：排查听力是儿童保健里常见的步骤〕

排除了问题，就继续在日常里一问一答，一指一说。

◆ 十五、放回日子里

苏晴的孩子十七个月，一直不爱说话。

苏晴有点着急。她的同事小周，孩子和她家的同岁，已经会说十几个词了。

有一天两个人在公司的茶水间聊起这件事。

小周说：“我家孩子是不是话多了点？每天叽叽喳喳，我都有点烦。”

苏晴说：“我家是不是话少了？”

小周说：“可能就是不一样吧。”

回到家，苏晴想起前一天晚上，孩子在地上把一个玩具一点一点拆开，又装上，一个人弄了二十多分钟。她在旁边看着，没有打扰。

她想：他也许是一个“手”的孩子，不是“嘴”的孩子。

不过她没有放松对“来回”的投入：每天仍然和他在玩具边一问一答，一指一说。

半年后，孩子的话慢慢多起来了。不如小周家的孩子多，不过每句话都很准。

这就是“器具”和“来回”的关系：器具决定了他的“风格”，来回决定了他“发生”。

带走的话

基因给的是器具。器具有差异，不过每一套都够用。智慧不是器具本身，是用器具和世界来回做出来的。不必比器具，要看来回。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
成年人智力测验分数的差异中，约六到八成可由基因差异统计地解释；儿童较低	〔中〕	双生子研究，数字待核，Haworth 等 2010

说法	证据级别	说明
遗传率是群体统计量，不是个体配比，也不等于不可改变	〔强〕	行为遗传学基本共识
身高遗传率高，平均身高仍长期上升	〔强〕	营养与健康改善所致
弗林效应：平均每十年约上升 3 分，近年部分国家停滞	〔强〕	多国数据
诱发型和被动型基因—环境相关	〔解释〕	行为遗传学概念，难以完全分开
贫困家庭中智力的遗传率较低	〔有争议〕	Turkheimer 等 2003，重复结果不一致
多基因分数可解释受教育年数差异约十几个百分点，智力约 5%—10%	〔中〕	数字随研究更新，非欧洲人群更弱，待核
收养到较好环境的孩子智力分数平均高出十几分	〔中〕	van IJzendoorn 等 2005，数字待核，收养家庭有选择
器具的差异不等于智慧的差异	〔解释〕	本书的理论判断，基于对“智慧”的定义
器具和智慧可以分开看，器具来自基因加孕期条件	〔解释〕	本书的归纳，孕期条件并不都由母亲决定
孕期饮酒、严重营养不良、某些感染会影响胎儿脑发育	〔强〕	产科基本常识
兄弟姐妹的“非共享环境”对性格差异贡献不小	〔中〕	行为遗传学多项研究，细节待核
外貌（身高、肤色、脸型）大部分来自遗传	〔强〕	遗传学基本常识
气质有一定遗传成分，比例各研究不同	〔中〕	多项双生子研究
习惯、腔调多半靠模仿学来	〔解释〕	本书的读法
针对已知遗传病、染色体异常的检测有明确用途	〔强〕	须在医生指导下进行
“智商潜力”“适合学什么”的检测缺少可靠依据	〔中〕	多基因分数预测力有限

说法	证据级别	说明
同卵双胞胎基因几乎一样，不是完全一样	〔中〕	发育中会有少量差异
双胞胎在子宫里的条件不一定相同，大脑连接形成带有随机成分	〔中〕	产科与发育生物学常识，对智力的贡献不清楚
高成就既需要天赋，也需要长期有指导的练习	〔中〕	多项研究，细节待核
“一万小时”说法	〔有争议〕	被不少研究者质疑
兄弟姐妹平均共享一半的基因变异	〔强〕	遗传学基本知识
出生顺序决定性格的说法	〔有争议〕	研究结论不一致
说话晚的原因多样，应先查听力	〔中〕	儿童保健常识
多基因分数是一把粗尺，适合群体，不适合预测个体	〔中〕	研究者普遍承认的局限
身高的多基因分数能解释的比例比智力大得多	〔中〕	细节待核
孩子的几种“风格”只是示意，常是混合的，会随年龄变化	〔解释〕	本书的举例，非分类

个体情况，比如孩子的发育评估、智力测验结果的解读，请咨询专业人员。商业基因检测对孩子“潜力”的宣称，请保持怀疑。

第 16 章

器具不同，智慧同样发生：盲、聋、腿脚不便的人，和他们的妈妈

◆ 一、一句要先说清楚的话

这一章要从一句话说起。

在本书的写作过程中，作者曾经和一位朋友聊起基因的事。朋友说：“一个人生来腿脚不便，他的智慧是不是就会差一些？”

作者的回答是：“这两者没有关系。”

这句话有点斩钉截铁。可是它是本书立场里很重要的一块。

本章就要把这句话讲清楚，讲得有证据。

要讲的是三种常见的“器具”差异：眼睛看不见，耳朵听不见，腿脚不便。

每一种都可以问同一个问题：

这个人用别的通道，同样的 SDE 智慧能不能发生？

答案是：能。而且这里面还有很多值得一讲的东西。

◆ 二、看不见的孩子，用手“看”

先讲盲。

20 世纪 60 到 70 年代，美国的精神分析学家塞尔玛·弗赖贝格在旧金山长期跟踪研究了一批先天失明的婴儿和他们的母亲。〔核：弗赖贝格的研究成果，收在她 1977 年的《看不见的婴儿》一书里，大意如此，具体细节待核〕

她发现了一些很有意思的事。

先天失明的婴儿在最初几个月里，和母亲之间的“来回”会遇到一个特殊的难题：

普通的婴儿对着母亲的脸色笑，母亲看到，笑回来。这是一个很重要的“来回”。可是盲婴看不到母亲的脸色。母亲也常常因为孩子的眼睛不看她，而不确定孩子是不是在回应她。

于是来回有可能“断”在这里。

弗赖贝格观察到，盲婴常常有一个特点：他们的脸在安静的时候是“静止”的，不太有表情。母亲看着他，容易觉得他没有反应。

但同时她也发现，盲婴有另一套“显露”的方式：他们的手。

当母亲说话的时候，盲婴的手会安静下来，或者轻轻动一动。当母亲的声音走近，他的手会伸出来。他们是用手的动作，用身体的“静”和“动”来回应的。

弗赖贝格的做法，是教母亲去“读”这套新的语言：看孩子的手，听孩子的声音，感受孩子身体的变化。

当母亲学会了读，“来回”就又接上了。

后来的追踪发现，在这样的支持下，盲孩子在语言、社交、认知上可以发展得很好。不过一般来说，一些动作，比如爬、走、够东西，会晚一些，因为没有眼睛去引导他。〔中：这类研究，样本不大，但方向比较一致〕

这个故事对本书最重要的启发是：

盲婴不是没有“来回”，他是用另一套“显露”来回。母亲需要换一套“眼睛”。

◆ 三、盲人的大脑，怎么用

那么，盲人的大脑是不是“少了一块”？

近年来，神经科学的研究给出了一个出人意料的答案：

盲人的大脑里，原本负责“看”的区域，也就是视觉皮层，没有被闲置。

20 世纪 90 年代，日本学者在一个著名的研究里，用脑成像观察盲人读盲文时的大脑活动。结果发现，在读盲文时，盲人的视觉皮层被激活了。而普通人用手去摸同样的东西时，视觉皮层没有被激活。〔强：Sadato 等，1996，发表于《自然》，后来有大量重复和扩展〕

也就是说，盲人的大脑把原来“看”的地盘征用来处理“触”和“听”了。

这个现象叫“跨通道可塑性”。

一些研究发现，先天失明的人在某些听觉和触觉任务上，比如辨别声音的位置、辨别触觉的细微纹理，表现比明眼人更好。〔中：研究结果不完全一致，不是所有的盲人，在所有任务上，都更好，要看失明的时间，和接受的训练〕

这些发现和本书的观点是对得上的：

“看”只是人和世界来回的一种通道。当这个通道不可用的时候，大脑会重新分配资源，让其他的通道扛起来。

所以“看不见”不等于“智慧少了一块”。它是“智慧用别的东西发生”。

第 1 章里提到的那位 18 世纪的盲人数学家桑德森，在剑桥大学讲授光学。海伦·凯勒既看不见又听不见，却学会了读写，成了作家。这样的人在历史上有很多。他们的故事不是“例外”，而是“证明”：智慧不依赖于某一个器官。

◆ 四、听不见的孩子，用手说话

再讲聋。

聋是另一种很有启发的情况。

先天失聪的孩子听不到母亲的声音，那他的语言怎么发展？

答案取决于一件事：他有没有“可以接收的语言”。

如果一个失聪的孩子生在聋人家庭，父母用手语交流，他从婴儿期就处在充满手语的环境里。

研究发现，这样的孩子学手语的过程和听力正常的孩子学口语的过程很相似：大约在一岁前后出现第一批“词”；两岁前后开始组合；三四岁能熟练地表达。手语里也有“咿呀学语”：失聪的婴儿会在手上“比划”出没有意义的、有节律的动作，就像听力正常的婴儿说“吧吧吧吧”。〔强：Newport、Meier、Petitto 等人的多项研究〕

可是如果孩子生在听力正常、不会手语的家庭，又没有及时得到助听设备、人工耳蜗或手语教学，他就可能长期处在“没有可接收语言”的状态里。

研究发现，这样的孩子在语言、认知、社交、心理健康上可能出现明显的迟滞。这种迟滞不是因为“聋”本身，而是因为他没有语言的“来回”。

〔强：语言剥夺对失聪儿童的影响，有大量证据〕

这个对比很有力：

同样是失聪，有的孩子语言发展和同龄人几乎一样好，有的孩子严重落后。

区别在哪儿？不在耳朵，在于有没有一个人和他用他能接收的方式来来回。

还有一个更令人惊叹的例子：尼加拉瓜手语。

20 世纪 70 年代以前，尼加拉瓜的失聪儿童大多分散在各自的家庭里，没有统一的手语。1977 年前后，首都马那瓜建立了专门的学校，把很多失聪的孩子聚在了一起。

孩子们一开始用各自家里简单的“家庭手势”交流。可是在几年里，在孩子们的互动里，一种新的、有语法、有结构的语言自己长出来了。后来的几代孩子又把它发展得越来越丰富。〔强：Senghas、Kegl 等人的研究，被广泛引用，是语言自发产生的经典案例〕

这几乎可以说是 SDE 的“教科书例子”：

一群孩子在没有人教的情况下，通过不断地互相“来回”，创造出了一门语言。

语言不是被“给”的，是在“来回”里发生的。

◆ 五、腿脚不便的孩子，用别的路径去够世界

再讲第三种：运动上的不便。

有的孩子生下来腿脚就不太方便：有的是脑瘫，有的是肌肉疾病，有的是肢体缺失，有的是先天性的骨骼发育问题。

对这样的孩子，很多父母担心的是：他探索世界的方式会不会受限？他的智慧会不会受影响？

我们回想第 5 章。触觉的 SDE 在子宫里是在“动”里发生的。出生后，爬、走是孩子探索世界的重要方式。

那么对一个爬不了、走不了的孩子，“来回”怎么发生？

答案是：用别的方式。

孩子可以用手去够、去抓；可以用眼睛去看、去追；可以用声音去叫、去应；可以被抱着、被带着去看世界；可以用轮椅和辅助设备去移动。

研究发现，很多有肢体障碍的孩子，只要有足够的探索机会和回应，他们的认知可以发展得和同龄人一样好。〔中：这类研究，包括脑瘫儿童的认知研究，因为脑瘫的类型和程度，差异很大，所以，结果也有差异，不能一概而论〕

可是这里要老实地说一句：

如果运动不便同时让孩子失去了大量探索世界的机会，那么这确实可能影响他的发展。比如一个孩子因为不能爬，长时间被放在一个地方，没有人带他看世界，他接触的东西和人就会少得多。

所以问题的核心不是“不能走”本身，而是“因为不能走，是不是就少了来回”。

对策也很清楚：把世界带到他面前，把来回换一个路径接上。

◆ 六、三条通道，一张对照表

前面讲了三种“不同”。这里用一张表，把它们并排放在一起。

不同	常用的通道	家人可以做的	要留意的
看不见	触、听、身体的动作	出声说明你在做什么；让孩子摸一摸；学着读他的手	爬、走、够东西可能晚一些，要给他安全的空间去探索
听不见	看、手语、助听设备	面对面说话，让他看到你的脸；尽早用上助听设备或手语	最怕的是“没有可以接收的语言”
腿脚不便	手、眼、声音、辅助器具	把世界带到他面前；别让他长时间待在一个地方	要防的是“来回变少”，不是“不能走”

这张表是本书对前面几节的归纳。〔解释〕

三行有一个共同的地方：每一行的第三列，都在说“把来回接上”。

通道不同，母亲要做的事就不同。不变的，是那句老话：来回不能断。

◆ 七、早一点发现，早一点接上

前面反复说“早一点”。这一节讲讲，早一点具体指什么。

先说听力。

我国的新生儿，出生后几天内一般会做听力筛查。〔核：具体做法各地略有不同，请以所在医院为准〕

筛查没通过，不等于孩子听不见。有一部分孩子，复查之后听力是正常的。〔中：这是筛查中常见的情况，原因比如耳道里还有残留液体〕

所以没通过的时候，不必先慌，按医院的安排去复查。

国际上有一个常被提到的目标，叫“1-3-6”：一个月内完成筛查，三个月内确诊，六个月内开始干预。〔核：许多国家和地区采用的目标，具体措辞待核〕

多项研究发现，听障儿童越早被发现、越早得到支持，语言的结果越好。〔中〕

再说视力。

婴儿期的眼科检查，可以发现先天性白内障等问题。〔强：眼科基本常识〕

有一种情况叫弱视：眼睛本身看起来没问题，但大脑没有学会好好用这只眼。弱视在儿童期治疗，效果比较好。〔强：眼科基本常识，治疗窗口主要在儿童期〕

如果你发现孩子不追光，不看人脸，眼睛总是晃动，或者一只眼总是歪着，请带他去眼科看看。〔中：儿童保健常见的提醒，具体判断请交给医生〕

最后说动作。

儿童保健的体检里，有一张“发育里程碑”的参考表，比如什么时候抬头、翻身、坐稳。〔强：儿童保健常规〕

晚几周不一定有问题。每个孩子有自己的节奏。〔强〕

如果孩子明显落后，或者本来会的事又退步了，请不要等，带他去儿童保健科或发育行为科。〔中：儿童保健的常见建议〕

还有一件事，常被人误会：手语不是“比划”，是一种真正的语言，有自己的语法。〔强：语言学共识〕

所以一个孩子学手语，不是“学得不够好”，而是在学一门语言。

◆ 八、一个需要老实说的地方

讲到这里，需要有一个严肃的补充。

前面说的盲、聋、肢体不便有一个共同的特点：孩子的“智慧”本身可以通过别的通道完整地发生。问题主要在于需要重新找到通道。

可是还有一类情况和这个不完全一样：一些神经发育上的差异，比如孤独症、一些类型的智力障碍、严重的发育迟缓。

这样的孩子，差异有时候不只是“某个通道不可用”，而是影响到“来回”本身。比如对人的信号不容易注意，对声音的反应不一样，对触碰特别敏感或特别不敏感。

对这样的孩子，本书不能说“只要回应就够了”。

因为在这种情况下，单靠日常的“回应”常常是不够的。需要专业的评估和专业的干预。

研究发现，早期干预，包括让父母学习如何用孩子能接受的方式去互动，在一些情况下可以改善孩子的发展。〔中：比如针对孤独症幼儿的“家长引导”的干预，有随机对照试验，显示在亲子互动和部分发展指标上的改善，效应的大小和持续时间，各研究不同〕

所以请记住：

如果你觉得孩子对声音、对人、对触碰有明显的“不同”，请不要一个人硬扛，也不要因为“孩子还小”而等着。

去看儿童保健科、发育行为科，请专业的人评估。

这样做不是在说“孩子有问题”，而是在说：“我要找到最适合他的通道。”

这和本书的主张是一致的：器具不同，需要换一套回路。早一点找更好。

◆ 九、这些故事，共同在说什么

好，把前面的故事放在一起：

盲婴：用手说话。母亲学着读手。

聋童：用手语说话。有手语的发展得好，没有语言的才落后。

腿脚不便的孩子：用别的路径去够世界。关键是来回没有断。

这些故事有一个共同的结构：

“器具”不同了，“通道”就不同了。不过“来回”这件事没有变。

只要来回接得上，智慧就在发生。

这就是本书前面说的“器具不同，不等于智慧不同”的证据。

那么反过来，对母亲是什么意思？

意思是：

如果你的孩子有一些“不同”，请不要先问“他能不能赶上别人”。先问：“他的通道是什么？我怎么和他接上？”

◆ 十、把家布置成一个好用的“来回场”

“器具”不同，家里的布置也可以跟着不同。下面是几条常见的小办法，都很朴素。

对看不见的孩子：

一，常用的东西放在固定的位置。孩子知道“水杯在这里”，就容易自己去够。〔中：视障儿童支持中常见的做法〕

二，多给他不同质地的东西摸：软的，硬的，凉的，温的。

三，进屋、离开、靠近时，先出声，让他知道你在。

对听不见的孩子：

一，说话前，先让他看到你的脸，轻轻碰一下他的肩，让他知道“要说话了”。〔中：听力师和语训老师的常见建议〕

二，房间里的光线要亮，不要背着光说话，不然他看不清你的嘴。

三，门铃、闹钟，可以换成带闪光或振动的。〔核：市面上有此类产品，选购请参考专业人员的意见〕

对腿脚不便的孩子：

一，玩具放在他够得着的地方，不要全放在高处。

二，地上铺一块软垫，让他可以趴着、滚着、爬着去够东西。〔中：安全和探索的常见建议，具体方式请遵康复师意见〕

三，多把他放在“有人的地方”，比如厨房、客厅，让他看到家里在发生什么。

这些办法有一个共同点：不用花很多钱，也不用很多时间。

它们只是在回答同一个问题：怎么让他的来回，不被家里的布置挡住。

◆ 十一、小区游乐场里的一个下午

周末，苏晴和江远带孩子去小区的游乐场。

滑梯旁边有个五岁的男孩，叫小禾，耳朵上戴着蓝色的助听器。他的妈妈站在一旁，手里拿着一瓶水。

一个小男孩在背后喊他：“喂，让一让。”

小禾没有回头。

那个孩子又喊了一声，有点急，伸手去推他。

小禾的妈妈走过来，轻轻拍了拍小禾的肩，指了指那个孩子。小禾转过身，看着对方的嘴。

那个孩子愣了一下，问：“他听不见吗？”

小禾的妈妈蹲下来，说：“他能听见一些。不过要靠这个小机器，而且你看着他说话，他会听得更清楚。”

孩子“哦”了一声，跑到小禾面前，一字一字地说：“来，玩，滑梯。”

小禾笑了，跟着他跑了。

江远看着这一幕，说：“她没有躲那个问题。”

苏晴点点头：“孩子比我们想的学得快。你把话说清楚，他们就知道怎么做。”

这个小故事里，没有人去“纠正”谁，也没有人去“可怜”谁。

一个孩子知道了“要看着他说”，另一个孩子得到了一次被接住的机会。

大人要做的，常常只是把事实说清楚：他的通道是什么，别人怎么跟他接上。

◆ 十二、常见的几个问题

问：孩子查出听力问题，我该怎么跟他相处？

答：先让他看到你的脸。说话时面对面，距离近一点，语速自然，不用夸张。〔中：听力师和语训老师的常见建议〕

有助听设备的，每天坚持戴。设备适不适合，请听耳科医生和听力师的意见。〔核：具体方案由专业人员评估〕

手语和口语不必二选一，有的家庭两样都用。不过在听障教育里，两条路线长期有不同意见。〔有争议〕

最要紧的是每天说话，别停。〔解释〕

问：孩子的视力有问题，怎么办？

答：先去眼科查清楚，不要自己猜。〔强：眼科基本常识〕

日常里，把你在做的事说出来，比如：“妈妈在倒水，水是温的，你摸一摸杯子。”让他摸，让他听，让他闻。〔中：视障儿童早期支持的常见建议〕

给他一个安全的、可以放心爬一爬、摸一摸的地方。

问：医生说孩子发育落后，我每天该怎么跟他相处？

答：先别把孩子当成一份诊断。他还是那个爱笑、爱闹、爱看你的孩子。

回到“来回”：他看哪里，你就说哪里；他做什么，你就跟着说什么；每次只加一点点难度。

专业干预里学到的几招，放进日常的玩耍里，不用另外开一场“训练”。
〔中：家长介导的干预，强调把方法放进日常互动，效果因孩子和方案而异〕

每天也留一段只是玩的时间。

问：要不要对孩子说“残疾”这个词？

答：日常里，说具体的事更有用，比如“你的耳朵需要助听器”“你的腿走得慢些，所以我们用轮椅”。〔解释：本书的建议，让孩子把“不同”看成可以说明的事实〕

“残疾”是法律和政策里的正式用词，办证、申请补助时会遇到。〔核：我国有残疾人证和相关保障，具体名称和办法以现行规定为准〕

等孩子长大，他自己会问，也会选自己喜欢的说法。到时用事实回答，不躲，也不必羞愧。

问：别的孩子会不会嫌弃他？

答：老实说，有的孩子会好奇，有的会躲，也有的会欺负人。多项研究发现，有残障的儿童在学校里遇到欺凌的风险更高。〔中〕

大人可以提前和老师说清楚孩子的情况与需要，也可以教孩子一句话：“我听不太清，请看着我说话。”〔解释〕

上普通学校还是特殊学校，要看孩子的具体情况，教育界有不同意见。

〔有争议〕

别人的目光，是母亲最难扛的一块。你不是一个人在扛。

问：孩子的“不同”，是不是我哪里没做好？

答：不是。先天的听力、视力和运动问题，原因有很多：有的和遗传有关，有的和孕期感染、早产等有关，也有相当一部分找不到明确原因。〔中：医学上对这类问题的病因研究表明原因多样，常常查不出，细节待核〕

本书没有“怪母亲”的立场。第 17 章会专门讲这一点。〔解释〕

你现在要做的，是找到专业的人，把来回接上。

◆ 十三、放回日子里

苏晴的一个远房表妹姓陈，生了一个孩子叫豆豆，先天性双耳重度听力损失。

孩子在出生后第二天，听力筛查没有通过。三个月时确诊。

陈一度崩溃。她说：“我觉得天塌了。”

后来她遇到了一位听力师和一位语训老师。听力师给孩子配了助听器，后来又做了人工耳蜗植入。语训老师教她怎么在家里和孩子说话：

“你看着他，凑近一点，说话慢一点。他看你的嘴型，也要听。一定要让他看到你的脸。”

“做饭的时候也不要不说话。你拿着一个东西给他看，一边说。”

陈开始每天给豆豆讲一天的事。

两年后，豆豆会说话了。不算流利，不过会说“妈妈要抱”。三岁上了普通幼儿园。

陈后来对苏晴说：“当时我以为最难的是他听不见。后来我才明白，最重要的是我不能不说话。”

这句话几乎是本章的总结。

带走的话

看不见，听不见，走不快，都是器具的不同。智慧可以从别的通道发生。要紧的不是通道，而是来回有没有断。如果孩子的“不同”需要专业的帮助，早一点去，是爱，不是承认失败。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
盲婴用手和身体的动静回应母亲，母亲学会读后来回恢复	〔核〕	弗赖贝格，1977，细节待核
盲人读盲文时视觉皮层被激活	〔强〕	Sadato 等，1996，后有大量重复
先天失明者在部分听觉、触觉任务上表现更好	〔中〕	结果不一致，与失明时间、训练有关
聋人家庭的失聪儿童学手语进程与听人儿童学口语相似	〔强〕	Newport、Meier、Petitto 等
失聪又无可接收语言的儿童，语言和认知明显迟滞	〔强〕	语言剥夺证据充分
尼加拉瓜手语由儿童互动自发形成	〔强〕	Senghas、Kegl 等，经典案例
肢体障碍儿童在有探索机会和回应时认知可与同龄人相当	〔中〕	脑瘫类型差异大，不能一概而论

说法	证据级别	说明
家长介导干预对孤独症幼儿亲子互动有改善	〔中〕	随机对照试验，效应因研究而异
器具不同，来回不变，智慧就在发生	〔解释〕	本书的理论判断
三种“不同”对应不同通道，共同点是把来回接上	〔解释〕	本书对前文的归纳
新生儿出生后几天内一般做听力筛查	〔核〕	各地做法略有不同
筛查未通过的孩子中，有一部分复查后听力正常	〔中〕	筛查中常见，请按医院安排复查
“1-3-6”：一月筛查、三月确诊、六月干预	〔核〕	许多国家和地区采用，措辞待核
听障儿童越早发现、越早支持，语言结果越好	〔中〕	多项研究，细节待核
婴儿期眼科检查可发现先天性白内障等	〔强〕	眼科基本常识
弱视在儿童期治疗效果较好	〔强〕	治疗窗口主要在儿童期
孩子不追光、不看人脸、眼睛晃动、一只眼总歪，应就医	〔中〕	儿童保健常见提醒
发育里程碑可作参考，晚几周不一定有问题	〔强〕	儿童保健常规
明显落后或已会的事退步，应及时就诊	〔中〕	儿童保健常见建议
手语是有自己语法的真正语言	〔强〕	语言学共识
面对面、距离近、语速自然，有助听障孩子接收语言	〔中〕	听力师和语训老师的常见建议
手语与口语路线在听障教育中有长期分歧	〔有争议〕	以孩子具体情况为准
视障儿童早期支持：说出动作、让孩子触摸	〔中〕	常见建议

说法	证据级别	说明
家长把干预方法放进日常互动	〔中〕	效果因孩子和方案而异
对孩子用具体事实说明“不同”	〔解释〕	本书的建议
“残疾”为政策法律用词，办证与保障以现行规定为准	〔核〕	各地办法不同
残障儿童遇到校园欺凌的风险更高	〔中〕	多项研究
普通学校与特殊学校的选择	〔有争议〕	以孩子具体情况为准
先天听力、视力、运动问题病因多样，不少查不出原因	〔中〕	细节待核，不应归咎于母亲
视障、听障、肢体不便儿童的家庭布置办法	〔中〕	视障、听障支持中的常见建议，不是单一研究结论
带闪光、振动的门铃闹钟可用	〔核〕	选购请参考专业人员意见
腿脚不便儿童的软垫与探索	〔中〕	具体方式请遵康复师意见

个体情况，比如新生儿听力筛查、视力问题、运动发育迟缓、社交沟通异常，请及时到儿童保健科或相关专科就诊。

第 17 章

奠基，不是命定：以及，一个社会该怎样接住母亲

◆ 一、一座房子的地基

苏晴的孩子一岁半的时候，家里开始装修。

她和江远站在工地上，看着工人挖地基。一个姓张的老师傅叼着烟，说：“地基打得好，上面怎么盖都稳。”

苏晴问：“那要是地基打得不好呢？”

张师傅想了想，说：“不好，也不一定塌。不过上面盖到几层，就得小心。有的可以补，加固，打桩。有的不好补，就得扒了重来。”

回家路上，江远说：“你有没有觉得，这话跟我们最近读的那些研究，很像？”

苏晴笑了：“我也这么想。”

这一章就借“地基”这个比喻，把本书的核心主张说完整：

0 到 3 岁是智慧的地基，是平台。不过地基不是房子的全部，也不是命。

◆ 二、“奠基”的意思

先说“奠基”是什么意思。

我们前面讲了十几章，可以用一句话把它收起来：

在子宫里和 0 到 3 岁的日子里，孩子通过和主要照料者之间几万次、几十万次的“来回”，建起了这几样东西：

一，对世界的基本信任：我哭了，有人来。这个世界大体上是可靠的。

二，对自己的基本感觉：我做的事是有用的。我是值得被回应的。

三，最早的分出不同、接成路的习惯：看到、听到、摸到不同，就去试，去回应，去改。

四，情绪调节的底子：被安慰过，才会安慰自己。

五，语言和社会交往的起点：话是用来和人说的；人是可以接近的。

这五样东西不是“知识”，不是“技能”，而是一种“基本的样子”，一种“怎么和世界打交道”的默认设置。

这样的默认设置，会在以后的日子里影响他怎么看书，怎么交朋友，怎么面对失败，怎么和伴侣相处，怎么当父母。

这就是本书说的“基础”和“平台”。

◆ 三、为什么说“不是命定”

同样重要的是，要把“不是命定”说清楚，而且要有证据。

第一个证据，我们前面已经讲过了：罗马尼亚的孤儿在被收养之后，大部分有很大的恢复。第 14 章。

第二个证据，来自一项持续了四十年的研究：考艾岛研究。

1955 年，美国夏威夷的考艾岛上出生了 698 个孩子。心理学家埃米·沃纳和她的同事从他们出生，一直追踪到中年。〔核：考艾岛纵向研究，由沃纳和史密斯主持，是儿童心理学里的经典追踪研究，具体数字，待核〕

在这些孩子里，大约三分之一在童年处在“高风险”的环境里：贫困，父母不和或离异，父母有酗酒或精神疾病，出生时有并发症。

研究者原本预期，这些孩子大多数长大以后会出现各种问题。确实，其中大约三分之二在十几岁时出现了学习或行为上的问题。

令人意外的是，高风险组里还有大约三分之一，长大以后成了有能力的、有爱心的、自信的成年人。

研究者把他们叫作“有韧性的孩子”。

是什么让他们不一样？

研究者发现了一个重要的共同点：这些孩子生命里至少有一个稳定的、关心他们的成年人。这个人不一定是父母，可以是祖母、姨妈、邻居、老师、教会的长辈。这个人让他们感到：我是被人看到的，被人在乎的。〔中：沃纳的结论，被很多后来的研究，所印证，哈佛大学儿童发展中心，也把“至少一个稳定的、有回应的成年人关系”，作为儿童韧性的核心因素〕

这个发现对本书的意义很大：

即使地基不太好，只要后来有人稳定地回应，孩子仍然可以走得很好。

第三个证据，来自对人的一生的追踪：人的大脑有终身的可塑性。

近几十年的神经科学研究发现，成年人的大脑仍然可以因为学习而发生结构上的变化。比如学习杂耍的人，大脑中与视觉运动有关的区域，灰质体积会增加。〔中：Draganski 等，2004，小样本，后来的重复，结果不完全一致〕

可塑性在童年最强，在成年减弱，但没有消失。

所以一个成年人如果在童年“回应”不够，仍然可以通过后来的关系来“重新学”：伴侣，朋友，导师，心理咨询。心理学里有一个概念叫“获得性安全依恋”。意思是一个人在童年没有形成安全依恋，但通过后来的关系，变得像安全型的人。〔中：这个概念，来自成人依恋访谈的研究，有一些纵向研究的支持，但样本有限〕

这就是“不是命定”。

◆ 四、一扇关死的门，还是一段慢慢变窄的路

你也许听过“关键期”这个词，好像过了某个年龄，门就关死了。

科学家的说法要谨慎得多。

对有些功能，比如视觉，早期确实有一段很重要的时间。这段时间里缺了该有的刺激，后来很难完全补回来。〔强：视觉发育的关键期，是神经科学的经典发现〕

对另一些功能，比如语言和情绪，更像是“敏感期”。

敏感期不是一扇门，是一条慢慢变窄的路。越早走越宽，越晚走越窄，不过很少完全封死。〔中：多数研究者对语言等功能的看法，细节仍有讨论〕

这个区别，对母亲很重要。

它的意思是：早一点给，事半功倍；晚一点给，仍然值得给。

所以请不要被“错过了”三个字吓住。

◆ 五、可是，也不要吧“可以补”，当成“可以不管”

写在这儿，必须加一句平衡的话。

“不是命定”不等于“不重要”。

“可以补”是需要“付出”的。补比“一开始就对”更难、更慢，更需要运气。

罗马尼亚的孩子里，被收养得晚的，恢复得不如早的。考艾岛上那三分之二的孩子，没有遇到那个稳定的成年人，就出了问题。

所以本书的立场是：

一方面，请不要把“0 到 3 岁”说成“三岁定终身”去吓唬父母，让母亲因为一次没抱、一次没回应而夜不能寐。

另一方面，也请不要因为“还可以补”，就对孩子早期的需要掉以轻心，对母亲的困境视而不见。

地基值得好好打。打不好，也有救。

◆ 六、一段不光彩的历史：怪罪母亲

讲到“母亲和孩子的关系”，有一段历史必须讲出来，提醒我们。

20 世纪 40 到 60 年代，在西方有一种很流行的说法，叫“冰箱母亲”。

意思是：一些孩子得了孤独症，是因为他们的母亲冷漠、没有感情，像冰箱一样。这个说法是美国心理学家布鲁诺·贝特尔海姆等人推广的。〔强：这是心理学史的公认事实〕

这个说法后来被证明是完全错误的。孤独症与大脑发育有关，有很强的遗传基础，与母亲的“冷漠”没有关系。

不过这个说法造成了巨大的伤害：一代一代的母亲被指责，被孤立，被要求去做心理治疗，去“反省”自己的“错误”。很多母亲从此背负了几十年的内疚。

这一段历史对所有写“母亲和孩子”的人是一个警示：

当我们说“母亲对孩子很重要”的时候，很容易滑到“母亲要为孩子的一切负责”。

本书要明确地拒绝这个滑动。

我们的立场是：

母亲是孩子最早的回路。不过母亲不是一个“孤立的个体”。她在一个家庭里，在一个社会里。她能给孩子多少，取决于社会给了她多少。

◆ 七、一个母亲，需要什么

那么，一个社会应该怎么接住母亲？

我们不妨列一列，一个母亲在孕期和 0 到 3 岁最需要的几样东西：

第一，健康的保障：孕期检查，生产的安全，产后的恢复，心理健康的筛查和治疗。

在产后抑郁这件事上，数字值得重视：根据多项研究，大约每七个产妇里就有一个在产后出现抑郁，大约占百分之十到十五。〔强：多项荟萃分析，不同国家，数字略有差异〕

产后抑郁不只是母亲会有，父亲也会有。研究估计，大约有百分之八到十的父亲，在孩子出生后的第一年里出现抑郁。〔中：荟萃分析的结论，不同研究的数字，差别较大，待核〕

产后抑郁不是“矫情”，也不是“想不开”，是一种需要治疗的疾病。如果得不到治疗，会影响母亲和孩子之间的“来回”：母亲对孩子的信号反应变慢，表情变少，声音变平。研究发现，母亲有严重、持续的抑郁，孩子在认知、情绪、行为上出现问题的风险会增加。〔中：相关研究很多，效应不大，但比较一致；有效的治疗，可以改善母婴互动〕

所以产后抑郁的筛查和治疗，是对母亲的保护，同时也是对孩子的保护。

第二，时间：产假，陪产假，哺乳假，育儿假。

母亲需要时间恢复身体，需要时间和孩子“来回”。父亲也需要时间进入“来回”。

我国的《女职工劳动保护特别规定》规定，女职工生育，享受不少于 98 天的产假。各地又在此基础上做了延长，同时有了陪产假、育儿假的规定。

〔核：具体天数，各省不同，请以当地最新的规定为准〕

研究在一些国家发现，有薪的产假和婴儿死亡率降低、母亲健康改善、母乳喂养率提高有关联。〔中：比较政策的研究，因果关系，难以完全证明〕

第三，钱：生育、养育需要很大的开销。

我国近年来也推出了一些措施，比如 3 岁以下婴幼儿照护的个人所得税专项附加扣除，以及各地推出的生育补贴等。〔核：具体的政策和标准，在不断调整，请以最新的规定为准〕

第四，托育：安全的、高质量的、负担得起的托育服务。

第 13 章讲过，托育的质量是关键。现实里，高质量的托育常常缺口很大。

第五，职场：不被歧视，不因为怀孕、生育被降职、被辞退。

这个问题在很多地方仍然存在。研究在一些国家发现了“母职惩罚”：同样的资历，母亲比非母亲更不容易被录用，薪水更低。〔中：多个国家的实验和观察研究，有一致的发现〕

第六，家庭内部的分工：母亲不应该一个人扛下所有的家务和育儿。

第七，被理解：不被指责，不被比较，不被说“你看别人家的”。

这七样东西，没有一样是母亲自己能“努力”得来的。它们是整个社会要提供的。

◆ 八、产后头一年，母亲身上发生着什么

要接住母亲，先要知道她正在经历什么。

生完孩子的头几天，很多母亲会情绪起伏，爱哭，容易紧张。这很常见，叫“产后情绪低落”。〔强：产科和精神卫生的常识，多数在产后两周左右自行缓解〕

这时候，激素在剧烈地变化，睡眠被切成一小段一小段。〔强：产后激素变化和睡眠碎片化是常识〕

身体也在恢复：伤口，奶胀，腰背酸痛，出汗。这些都不是“矫情”。

分清这两种情况，很重要。

情绪低落，过一阵就会缓过来。

如果低落超过两周，还越来越重，睡不着，吃不下，对孩子没兴趣，那就可能是产后抑郁。〔强：这是诊断和筛查的常见提示，具体标准请由医生判断〕

这时候，请去看医生，不要硬撑。

还有一件事要说：产后头一年，母亲的睡眠几乎一定是不够的。

所以家里的第一件事，不是“教孩子”，而是让母亲睡得着。

一个睡得着觉的母亲，比一个“很努力地做胎教”的母亲，更能给孩子稳的来回。〔解释：本书的判断，不是实验结论〕

◆ 九、家里的人，能做什么

社会是一个大概念。回到每个家，我们每个人也有自己的位置。

对母亲的家人，最有用的几件事其实很朴素：

一，不要评判。不要说“你怎么又让他哭”“我们那时候都不这样”。

二，帮忙，具体地帮。不要说“你有什么需要，跟我说”，而是说“我今晚把孩子接过去，你睡四个小时”。

三，看见她。在她累的时候说一句“你辛苦了”。这句话看起来很小，不过研究和无数的母亲都在说：被看见，真的有用。

四，注意她的状态。如果母亲持续两周以上情绪低落、睡不着、吃不下、对孩子没有兴趣，或者有伤害自己、伤害孩子的念头，请立刻陪她去看医生。这不是软弱，是病。

◆ 十、谁来托，托什么：一张清单

前面列了社会要给的七样东西，又说了家里人能做的几件事。这里把各方放在一张表里。

谁	能做的	不该压在母亲身上的
社会	医疗、产假、托育、反歧视、育儿补贴	个人“努力”换不来的条件
家庭	分担夜里的照料和家务，不评判，具体地帮	把育儿当成“她一个人的事”
父亲	进入“来回”：抱，说，哄，夜里也起来	“只负责挣钱”
母亲自己	睡够，求助，把要求放低一点，必要时看医生	事事做到最好

这张表是本书的归纳，不是某一项研究的结论。〔解释〕

表里单列了父亲。

多项观察研究发现，父亲更多参与育儿，与孩子的认知和情绪发展较好有关联。不过这类研究很难证明因果。〔中〕

表里还有一格，容易被忽略：母亲自己。

她能做的，是把要求放低一点，敢开口说“我需要帮忙”。这不是偷懒，是在守住整座房子的地基。

◆ 十一、江远的一个夜班

孩子四个月的时候，有一阵夜里总醒。

头两周，都是苏晴起。她白天上不了班，眼睛下面一圈青。

有一天夜里三点，孩子又哭了。江远没有等苏晴动，自己爬起来，说：“我来。”

他抱着孩子在屋里走。孩子在他怀里哭得更大声，他有点慌，嘴里却只会说一句：“我在这儿，我在这儿。”

走到第二十分钟，孩子哭声低下来，把脸埋在他的肩上。

江远不敢动。他站在黑暗里，站了好久。

第二天上班，他困得不行，在会上差点睡着。

不过他回家后对苏晴说：“昨晚我才明白，你每天在做的是什么事。”

苏晴说：“你做得挺好的。”

江远说：“我什么都不会，就只会说‘我在这儿’。”

苏晴笑了：“那就够了。”

这个小故事想说的是：

父亲进入“来回”，不需要做得完美。

他只需要在，只需要稳，只需要一次一次地回来。〔解释：本书的读法，与前面讲的“来回”一致〕

母亲的睡眠，也在这样的轮换里，被一点一点接住了。

◆ 十二、苏晴回到办公室

苏晴休完产假，回到公司的第一天，心里很忐忑。

项目组每天下午五点半开例会。她五点要去接孩子。

她不好意思开口。她想：别人都没说，我一个刚回来的，提什么要求？

晚上江远听她说了，问：“你们主管是个什么样的人？”

苏晴说：“老赵，人还不错。”

江远说：“那你试试说。就当是告诉他一个事实。”

第二天，苏晴去找老赵，说：“赵哥，我五点要去接孩子，例会能不能提前一点？”

老赵想了想，说：“我看看大家的时间。”

一周后，例会改到了下午三点。

后来苏晴才知道，组里另一位同事要照顾生病的父亲，还有一位在读夜校。他们都没说过，都松了一口气。

这件事很小。

不过它说明了一点：托住一位母亲的办法，常常也托住了很多别的人。

当然，老实说，不是每个主管都像老赵。〔解释〕

所以才需要制度，不能只靠运气。

◆ 十三、常见的几个问题

问：我小时候没被好好对待，会不会重复在孩子身上？

答：有可能受影响，不过不是注定。多项研究发现，童年的不利经历与成年后的养育困难有关联。这是关联，不是必然。〔中〕

也有不少研究发现，有相当一部分人走出了自己童年的样子。〔中：细节待核〕

有几件事能帮到你：看见自己的老习惯；找一个信得过的人说一说；必要时去做心理咨询。〔中：与“获得性安全依恋”的研究方向一致，样本有限〕

如果你担心自己会伤害孩子，请马上联系专业人员或心理援助热线。
〔核：各地热线不同，请查询当地〕

问：婆家和娘家，怎么分工？

答：没有标准答案。本书只给三条建议。〔解释：来自家庭生活的常识，不是研究结论〕

一，先分“事”，不分“人”：夜里、做饭、洗衣、陪玩，哪几件事谁来做，说清楚。

二，说清楚“谁听谁的”：育儿的大方向由父母定，老人做帮手。

三，不比较两边谁付出得多。

关于老人带孩子，各国的研究结论不一致。〔有争议〕孩子最需要的，是稳定、有回应、不吵架的照料。〔解释〕

问：母亲要不要回职场？

答：本书没有统一答案。有的母亲想早点回，有的想晚点回，有的因为经济必须回。

母亲上班对孩子发展的影响，不同研究结论不一致。〔有争议〕

有研究提示，托育质量、家庭收入、母亲的心情，比“在不在家”更能说明问题。〔待核〕

你可以问自己三句话：孩子白天有稳定的人照顾吗？我的身体和心情撑得住吗？家里的经济怎么样？

不管选哪一条路，都不是“好母亲”和“坏母亲”的分界线。

问：我有时会对孩子发火，是不是伤害了他？

答：偶尔发火，事后回来安抚，多数不会造成伤害。

依恋研究里有“断裂与修复”的说法：亲子之间总有不同步的时候，修复回来，比从不出错更要紧。〔中：观察研究支持，细节待核〕

做法很简单：蹲下来，看着他，说：“刚才妈妈声音大了，吓到你了，对不起。”

如果发火变成天天的事，自己控制不住，请去找帮助。〔核：可咨询儿童保健科或心理门诊〕

问：0 到 3 岁已经过去了，我还能补吗？

答：能。前面讲过，大脑的可塑性在童年最强，成年减弱，但没有消失。

〔中〕

现在开始，每天留一小段只属于你们俩的“来回”。再帮他找到一两个稳定的成年人。〔中：稳定有回应的成年人是韧性的核心因素，见前文〕

补比一开始就对更慢，也更需要耐心。不过一点一点补，是有用的。

问：我一个人带孩子，没有人帮，怎么办？

答：先别责怪自己。一个人撑所有事，本来就不是一个人该承担的。

可以先问问社区、街道、妇幼保健机构有没有育儿支持，托育机构、临时照料也值得问一问。〔核：各地服务不同，请查询当地〕

把标准降下来：每天十分钟的“来回”，加上一个稳定的作息，已经足够。〔解释〕

把“求助”也当成育儿的一部分。

◆ 十四、放回日子里

苏晴的婆婆是个很传统的人。

孩子刚出生的时候，她来住了一个月。她有很多“规矩”：不能洗头，不能吹风，不能下地，吃的要全是汤。

苏晴一开始很不舒服。她觉得被“管”着，被“规定”着。

有一天夜里，孩子哭，苏晴起来，婆婆也起来了。苏晴说：“妈，您去睡吧，我来。”

婆婆没有走，站在门口看了看，说：“你去睡，我来抱一会儿。你刚生完孩子，身体虚。”

苏晴愣了一下。她忽然发现，婆婆眼睛里有一种很朴素的心疼。

那天晚上，她躺回去，睡了四个小时。

后来她跟江远说：“其实妈那些规矩，我不一定都认同。可是她那天让我睡了。”

这件事让苏晴对“月子”有了一点不同的理解：很多传统的做法，从科学上说不一定有证据。不过它们背后有一个很古老、也很实在的东西：产后的母亲需要被人照顾。

也就是说，“月子”作为一种社会习俗，它的核心价值也许不在于不洗头、不吹风，而在于：在这一个月里，全家人围着母亲转，让她被托住。

◆ 十五、本编小结

第五编三章，到这里可以收起来：

第 15 章说，基因给器具。器具重要，不过不是智慧本身。基因和环境是缠在一起的，遗传率不等于命运。

第 16 章说，盲、聋、腿脚不便，是器具的不同，智慧可以从别的通道发生。重要的是“来回”没有断。

第 17 章说，0 到 3 岁是地基，不是命。后来的好日子仍然有用。社会要接住母亲，不能怪罪她。

三章走完，本书前面的“为什么”就讲完了。

从下一编开始，进入本书最具体的部分：怎么做。

带走的话

0 到 3 岁，是地基，不是命。母亲，是孩子最早的回路，不过，不是一个人，扛着所有的事。一个社会，该怎么接住母亲，就是怎么接住下一代。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
考艾岛研究：高风险儿童中约三分之一成为有韧性的成年人	〔核〕	沃纳和史密斯，具体数字待核
至少一个稳定、有回应的成年人是韧性的核心因素	〔中〕	多项研究支持，哈佛儿童发展中心亦强调
成年人大脑有终身可塑性（如学习杂耍后灰质变化）	〔中〕	Draganski 等，2004，小样本，重复不完全一致
获得性安全依恋	〔中〕	成人依恋访谈研究，有一些纵向支持
“冰箱母亲”理论是错误的	〔强〕	心理学史公认
约十到十五个产妇中有抑郁	〔强〕	多项荟萃分析
约 8%—10% 的父亲在第一年出现抑郁	〔中〕	数字待核
母亲严重持续抑郁，与孩子风险增加相关	〔中〕	相关研究，效应不大，治疗可改善母婴互动
我国法定产假不少于 98 天，各地有延长	〔核〕	以当地最新规定为准
有薪产假与婴儿死亡率降低等相关	〔中〕	政策比较研究，因果难证
母职惩罚	〔中〕	多国研究较一致
月子习俗的核心价值是“被照顾”	〔解释〕	本书的读法，不评价具体做法的科学性
社会、家庭、父亲、母亲各自能做的事	〔解释〕	本书的归纳，非单一研究结论
父亲更多参与育儿，与孩子认知、情绪发展较好有关联	〔中〕	观察研究，因果难证
要求单位调整会议时间，往往同时帮到其他有照护任务的人	〔解释〕	本书的场景，不是研究结论
童年不利经历与成年后养育困难有关联，不是必然	〔中〕	关联研究，细节待核
不少人走出了自己童年的样子	〔中〕	细节待核

说法	证据级别	说明
后来的稳定关系和咨询可帮助改变	〔中〕	与获得性安全依恋研究方向一致，样本有限
婆家娘家分工的三条建议	〔解释〕	家庭生活常识，非研究结论
隔代照料对孩子发展的影响	〔有争议〕	各国研究结论不一致
母亲就业对孩子发展的影响	〔有争议〕	不同研究结论不一致
托育质量、家庭收入、母亲心情比“在不在家”更能说明问题	〔待核〕	研究提示，需进一步核实
亲子“断裂与修复”：修复比从不出错更要紧	〔中〕	依恋研究的观点，细节待核
大脑可塑性终身存在，童年最强	〔中〕	见本章前文
社区、妇幼保健机构等可提供育儿支持	〔核〕	各地服务不同
产后情绪低落常见，多在两周左右自行缓解	〔强〕	产科和精神卫生常识
产后激素剧烈变化、睡眠碎片化	〔强〕	常识
低落超过两周且加重，应考虑产后抑郁并就医	〔强〕	具体标准由医生判断
睡得着的母亲更能给孩子稳定的来回	〔解释〕	本书的判断，非实验结论
父亲进入“来回”不需要完美，在场与稳定就够	〔解释〕	本书的读法
视觉发育有较严格的关键期	〔强〕	神经科学经典发现
语言、情绪等更像可塑性逐渐下降的敏感期，很少完全封死	〔中〕	多数研究者的看法，细节仍有讨论

个体情况，比如持续情绪低落、产后抑郁、有伤害自己或孩子的念头，请立即就医或联系当地心理援助热线、急救电话。

第 六 编

做子宫里的妈妈：三步法

这一编四章，讲怀孕的九个月里，怎么做。

第 18 章立总纲：把回路稳住，不是给胎儿加料。并讲先要守住的底线，和睡、吃、动。第 19 章讲第一步，给差异。第 20 章讲第二步，看显露。第 21 章讲第三步，稳环境，和一张“不必做”的清单。

四章走完，你会发现：方法很少，每天二十分钟，其余时间过你的日子。

第 18 章

子宫里的妈妈怎么做：三步法，和先要稳住的身体

◆ 一、从“为什么”到“怎么做”

前面十七章讲的是“为什么”。从这一章起，讲“怎么做”。

先说一句让忙碌的读者安心的话：

本书的方法，不需要你买任何东西，不需要你上任何课，也不需要你每天花几个小时。

它只有三步，每天加起来大约二十分钟。其余的时间，你过你的日子。

这三步是：

第一步，给差异。给孩子一些有规律的、温和的“不同”，让他去分。

第二步，看显露。看孩子对这些“不同”有什么反应。

第三步，稳环境。把你自己和你的日子稳住。

三步里，最后一步最重要，也最容易被忽略。

为什么？因为第 4 章到第 7 章讲了：孩子在子宫里最大的“环境”就是你。你的睡眠、饮食、情绪和日子，就是他的天，他的地。

所以这一章先讲第三步里最基础的一块：把身体稳住。后面三章，再讲给差异、看显露，以及把心稳住。

◆ 二、一条总纲：把回路稳住，不是给胎儿加料

在讲具体做法之前，先给本书的方法论立一条总纲。

这条总纲是：

把回路稳住，不是给胎儿加料。

什么叫“加料”？

就是市面上很多“胎教”的做法：让孩子听某种音乐，看某种图片，用某种仪器，吃某种补品，想通过这些让孩子“更聪明”。

这些做法大部分没有可靠的证据。有的还有风险。

什么叫“稳住回路”？

就是让母亲和孩子之间的这个“来回”，在一个稳定、安全、持续的环境里自然地运转。

第 4 章到第 7 章讲过，孩子在子宫里学的是：节律，调子，有人在。

这些东西不是靠“加料”，而是靠“稳”得到的：

稳的作息，给他稳的节律。

稳的情绪，给他稳的化学环境。

稳的陪伴，给他稳的“有人在”。

这就是为什么本书把“稳环境”放在第一位。

◆ 三、先把安全的事，说在前面

在谈“稳”之前，有一些关系到孩子安全的事不能含糊。这些事证据很强，所有产科医生都会说：

不吸烟，也尽量避免二手烟。吸烟会增加早产、低出生体重、胎盘问题的风险。〔强：大量证据〕

不饮酒。酒精会通过胎盘到达胎儿。孕期饮酒没有已知的安全剂量，可能导致胎儿酒精谱系障碍，影响脑发育。〔强：世界卫生组织和各国指南一致建议孕期不饮酒〕

不随意用药，包括中药和保健品。任何药物都要先问医生。〔强〕

按时产检。产检是保证母子安全最基本的手段。〔强〕

补充叶酸。在备孕和孕早期，每天补充叶酸可以降低胎儿神经管缺陷的风险。通常建议每天 400 微克，具体剂量要遵医嘱，有些情况需要更高的剂量。〔强：世界卫生组织和多国指南的推荐〕

控制咖啡因。第 4 章讲过，每天不超过 200 毫克。〔中〕

避免高风险的食物。比如生的或半熟的肉和蛋，未经巴氏杀菌的奶制品，某些汞含量较高的大型肉食性鱼类。具体的清单各国略有差异，请遵医嘱。〔强：食品安全的一般建议〕

注射该打的疫苗。比如流感疫苗，在孕期被很多国家推荐。各国的建议不同，请遵医嘱。〔中〕

这些是“底线”。底线之上，才是“方法”。

◆ 四、睡：让身体有节律

先讲睡。

睡眠是孕期里最容易被忽略，又最关键的一件事。

为什么？

第一，睡眠是母亲身体修复的时间。

第二，睡眠决定了母亲白天的情绪和精力。

第三，孕晚期睡眠的姿势关系到安全。

我们一个一个讲。

关于睡眠的时间：大多数成年人每天需要七到九个小时。孕妇往往需要多一点。如果晚上睡不够，白天尽量找机会小睡一会儿。〔中：一般的睡眠建议，没有针对孕妇的一个统一的数字〕

关于睡眠的节律：尽量固定入睡和起床的时间，周末也不要差太多。这样能让母亲身体的生物钟稳定。研究发现，母亲的昼夜节律会通过激素，比如褪黑素，传递给胎儿，影响胎儿的节律。〔中：动物研究和少量人类研究，机制还在探索〕

关于睡眠的姿势，有一个有证据的、重要的提醒：

孕 28 周以后，建议侧卧睡，左侧或右侧都可以，不建议仰卧。

为什么？因为仰卧时，增大的子宫会压迫母亲腹部的大血管，可能减少回流到心脏的血，进而影响胎盘的血供。

2017 年到 2019 年，来自多个国家的研究，包括一项汇总了多个研究的分析，发现孕晚期仰卧入睡的女性，发生晚期死胎的风险比侧卧的女性大约高出两倍多。〔中：Cronin 等，2019，汇总了多个病例对照研究，样本大，不过是观察性研究；绝对风险依然很低，所以不要过度恐慌〕

所以建议是：睡前选择侧卧；半夜如果发现自己仰着，不要慌，翻回侧卧就好。可以在背后放一个枕头来保持侧卧。不过不必整晚紧张地“保持一个姿势”。

如果睡不着，怎么办？

先别着急。这是很多孕妇都有的问题。有几个办法：

睡前一小时把灯光调暗，手机放到远一点的地方。

睡前洗个温水澡，听一点平静的声音，或者读几页书。

如果躺了二十分钟还是睡不着，就起来坐一会儿，等有困意了再回去。别在床上焦虑地“数时间”。

如果长期失眠，影响白天的生活，请告诉医生。有一些安全的办法。

◆ 五、吃：不是“补”，是“稳”

再讲吃。

很多家庭一知道怀孕，就开始“大补”。燕窝，海参，鱼汤，各种保健品，轮番上。

本书的立场是：吃，不是“补”，是“稳”。

“稳”的意思是：

一，规律。三顿正餐，加两到三次小点心。避免长时间空腹，也避免一顿暴食。这样母亲的血糖比较稳定，对孩子也比较稳。

二，多样。主食、蛋白质、蔬菜、水果、奶制品都有。不需要特别的“补品”。

三，够用。孕期需要的能量，并不是“吃两个人的份”。研究和指南的一般建议是：孕早期几乎不需要额外增加；孕中期每天增加约 300 到 350 千卡；孕晚期每天增加约 450 千卡左右。〔核：美国和多国指南的大致数字，各国和个人情况，差异很大，请遵医嘱〕

四，留意几样营养素：叶酸，铁，钙，碘，维生素 D，以及含 DHA 的 omega-3 脂肪酸。大部分可以从日常饮食里得到。如果不够，医生会建议补。〔中：各国指南略有差异，请遵医嘱〕

五，体重在合理的范围里增长。孕期体重增长的建议范围和孕前的体重指数有关。医生会告诉你你的范围。〔强：指南共识〕

关于“补品”，有一个朴素的原则：

没有医生的建议，不要自己加。尤其是一些含有维生素 A 的补品，过量可能对胎儿有害。〔强：维生素 A 过量致畸，有明确证据〕

这一条也适用于“传统补品”：它们不一定无害，也不一定有用。

◆ 六、动：走路，是最好的“摇篮”

再讲动。

第 5 章讲过，母亲的每一步，都是在“摇”着孩子。

关于孕期运动，美国妇产科医师学会的建议是：没有禁忌的孕妇，每周至少做 150 分钟的中等强度有氧运动，比如快走、游泳、固定自行车、孕妇瑜伽。〔核：ACOG 2020 年的意见，大意如此〕

“中等强度”有一个很简单的判断办法：运动时你能说话，但不能唱歌。

研究发现，孕期适度运动可以降低妊娠期糖尿病、妊娠期高血压的风险，改善睡眠和情绪，不增加早产或胎儿不良结局的风险。〔强：多项系统综述〕

不过有一些情况不能运动，或者要特别小心：前置胎盘，宫颈机能不全，有早产的风险，持续阴道出血，严重的心肺疾病，等等。具体请遵医嘱。

运动的“怎么做”，有几条：

第一，从你原来熟悉的运动开始。没有运动习惯的人，从每天十到十五分钟的散步开始。

第二，不要做有摔倒风险或身体碰撞的运动：滑雪，骑马，球类对抗，潜水等。

第三，不要在太热、太闷的环境里运动。

第四，多喝水。

第五，如果出现头晕、胸痛、阴道出血、规律的宫缩、胎动减少，立刻停下来，联系医生。

对苏晴来说，最合适的是每天下班以后，在小区里快走三十分钟。

她发现，走路的时候，肚子里的孩子常常是安静的。回到家坐下，他会开始动。她想，也许是被“摇”睡了，又被“摇”醒了。

这样的“摇”，是你能给孩子的最简单、最稳定的“触觉节律”。

◆ 七、一张孕期“稳”的清单

把前面的内容，收成一张清单。可以打印，贴在冰箱上。

方面	要做的	要避免的
睡	固定作息；孕 28 周后侧卧；白天可小睡	熬夜；孕晚期整夜仰卧
吃	规律三餐加点心；饮食多样；按医嘱补叶酸等	大补；自己加保健品；生冷高风险食物；酒；过量咖啡因
动	每周约 150 分钟中等强度；快走最好	有摔倒、碰撞风险的运动；闷热环境；不适时硬撑
医	按时产检；用药先问医生	自己判断吃药；不舒服硬扛
环境	远离烟；工作环境，噪声、化学品有风险 时与单位沟通	二手烟；长期高噪声

请注意，这张清单里每一条都是“稳”，不是“加”。

◆ 八、孕期三个阶段的“稳”清单

前面那张清单是总的。九个月里，身体一直在变，每个阶段要稳的地方不一样。

下面分三段来看。

阶段	常见的身体状态	睡	吃	动	要留意
孕早期，孕 1—12 周	容易累，容易困，有的人恶心呕吐	困了就睡，不硬撑	少量多餐，吃得下什么先吃什么，叶酸照常补	散步就好，不求强度	出血、剧烈腹痛、呕吐到喝不进水，要就医
孕中期，孕 13—27 周	多数人精力回来了，胃口也好一些	固定作息，开始练习侧卧	能量略增，留意铁和钙	每周约 150 分钟，快走游泳都行	按医生安排做各项筛查

阶段	常见的身体状态	睡	吃	动	要留意
孕晚期，孕 28 周起	腰背酸，胃胀，夜里睡不踏实	侧卧，背后和两膝之间垫枕头	少量多餐，睡前不吃太饱	慢走，动作放慢	数胎动；规律宫缩、破水、出血要就医

孕早期的疲倦和恶心很常见。多数人到了孕中期会舒服一些。〔强：产科常识，个体差别很大〕

孕晚期有几个信号，要立刻联系医生：明显的头痛，眼前发花，手和脸突然肿得厉害。这些可能和妊娠期的高血压类问题有关，需要及时检查。〔强：产科指南共识〕

这张表只是把前面讲过的话，按阶段重新排了一遍。每一格都是“可以”，不是考试。〔解释：本书的整理方式〕

◆ 九、一个工作日，怎么“稳”

很多人想知道，上班族的一天里，这些事怎么放进去。

下面是一个例子。时间随便挪，顺序也随便换。

时间	稳的小事	说明
起床后	先在床边坐一分钟，再站起来	起得太猛容易头晕
早餐	有主食，有蛋白质，有一点水果	空着肚子上班容易恶心
上午	每过一小时，站起来走几分钟	久坐对腰背和腿都不好
午餐	好好吃，不边吃边开会	吃饭也是一种节律
下午	备一包点心，饿了就吃	不要饿到头晕才吃
下班后	快走二十到三十分钟	也是最稳的“摇篮”

时间	稳的小事	说明
晚饭后	十分钟，一只手，一把嗓子	第 19 章细讲
睡前	灯调暗，手机放远，侧卧	孕 28 周后尤其要侧卧

站起来走动对腰背和腿部循环有好处。孕期久坐，腿部的血液更容易淤在下面。〔中：一般的健康建议，没有专门针对某个孕周的数字〕

这张表里有八件小事。你只要做成其中的三四件，就已经很稳了。

◆ 十、做不到的日子：降级版本

有的日子，什么都做不到。孕吐的日子，加班的日子，家里有事的日子。

这样的日子不用补课。你换一个小一点的版本就行。

日子	睡	吃	动
好的日子	固定时间睡，侧卧	三餐加点心	快走三十分钟
一般的日子	比平时早睡半小时	吃得下的就吃，别饿着	走十分钟
很糟的日子	躺下休息，不看手机	一杯水，一点能吃的	站起来拉伸一下

这是本书给出的降级安排。它没有经过试验检验，只是把“稳”的要求，拆成了几个台阶。〔解释〕

再糟的日子，还有一个三分钟版本：

一，喝一杯水，坐下来。

二，手放在肚子上，慢慢呼吸三次。

三，对自己说一句：“今天先这样。”

如果三分钟也做不到，那就什么都不做。

回路靠的是长时间的稳定，不靠哪一天拿满分。偶尔的几天乱了，没有证据说会对孩子有害。〔解释：本书的看法；大量孕妇有过乱的日子，是普遍的情形〕

◆ 十一、产检时，可以这样问医生

产检的时间很短。很多人出了诊室才想起，有一半的问题没问。

建议你提前在手机里记几条。下面是几句现成的话，可以直接用。

想问的事	可以这样说
睡	“我最近夜里醒得多，有什么安全的办法？”
吃	“我现在的体重增长，在我的范围里吗？”
动	“我平时想快走，有什么情况不能做？”
用药	“我正在吃这个药或保健品，需要停吗？”
出行	“我下个月要出差，坐飞机或高铁可以吗？”
情绪	“我最近心情很低，要不要看看？”

这些问题没有一个是“傻问题”。医生每天听到的，比这些还要细。

有一条建议：问完以后，把医生的话用自己的话再说一遍，请医生确认。这样可以避免听错。〔解释：本书的沟通建议〕

◆ 十二、第一周，怎么试

如果你想从今天开始，又怕一下子做太多，可以按下面的节奏试一周。

第一天，只做一件事：定一个固定的睡觉时间。

第二天，在原来的基础上，下班后走十分钟。

第三天，检查冰箱，把点心备好。

第四天，学着侧着睡一次，背后垫一个枕头。

第五天，把想问医生的问题，记在手机里。

第六天，和家人说一句：“这九个月，我需要你们帮我几件小事。”

第七天，什么都不加。看看这一周，哪一件最顺手，就留下哪一件。

这一周不是任务。它只是让你知道，“稳”可以从很小的地方开始。〔解释：本书的建议，没有试验检验〕

◆ 十三、常见的几个问题

下面是读者常问的几个问题。每一条只给大方向。你自己的情况，请问你的医生。

问：孕吐吃不下，怎么办？

答：孕吐很常见，多数人到孕 12 到 14 周前后会明显减轻。〔强：产科常识〕吃得下什么就先吃什么，不必硬凑“营养均衡”。少量多餐，起床前先在床边吃几片干的东西，有的人觉得有用。〔中：临床经验和小样本研究〕

生姜、维生素 B6 这类办法，有人有效，有人没用，证据并不一致。〔有争议〕用药请医生开。

如果连水都喝不进，体重明显往下掉，尿很少，要马上去医院。这可能是需要治疗的严重呕吐。〔强：产科指南共识〕

问：胖了多少算正常？

答：没有一个人人适用的数。建议的增重范围和孕前体重指数有关，医生会告诉你一个范围。〔强：指南共识〕

看的是一条曲线，不是某一周的数字。一周之内涨多涨少，常常是水分的事。〔解释〕

不要因为怕胖而自己节食，也不要因为“补”而硬吃。增重过多或过少，都与不好的结局有关联。〔中：观察性研究〕

问：我吃素，或者是过敏体质，怎么吃？

答：多项指南认为，安排得当的素食可以满足孕期需要。要留意铁、钙、碘、维生素 B12 和 DHA。纯素食的人，最好和医生或营养师商量要不要补。〔中：各国指南略有差异〕

如果你自己对某种食物过敏，当然要继续避开它。〔强〕

至于为了预防孩子将来过敏，在孕期主动回避常见食物，目前的指南一般不建议这样做。〔中：多个指南的大意，证据在更新〕

问：咖啡、染发、坐飞机，能不能？

答：咖啡的上限，前面讲过了。各家咖啡的浓度差别很大，一杯下去如果觉得够了，就别再加。〔中〕

染发，一般认为偶尔做一次风险低。有人选择孕早期先推迟，并且在通风好的地方做。〔中：证据有限〕

坐飞机，没有并发症的孕妇，孕中期出行通常比较合适。不过航空公司对孕周有各自的规定，出发前要问医生，也要问航空公司。〔中〕飞行中隔一段时间起来走走，多喝水，可以减少久坐的麻烦。〔中〕

问：失眠，翻来覆去怎么办？

答：孕期睡得不好很常见。〔强〕白天水喝够，睡前一两小时少喝一点，可以少起几次夜。起夜不开大灯，回床上更容易再睡。〔解释：本书的实用建议〕

不要自己吃助眠药物或者保健品，先问医生。〔强〕

偶尔几晚睡不好，目前没有证据说会伤害孩子。如果长期严重失眠，要告诉医生。〔中〕

问：腿抽筋，半夜疼醒了怎么办？

答：孕中晚期腿抽筋很常见。〔强〕醒了以后，把脚掌慢慢往回勾，拉伸小腿，再站一会儿。〔中：常用的缓解办法〕

睡前拉伸小腿，白天多走路，可能有帮助。补钙或者补镁到底有没有用，证据不一致。〔有争议〕

如果只有一条腿持续又肿又痛，发红发热，要马上去医院，排除血栓。
〔强：产科安全提示〕

问：火锅、刺身、老火汤，能吃吗？

答：火锅涮熟了就可以吃。生的或半熟的肉、蛋和海鲜，孕期要避免。
〔强：食品安全的一般建议〕

老火汤的味道好，营养却不一定多。汤里大部分是水和油，肉和菜本身才是主要的营养。〔中：一般营养常识〕所以不必强迫自己每天喝一大碗。

问：家里人让我躺着别动，有必要吗？

答：没有并发症的孕妇，一般不需要长期卧床。适度活动对身体和情绪都有好处。〔强：前面讲过的运动证据〕

如果医生因为出血、先兆早产等情况，明确要求你多休息，那要照医生的话做。〔强〕

家里人是出于爱。你可以把医生的原话转述给他们听，比自己解释更有说服力。〔解释：本书的沟通建议〕

问：每个人都说要补钙，我要不要吃钙片？

答：先看饮食。奶制品、豆制品、绿叶菜都含钙。〔强：基础营养常识〕

要不要额外补，补多少，请医生根据你的饮食和检查来定。不要自己叠加好几种含钙的保健品。〔中：各国指南略有差异，请遵医嘱〕

问：吃完饭胃里烧得难受怎么办？

答：孕期胃灼热很常见，子宫变大会顶着胃。〔强〕少量多餐，饭后不要马上躺下，睡前两小时不吃东西，床头略垫高一点，很多人会好一些。

〔中：常用建议〕

如果还不行，请问医生。不要自己买药。〔强〕

◆ 十四、放回日子里

苏晴孕十六周的时候，在产检时问医生：

“我最近睡得不太好，会不会影响孩子？”

医生是个五十多岁的女医生，看着她，说：“你睡得怎么样？”

苏晴说：“入睡很慢，半夜要起来上两三次厕所，早上五点就醒了。”

医生笑了：“这是孕期的正常现象。你不用太紧张。你只要白天累了，就歇一会儿。”

苏晴又问：“那吃的呢？我最近吃得不多，是不是对孩子不好？”

医生看了看她的产检结果，说：“你的体重增长在正常范围里。孩子也长得很好。你不用给自己加压力。”

苏晴愣了一下：“那我还需要做点什么？”

医生说：“你把日子过稳，就是最好的‘做点什么’。”

走出医院，苏晴把这句话记了下来：把日子过稳，就是最好的“做点什么”。

再说两个小场景。

苏晴孕八周的时候，早上坐地铁，闻到旁边人的早餐味，一阵恶心涌上来。她赶紧下车，扶着站台的柱子。

到了公司，同组的林姐看她脸色发白，从抽屉里拿出一包苏打饼干：“我第一胎吐了三个月。先吃一片，别等饿。”

苏晴吃了一片，好一些了。她问：“吐成这样，孩子有没有营养？”

林姐说：“我那时候也问过医生。医生说，先让妈妈活得下去，别的以后再说。”

苏晴笑了。她把饼干放进包里，当天下班后只走了十分钟，就回家躺下了。

那天她没有“稳”得很漂亮。不过她给自己留了一块饼干，一杯水，一张床。这就够了。

还有一个场景。孕十周的一个晚上，江远看她什么都不想吃，就学着煮了一锅小米粥，咸的，放了一点青菜。

苏晴喝了半碗。她说：“有点咸。”

江远说：“下次少放盐。”

他把这句话记在手机里。后来的每一周，他煮粥的水平都在往上走。

这两个场景的话，可以收成一句：“稳”常常很小，小到只是一片饼干，一碗粥。

带走的话

孕期的第一件事，不是给孩子加料，而是把你自己的日子，稳住：睡得够，吃得稳，走得动，该查的查。底线，要守住：不烟，不酒，不乱用药。底线之上，过日子，就是方法。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
孕期吸烟增加早产、低出生体重等风险	〔强〕	大量证据
孕期饮酒无已知安全剂量，可致胎儿酒精谱系障碍	〔强〕	WHO 及各国指南一致
备孕和孕早期补叶酸降低神经管缺陷风险，通常每天 400 微克	〔强〕	剂量请遵医嘱
咖啡因每天不超过 200 毫克	〔中〕	各国略有差异
孕 28 周后建议侧卧，仰卧入睡与晚期死胎风险升高相关	〔中〕	Cronin 等，2019；观察性研究，绝对风险很低
母亲昼夜节律通过激素影响胎儿节律	〔中〕	机制还在探索

说法	证据级别	说明
孕中、晚期每天分别增加约 300—350、约 450 千卡能量	〔核〕	大致数字，请遵医嘱
维生素 A 过量致畸	〔强〕	补充剂须遵医嘱
每周约 150 分钟中等强度运动	〔核〕	ACOG 2020，大意；有禁忌者除外
孕期适度运动降低妊娠期糖尿病和高血压风险	〔强〕	系统综述
把回路稳住，不是给胎儿加料	〔解释〕	本书的方法论总纲
孕早期疲倦、恶心很常见，多数人孕中期好转	〔强〕	产科常识，个体差别大
孕晚期明显头痛、眼花、突然水肿加重需及时就医	〔强〕	与妊娠期高血压类问题有关
孕期久坐对腰背和腿部循环不利，宜定时起身	〔中〕	一般健康建议
三阶段清单和降级版本的安排	〔解释〕	本书的整理，未经试验检验
孕吐多在孕 12—14 周前后减轻	〔强〕	产科常识
起床前吃干点心缓解孕吐	〔中〕	临床经验和小样本研究
生姜、维生素 B6 缓解孕吐	〔有争议〕	证据不一致，用药请遵医嘱
呕吐到喝不进水、体重明显下降需就医	〔强〕	可能是严重妊娠呕吐
增重范围与孕前体重指数有关，过多或过少均有关联不良结局	〔强〕 〔中〕	前者指南共识，后者观察性研究
安排得当的素食可满足孕期需要，需留意铁钙碘 B12 DHA	〔中〕	各国指南略有差异
不建议为预防孩子过敏而孕期主动回避常见食物	〔中〕	多个指南大意，证据在更新
偶尔染发风险低，可孕早期推迟并通风	〔中〕	证据有限

说法	证据级别	说明
孕中期出行较合适，航空公司有孕周规定	〔中〕	出发前问医生和航空公司
孕期睡眠变差很常见；偶尔几晚睡不好无证据显示伤害孩子	〔强〕 〔中〕	长期严重失眠请就医
助眠药物和保健品须先问医生	〔强〕	用药原则
孕中晚期腿抽筋常见，拉伸可缓解	〔强〕 〔中〕	一条腿持续肿痛发热要排除血栓
补钙补镁对腿抽筋是否有用	〔有争议〕	证据不一致
生或半熟的肉、蛋、海鲜孕期要避免	〔强〕	食品安全的一般建议
老火汤的营养主要在肉和菜，不在汤	〔中〕	一般营养常识
没有并发症的孕妇一般不需长期卧床；有医嘱者例外	〔强〕	遵医嘱
补钙先看饮食，是否额外补请医生定	〔中〕	各国指南略有差异
孕期胃灼热常见，少量多餐、睡前不进食、垫高床头	〔强〕 〔中〕	用药请问医生

个体情况，比如孕期并发症、用药、运动禁忌、体重管理，请遵医嘱。出现出血、腹痛、规律宫缩、胎动明显减少，请立即就医。

第 19 章

第一步，给差异：每天十分钟，一只手，一把嗓子

◆ 一、先说“为什么只要十分钟”

这一章，讲三步法里的第一步：给差异。

“给差异”，听起来像个学术词。换成大白话，就是每天给孩子一些有规律的、温和的、能分得出来的“不同”。

本书只提两种：触和声。因为这是孩子在子宫里最早、最可靠的两个通道。

第 5 章、第 6 章讲过证据。现在只讲做法。

先回答一个问题：为什么只要十分钟？

第一，孩子在子宫里醒着的时间本来就不多。孕晚期，胎儿每天大约有一大半时间在睡眠状态里。〔中：胎儿有睡眠和活动周期，不同孕周，比例不同，具体数字，待核〕你不需要，也不可能二十四小时都在“给”。

第二，“给差异”的效果来自“规律”，不来自“时长”。十分钟每天同一个时间，比一小时不定时更有用。因为规律容易被孩子“接成路”。

第三，母亲需要有自己的生活。把这件事做成负担，就违反了本书的总纲：稳。

所以十分钟足够。

◆ 二、先看一个“十分钟”的完整程序

我们先把整个程序摆出来，再逐一拆开讲。

这个十分钟，分四段：

第一段，坐下来，一分钟。找一个舒服的姿势，侧靠着或半躺着。深呼吸几次，让心率慢下来。

第二段，放上手，两分钟。把手放在肚子上。不用动，先放着。感受一下肚子里现在是在动，还是安静。

第三段，说话或哼唱，五分钟。对着肚子，用平常说话的音量讲话、念几页书，或者轻声哼一首歌。

第四段，收尾，两分钟。轻轻拍两下，说一句固定的话，比如“好了，睡吧”或“明天见”。然后起身。

整个过程不超过十分钟。

这里面有一个“固定”的结构：同一时间，同一个姿势，同一个开头，同一个收尾。

为什么要固定？

因为有规律的“开头”和“收尾”，是最简单的“预期”。孕晚期的孩子能通过多次重复，学会“这个时候要发生什么”。

目前没有直接的证据证明胎儿会“预期”某个日常的仪式。不过前面讲过的习惯化、记忆的研究，都说明孩子能学到“重复的东西”。所以用固定的结构，是一个合乎证据的、安全的做法。〔解释：这是本书的推论，没有直接的实验证据〕

◆ 三、第一段，坐下来：先稳住你自己

这一分钟看起来最不重要，其实最重要。

因为你要把自己从“忙”里拉出来。

如果你在紧张、着急的状态里去做十分钟的“胎教”，这十分钟对你和孩子都是负担。

所以先坐下，慢慢呼吸。

呼吸的做法很简单：用鼻子吸气，数四下；停一下；用嘴缓缓呼气，数六下。重复五到六次。

这样的慢呼吸，被很多研究发现可以让心率下降，让副交感神经活跃起来，让人感到放松。〔中：多项研究支持慢呼吸对短期放松有效，对长期健康的影响有待研究〕

请注意，这一段不是任务，不要因为“做不好”而焦虑。

如果那天你就是静不下来，也没有关系。直接进入第二段。

◆ 四、第二段，放上手：触觉的差异

接下来，是触觉。

把手放在肚子上，有几个要点：

一，手的温度。如果手很凉，先搓一搓，捂热。

二，力度。轻。像摸一只熟睡的猫一样。不要用力按，不要用力推，更不要去“按摩”腹部。

三，位置。可以放在肚子的上部、中部或下部。孩子哪里在动，就放哪里。

四，不动。先放着，别急着去“摸”。孩子对稳定放着的手，比对乱摸的手更容易形成“预期”。

五，听到“回”，再回应。如果孩子踢了一下、顶了一下，你可以轻轻把手在那个位置压一下，再放开。很多孕妇会这样做，孩子有时会再动一下。这个“回应游戏”对孩子是否有长期的好处，没有证据。不过它没有已知的风险，而且很多母亲和父亲觉得这是一个很愉悦的互动。〔解释：这是本书的互动建议。没有证据表明它会提高孩子的智力，只当作亲子互动，不要当作训练〕

这里要提醒几件安全上的事：

第一，宫缩的时候不要按压。如果你感到肚子变硬，一阵一阵规律地紧，要先停下来观察。如有规律的宫缩，要联系医生。

第二，如果医生告知你有前置胎盘、先兆流产或先兆早产，一般要避免对腹部的刺激，包括按摩。请先问医生。

第三，不要用任何仪器对着肚子发出声音或振动。市面上有一些“胎教仪”，没有证据证明有益，而且有些声音可能过大。〔中〕

第四，不要因为“孩子没有动”，就去“逗”他，用力拍打、晃动来“叫醒”他。孩子有睡眠周期，不是随时都醒着。

◆ 五、第三段，说话或哼唱：听觉的差异

再讲声音。

声音是这十分钟里最核心的部分。

说什么？有几个选择，你可以轮着来：

一，说你的日子。“今天早上我吃了什么，路上看见了什么，同事说了什么好笑的事。”就像对一个认识的朋友聊天。

二，念一本书。可以是绘本、儿歌、诗，也可以是你自己正在读的小说，工作文件之外的东西。内容不重要，调子更重要。

三，哼歌。不需要唱得好，不需要有歌词，哼调子就行。如果你给孩子反复唱同一首歌，孩子出生后对这首歌可能更熟悉。〔中：有少量研究发现，孕期反复听某首曲子的新生儿对这首曲子有更明显的反应，样本小，需要更多研究〕

四，叫他的名字或小名。如果你们已经想好了小名，每天叫几次。

声音的大小：像平常面对面说话的音量就好。不需要放大，也不需要贴近。

语速：平稳，不用太慢。一个自然、温柔的调子就足够。

语言：你最自然的话。如果说方言，就说方言；如果你和丈夫说两种语言，就两种都用。不要为了“让孩子学标准普通话”，而刻意换一种你不自然的话。因为自然才有自然的节律和情感。

有一个很实际的问题：如果你是个不爱说话的人，觉得对着肚子说话很尴尬，怎么办？

没关系。

你可以只读你自己想读的书，出声读出来。你可以只哼歌。你也可以什么都不说，放一首你喜欢的歌，让它在房间里放着，音量适中，不要把设备贴在肚皮上。

重要的不是你说了什么，而是你在这里，用你的声音在场。

◆ 六、爸爸的声音，和家里其他人的

第 6 章提到过，有研究发现孕晚期的胎儿对父亲的声音也有反应，不过比对母亲的声音反应弱一些。〔中：Lee & Kisilevsky, 2014，样本小，细节待核〕

这给了一个很具体的建议：

让父亲，也来说话。

做法很简单：

在“十分钟”里，让父亲坐在旁边，也把手放上去，也说几句话，或者读几页书。

建议父亲用平常的声音，不要刻意压低或拔高。

建议每天同一个时间。

如果家里还有一个大一点的孩子，也让他来对肚子里的弟弟妹妹说说话。研究没有直接的证据说明孩子能听出哥哥姐姐的声音。不过这样做对大孩子有好处：他会觉得自己也是这个“来回”的一部分，会减少对新生儿的敌意。

〔中：来自观察和临床经验，对“敌意”，直接证据有限〕

如果丈夫不在身边，比如出差，可以用手机录一段他的声音，在“十分钟”里放给孩子听。同样，放的时候把手机放在离肚子有一点距离的地方，音量不要大。

◆ 七、别忘了，你自己，也是“触觉”的来源

除了十分钟，一整天里还有几个自然发生的“触觉差异”也值得留意：

走路。第 18 章讲了。每天快走三十分钟，是孩子最稳定的“摇篮”。

洗澡。温水让身体放松。不要用过热的水，也不要长时间泡在热水里，比如温泉、桑拿。因为孕早期母亲体温过高，可能增加胎儿神经管缺陷的风险。一般建议孕期洗澡水不超过 38 到 39 度，泡澡时间不超过十五分钟。〔中：体温过高与神经管缺陷的关系，来自观察性研究，具体数字，各国建议，略有出入，请遵医嘱〕

游泳。水的浮力让母亲放松。有证据说明孕期游泳是安全的。不过要选卫生、水质好的泳池。〔中〕

孕妇瑜伽或拉伸。可以让身体有节律、有呼吸、有放松。

穿着舒适。不要穿紧绷的衣服，不要穿高跟鞋。

这些都不需要“额外”的时间。它们是你本来就会做的事。只是你知道，它们对孩子是有意义的。

◆ 八、按孕周，怎么安排

最后，把整个孕期，用一张表，收起来。

孕周	孩子在做什么	你可以做什么
孕 1—12 周	神经系统，刚开始形成，还没有触和听	不需要做“胎教”；稳住自己：叶酸，睡眠，产检
孕 13—18 周	手、脚开始动，母亲，感觉不到	可以，开始，轻声，说话，哼歌；不强求，也不要焦虑
孕 19—24 周	开始，对声音，有反应；母亲，第一次，感到胎动	开始，建立“十分钟”：放手，说话，固定时间
孕 25—32 周	听觉，稳定；触觉，全身，敏感	每天“十分钟”，加上，爸爸的参与；走路，每天
孕 33—40 周	记忆，开始，更稳定；睡眠周期，更明显	继续，“十分钟”；在，睡前，做；固定，开头和收尾

注意，表里没有哪一行写着“必须”。

每个人的节奏不一样。你可以晚一点开始，可以有几天忘了，也可以几乎不做，只是过日子。

这些都没有关系。

◆ 九、现成的话：开场白和收尾话

很多人卡在第一句。不知道说什么，就不说了。

下面是一些现成的话。你可以原样念，也可以改成自己的。

场景	可以这样说
刚开始，还有点尴尬	“你好呀，今天是我们的十分钟，我先坐一会儿。”
平常的一天	“今天我上班坐了很久，下班走了二十分钟，路上有一棵树开花了。”
很累的一天	“今天累了，我们就这样待一会儿。”
心情不好的一天	“今天妈妈有点难过，不是你的事。我们安静一会儿。”

场景	可以这样说
爸爸来的时候	“这是爸爸。他今天要给你讲一件他觉得好笑的事。”
收尾	“好了，睡吧。明天见。”

这些话里没有“教”。它们只是在告诉他：我在，今天过得怎么样，现在要结束了。

第四行那句话，有一个小道理：你不必为自己的难过道歉，也不用假装开心。孩子听到的更多是你的调子，不是每一个字。〔解释：本书的看法，没有直接证据说明胎儿能分辨情绪的内容〕

如果实在想不出话，可以只读书。读你自己的书就行。

◆ 十、一周样板：七天怎么做

下面是一个例子，看看一周里“十分钟”可以怎样排。

日子	做法	时长
周一	完整版：坐下，放手，说话，收尾	十分钟
周二	读绘本两页，哼一首歌	十分钟
周三	爸爸加入，讲一件今天的事	十分钟
周四	加班晚归，只做放手加一句话	三分钟
周五	完整版，说说一周的事	十分钟
周六	白天散步代替，晚上只放手	五分钟
周日	休息，什么都不做	零分钟

一周里有两天是缩短版，一天是休息。这是正常的，也是够用的。

给差异的效果，来自“规律”。一周有四五天做，就已经有规律了。〔解释：本书的推论，没有直接的实验数据〕

◆ 十一、如果十分钟做不到：三分钟版本和零分钟版本

有的日子，十分钟真的挤不出来。那就换版本。

三分钟版本：

一，坐下，慢呼吸三次。

二，手放在肚子上。

三，说一句话，比如“今天先这样”。

零分钟版本，是什么都不做。你照常走路，照常说话，照常和别人聊天。孩子一样能听到你的声音。

怀孕的人一天里的说话声，本来就足够多。孕晚期，胎儿能听到母亲的声音，这是第 6 章讲过的证据。〔中：第 6 章已讲〕

所以十分钟是一个“约会”，不是“必须”。偶尔取消，不算失约。

◆ 十二、做之前，检查五件事

每次开始以前，花十秒钟问自己五个问题。

一，肚子有没有变硬，一阵一阵紧？如果有，先停下观察。

二，医生有没有说过，要避免刺激腹部？

三，我的手暖和吗，力度轻吗？

四，旁边有没有设备贴在肚子上？有就拿开。

五，我今天愿意做吗？不愿意，就换成三分钟版本，或者不做。

前两条是安全，第三、四条是方法，第五条是你的意愿。

意愿是最后一条，也是很重要的一条。因为这件事要靠你每天都愿意回来。〔解释：本书的立场〕

◆ 十三、说什么：一份话题单

很多人说了三天，就没话了。下面是一份话题单，随手翻一条就行。

今天吃了什么，哪一口最好吃。

路上看到的一样东西：一棵树，一只猫，一个背书包的小孩。

今天最累的一刻，和最轻松的一刻。

家里谁说了一句有意思的话。

窗外是晴是雨，温度冷还是热。

明天打算做什么，哪一件最想做。

你小时候住过的地方，门口有什么。

你喜欢的一首歌，和它为什么好听。

家里还没有布置好的房间，打算怎么摆。

今晚想吃的夜宵。

这些话题里，没有一条是“教”。它们都是“聊”。

如果有一天，什么话都不想说，就念话题单上的一条，念完就收尾。

◆ 十四、一个典型工作日：二十分钟怎么排

三步法加起来大约二十分钟。下面是一个上班族的排法。

时间	做什么	用时
通勤路上	慢呼吸，看窗外	三分钟
午休	站起来走一走，喝水	五分钟
下班回家	快走，一路上看看天	本来就有的
晚饭后	十分钟：放手，说话，收尾	十分钟
睡前	在本子上写三行，看自己和孩子	一分钟
合计	把“十分钟”放在固定时间，其余都是顺手的事	约二十分钟

这张表没有给你增加一个新的“大块任务”。它只是把已有的时间，用得更有意识一点。〔解释：本书的排法〕

如果哪天只有三分钟，就取通勤和睡前两段。其余照常过日子。

◆ 十五、十分钟里，可能遇到的几种情形

做了几天以后，你会遇到一些没想到的情形。下面是常见的几种，和一般的处理办法。

情形	可以这样做
孩子猛地踢了一脚	手轻轻压一下就放开，说一句“收到”，继续
肚子一阵阵发硬，变紧	先停下来，侧卧休息，观察；规律出现就联系医生
整个十分钟孩子都不动	不必叫醒他，照常收尾；如果一整天都比平时少，按第 20 章去医院
你自己突然很想哭	手放着，不说话也行；哭完再收尾
腰酸，坐不住	换侧卧，垫枕头，缩短时间

情形	可以这样做
家人在旁边插话	当作日常聊天，不用赶人，也不用解释

肚子发硬的情形，要分清两种。偶尔的、不规律的发紧，在孕中晚期比较常见；规律的、越来越密的紧，要联系医生。〔强：产科常识；具体界线请问医生〕

孩子一整天比平时少动，是第 20 章讲的安全问题，不要拿“十分钟”来代替就医。〔强〕

◆ 十六、一家人的分工

“十分钟”看起来是母亲和孩子的事。其实家里每个人都可以有一件小事。

爸爸：每天陪坐十分钟，手放上去，说一件今天的事。

大孩子：对肚子说一句晚安。

外婆或婆婆：把晚饭后的十分钟留出来，不打扰，不指挥。

你自己：决定今天做完整版，还是三分钟版。

这张分工很轻，轻得几乎不占时间。〔解释：本书的建议〕

它的好处是，这十分钟变成了一个家的习惯，不是母亲一个人的任务。第 21 章会专门讲，家人怎么具体地帮。

◆ 十七、常见的几个问题

问：我很内向，对着肚子说话觉得别扭，可以吗？

答：可以。你不必“对着肚子说话”。你可以写下今天三件事，出声读一遍。你也可以读一页喜欢的书，或者哼一首歌。

你说话的声音，本来就会传到孩子那里。〔中：胎儿能听到母亲的声音〕换一种方式说，没有什么不同。

问：爸爸经常出差，怎么办？

答：可以让他出发前录一段，三到五分钟就好。内容可以是他平时说的话，也可以是念一页书。

回放的时候，音量调到平常说话的大小，手机放在离肚子有一点距离的地方，不要贴着肚皮。〔中：没有证据说明贴着有益，距离近音量可能过大〕

也可以让他在视频通话时，对着手机说几句。这对你们两个人都是一种连接。〔解释：本书的建议〕

问：怀的是双胞胎，要怎么做？

答：双胎妊娠的产检更密，早产的风险也比单胎高，所以先听医生的安排。〔强：产科常识〕运动、睡眠、能不能按压腹部，都要问医生。

“十分钟”的原则不变。你不必分开对两个孩子说话，对着肚子说就行。

胎动的分辨会更难。数胎动的方法，请医生专门指导。〔核：双胞胎的数法各医院不同〕

问：我做十分钟的时候，孩子老是不动，或者睡着了，是不是不喜欢？

答：不是。胎儿有睡眠周期，安静的时候，多半是在睡。〔中：第 20 章讲过〕你不需要把他“叫醒”。

可以试着换一个时间，比如晚饭后，很多孕妇觉得这个时段孩子比较活跃。〔中：来自孕妇的经验报告，没有统一的规律〕

就算他睡着了，你的声音和手也没有白做。回路讲的是日复一日的稳，不是每一次的反应。〔解释〕

问：忘了做好几天，会有什么后果？

答：目前没有任何研究说，漏做几天会有害。〔解释：没有证据显示漏做有害，本书据此判断〕

想起来了，就接着做。不用补，也不用自责。

问：能放音乐吗？音量和距离怎么把握？

答：可以放。音量像平常聊天一样，设备放在离肚子至少一臂远的地方。不要把耳机或音箱贴在肚皮上。〔中：多个产科机构的预防性建议〕

声音要穿过母亲的身体才到达胎儿，低沉的声音更容易传过去，尖细的声音会被削弱。〔中：声学常识，不同研究的数字不一，待核〕

放什么都可以，你自己喜欢的最好。不必专门放莫扎特。〔证据弱：莫扎特效应没有可靠证据，第 21 章还会讲〕

问：肚子很大，不知道手放在哪里舒服？

答：放在你觉得最舒服的位置。孕晚期可以侧卧，在肚子下面垫一个小枕头托着，手顺势放上去。〔解释：本书的实用建议〕

问：大孩子想参加，怎么办？

答：欢迎。让他坐在你旁边，对着肚子说一两句话就行。他可能说得很短，也可能说得很怪，这都不要紧。

目的不是训练谁，而是让他觉得自己也在这个家的“来回”里。〔中：来自观察和临床经验，直接证据有限〕

问：我在地铁上、办公室里，没法出声，怎么办？

答：没法出声的时候，可以在心里说，也可以只放手放慢呼吸。

不必特意找个角落，也不要因为周围有人而紧张。回到家以后，再做完整版。〔解释：本书的变通办法〕

问：我上夜班，作息不固定，怎么“固定”？

答：固定的是“你的节律”，不一定是钟点。夜班的人，可以把“起床后的第一个安静时刻”当作固定点。〔解释：本书的变通办法〕

白天睡觉时，尽量让环境暗一点安静一点，这对你的睡眠有帮助。〔中：一般的睡眠建议〕

夜班的工作环境，如果有化学品、重体力或噪声，请和医生、单位沟通。〔强：职业保护的一般原则〕

◆ 十八、放回日子里

苏晴从孕二十周开始，每天晚上九点做“十分钟”。

第一周，她做得很不自然。对着肚子说话，觉得像在对着墙。

第二周，她开始读一本很薄的绘本，是一个朋友送的，叫《晚安，月亮》。她一页一页读出来，声音不大。

第三周，江远也来了。他坐在床边，手放在她的肚子上，说：“今天我在公司吃了一个很难吃的盒饭。”

苏晴笑，孩子在肚子里动了一下。

到了孕三十周，她已经习惯了。有一天她因为加班，到十一点才到家，累得倒头就想睡。

她在床上躺了一会儿，忽然想起今天还没有“十分钟”。

她把手放在肚子上，说了一句：“今天累了，我们就这样待一会儿，好吗？”

没有念书，没有哼歌，就只是放着。

肚子里轻轻地动了一下。

那一天，她觉得这就是最好的“十分钟”。

再说两个场景。

孕二十六周，江远要去外地出差三天。出发前一晚，他坐在书桌前，拿手机录了一段话。

他不知道说什么，先念了一首短短的儿歌，然后又说：“我是爸爸。我这几天不在。妈妈不舒服的时候，你乖一点。”

他听了一遍，觉得自己的声音很傻，想删掉。

苏晴说：“别删。”

出差的第二天晚上，她按平常的时间，坐在床边，手机放在床头柜，离肚子有一臂远。声音放得很轻。

孩子在肚子里动了一下，接着又动了一下。

她没有确定这是不是回应。她把这件事告诉江远，江远在电话那头安静了好几秒。

还有一个人。同事徐静是个很内向的老师，孕三十周。她说，一对着肚子说话，就觉得自己像演员。

后来她换了办法：每晚备课以后，把明天要讲的课，出声小声地过一遍。孩子听不懂，不过那是她最熟悉的声音，也是最自然的节奏。

她说：“我讲我的课，他听他的。我们都不用演。”

这两个场景的话，可以收成一句：不要为了“做对”而改变你的样子。你本来的声音，就是最好的声音。

带走的话

给差异，不用多：每天十分钟，一只手，一把嗓子。要稳：同一个时间，同一个姿势，同一个开头，同一个收尾。不做，也没有关系。做了，也别当成训练，当成，你们的“约会”。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
胎儿有睡眠和活动周期，孕晚期睡眠占大半时间	〔中〕	具体比例待核
慢呼吸可使心率下降、感到放松	〔中〕	短期放松有证据
用固定结构的“十分钟”仪式	〔解释〕	本书的推论，无直接实验证据
与胎动“踢一压”的回应游戏	〔解释〕	无证据显示提高智力，只作亲子互动

说法	证据级别	说明
胎教仪可能声音过大，无益证据	〔中〕	预防性建议
孕期反复听某曲，新生儿对该曲有更明显反应	〔中〕	少量研究，小样本
胎儿对父亲声音有反应，弱于母亲	〔中〕	Lee & Kisilevsky, 2014, 待核
让大孩子参与可减少对新生儿敌意	〔中〕	临床和观察，直接证据有限
孕早期体温过高与神经管缺陷风险相关	〔中〕	观察性研究，请遵医嘱
孕期游泳是安全的	〔中〕	选择卫生的泳池
渐进的三分钟、零分钟版本与一周样板	〔解释〕	本书的降级安排，无试验检验
对着肚子说话的“话”不必有内容，调子更重要	〔解释〕	没有直接证据说明胎儿分辨内容
孕晚期胎儿能听到母亲的声音	〔中〕	第 6 章已讲
手机、音箱不要贴在肚皮上，音量如平常谈话	〔中〕	预防性建议，没有证据说贴近有益
低频声音更容易穿过母体，高频被削弱	〔中〕	声学常识，具体数字待核
双胎妊娠产检更密，早产风险更高	〔强〕	产科常识，听医生安排
双胎的胎动数法	〔核〕	各医院不同，请医生指导
胎儿安静时多半在睡，不必叫醒	〔中〕	第 20 章已讲
晚饭后胎儿较活跃	〔中〕	孕妇经验报告，没有统一规律
漏做几天无证据显示有害	〔解释〕	本书据证据缺失作出的判断
莫扎特效应对胎儿	〔证据弱〕	没有可靠证据
话题单、二十分钟排法和各种变通	〔解释〕	本书的建议，无试验检验
让大孩子参与有助于减少对新生儿的敌意	〔中〕	观察和临床经验，直接证据有限
偶尔不规律的发紧常见，规律且渐密要联系医生	〔强〕	产科常识，界线请问医生

说法	证据级别	说明
一整天胎动比平时少属于安全问题，应就医	〔强〕	与第 20 章一致
夜班的变通：固定“起床后第一个安静时刻”	〔解释〕	本书的变通办法
工作环境有化学品、重体力、噪声需与医生和单位沟通	〔强〕	职业保护的一般原则

个体情况，比如前置胎盘、先兆流产、先兆早产、规律宫缩，请先咨询医生，不要自行做腹部刺激。

第 20 章

第二步，看显露：读懂胎动，也读懂你自己

◆ 一、给了差异，要看回应

给了差异，不看回应，是单向的。

SDE 的“来回”，缺一不可。第一步，你给了孩子一些“不同”；第二步，你要看他有什么“显露”。

孩子在子宫里能“显露”的东西不多。最主要的，就是动。

这一章讲怎么读懂胎动。再讲一件常常被忘记的事：你自己的“显露”，也要看。

◆ 二、胎动是什么

先把几个基本的事讲清楚。

胎动指的是胎儿在子宫里的各种动作：踢，翻，伸展，打嗝，手脚的抽动，等等。

第 5 章讲过，初产妇一般在孕 18 到 20 周第一次感到胎动。

胎动的规律有几个特点：

一是有睡眠和活动周期。胎儿在睡眠状态下很少动，这种状态可能持续二三十分钟，最长可能到九十分钟左右。〔中：胎儿睡眠周期的研究，样本不大，具体数字，待核〕所以，如果你感到有一阵子不动，不一定是问题。

二是一天里有高峰。很多孕妇发现，孩子在晚上，特别是她们躺下休息的时候最活跃。一个原因是白天母亲在活动，对胎儿有“摇”的作用，容易让他安静；晚上母亲静下来，他就动起来。另一个原因是，母亲在安静的时候更容易感觉到胎动。〔中〕

三是进入孕晚期，动的“形式”会变。因为空间变小，大幅度的翻滚会减少，更多的是伸展、顶、滚动。不过动的“次数”不应该明显减少。〔强：产科常识〕

四是每个孩子有自己的“常规”。有的孩子爱动，有的孩子安静一些，这些都在正常范围里。关键不在于“别人家的孩子一天动多少”，而在于“你家这个孩子平时大概是什么样”。

这一点很重要，下面还要讲。

◆ 三、数胎动：两种常用的方法

第 7 章提到数胎动。这里讲细一点。

数胎动是孕晚期一个很有价值的安全措施。

常用的办法有两种。不同医院建议不同，请以你的医生的为准。

第一种，叫“十次法”：从孕 28 周开始，每天选一个孩子比较活跃的时间，通常是饭后或者晚上，侧卧或半靠着，专心数胎动。从开始到孩子动满十次，记录所用的时间。如果在两个小时内孩子动够十次，就可以停了。如果两个小时不到十次，要联系医生。〔核：美国妇产科医师学会等机构，介绍的方法之一，具体的措辞，待核〕

第二种，叫“一小时法”：国内很多医院教的方法是，每天早、中、晚各数一小时，把三次的胎动数加起来，乘以四，就是十二小时的胎动数。正常情况下，十二小时不少于三十次；如果少于十次，提示胎儿可能缺氧，需要立即就医；如果在十到三十次之间，需要结合其他情况，请教医生。〔核：这是国内产科常用的一种教法，具体数字，各医院，略有差异，请遵医嘱〕

两种办法各有道理。选一种，坚持就好。

还有一个比数字更重要的原则，是英国皇家妇产科医师学院等机构近些年一再强调的：

不要死守一个数字。要熟悉你的孩子平时的动法。如果发现动得明显比平时少，或者动的方式明显变了，不要等，不要想着“再看一天”，马上联系医院。〔核：这是英国皇家妇产科医师学院等机构的建议，大意如此，具体措辞，待核〕

这条原则背后有一个很朴素的理由：对一些孩子，“动得越来越少”是一个早期的警报。及时就医，能够挽救生命。

所以有几件事，请你记在心里：

一，孕28周以后，每天留意胎动。

二，发现胎动明显减少或者停了，立刻去医院。不要吃点东西、喝点冰水，等着看看。

三，不要用家用的胎心仪代替数胎动。因为用家用设备听到“有心跳”，可能让你错误地放心，而延误就医。〔中：多个产科机构不建议用家用胎心仪，因为可能带来错误的安全感〕

四，去了医院，医生说没事，也不要觉得“白跑一趟”。医生们欢迎你
来。

◆ 四、不要把胎动，读成“心情”

讲完“安全”，再回到“显露”这个话题。

胎动除了是安全的信号，也是孩子和你互动的“语言”。

不过这里要特别小心：不要把胎动读得太满。

很多母亲会这样想：

“我一哼歌，他就动，他喜欢我唱歌。”

“我一生气，他就踢，他是在抗议。”

“他今天特别安静，是不是在生我的气？”

这样的想法很自然，也很温暖。它是母亲和孩子建立“依恋”的一部分。

第 7 章讲过，母胎依恋是有益的。

不过从科学上讲，没有可靠的证据说明，胎儿的某一个动作对应着某一种“情绪”。

所以建议是：

你可以用这样的想法去和孩子“说话”，去感受被回应。但不要把它当成一个“诊断”。

比如，不要因为孩子这两天踢得少，就推断“他是不是不开心”。回到第三节的安全原则：动，是不是比平时少？

也不要因为孩子在你生气的时候踢得厉害，就推断“我的情绪伤害了他”，从而自责。这样的解读缺少证据，还会增加你的焦虑。

本书的态度是：

胎动是孩子的“显露”。读它，是为了和他“对上”，不是为了“评分”。

◆ 五、一个简单的“胎动日记”

如果你愿意，可以做一个很简单的记录。

不是为了监控孩子，而是为了让自己“看见”。

每天在“十分钟”结束以后，花一分钟，在小本子或手机备忘录里记三件事：

一，今天他什么时候最活跃？

二，“十分钟”里他有没有动？大概是什么样的动？

三，今天和平时比，有没有什么不一样？

可以是这样的：

“8月14日。晚上九点，活跃。十分钟里动了三四次，在左下腹，我手放上去，他顶了一下。和昨天差不多。”

“8月15日。今天白天没怎么感觉到，晚上才有。比昨天少一点点，但晚上还是动了。继续观察。”

“8月16日。今天明显比平时少。从下午到现在几乎没动。已经联系医院。”

你看，这样的记录只花一分钟。不过它有两个好处：

一，让你对孩子“平时的样子”有一个清楚的印象。万一有变化，你立刻能发现。

二，让你每天有一个固定的、小小的“被回应”的时刻。

这两个都是 SDE 里很有价值的东西。

◆ 六、产检和超声：不要多，也不要少

说到“看”，就会想到超声。

很多父母想多做几次超声，看看孩子。有的还去做“四维彩超”，商业的，只为了看孩子的脸。

先说一个事实：

目前，常规的 B 超在医学指征的范围内，被认为是安全的。没有医学指征的、过于频繁的、时间过长的超声，不建议。尤其是商业性的、只为留念的检查。世界卫生组织、美国食品药品监督管理局、国际妇产科超声学会，都曾表达类似的观点：超声应该由有资质的人员，在有医学指征的情况下使用。

〔核：各机构的措辞，略有差异，大意如此，待核〕

超声对孩子会不会有影响？目前的证据没有发现明确的、长期的不良影响。不过原则上，要“合理使用”。

所以本书的建议是：

按医生的安排，做常规的产检和超声。

如果你想看孩子，可以在医生做超声的时候一起看。

不必为了“看一看”额外去做。

◆ 七、看你自己的“显露”

现在说一件很多人忽略的事。

SDE 有两边。你看孩子的显露，孩子也在“接收”你的显露。

所以你要看自己。

怎么看？每天花一分钟，问自己三个问题：

一，我今天睡得怎么样？

二，我今天吃得怎么样？

三，我今天心情怎么样？有没有哪一刻特别紧，或者特别空？

可以用一个很简单的一到五分来打分。

比如：睡眠三分；吃饭四分；心情两分。

如果连续几天心情都在两分以下，要留意。

有一些具体的信号，值得认真对待：

一，连续两周以上，大部分时间情绪低落，或者没有兴趣，做什么提不起劲。

二，睡眠严重紊乱。不是“睡不着”，而是躺着心跳很快，焦虑，停不下来。

三，对未来特别绝望，觉得什么都不会好了。

四，有伤害自己的念头。

出现这些，请立刻告诉你的丈夫、家人和你的医生。这不是“想多了”，这是孕期抑郁、焦虑的信号，需要专业的帮助。

第 17 章讲过，孕期和产后抑郁很常见，是可以治疗的。

◆ 八、按孕周，看什么

胎动不是一成不变的。不同的孕周，你能看到的東西不一样。

孕周	你可能看到的	你可以做的
孕 18—24 周	第一次感到胎动，像气泡、像轻轻的蠕动，不一定每天都有	不用数。感觉到了就记下日期
孕 25—31 周	动作变得有力，开始有规律的活跃时段	熟悉他的“习惯”，在睡前做记录
孕 32—36 周	空间变小，翻滚少了，顶、伸、滚更多	按医生建议数胎动，侧卧
孕 37 周起	动作的形式更温和，次数不应明显减少	继续每天留意；比平时少就联系医院

孕 18 到 24 周，感觉不到胎动，或者一天有一天无，都很常见。〔中：初产妇首次感到胎动的孕周有较大个体差异〕如果到了孕 24 周以后，还是什么都没感觉到，请在下一次产检时告诉医生。〔核：具体界线请医生判断〕

孕晚期动作形式变了，次数不应明显减少。这一条在本章前面已经讲过。〔强：产科常识〕

◆ 九、一周的胎动小本子

如果你愿意记，下面是一张可以抄的表。

日期	最活跃的时间	十分钟里的动	和平时比
周一	晚上九点	三四次，左下腹	差不多
周二	饭后	两次	差不多
周三	夜里十点	很多次	差不多
周四	白天几乎没感觉，晚上有	一次	稍少，继续观察
周五	晚饭后	三次	恢复了

表里“和平时比”这一列最重要。它是你自己的基线。

基线要靠一周两周的积累才看得出。有了基线，“明显比平时少”才有意义。〔解释：本书的建议，和各机构强调熟悉自己孩子模式的原则一致〕

◆ 十、要去医院的时候，怎么说

如果你发现胎动明显比平时少，不要在家里反复纠结。

你可以按下面的顺序行动：

一，先侧卧，专心感受几分钟，同时准备出门。不要为了“逗他动”去拍打、晃动肚子。

二，如果还是比平时少，马上联系你的产科，或者去最近的医院。

三，如果是夜里，直接去急诊的产科。不要等到天亮。

四，带上产检本和你的小本子。

到了医院，可以这样说：

“我孕××周。今天的胎动比平时明显少。平时他每天晚上大概这么动，今天大概是这样。上一次明显感觉到是几点。”

医生需要的就是这三样：孕周，平时的样子，今天的变化。

去了没事，不丢人。医生欢迎你来。〔强：各国产科机构一致的建议〕

◆ 十一、三分钟版本：当天只做一件事

有的日子，你太累，十分钟、小本子、数胎动都想省。

那就只保留最后一件事：晚上睡前，侧卧，花几分钟感觉一下，他今天和平时比，有没有不一样。

如果没有不一样，就睡。

如果有，按上一节的办法行动。

这是最低限度的“看显露”。其他的，都可以缓一缓。〔解释：本书的降级安排，安全部分不降级〕

◆ 十二、睡前的五步：把“看”放进一个固定的时刻

“看显露”不需要另找时间。可以放在睡前，和“十分钟”连在一起。

一，十分钟做完，手还放着，多停一会儿。

二，感觉一下，他现在是在动，还是在睡。

三，翻成侧卧，孕 28 周以后尤其要这样。

四，在小本子上写三行。

五，问自己一句：“今天和平时比，有没有什么不一样？”

如果答案是“没有”，就关灯。

如果答案是“有”，先看是不是安全问题。是，就行动。不是，就写下来，明天再看。

这五步加起来，不到五分钟。〔解释：本书的排法〕

◆ 十三、产检时，医生可能怎么问你

孕晚期的产检，医生常常会问你：“胎动怎么样？”

你可以这样回答：

“平时他晚上九点前后最活跃，十分钟里能动三四次。最近一周差不多。”

这比“还行”有用得多。

如果你记了小本子，可以直接给医生看。医生一眼就能看出趋势。

医生也可能会安排监护，或者让你再数一次。照做就好。

不同医院的做法不同，请以你的医生为准。〔核：各医院的随访方式不同〕

◆ 十四、谁来陪你数：写给家人的一页

数胎动，常常是母亲一个人在夜里做的事。一个人做，容易越数越慌。

家人可以做三件很小的事。

第一，陪着坐。你不用说什么，坐在旁边，看一下手机上的计时。

第二，记数。母亲说“动了”，你就在本子上画一笔。这样她可以专心感受。

第三，出发。如果母亲说“比平时少”，不用再问“是不是想多了”，直接拿起车钥匙。

有一句话，家人可以备着：“我们去看看，没事最好。”

这句话比“别担心”有用得多。因为它把担心变成了一件可以立刻做的事。〔解释：本书的建议〕

◆ 十五、孩子的反应，怎么读才稳

第 19 章里，你在给他触和声。这一章要看他的回应。读的时候，有三条原则。

第一，只读“和平时比”，不读“代表什么”。他今天比昨天多动了一点，说明不了他“开心”。

第二，只读多次的规律，不读一次的反应。某一晚他没回应你，不等于他不喜欢。

第三，读到安全信号就行动，读到温暖的信号就收下。

收下是什么意思？你一哼歌，他动了一下。你可以笑，可以高兴，可以把手放上去。这是你和他的小小共鸣。〔解释：本书的态度，没有证据说这是他的“回答”〕

不必证明它是真的。你只要知道，你的感受是你的，不会伤害他。

◆ 十六、不用急着给每个动作找解释

很多母亲有一种冲动，想知道每个动作是什么意思。

网上有很多“胎动图解”，说踢是什么，翻是什么。这些说法大多没有可靠的证据。〔证据弱：没有可靠研究把某个动作对应某种情绪或需要〕

本书的看法很简单：动，说明他在。动得和平时一样，说明他一切照旧。动得明显不同，就去医院。

这三句，已经够用了。

◆ 十七、情绪的红黄绿：你自己的显露

前面讲了每天问自己三个问题。下面把结果分成三档，更方便决定要不要找人。

档次	样子	可以做的
绿	偶尔烦，偶尔哭，睡得着，能做事	照常过日子；用“五分钟落地”
黄	好几天情绪低，睡得差，什么都懒得做，但还能撑	告诉丈夫或亲近的人；下次产检时和医生说
红	连续两周以上低落或焦虑；停不下来；觉得没有希望；有伤害自己的念头	当天告诉家人和医生；联系急救或当地心理援助热线

孕期的情绪起伏很常见。大部分人在绿和黄之间来回。〔强：多项研究共同发现〕

红色的信号，需要专业帮助，不是靠“想开一点”能解决的。孕期抑郁和焦虑是可以治疗的。〔强：指南共识〕

你不用等到“很严重”才去说。黄色的时候就可以说。

◆ 十八、常见的几个问题

问：胎动少了一天，要不要去医院？

答：要联系医院。明显比平时少，就不要等。不要想“再看一天”。

〔核：英国皇家妇产科医师学院等机构的建议，大意如此〕

不要靠吃东西、喝冰水来“试一试”，也不要家用胎心仪来确认。

〔中：多个产科机构的建议〕去了医院，医生检查没事，是最好的结果。

问：我的胎盘在前壁，感觉不到什么胎动，怎么办？

答：胎盘长在前壁的人，胎动有时会感觉得晚一些，也轻一些。〔中：临床常见的说法，不同人差别大〕

这不代表孩子有问题。不过你仍然要熟悉“他平时的样子”，明显变化就去医院。具体怎么数，请医生指导。〔核〕

问：宝宝一跳一跳的，是怎么回事？

答：很多孕妇会感到肚子里有节律的、小小的跳动，一下一下，像打嗝。常见的说法是，这是胎儿在练习呼吸或者打嗝。〔中：产科常见现象，具体机制还在研究〕

如果每天持续很久，或者你有担心，在产检时间问一下医生。

问：我数不清楚，到底哪个算一次？

答：不同的医院有不同的规定。一般的做法是：一阵连续的动作，算一次，不要每踢一下都算一次。〔核：具体算法请遵医嘱〕

你不必追求精确。精确的数字不如“和平时比”重要。如果数着数着，你开始焦虑，就换成睡前只做一次的简单留意。〔解释：本书的建议〕

问：孕 20 周了还没感觉到胎动，要紧吗？

答：初产妇第一次感到胎动，常见在孕 18 到 20 周，不过差别很大。

〔中〕如果你很担心，可以在产检时请医生听胎心，告诉你一切正常。

问：我做了好几次 B 超，要紧吗？

答：医生安排的常规超声，在医学指征下被认为是安全的。〔核：多个机构的意见，措辞待核〕

做过了就做过了。往后按医生的安排，不额外为了留念去做。

问：白天不动，晚上才动，正常吗？

答：很多孕妇都是这样。白天你在走动，对孩子是“摇”，他容易安静。

晚上你停下来，他才活跃。〔中〕

只要和他平时的模式一致，就不用担心。

问：夜里被踢醒，睡不好，怎么办？

答：孕晚期很多人都会这样。〔强〕换一个侧卧的方向，在腰后和两膝之间垫枕头，会舒服一些。〔中：常用建议〕

被踢醒其实是好消息，说明他在动。不过白天要找机会补觉。

问：孩子突然动得特别厉害，然后又安静下来，要不要紧？

答：如果你感到他突然猛烈地动，随后明显比平时少或者不动了，请马上联系医院，不要等。〔待核：这是一些产科机构提到的情形，具体措辞待核；总原则是明显变化就就医〕

问：我发烧、感冒了，胎动也少了，怎么办？

答：生病时你的身体状态会变，你对胎动的感觉也会变。不过不要自己下判断。

请联系医生，说清你的症状和胎动的变化。用药请遵医嘱。〔强：用药原则〕

问：胎动比朋友的孩子少，是不是有问题？

答：每个孩子有自己的常规。比较别人家孩子的次数，没有意义。〔强：产科常识〕看的是你家这个孩子，和他自己平时比。

◆ 十九、放回日子里

孕三十二周的一个晚上，苏晴坐在床边数胎动。

她用的是“十次法”。晚上九点，侧卧，手放在肚子上。

前面二十分钟，孩子动了六次。后面二十分钟，一次也没有。

她有点紧张。她想起前一个星期产检时，医生说过：“如果觉得他比平时安静，不要等。”

她喝了一口温水，换了一个姿势，轻轻拍了拍肚子。

又过了十分钟，孩子动了一下。

两下。

三下。

她松了一口气。又过了十五分钟，十次数满了。一共用了五十分钟，和平时差不多。

她在日记里写：“今天有点吓到。不过他回来了。”

后来她跟江远说起，江远说：“你下次早点叫我。我陪你数。”

第二天晚上，江远坐在她旁边，手机开着计时。

两个人一起数。

这一刻是一个很小的“稳环境”：丈夫成为了她的“E”，帮她分担了一部分焦虑。

再说两个场景。

苏晴的朋友周敏，孕三十三周。有一天她忙着赶项目，直到晚上八点，才想起好像一整个下午都没感觉到孩子动。

她先侧卧了半个小时，喝了一点水，还是只有很轻的一下。

她本来想：再等等看。然后想起了产检时医生的话。她拿起包，对丈夫说：“我们去医院。”

在急诊，护士给她做了监护。一个小时以后，医生看了结果，说：“现在一切都好。你来对了。”

周敏回到家，在小本子上写：“今天虚惊一场。下次我不会再等了。”

她后来对苏晴说：“去了医院，我才发现我白纠结了两个小时。”

另一个场景。孕三十六周的一个周日，苏晴翻开小本子，把近一个月的记录看了一遍。

她发现，每天晚上九点前后，是孩子最活跃的时间。她还发现，在她加班特别晚的那几天，他有点晚才开始动，不过都动了。

她拿笔在本子上圈了一句：“他有自己的节律。”

这一句话，比任何数字都让她安心。

这两个场景的话，可以收成一句：看显露，不是为了评分，是为了在需要的时候，你马上能知道，该不该走。

带走的话

看显露，最要紧的，是安全：孕 28 周以后，每天留意胎动；比平时明显少，马上去医院。胎动，是用来“对上”的，不是用来“评分”的。也要看自己：睡得怎样，吃得怎样，心情怎样。连续两周低落，要去找人帮忙。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
胎儿有睡眠和活动周期，睡眠状态可持续数十分钟，最长约 90 分钟	〔中〕	具体数字待核
孕晚期胎动形式改变，但次数不应明显减少	〔强〕	产科常识
“十次法”：2 小时内应有 10 次胎动	〔核〕	ACOG 等介绍方法之一，措辞待核
“一小时法”：12 小时胎动不少于 30 次，少于 10 次需立即就医	〔核〕	国内常用教法，各医院略有差异
熟悉自己孩子的常规模式，明显变化即就医	〔核〕	英国皇家妇产科医师学院等建议，大意
不建议用家用胎心仪代替数胎动	〔中〕	产科机构建议，避免错误的安全感
胎儿每个动作对应某种情绪	〔无证据〕	本书明确不这样读
常规 B 超在医学指征下安全，不建议无指征的频繁检查	〔核〕	多个机构的意见，措辞待核
孕期抑郁焦虑的信号需要专业帮助	〔强〕	指南共识

说法	证据级别	说明
初产妇首次感到胎动的孕周个体差异很大，孕 24 周后仍无感觉请告知医生	〔中〕 〔核〕	具体界线请医生判断
孕晚期动作形式变化，次数不应明显减少	〔强〕	与前文一致
去医院时说清孕周、平时的样子、今天的变化	〔解释〕	本书的沟通建议
胎动明显减少应立即就医，去了没事也受欢迎	〔强〕	各国产科机构一致建议
三分钟版本只保留睡前留意一件事	〔解释〕	本书的降级安排，安全部分不降级
孕期情绪起伏常见，红色信号需要专业帮助	〔强〕	多项研究和指南共识
前壁胎盘胎动可能感觉得晚、轻	〔中〕	临床常见说法，个体差别大
有节律的小跳动可能是打嗝样动作	〔中〕	产科常见现象，机制在研究
一阵连续的动作算一次胎动	〔核〕	各医院算法不同，请遵医嘱
不靠吃东西喝冰水试探胎动，不用家用胎心仪确认	〔中〕	多个产科机构建议
胎动图解把某动作对应某种情绪或需要	〔证据弱〕	没有可靠研究支持
孕晚期夜间被踢醒常见，侧卧垫枕头可缓解	〔强〕 〔中〕	常用建议
猛烈动之后明显减少，应联系医院	〔待核〕	总原则是明显变化即就医
生病时用药请遵医嘱，说清症状和胎动变化	〔强〕	用药原则
睡前五步、对医生讲清胎动模式	〔解释〕 〔核〕	本书排法；各医院随访方式不同
家人陪数、记数、陪同出发	〔解释〕	本书的建议
白天不动、晚上才动常见	〔中〕	白天母亲活动有“摇”的作用
与别家孩子比较胎动次数没有意义	〔强〕	产科常识

个体情况，比如胎动异常、孕期抑郁、焦虑、有伤害自己的念头，请立即就医或联系当地心理援助热线、急救电话。

第 21 章

第三步，稳环境：把心稳住，并且放下那张“不必做”的单子

◆ 一、最难的一步

三步法里，前两步是具体的：每天十分钟，一只手，一把嗓子；每天一分钟，看胎动，看自己。

第三步，稳环境，听起来最空，做起来最难。

因为它不是一件事，而是一整个日子。

这一章讲三件事：

第一，母亲的心怎么稳。

第二，一个家怎么帮她稳。

第三，一张“不必做”的清单。你会发现，这张清单可能比前面的“要做”更让你轻松。

◆ 二、压力是什么，不是什么

第 7 章讲过，长期的、严重的压力，可能对孩子有一点影响。可是也讲过：这个影响不大，也不是母亲一个人的责任。

现在要讲另一面：怎么办。

先说清楚一件事：压力不是敌人。

人活着就有压力。一点压力让我们警觉，让我们完成任务。有害的是“长期的、没有出口的、没有人分担的”压力。

所以目标不是“零压力”，而是压力来了有出口，有人接。

这个出口有几种：

一，身体的出口。走路，拉伸，慢呼吸，热水澡。研究发现，孕期规律的运动可以改善情绪，降低抑郁的风险。〔强：多项系统综述〕

二，说话的出口。有一个人，你什么都可以说。可以是丈夫、母亲、朋友，也可以是医生或孕妇小组。研究发现，社会支持和孕期较低的焦虑、抑郁有关联。〔中：第 7 章讲过〕

三，专业的出口。如果你的焦虑、低落持续两周以上，影响生活，要去看医生。有两类办法有证据：认知行为治疗、人际关系治疗等心理治疗，以及在医生指导下使用药物。很多抗抑郁药在权衡利弊之后，孕期可以使用。具体一定要由医生来决定，不要自己擅自停药。〔强：指南共识；具体治疗，请遵医嘱〕

停药这件事，要特别说一句：

有些孕妇一发现怀孕，就把正在吃的精神科药物自己停了。这样做有风险：病情可能复发，对母亲和孩子都不好。请先找医生。

◆ 三、一个“五分钟”的减压办法

如果你想要一个很具体的办法，下面这个可以每天用。

它叫“五分钟落地”。

做法：

第一分钟，坐下来，脚踩在地上，感觉脚底和地面的接触。

第二分钟，慢呼吸：用鼻子吸四下，用嘴呼六下。

第三分钟，在心里说出现在最占着你的那件事。比如：“我在担心下周的产检。”不用解决它，只是说出来。

第四分钟，问自己：“这件事，今天我能做的有什么？”如果有，写下来。如果没有，对自己说一句：“今天到此为止。”

第五分钟，把手放在肚子上，说一句：“我们今天先这样。”

这个方法没有什么“神奇”。它只是把“呼吸、命名、行动、放下”四个动作连起来。

研究发现，正念类的训练对孕期的焦虑和抑郁有一定的帮助，效应不大，但比较一致。〔中：多项随机对照试验和荟萃分析，质量参差，效应量小到中等〕

不用强求坚持。每天做一次已经很好，一周做三次也有用。

◆ 四、一个家，怎么帮她稳

接下来讲家人。

很多家庭对孕妇有一种“善意的失控”：一边把她当成“国宝”，什么都不让做；一边不停地给建议，给规矩，给压力。

“不能抬手。”“不能吃这个。”“你怎么还在看手机，对孩子不好。”“要保持好心情啊。”

这些话每一句出发点都是爱。可是加起来，会让孕妇觉得自己被“盯着”，每一个动作都有可能“伤害孩子”。

下面是几条家人最有用的做法：

一，减少“规矩”，增加“具体的帮助”。

不要说“你不能提重物”，而是说“这箱东西我来提”。

不要说“你别生气”，而是说“你生气是应该的，我陪你”。

二，不要说“要保持好心情”。

这句话听着好，其实等于给她又加了一个任务：她不开心，还要为自己“不开心”而内疚。

三，把“选择权”还给她。

吃什么，不吃什么，怎么睡，做什么运动，在医生的建议范围里让她自己选。

四，一起分担那个“焦虑”。

像第 20 章里江远陪苏晴数胎动。焦虑一个人扛是 100 分，两个人扛就是 50 分。

五，保护她，不被外面的“指点”打扰。

亲戚的建议，邻居的看法，网上的信息，你可以替她挡一挡。

◆ 五、工作和孕期

现实里，很多孕妇要上班。

怎么办？

一，了解自己的权利。《女职工劳动保护特别规定》规定了，用人单位不得因为女职工怀孕、生育，降低工资、予以辞退、与其解除劳动或聘用合同。

〔核：具体条文，以最新的为准〕

二，和单位沟通调整。如果你的工作需要长时间站立、接触化学品、大噪声，或者高强度的体力劳动，请和单位沟通，调岗或调整工作安排。这是法律允许的。

三，学会说“不”。孕期的加班不是“应该”。你可以说：“我这周只能到六点。”

四，在办公室里每小时站起来动一动。

对于不得不加班的情况，比如苏晴月底结账：

可以每天安排十五分钟真正的“停下来”：不看屏幕，不想工作，只是喝一杯水，看看窗外，把手放在肚子上。

这十五分钟不是“偷懒”，是“稳”。

◆ 六、一张“不必做”的清单

好，现在是这一章最让人松一口气的部分：“不必做”的清单。

在孕期，有很多说法让母亲焦虑，让家人操心。其实它们大多数要么没有证据，要么被夸大了。

下面列一列。每一条都配了一句简单的说明。

不必做	为什么
不必给胎儿专门放莫扎特或古典音乐	莫扎特效应没有可靠证据，对胎儿更没有。日常说话足够好
不必买胎教仪贴在肚皮上	没有证据说明有益，声音可能过大
不必上昂贵的胎教班	没有证据证明能提高孩子智力
不必每天对着肚子“教”认字、数数	胎儿没有这样的学习能力，孩子出生以后才有意义
不必时时刻刻“保持好心情”	人不可能永远开心，偶尔的情绪波动是正常的
不必因为生了一次气、哭了一次而自责	偶尔的情绪不会伤害孩子，长期的、严重的才需要帮助
不必把胎动解读成孩子的“心情”	没有证据，会增加焦虑
不必大补，吃“双份”	孕期不需要吃两个人的量，过度增重对母子都不好
不必因为“别人家孩子”怎么样而焦虑	每个孩子节奏不一样
不必担心“怀孕时的一些小事”，比如吃了半杯咖啡、染了头发、坐了飞机	这些大多数在合理的范围里没有明显的风险，具体请问医生
不必相信“怀孕时的某些食物决定孩子的肤色、性别”这类传说	没有证据
不必因为自己没做到这里的任何一条而内疚	本书的所有建议是“可以”，不是“必须”

请你把这张表认真读一遍。

最后一条最重要。

◆ 七、为什么本书要花一章讲“不必做”

有读者可能会问：你不是要教我怎么做吗？为什么用这么多篇幅讲“不必做”？

因为本书有一个很深的担心：

“做妈妈的方法”很容易变成一张新的“任务清单”，变成新的“焦虑来源”。

很多母亲读了各种“科学育儿”的书，非但没有更放松，反而更焦虑，觉得自己哪一样都没做到。

这违背了本书的初衷。

本书的所有方法只有一个目的：让母亲和孩子之间那个“来回”更稳。

如果一条建议让你更焦虑，让来回更不稳，那么请你把它放下。

◆ 八、三个阶段，心怎么稳

心的“稳”，也随着孕周在变。每个阶段，担心的事不一样。

阶段	常见的担心	可以做的小事
孕早期	会不会流产，该不该告诉别人，吐得厉害怎么办	把担心写下来，产检时间；找一个可以说的人
孕中期	筛查结果，工作怎么安排，要不要买这买那	一次只处理一件事；把“买什么”交给家人去查
孕晚期	怕生产，怕疼，怕做不好妈妈，睡不着	和医生聊生产计划；和有经验的人聊；练习呼吸

孕期的担心很普遍。几乎每个人都有，只是说出来的多少不同。〔强：多项研究共同发现，孕期焦虑与担心很常见〕

担心本身不是问题。“担心”到了睡不着、停不下来，才需要找人帮忙。
〔强〕

◆ 九、一个工作日：二十分钟的完整安排

前面三章讲了三步。把它们放进一个上班族的一天，大概是这样。

时间	做什么	属于哪一步	用时
早上	起床后坐一分钟，问自己睡得怎么样	看显露	一分钟
通勤	慢呼吸，不刷让你烦的消息	稳环境	三分钟
午休	站起来走一走，喝水	稳环境	五分钟
下班	快走，回家的路上看看天	稳环境	本来就有的
晚饭后	放手，说话，固定的收尾	给差异	十分钟
睡前	记三行，侧卧	看显露	一分钟

合计大约二十分钟。其他时间，你过你的日子。〔解释：本书的排法〕

其中真正“额外”的时间，只有晚饭后那十分钟。别的都是把原来的时间，用得稳一点。

◆ 十、怎么对家人说“不”：几句现成的话

很多孕妇难的不是不知道怎么做，而是不好意思拒绝。

下面是几句现成的话。语气可以随你自己调整。

场景	可以这样说
婆婆让你多吃、少动	“医生说我可以正常走路，也让我控制一下体重。我听医生的。”
亲戚塞给你一个偏方	“谢谢您。我吃东西要先问医生，这个我先收着。”

场景	可以这样说
有人说“你怎么还玩手机”	“我在休息。这是我今天的十分钟。”
有人说“要保持好心情”	“我有时好有时不好。我在想办法，需要的时候我会说。”
有人要摸你的肚子	“现在不太方便，谢谢您关心。”
同事让你加班	“我这周只能到六点。这件事周三前我能交。”
有人说“某某的孩子怎么样”	“每个孩子节奏不同，我们按医生的来。”

这些话有一个共同点：不争，不解释太多，也不道歉。

你不是在对抗谁。你是在保护那个“来回”。〔解释：本书的沟通建议〕

◆ 十一、一家人的周计划

家里人想帮忙，常常不知道怎么帮。给一张小表，可以减少猜。

日子	丈夫	母亲或婆婆	孕妇自己
周一	做晚饭	去买菜	十分钟，早睡
周二	陪走半小时	洗衣服	十分钟
周三	陪十分钟，说一件事	休息	休息，不用做饭
周四	做晚饭	陪聊天	十分钟
周五	收拾房间	做汤，少油少盐	十分钟
周六	陪去产检或逛街	休息	和朋友吃一顿饭
周日	全家不安排事	全家不安排事	什么都不做

这张表是一个例子，请按你家的情况改。重点是：家人的帮助是“具体的”，不是“说一句关心”。

具体的帮助，才能减轻孕妇的负担。研究发现，家人在家务和情感上的支持，与孕期较低的压力有关。〔中：观察性研究，因果关系不确定〕

◆ 十二、三个出口，一周怎么排

前面讲了压力要有三个出口：身体的，说话的，专业的。下面把它们放进一周里。

出口	一周里可以这样安排
身体	快走三到五次，每次二十到三十分钟；睡前拉伸几分钟
说话	约一个固定的人，每周通一次电话；和丈夫每天说三句真话
专业	产检时带一个情绪的问题；有需要，约心理门诊

“每天说三句真话”是什么意思？

一句今天让你开心的事，一句今天让你烦的事，一句你明天需要他做的事。

这三句话，不超过两分钟。〔解释：本书的沟通建议，没有试验检验〕

固定的人比“偶尔的倾诉”更有用，因为稳定的支持更容易形成习惯。

〔中：社会支持相关研究的大意〕

◆ 十三、一个家的三句约定

如果全家人只记三句话，可以是这三句。

第一句：你累了就休息，不用解释。

第二句：有话直接说，不要猜。

第三句：医生说的，我们听医生的。

三句话，把这一章前面讲的大部分事，都包进去了。

第一句给她“喘气”的权利。第二句减少猜来猜去的消耗。第三句把“规矩”交给医生，避免家里每个人各有一套。〔解释：本书的建议〕

你们可以把这三句话，写在冰箱的便利贴上。

◆ 十四、别人的话，怎么听

孕期会遇到很多“别人的话”。有的好心，有的随口，有的带着比较。

有一个简单的办法，叫“三问”：

这句话有没有证据？

这句话和我的医生说的一样吗？

这句话让我更稳，还是更慌？

三个问题里，两个是“不”，就可以放下。

比如“怀孕不能吃螃蟹”，没有可靠证据说某种熟的海鲜一定有害；具体食物怎么吃，请问医生。〔中：食品安全的一般建议是煮熟，有特殊情况者遵医嘱〕

比如“怀孕要多补，孩子才聪明”，没有证据。〔强：本书第 18 章已讲，过度增重对母子都不好〕

“三问”不是让你对所有人冷淡。它只是给你一道门，让你可以礼貌地把话放下。〔解释：本书的建议〕

◆ 十五、如果做不到：三分钟版本和零分钟版本

有的时候，连“五分钟落地”也做不到。

那就用三分钟版本：

一，坐下，脚踩在地上。

二，慢慢呼吸三次。

三，说一句：“今天先这样。”

零分钟版本，是你什么都不做，只是让自己休息。

没有哪一个孕妇每一天都做得到。如果一个星期里有一两天，你能做到其中任何一件，就已经够用了。〔解释：本书的看法，大部分人的日子都是起伏的〕

◆ 十六、常见的几个问题

问：婆婆总让我这样那样，我怎么拒绝才不伤感情？

答：先听她的出发点。她多半是出于爱。再把“医生怎么说”放在前面，比“我不想”更容易被接受。

可以用上面表里的话。如果你说不出口，请丈夫替你说。〔解释：本书的建议〕

家人之间的分歧，有时不需要说服，只需要把决定权明确放在孕妇身上。

问：我老是想哭，怎么办？

答：孕期的情绪起伏很常见，激素变化是其中一个因素。〔强：产科和精神卫生的共同认识〕偶尔哭，哭完好一点，不用担心。

如果连续两周以上，大部分时间低落，对什么都没兴趣，要告诉医生，不要只是忍着。〔强：指南共识〕

问：要不要请假，或者辞职？

答：先不要在最累的那一周做决定。和医生谈谈你的工作性质，再和单位谈调整岗位或者工作时间。〔解释：本书的建议〕

如果你的工作有明确的职业危害，比如长时间站立、化学品、重体力，请医生出具建议，用来和单位沟通。〔中：各地的做法不一，请遵医嘱〕

辞职是一个大决定，也不是“稳环境”的必需。有人辞了更稳，有人留着更稳，要看你的情况。

问：怀孕了还吵架，是不是会伤害孩子？

答：偶尔的争吵，大部分夫妻都会有，没有证据说会伤害孩子。〔中：第 7 章讲过，偶尔的情绪波动不是问题，长期严重的冲突才需要干预〕

吵起来的时候，可以约好一个“暂停”的暗号。各自离开二十分钟，冷静一下再谈。〔解释：本书的建议，常见的夫妻沟通办法〕

如果争吵经常升级，或者在家里感到不安全，请联系医生、家人或当地的求助渠道。〔强：这是安全问题，要优先处理〕

问：我很怕生产，一想到就睡不着，怎么办？

答：怕生产很常见。〔强〕可以在产检时，请医生或助产士讲讲生产的过程，和医院的安排。了解得多一点，担心常常会小一点。〔中：产前教育对焦虑有帮助，效应大小不一〕

孕晚期可以多练习慢呼吸。你已经在用“五分钟落地”，这就是一个练习。〔解释〕

问：我和我的妈妈关系不好，想到要做妈妈就紧张，怎么办？

答：这是很多人都会有的感受。你的过去，不决定你将来怎么做妈妈。本书不会因为这个责怪你。

如果这件事一直压在你心里，可以和值得信任的人谈，或者去看心理门诊。〔中：心理咨询对这类困扰有帮助〕

问：朋友圈里别人都在晒胎教，我什么都没做，是不是很失败？

答：不是。朋友圈里看到的，只是别人想让你看到的那一部分。〔解释〕

本书的所有建议都是“可以”，不是“必须”。你把睡、吃、走、稳做好，就已经够了。

问：我睡不着，一直想各种坏事，怎么办？

答：先用“五分钟落地”。把想的事说出来，写在本子上，告诉自己“明天再想”。

如果这样的夜晚越来越多，请告诉医生。有一些有证据的办法可以帮你。〔强：指南共识〕

问：丈夫不爱说话，也不知道怎么帮，怎么办？

答：不要等他“自己懂”。给他一件具体的小事：每天陪十分钟，或者每周做两次饭。

很多男性并不是不想帮，而是不知道帮什么。〔解释：本书的观察，不是研究结论〕

问：网上的信息太多太乱，看了更焦虑，怎么办？

答：可以规定自己每天只看一次，限定十五分钟。看到让你紧张的内容，先写下来，在产检时间医生。

本书的建议是：以你的医生和正规的指南为准。〔解释：本书的立场〕

◆ 十七、放回日子里

苏晴孕三十四周的时候，参加了医院办的“孕妇学校”。

课上有一位看起来很年轻的助产士，讲到“孕期饮食”。台下有一位大概三十多岁的孕妇举手问：

“我前两天吃了一顿火锅，是不是对孩子有影响？”

助产士笑了：“火锅吃了就吃了。你有没有吃生的、不熟的？”

孕妇说：“没有，涮得很熟。”

“那没事。”助产士说，“在座的我看一半的人，每天都在为各种小事担心。我给你们说一句实话：孕期最大的风险不是一顿火锅，是你们一直在担心火锅。”

台下笑了。

那一刻苏晴也笑了。她忽然觉得肩膀松了一点。

那天晚上回到家，她对江远说：“我打算把之前收藏的那几十篇‘孕期禁忌’全部取消收藏。”

江远说：“好。”

她说：“然后我们今天做‘十分钟’，好吗？”

“好。”

再说两个场景。

苏晴的婆婆从老家来住了。第一天， she 就把苏晴的运动鞋收进了柜子：“怀着孩子，别老走，会动了胎气。”

苏晴愣了一下，没有当场说什么。晚上，她对江远说：“我想每天下班走半小时，医生说可以。”

第二天吃早饭，江远对妈妈说：“医生专门跟苏晴说了， she 可以正常走路。我陪她走，你放心。”

婆婆看了看儿子，说：“那你走慢一点。”

苏晴把运动鞋拿回来的时候，婆婆还问了一句：“你要不要带件外套，晚上凉。”

后来她们的关系，没有因为这一件事变坏。苏晴想，把“医生说”放在前面，很多话就好说多了。

还有一个场景。林姐有一次在办公室，看着电脑，眼泪突然掉下来了。她孕三十周，没有什么特别的事。

同组的人不知道说什么。苏晴递给她一杯温水，说：“我也有过。你要不要出去走五分钟？”

两个人在楼下走了一圈。林姐说：“我就是觉得好累。”

苏晴说：“累是真的。你和医生说过吗？”

林姐说：“还没有。我觉得不算什么。”

苏晴说：“下次产检说一句吧，就说你最近老想哭。”

林姐点了点头。

这两个场景的话，可以收成一句：稳环境，是有人递一杯水，有人替你说一句话。

◆ 十八、本编小结

第六编四章，到这里可以收起来：

第 18 章立了总纲：把回路稳住，不是给胎儿加料。讲了先守住的底线，和睡、吃、动。

第 19 章讲了第一步，给差异：每天十分钟，一只手，一把嗓子，固定的开头和收尾。

第 20 章讲了第二步，看显露：读懂胎动，数胎动，安全第一；也看你自己。

第 21 章讲了第三步，稳环境：把心稳住，让家人具体地帮；放下那张“不必做”的单子。

三步法每天加起来二十分钟，其余的时间过你的日子。

下一编讲孩子出生以后，0 到 3 岁怎么做。三步法会沿用，只是换了样子。

带走的话

稳环境，不是要你不累、不烦、不气。是要你累了有地方歇，烦了有人听，气了有人陪。本书所有的建议是“可以”，不是“必须”。让你更焦虑的建议，请放下。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
孕期规律运动改善情绪，降低抑郁风险	〔强〕	多项系统综述
社会支持与孕期较低焦虑和抑郁相关	〔中〕	第 7 章已讲
认知行为治疗、人际治疗对孕期抑郁有效	〔强〕	指南共识
孕期使用抗抑郁药须权衡利弊，不可擅自停药	〔强〕	须遵医嘱
正念训练对孕期焦虑抑郁有小到中等帮助	〔中〕	随机对照试验质量参差
《女职工劳动保护特别规定》禁止因怀孕、生育降薪、辞退	〔核〕	以最新条文为准
莫扎特效应、胎教仪、胎教班提高智力	〔证据弱〕	本书不推荐
“五分钟落地”是呼吸、命名、行动、放下四个动作的组合	〔解释〕	本书的组合，单个成分有证据，整套未经检验
孕期担心、焦虑很常见，停不下来需要帮助	〔强〕	多项研究和指南共识
二十分钟排法、周计划、三分钟版本	〔解释〕	本书的安排，未经试验检验
对家人说“不”的话	〔解释〕	本书的沟通建议
家人在家务和情感上的支持与较低孕期压力相关	〔中〕	观察性研究，因果关系不确定
孕期情绪起伏常见，激素变化是因素之一	〔强〕	产科和精神卫生的共同认识
低落持续两周以上需告诉医生	〔强〕	指南共识

说法	证据级别	说明
职业危害需医生建议配合单位调整	〔中〕	各地做法不一，请遵医嘱
偶尔争吵无证据显示伤害孩子，长期严重冲突才需干预	〔中〕	第 7 章已讲
争吵升级或感到不安全需联系求助渠道	〔强〕	属于安全问题
睡不着、反复想坏事越来越多须告诉医生	〔强〕	指南共识
三个出口的一周排法、每天三句真话、一家三句约定	〔解释〕	本书的建议，无试验检验
稳定的社会支持更容易形成习惯，有助于减压	〔中〕	社会支持相关研究大意
流言“三问”：有无证据、是否同医生、让我更稳还是更慌	〔解释〕	本书的方法
熟的海鲜一般无需忌口，特殊情况遵医嘱	〔中〕	食品安全的一般建议
怕生产常见，产前了解有助于减轻担心	〔强〕 〔中〕	效应大小不一
心理咨询对亲子关系带来的困扰有帮助	〔中〕	请专业人员评估
丈夫不知如何帮，需给具体的小事	〔解释〕	本书的观察，不是研究结论
限定网上信息的阅读，以医生和正规指南为准	〔解释〕	本书的立场

个体情况，比如孕期焦虑、抑郁、精神科用药、工作岗位的职业危害，请遵医嘱，必要时寻求专业帮助。

第七编

做 0 到 3 岁的妈妈：三步法，一天一天用

这一编五章，讲孩子出生以后的三年，怎么做。

第 22 章把三步法带到出生以后，并讲回应的四个动作。第 23 到 26 章，按月龄，讲 0 到 6 个月、6 到 12 个月、1 到 2 岁、2 到 3 岁。第 26 章的后半，是一章写给“做不到完美”的妈妈。

五章走完，你会看到：这三年所有的方法，说到底只有一件事，就是在，并且在没对上以后回来。

第 22 章

孩子出生以后：三步法换个样子，继续用

◆ 一、第三天的夜里

孩子出生后的第三天夜里，苏晴醒了。

不是被哭声吵醒的，是她自己醒的。她躺在床上，看着旁边小床里的孩子，一动不动，胸口一起一伏。

她看了很久。

然后她忽然想到一个问题：这个小人儿，现在要什么？

九个月里，她有一套办法：每天十分钟，一只手，一把嗓子。孩子在肚子里，她把手放上去，他就动一下。

现在孩子出来了，那套办法还能用吗？

答案是：能用。三步没有变，只是换了样子。

这一章先讲这三步在出生以后怎么用，再讲一个很重要的东西：回应的四个环节。

◆ 二、三步法，换了样子

先把三步放在一起看。

步骤	孕期的样子	出生后的样子
给差异	每天十分钟：放手，说话，哼歌	每天几段“面对面”：抱，看，说，唱，玩
看显露	数胎动，写胎动日记	看他的信号：哭，笑，看，躲，伸手，扭头

步骤	孕期的样子	出生后的样子
稳环境	睡好，吃稳，走动，稳住心情	稳住作息，稳住照料者，稳住自己

你看，三步一样，区别只有一点。

孕期孩子的“显露”很少，只有动。出生以后，孩子的“显露”一下子多了：他会哭，会笑，会看，会躲，会伸手，会发声。

所以出生以后，最重要的变化是第二步。

“看显露”从“数胎动”变成了“读信号”。

◆ 三、回应的四个环节

第 13 章讲过，依恋研究里有一个核心概念：敏感性。

敏感的回应有四个环节：注意到，读懂，及时回应，回应得合适。

把它们换成大白话，就是四个动作。本书叫它们：看，猜，做，看。

第一个“看”：注意到孩子的信号。

孩子皱了一下眉，把头扭开了，手伸向了一个东西。这些都是信号。第一步是看到它们。

这一步最容易被手机和各种事情打断。你拿着手机，孩子在看你，你没有抬头，这个信号就漏掉了。

第二个“猜”：读懂它的意思。

孩子哭了。是饿了，是困了，是尿了，是胀气，是太吵，还是想要抱？你要猜。

猜是一件很难的事，尤其是对新生儿。猜错是常事。本书后面会说，“猜错”一点也不可怕。

第三个“做”：回应。

猜了一个答案，就去做：喂奶，抱起来，换尿布，拍嗝，把灯调暗。

第四个“看”：看看回应对不对。

做了以后，再看他的反应。他安静了，就是对了。他还在哭，就是没猜中，换一个再猜。

这四步在孩子醒着的时候会不停地转，一天里转几百圈。

每一圈，孩子都在学一件事：我发出一个信号，外面会变。

这就是第 11 章讲的“你来我往”，现在有了四个具体的动作。

◆ 四、“猜错”，为什么不可怕

很多新手母亲最大的焦虑是：我猜不对。

孩子一哭我就慌，我不知道他要什么。

这里要讲一个很有力的研究。

第 11 章讲过，特罗尼克发现，即使是关系很好的母婴之间，“对上”的时间也只占一小部分，大部分时间是“没对上”和“修复”。

这个发现放到“猜”这件事上，意思是：

猜错是常态。猜错了再猜，才是关键。

孩子并不需要一个“每次都猜中”的妈妈。他需要的是一个“猜不中也不走开”的妈妈。

一个哭了半小时、终于安静下来的孩子，学到的是：我哭，有人来；这个人试了好几次，终于对了；这个人没有放弃我。

这样的经验，比“一哭就中”更有分量。

所以下次你抱着孩子，试了一样又一样都没猜对，不用急。你可以对他说：

“我知道你难受。妈妈在这儿。我们再试一个。”

这一句话，孩子听不懂内容。可是他听得懂调子：有人在，有人在试，有人没走。

◆ 五、给差异：一天里的几段“面对面”

第一步，给差异。

出生以后，“给差异”不再是每天固定的十分钟，而是分散到一天里的各个时候。

最重要的是一件事：面对面。

面对面是什么意思？

是让孩子眼睛能看到你的脸，让你的声音直接传到他耳朵里，让你的手能碰到他。

一天里有几个天然的“面对面”时间：

一，喂奶的时候。无论母乳还是奶瓶，都抱着他，让他看着你。

二，换尿布的时候。这是一个很好的“说话”机会。每换一次，说几句话：“来，换尿布了，抬一下腿。”

三，洗澡的时候。水是他熟悉的东西。温水，轻轻地碰触，慢慢地说话。

四，醒着又安静的时候。这是孩子最想“玩”的时候。把他放在你面前，让他看着你。你笑，你说话，等他回应。

五，睡前。一个固定的、很短的小仪式：抱着，唱一首歌，说一句“晚安”。

这五个时间加起来，一天大概一个多小时。其实都是你本来就要做的事。

“给差异”的要点不是“多做”，而是“在做的时候是真的‘在’”。

“在”是什么意思？

是你换尿布的时候不看手机，看着他。

是你喂奶的时候不是一边刷视频一边机械地喂，而是偶尔低头看他的眼睛。

是你说话的时候不是对着空气，而是对着他，说给他听。

◆ 六、看显露：读懂孩子的“语言”

第二步，看显露。

新生儿没有话，可是他有一套“语言”。下面列几个最常见的。

孩子的信号	常见的意思	你可以试试
把头转向你的手，张嘴，嘴唇做吮吮的动作	饿了，早期的饥饿信号	喂奶

孩子的信号	常见的意思	你可以试试
把手放到嘴边，吮手	可能饿了，也可能是自我安抚	观察，如果还有别的饥饿信号，就喂
眼睛睁大，看着你，安静	醒着，想互动	面对面，说话，笑
把脸扭开，眼睛不看你，皱眉	刺激太多了，需要休息	停下来，安静地抱着
打哈欠，揉眼睛，眼神发呆	困了	把环境调安静，哄睡
身体绷紧，哭声尖，拱背，腿蜷起	可能肚子不舒服，胀气	竖着抱，拍嗝，轻揉腹部
哭声由小到大，一波一波	饿，或者累，或者不舒服	从最常见的开始排查

这张表只是起点。每个孩子都有自己的“方言”。

你会很快学会你孩子的方言。

有一个技巧：

观察比判断更重要。刚开始不要急着对号入座。每次孩子哭、笑、扭头的时候，多看两三秒，记在心里：他是在什么情况下发出这个信号的？

一个星期以后，你就会发现自己已经“懂”他了。

◆ 七、有一种“信号”，是在说：“够了”

这里要特别说一种信号，很多父母容易忽略。

第 11 章提到过，过度刺激，孩子会躲。

孩子的“够了”信号包括：把脸扭开，闭上眼睛，打哈欠，打嗝，身体发僵或者软下去，手指张开，皱眉，哭。

这些信号是孩子在说：我现在需要休息一下。

这个时候，如果大人还在不停地逗他，对着他笑，跟他说话，他会更烦躁。

正确的做法是：看到“够了”的信号就停。安静地抱着他，或者把他放下，让他歇一会儿。

等他再次睁大眼睛看你，才继续。

这个“跟着孩子的节奏”，是做妈妈最核心的本事之一。

◆ 八、稳环境：稳作息，稳照料者，稳自己

第三步，稳环境。

出生以后，“稳环境”有三层意思。

第一层，稳作息。

新生儿没有昼夜的概念。他们睡睡醒醒，每两三个小时一轮。不过从出生开始，你就可以慢慢帮他建立“白天”和“夜晚”的区别：

白天醒着的时候，保持光线明亮，家里有正常的声音，多说话，多玩。

晚上喂夜奶的时候，光线调暗，声音放轻，不逗他，不说太多话，喂完直接放回去。

这样几周到几个月之后，孩子的睡眠会慢慢集中到夜里。〔中：昼夜节律的建立，一般在出生后几周到几个月，个体差异大〕

第二层，稳照料者。

第 13 章讲了，主要照料者要相对固定。

出生后头几个月里，如果可能，让一两个人成为孩子的主要照料者，其他人做辅助。人太多、轮换太频繁，孩子就要不停地适应不同的人的节奏。

第三层，稳自己。

这是最容易被忽略、又最重要的一层。

新生儿对母亲的情绪很敏感。第 7 章和第 17 章讲过，母亲的状态会影响“来回”的质量。

所以你要照顾好自己：

睡眠。新生儿头几周会把你的睡眠切成碎片。一个重要的原则：孩子睡，你也睡。不要趁孩子睡的时候去做家务，把自己累垮。

吃饭。尤其是哺乳期，需要吃好，多喝水。

求助。你可以，也应该，让家人帮你。

情绪。如果持续情绪低落、焦虑，对孩子没有感觉，或者有伤害自己、伤害孩子的念头，请立刻告诉身边的人和医生。

这一点，第 26 章还会专门讲。

◆ 九、一天的来回：一份可以照抄的安排

新生儿的一天没有表可以照着走。

下面这张表只是一个“大概的样子”，让你心里有数。它是本书的示例，不是医学规定。〔解释：示例安排，个体差异大〕

时段	大概在做什么	可以放进去的“来回”
早上醒来	喂奶，换尿布	拉开窗帘，说一句“早上好”

时段	大概在做什么	可以放进去的“来回”
上午	睡一觉，醒一会儿	醒着时面对面三五分钟
中午	喂奶，小睡	洗澡或抚触，放这里或傍晚都行
下午	醒着的时间稍长	抱到窗边看看，唱一首歌
傍晚	容易闹，哭会多	竖着抱，慢慢走，不勉强玩
睡前	喂奶，换尿布	调暗灯，固定一句“晚安”
夜里	醒来吃奶	灯暗，话少，喂完放回

表里没有钟点，因为新生儿的钟不在墙上，在他自己身上。

一天里“醒着又安静”的时间，加起来常常只有一两个小时。〔中：新生儿清醒时间短，个体差异大〕

把这一两个小时用在面对面上，就够了。其余的时间，他睡，你也睡。

◆ 十、可以直接说出口的几句话

很多母亲不知道，对着一个不会回话的小人儿该说什么。下面几句可以直接用。

一，换尿布前：“来，换尿布了，抬一下腿。好了。”

二，他哭的时候：“我听到了。妈妈在。我们看看是什么。”

三，他把脸扭开的时候：“好，你歇一会儿。”

四，猜不中的时候：“这个不是。我们再试一个。”

五，他看着你吃奶的时候：“你看到我了，是不是？”

六，睡前：“今天结束了。晚安。”

说什么不重要。重要的是调子慢，声音柔，说完停一下，等他。〔中：对婴儿说话有助于他的注意和语言发展〕

◆ 十一、做不到的时候：降级版本

有的日子，你累到只想躺着。这时候不必做完整的三步法。

本书给你一个“最低版”，只有三条：

一，每天有一次真正的面对面，哪怕只有两分钟。

二，他哭的时候，先排查最常见的几样：饿，尿，困，胀气。

三，你撑不住了，就喊人。

降级不是失败。降级是你在保存体力。

一个星期里有几天只做最低版，仍然在“足够好”的范围里。〔解释：本书的立场，呼应第 13 章“足够好”〕

唯一不能降级的，是安全睡眠和不摇晃。这两条第 23 章会详细讲。〔强：儿科学共识〕

◆ 十二、哭了的时候：一张排查小卡

下面这张表可以拍下来放在手机里。夜里半睡半醒的时候，看一眼就够了。

先看	怎么办
饿	有早期信号就喂，不等他哭到嗓子尖
尿布	湿了或脏了就换
困	打哈欠，揉眼睛，就把环境调安静

先看	怎么办
胀气	竖着抱，拍嗝，轻揉肚子
冷热	摸一摸后颈，比你的手稍暖就行，不要捂
太吵太亮	换到暗一点、安静的房间
想要抱	抱起来，让他贴着你

这张卡是“从最常见的开始”的意思。〔解释：本书的排查顺序〕

还有一盏“红灯”：发烧，呕吐，拒奶，精神很差，呼吸不对。出现任何一样，请马上就医，不要当成普通的哭。〔核：参考儿科常规建议，以医生为准〕

◆ 十三、头两周，家里先备好这几样

稳环境，从屋子开始。下面几样够用了，不需要买一大堆。

一，一张平坦结实的小床，放在你的房间里。〔强：安全睡眠建议，第 23 章详述〕

二，几套松软的衣服，几块尿布，一包湿巾。

三，一盏可以调暗的小灯，夜里喂奶用。

四，一个你坐着舒服的喂奶位置，旁边放水和吃的。

五，儿保门诊和急救电话，写在冰箱上。〔解释：本书的建议，半夜慌的时候用得上〕

六，大人抱孩子之前先洗手，生病的人先不要靠近。〔强：手卫生是预防感染的基本办法〕

◆ 十四、第十天夜里的一张纸条

孩子出生后第十天，奶奶从老家赶来帮忙。

奶奶有一个习惯：孩子夜里一哼，她就起来抱。

苏晴躺在隔壁，听见动静就睡不着。三个晚上下来，她的眼睛红得像兔子。

第四天，江远在冰箱上贴了一张纸：

“晚上 11 点到 3 点，江远。3 点到 7 点，苏晴。白天孩子醒着，奶奶看，苏晴补觉。”

奶奶看了一眼，说：“我来就是帮你们的，晚上我也能起。”

江远说：“妈，白天带他才是大头。晚上让我们自己来，您养好精神。”

奶奶没再说话，把纸条用磁铁压平了。

那天夜里，苏晴睡了整整一段，四个小时，没有被打断。

早上醒来，她坐在床边哭了一会儿。不是难过，是缓过来了。

这件事的道理很简单：分工不是客气，是安排。

每个人都有一段不被打断的睡眠，整个家才撑得住。〔中：睡眠长期被打断，与产后情绪问题相关〕

◆ 十五、常见的几个问题

问：我总是猜不对，是不是我不适合当妈妈？

答：不是。猜不对是所有新手父母的日常，本章前面已经讲过。可以按顺序排查：饿，尿，困，胀气，太吵太亮，想要抱。每试一样，等一两分钟再

看，不要几样同时上。试了一圈都不对，就抱着他，陪他。〔解释：本书的排查顺序，常见原因在前〕

问：夜里到底谁起来？

答：要喂母乳的话，通常要妈妈起来。可是换尿布，把孩子抱来，喂完拍嗝再哄回去，这些可以分给另一个人。用奶瓶的家庭可以两个人轮班。目标只有一个：让每个大人都有一段不被打断的睡眠。

问：月子里怎么分工？

答：妈妈的活只有三样：喂，睡，恢复。做饭，洗衣，收拾，接待客人，交给别人。来看孩子的亲友可以挡一挡，约在满月以后也不迟。要不要开窗，洗不洗头这类老规矩，请问你的医生或护士，不必全凭一句“老人说”。

〔核：产后护理的具体做法，以产科医生和护士的建议为准〕

问：他一放下就哭，一抱就好，是不是被我惯的？

答：不是。新生儿刚从子宫出来，离开怀抱本来就不适应。这个阶段抱，没有“宠坏”这一说。第 23 章会讲这件事的证据。〔中：头几个月对哭泣的回应，与后来的安全依恋相关〕

问：家里人的意见不一样，我听谁的？

答：先在两件事上守住底线：安全睡眠，不摇晃。这两条没有商量的余地。〔强：儿科学共识〕其他的事可以让一让。你说“医生是这样说的”，比说“我觉得”更容易被接受。

问：新生儿是按时间喂，还是他要就喂？

答：头几周，多数指南建议看信号喂，也就是他表现出饿了就喂。〔中：新生儿胃小，常需要频繁喂养，个体差异大〕如果他睡得太久，一直不醒，或者尿布明显变少，请联系儿保医生。〔核：以医生建议为准〕

问：他一到傍晚就闹，是我哪里没做好吗？

答：不是。很多孩子傍晚哭得最多。〔强：婴儿哭泣在傍晚和晚上集中，第 23 章会细讲〕这时候不用硬找原因。竖着抱，慢慢走，放轻声音，等这一阵过去。

问：亲友想来看孩子，能让他们抱吗？

答：可以，但有条件：先洗手，生病的人不来，不要亲孩子的脸和手。新生儿的抵抗力还弱。〔中：预防感染的常见建议〕你有权说“这两周先不接待”。这不是失礼，是保护。

问：我夜里喂奶，忍不住看手机，怎么办？

答：不用自责，夜里确实无聊。办法是把手机放远一点。白天面对面的时候不看。夜里可以看，不过隔一会儿低头看看他的脸。〔解释：本书的折中做法〕

问：我对孩子好像没什么感觉，正常吗？

答：头几天到两周，情绪起伏很大是常见的，常被叫做“产后忧郁”，多数会自己好转。〔中：产科常见现象，天数个体不同〕如果超过两周还没有好转，或者有伤害自己、伤害孩子的念头，请告诉医生。〔强：精神卫生指南的一致建议〕这不是你不爱他，是身体和心理都在恢复。

◆ 十六、放回日子里

出生后的第二周，苏晴开始试着“读”孩子。

有一天下午，孩子醒着。她把他放在腿上，面对着自己，看着他。

孩子也看着她。

她轻轻地笑了一下，说：“嗨。”

孩子的嘴动了动，眼睛睁得更大。

她又说：“嗨，你好呀。”

孩子把手从襁褓里挣了出来，在空中抓了一下。

她把一根手指伸过去，他握住了。

两个人就这样，一个看着一个，大概三四分钟。

然后孩子把头扭开，眼睛看向旁边，打了一个哈欠。

她没有再逗他，把他抱在怀里，轻轻地晃。

不一会儿，孩子睡着了。

整个过程，四个步骤她都做了：看到信号，猜，做，再看。

她没有意识到这就是“三步法”。她只是在和孩子在一起。

带走的话

出生以后，三步没变：给差异，看显露，稳环境。回应是四个动作：看，猜，做，再看。猜错是常事。猜错了不走开，才是关键。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
敏感回应包括注意、读懂、及时、合适四个环节	〔强〕	安斯沃思的敏感性概念，第 13 章已讲
母婴“没对上一修复”是常态	〔中〕	特罗尼克的研究，第 11 章已讲，数字待核
过度刺激时婴儿会通过回避、扭头等表示“够了”	〔中〕	观察研究和临床经验
面对面互动对婴儿语言和社会发展有益	〔中〕	第 12 章已讲
白天明亮、夜里昏暗，有助昼夜节律建立	〔中〕	个体差异大
三步法的出生后版本、“看、猜、做、再看”	〔解释〕	本书的方法论概括
手卫生和少接触病人可预防感染	〔强〕	基本卫生常识
家里备物清单、排查小卡、夜里看手机的折中做法	〔解释〕	本书的建议
发烧、呕吐、拒奶、精神差、呼吸不对要就医	〔核〕	以儿科医生建议为准
新生儿常需频繁喂养，宜看信号喂	〔中〕	个体差异大，以医生建议为准
傍晚哭得多是常见现象	〔强〕	第 23 章详述
新生儿抵抗力弱，访客先洗手	〔中〕	预防感染的常见建议
一天的来回示例安排	〔解释〕	本书示例，不是医学规定
新生儿清醒时间短，个体差异大	〔中〕	发育观察共识
对婴儿说话有助于注意和语言发展	〔中〕	观察研究，第 12 章已讲
最低版三条、排查顺序	〔解释〕	本书的方法概括

说法	证据级别	说明
安全睡眠和不摇晃不能降级	〔强〕	儿科学共识，第 23 章详述
睡眠长期被打断与产后情绪问题相关	〔中〕	观察研究
产后头几天到两周情绪起伏常见	〔中〕	天数个体不同
产后护理的具体做法听医生护士的建议	〔核〕	以当地医疗建议为准
超过两周未好转或有伤害念头需告知医生	〔强〕	精神卫生指南共识

个体情况，比如喂养困难、黄疸、持续哭闹、体重增长不足，请咨询儿科医生。

第 23 章

0 到 6 个月：抱，喂，哄，和第一个微笑

◆ 一、第六周的哭

孩子六周大的那个星期，是苏晴最难熬的一个星期。

他每天傍晚准时开始哭。不是饿，不是尿，不是胀气。抱起来也不行，喂奶也不行。他就是哭，哭得小脸通红，一哭就是两三个小时。

江远下班回来，看见苏晴抱着孩子坐在沙发上，眼睛是肿的。

“他怎么了？”

“不知道。”苏晴说，“我什么都试过了。”

江远接过孩子，在屋里来回走。孩子还在哭。

那天晚上两个人没吃饭。十点以后，孩子哭累了，睡着了。苏晴靠在江远肩上，说：“我是不是个很差的妈妈？”

江远说：“医生不是说了吗，这个月份的孩子就是这样。”

他说得对。这一章就从这件事讲起：0 到 6 个月是什么样子，你可以做什么，哪些事不必做。

◆ 二、这六个月，孩子在做什么

先看一张大致的地图。

月龄	孩子常见的样子
0 到 1 个月	大部分时间在睡，醒着时盯着近处的脸，对声音有反应，哭是主要的“语言”
1 到 2 个月	开始出现社交性的微笑，一般在六到八周前后，会发出“啊”“哦”的声音
3 到 4 个月	笑出声，咕咕地“聊天”，头能抬起来，会盯着自己的手看
5 到 6 个月	开始翻身，伸手够东西，放进嘴里，认得熟悉的人，对陌生人开始有不同反应

这张表里的月龄是“常见范围”，不是“考试线”。有的孩子早两周，有的晚两周，都是正常的。〔中：参考世界卫生组织和美国疾控中心的发育里程碑，个体差异大〕

这里面，最让母亲们难忘的是第一个社交性的微笑。

那是孩子第一次不是因为胀气或者睡着时的偶然，而是真的看着你，对你笑。

这是孩子“来回”的一个重要里程碑：他开始主动对人发出信号。

◆ 三、抱：抱多了，不会宠坏

先说一个几乎每个新手家庭都会遇到的争论。

奶奶说：“别老抱着，抱惯了就放不下了。”

妈妈说：“他才几周大，哭了不抱，不是太可怜了吗？”

这件事，证据是比较清楚的。

第 10 章讲过，在婴儿期，对哭泣的敏感回应和后来的安全依恋有关联。没有证据表明，头六个月抱得多会让孩子变得“难带”或者“依赖”。〔中：证据主要来自观察研究，因果关系不易证明〕

反过来，有一项很有意思的研究：在一些传统社会里，婴儿大部分时间被抱着或者背着，哭得反而更少。〔中：有人类学观察，也有对此的争议，不同文化的比较，很难控制别的因素〕

一个孩子在一个全新的世界里，最需要的是这个世界可靠。抱是最直接的证明。

所以本书的建议是：

头六个月，想抱就抱。孩子哭，就去看。你不需要担心“宠坏”。

当然，你也不需要一直抱着。你累了，可以把孩子放在安全的婴儿床里，休息一会儿。你需要吃饭，上厕所，洗澡。这不是对孩子的“抛弃”。

◆ 四、哭：它有高峰，也有出口

现在讲哭。

婴儿的哭有一个很有规律的特点：

大多数孩子从出生后两周左右，哭得越来越多，到六到八周达到高峰，然后慢慢减少，到三到四个月明显下降。〔强：多项研究的一致发现，美国学者巴尔等人对此做过系统研究〕

在高峰期，一天哭两三个小时是常见的。哭常常集中在傍晚和晚上。有的时候，无论你怎么哄都不管用。这种哭有时被叫做“难以安抚的哭”。

研究者用“紫色哭泣”这个说法来概括这个阶段的特点。〔核：Period of PURPLE Crying，是一个儿童虐待预防教育项目的名称，每个字母代表一个特点，包括：哭的高峰，难以安抚，突然开始、突然停止，等等〕

这个认识对母亲很重要。

它告诉你：孩子在六周时哭得最凶，不是你做错了什么，也不是孩子“有问题”。这是一个常见的、会过去的阶段。

不过有一个很重要的提醒：

如果孩子的哭伴随着发烧、呕吐、拒奶、精神很差、呼吸不对，或者哭声特别尖、和平时明显不同，要马上就医，不要当成“正常的哭”。

那么在“正常的哭”面前，你可以做什么？

有一套被很多儿科医生推荐的安抚办法，叫“五个 S”，由美国儿科医生卡普提出。〔中：这套方法，在临床上，被广泛使用，直接的研究证据，有限，需要更多研究〕

第一，襁褓。用包被把孩子包起来，模拟子宫里的紧致感。注意要包得紧紧合适，髋关节要能自由活动，孩子会翻身了就不要再包。

第二，侧卧或者趴着。只能在你抱着他、看着他的时候。绝对不要让孩子侧卧或者俯卧着睡觉。

第三，嘘声。在他耳边发出“嘘——”的声音，要比他的哭声大一点，再慢慢降下来。这个声音像子宫里的血流声。

第四，摇晃。轻轻地，小幅度地，有节奏地摇。不是剧烈地摇。

第五，吸吮。给他一个安抚奶嘴，或者让他吃手指。

这几样其实就是把子宫里的东西还给他：包着，有声音，有节奏，有吸吮。

这个思路和本书第 9 章是一样的。

◆ 五、最重要的一条：绝对不要摇晃婴儿

说到哭，必须说一条生死攸关的事。

绝对不要剧烈地摇晃婴儿。

婴儿的脖子很软，头相对很重。剧烈的摇晃会让大脑在头骨里来回撞击，造成颅内出血、视网膜出血、严重的脑损伤，甚至死亡。这种情况叫“婴儿摇晃综合征”，或者“虐待性头部创伤”。〔强：这是儿科学的明确结论，婴儿哭得最凶的六到八周，也是这类事件发生率最高的时候〕

绝大多数的父母不是故意伤害孩子。他们是在很累、很崩溃、孩子怎么也哄不好的时候，一时失控。

所以请你现在就和你的家人说好一条规则：

当你觉得自己快撑不住的时候，把孩子放到安全的婴儿床里，放平，仰卧，然后走出房间，到另一个房间待几分钟。深呼吸，喝一杯水，给家人或者朋友打个电话。

孩子哭几分钟没有关系，他不会受伤。可是你在崩溃的时候抱着他，就有风险。

这条规则是在保护孩子，也是在保护你。

如果你有时会有“想伤害孩子”的念头，请不要羞愧，也不要一个人扛。告诉你信任的人和医生。这是需要帮助的信号，不是你是个“坏妈妈”的证据。

◆ 六、喂：母乳，还是奶瓶

接下来讲喂养。

世界卫生组织建议前六个月纯母乳喂养，六个月后在添加辅食的同时继续母乳喂养，到两岁或更久。〔强：WHO 的长期建议，有大量证据支持母乳对婴儿和母亲健康的益处〕

可是现实里有各种原因：母亲生病，奶量不足，需要上班，婴儿有特殊情况。很多家庭需要配方奶，或者混合喂养。

本书的立场很清楚：

母乳对健康有益，这是事实。可是“喂养方式”不是“爱”的成绩单。

用奶瓶喂奶的母亲和母乳喂养的母亲一样，可以给孩子“足够好的回应”。

因为对本书来说，重要的不是“奶”，而是“喂奶的时候发生了什么”。

一个抱着孩子、看着他、和他说话、跟着他的节奏喂奶瓶的妈妈，比一个一边看手机一边塞奶嘴的母乳妈妈，给孩子的“来回”要多得多。

所以无论哪种方式：

抱着，让孩子看得到你的脸。

跟着他的节奏。他吸，你给；他停，你停。

奶瓶喂养有一个技巧，叫“节奏式喂养”：让奶瓶保持较水平的角度，让孩子自己控制吸奶的速度，每吸几口就停一下，让他休息。这样更像母乳喂养，也不容易吃得太快、太多。〔中：有些指南推荐，直接的证据有限〕

如果你母乳喂养遇到困难，比如疼痛、奶不够，请不要一个人硬撑。找哺乳顾问，或者医生。

如果最后你选择了配方奶，请不要内疚。

◆ 七、睡：安全，是第一位的

再讲睡。

新生儿一天要睡十六到十八个小时，分成很多段。〔中：个体差异大〕

关于睡眠，有几条和孩子的生命有关，必须记住。这些是美国儿科学会在 2022 年更新的安全睡眠建议，也是世界上很多国家的共识：

一，让孩子仰卧着睡，每一次都是，包括午睡。〔强〕

二，睡在一个平坦的、结实的床垫上，床上不放枕头、被子、毛绒玩具、护栏垫。〔强〕

三，孩子最好和父母睡在同一个房间，但不是同一张床。建议至少头六个月，最好到一岁。〔强：同室不同床，可以降低婴儿猝死的风险〕

四，不要在沙发上、扶手椅上抱着孩子睡觉。因为你睡着了，孩子有窒息的风险。〔强〕

五，避免孩子过热。穿得比你稍微少一点。〔强〕

六，如果要和孩子在一起，就不吸烟，不饮酒，不吃让人嗜睡的药。
〔强〕

这几条看起来简单，做到却很不容易。因为累了抱着孩子在沙发上睡着，是很常见的事。

所以在你特别累的时候，宁可把孩子放回他的小床，也不要抱着睡着。

关于“睡整夜”：

很多家庭被“三个月要睡整夜”的说法所困扰。其实大多数孩子在六个月以前，夜里都要醒来吃奶。这是正常的，因为他的胃很小，需要常常吃。

〔中：个体差异很大〕

不要因为别人家的孩子睡得比你家好而焦虑。

◆ 八、安全睡眠检查表：睡前扫一眼

下面这张表可以打印出来，贴在婴儿床边。每次放孩子睡之前，扫一眼。

检查项	做到了吗
仰卧，包括午睡	
床垫平坦结实，床单拉紧	
床里没有枕头，被子，毛绒玩具，护栏垫	
孩子睡在你房间的小床里，不在你的床上	
房间不过热，孩子没有穿得太多	
孩子身边没有人吸烟	
你不是在沙发或扶手椅上抱着他睡着	

这几条来自美国儿科学会的安全睡眠建议。〔强：AAP 2022 年更新建议，请以最新版本为准〕

市面上有一些号称“帮助睡眠”的产品，比如侧睡枕、定型枕。儿科学会不建议使用。〔核：AAP 的安全睡眠建议，大意如此〕

孩子在汽车安全座椅里睡着了，到家以后把他抱出来，放到平坦的床上。
〔核：AAP 建议，不让孩子长时间睡在座椅里〕

这些事不能降级。累的时候，宁可少做别的。

◆ 九、玩：很简单的四件事

六个月以前的孩子不需要复杂的“玩”。

下面是四件很简单、也很有效的事：

第一，面对面，说话和笑。

你说一句，停一下，等他回应。他发出一个声音，你也学他发一个。这个“你一句，我一句”，是孩子最早的“话轮”。

第二，唱歌。

不需要唱得好。可以唱孕期你唱过的那首歌。出生以后，孩子对它可能更熟悉。〔中：第 6 章讲过〕

第三，抚触。

给孩子洗完澡以后，用温和的婴儿油，轻轻地抚摸他的手臂、腿、背。边摸边说话。研究发现，对早产儿，抚触有助于体重增长，对足月儿的益处不太明确。〔中：Cochrane 综述等〕

可是即使没有“疗效”，这也是一个很好的亲子“来回”的时间。

第四，趴着玩。

在孩子醒着、旁边有人看护的时候，让他趴在垫子上，每天从几分钟开始累积。这有助于他练习抬头和肩部的力量。〔核：美国儿科学会建议，大意如此〕

注意，一定是醒着、有人看着的时候。睡着时不要趴。

这四件事不需要买任何东西。

◆ 十、各月龄“可以玩什么”

下面这张表给你一点具体的想法。没有一样需要花钱。

月龄	可以玩	你做什么
0 到 1 个月	近处看你的脸，听你说话，轻轻抚触	靠近，慢慢说
1 到 2 个月	学他发出的声音，让他的眼睛追着一件慢慢移动的东西	说一句，停一下
3 到 4 个月	趴着玩，抓握摇铃，照镜子	在旁边看着，夸他
5 到 6 个月	够东西，换手，摇响，用手帕轻轻盖住你的脸再拿开	把东西放在他够得着的地方

〔中：参考世界卫生组织和美国疾控中心的发育里程碑，个体差异大〕

玩具要大到不能整个塞进嘴里，不能有会掉下来的小零件。〔强：婴幼儿窒息的常见预防原则〕

孩子对一样东西玩腻了，就换另一样。他不需要一次拥有很多。

◆ 十一、一天的来回：4个月左右的样子

这个月龄的孩子，白天开始有几段比较规律的醒和睡。下面是一个示例。

〔解释：本书示例，个体差异大〕

时段	大概在做什么	放进去的“来回”
早上	醒来，喂奶	拉开窗帘，说早上好
上午	玩一会儿，睡一觉	趴着玩几分钟，面对面聊天
中午前后	喂奶，小睡	洗澡，抚触
下午	醒着的时间变长	出门透透气，唱歌

时段	大概在做什么	放进去的“来回”
傍晚	可能还会闹	抱着慢慢走，不勉强玩
晚上	洗澡，喂奶	调暗灯，固定一句“晚安”

傍晚闹的孩子，到三四个月会明显好一些。这一点前面讲过。

◆ 十二、做不到的时候：降级版本

这六个月，你大概率会有几天什么都做不动。下面是“最低版”：

一，每次喂奶，抬头看他三次眼睛，对他说一句话。

二，每天趴着玩两分钟，你在旁边。

三，睡前扫一眼检查表。

四，哭到撑不住，就放下，走开，找人。

别的都可以放。玩具，早教，拍照，发朋友圈，全都可以放。

唯一不降的，是安全睡眠和不摇晃。

◆ 十三、周女士的那个傍晚

那个哭了三个小时的晚上过去以后，第二天，苏晴在小区里碰到了周女士。

周女士住楼上，有一个两岁的女儿。她看苏晴的脸色，就知道发生了什么。

“昨天晚上？”她问。

苏晴点点头，眼眶又红了。

周女士说：“我家那个也这样。我那时候，半夜躲在厕所里哭。”

苏晴愣了一下。她一直以为只有自己这样。

周女士接着说：“后来我学了一招。他一闹，我就交给孩子爸，自己下楼走二十分钟。回来再接。”

“他不会有事吗？”

“哭几分钟，孩子不会怎么样。你在崩溃的时候一直抱着，反而更不好。”

那天傍晚，苏晴照做了。她把孩子交给江远，下楼绕着小区走了一圈。

风很凉。她走到第二圈的时候，忽然发现自己的肩膀松下来了。

她回到家，孩子还在哭。她接过来，抱着，轻轻地晃。

这一次，她没有那么慌。

这件事想说的是：听到有人说“我也这样”，本身就是一种安抚。

而且“交出去，走开一会儿”，是一个正当的办法。它不是逃跑。〔强：哭到撑不住时放下孩子、走开几分钟，是预防摇晃伤害的核心建议〕

如果你走开以后，心情还是很差，一连几天都这样，请告诉医生。

◆ 十四、常见的几个问题

问：母乳不够怎么办？

答：很多母亲觉得自己奶不够，其实孩子可能吃得够。可以看几样：尿布够湿，吃完能安静一会儿，体重按儿保医生看的曲线在长。〔中：喂养评估常用的指标，具体数字请听儿保医生〕拿不准的时候，先找哺乳顾问或儿保医

生，不要急着自己断掉母乳。〔核：以医生评估为准〕如果最后加了配方奶，也不是失败。

问：要不要训练他睡整夜？

答：六个月以前，本书不建议做任何“让他哭到睡着”的训练。〔有争议：各种睡眠训练方法的长期影响，研究有限，专家意见不一〕小婴儿夜里醒来吃奶是正常的。六个月以后，如果全家的睡眠真的撑不住了，请和儿保医生一起挑办法。

问：奶睡，抱睡，会不会养成坏习惯？

答：这两样都很常见。目前没有可靠的证据说明它们会长期伤害孩子。〔中：观察研究，证据有限〕有一条不能让：不要抱着他在沙发或扶手椅上睡着。〔强〕孩子睡熟以后，把他放回小床，仰卧。想慢慢改，可以从“困了但还醒着”的时候放下开始，不用一次到位。〔解释：本书的温和做法〕

问：安抚奶嘴能用吗？

答：可以用，不是必须用。有指南认为，睡觉时给安抚奶嘴，可能降低婴儿猝死的风险。〔中：AAP 建议提到，机制和证据强度仍有讨论〕母乳喂养的孩子，一般等哺乳顺利了再给。〔核：以最新指南为准〕孩子不要，就不要勉强。睡着以后奶嘴掉了，不用再塞回去。〔核〕

问：黑白卡要不要买？

答：新生儿的视力还很弱，对黑白或对比强的图案更容易有反应。〔中：视觉发育常识，个体差异大〕买不买都可以。他一出生就爱看像人脸的图案，所以最好的“卡”是你的脸。〔中：新生儿偏好类似人脸的图案，有研究支持，细节待核〕

问：黄疸，湿疹，可以自己处理吗？

答：这两样请问医生，不要自己试偏方。新生儿黄疸很常见，多数是轻的。〔强：儿科常识〕如果皮肤和眼白黄得明显，一直黄到手脚，或者孩子吃奶差，精神差，要尽快去医院。〔核：以儿科医生建议为准〕湿疹常见，皮肤干，发红，发痒。怎么保湿，要不要用药，请听医生的。〔核〕

问：吐奶，打嗝要紧吗？

答：吐奶很常见，多数孩子长大一些会自己好。〔中：婴儿期常见现象，个体差异大〕喂完竖着抱一会儿，有的孩子会舒服些。〔解释〕如果吐得像喷出去，吐出绿色或带血的东西，或者体重不长，请马上看医生。〔核：以儿科医生建议为准〕

◆ 十五、什么时候，需要看医生

最后讲一讲需要留意的几个信号。

发育有早有晚，不需要为一点点差异焦虑。可是如果出现下面这些情况，建议尽早去看儿童保健科：

两个月，对大的声音没有反应，眼睛不追着人看。

四个月，还是不对人笑，不发出声音，不追视。

六个月，不会伸手够东西，不会发出咿咿呀呀的声音，对人没有任何互动的反应。

任何时候，已经掌握的能力出现倒退，比如原来会笑，现在不笑了。

〔核：参考美国疾控中心和美国儿科学会的发育监测建议，大意如此，请以最新的版本为准〕

早发现，早评估，早支持。这不是“贴标签”。这和第 16 章是一个道理：找到最适合他的通道。

◆ 十六、放回日子里

孩子快满四个月了。

一天早上，苏晴把他放在床上，自己躺在旁边，面对着他。

他看着她，她也看着他。

她说：“你今天睡得好不好？”

他看着她的嘴。嘴动着，他也把嘴动了动。

“啊——”她拉长了声音。

他也“啊——”了一声，很短，很轻。

她笑了。他也咧开嘴笑了。

两个人对着笑了很久。

那天江远下班回来，苏晴把手机递给他。里面有一段她拍的视频，很短，只有二十秒。

江远看了三遍。

他说：“他在跟你说话。”

苏晴说：“嗯。我也这么觉得。”

在这个早晨，没有玩具，没有音乐，没有任何所谓“早教”。

只有两个人，一个看着一个，你一声，我一声。

这就是 0 到 6 个月所有的“课程”。

带走的话

头六个月，抱，没有错；哭，有高峰；喂养方式，不是爱的成绩单。孩子哭到你撑不住的时候，把他放到安全的小床，走开几分钟。绝不摇晃。面对面，你一声，我一声，就是最好的课程。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
社交性微笑一般在 6—8 周出现	〔中〕	发育里程碑，个体差异大
头六个月抱得多不会宠坏	〔中〕	观察研究为主
哭的高峰在 6—8 周，之后下降	〔强〕	巴尔等多项研究一致
紫色哭泣概念	〔核〕	虐待性头部创伤预防项目，细节待核
“五个 S”安抚法	〔中〕	临床广泛使用，直接研究证据有限
绝对不能摇晃婴儿	〔强〕	儿科学明确结论
WHO 建议前 6 个月纯母乳	〔强〕	长期建议
节奏式奶瓶喂养	〔中〕	部分指南推荐，直接证据有限
安全睡眠六条（仰卧、平硬床面、同室不同床等）	〔强〕	AAP 2022 更新建议，请以最新为准
抚触对早产儿体重增长有帮助，对足月儿益处不明确	〔中〕	Cochrane 综述等
清醒时有人看护的趴卧练习	〔核〕	AAP 建议，大意
发育里程碑警示信号	〔核〕	参考美国疾控中心、AAP，以最新版本为准

说法	证据级别	说明
安全睡眠检查表七项	〔强〕	AAP 2022 更新建议，请以最新为准
侧睡枕、定型枕等产品不建议使用	〔核〕	AAP 安全睡眠建议，大意如此
不让孩子长时间睡在汽车安全座椅里	〔核〕	AAP 建议，大意如此
各月龄“可以玩什么”	〔中〕	参考发育里程碑，个体差异大
玩具不可整个塞进嘴，不留易脱落小零件	〔强〕	婴幼儿窒息预防的常见原则
4 个月左右的一天示例、降级版本	〔解释〕	本书示例，个体差异大
哭到撑不住时放下孩子、走开几分钟	〔强〕	预防摇晃伤害的核心建议
母乳是否足够可看尿布、满足感、体重曲线	〔中〕	具体数字听儿保医生
母乳困难时先找哺乳顾问或医生	〔核〕	以医生评估为准
六个月以前不做“哭到睡着”式训练；各种睡眠训练长期影响不明	〔有争议〕	研究有限，专家意见不一
奶睡、抱睡没有可靠证据显示长期伤害	〔中〕	观察研究，证据有限
睡觉时用安抚奶嘴可能降低猝死风险	〔中〕	AAP 建议提到，证据强度仍有讨论
哺乳顺利后再给奶嘴，睡着后掉了不必塞回	〔核〕	以最新指南为准
新生儿对黑白、对比强的图案反应更明显	〔中〕	视觉发育常识
新生儿偏好类似人脸的图案	〔中〕	有研究支持，细节待核
新生儿黄疸常见，多数较轻	〔强〕	儿科常识
黄疸明显、扩散到手脚、吃奶差精神差需就医	〔核〕	以儿科医生建议为准
湿疹的保湿与用药问医生	〔核〕	以医生建议为准
婴儿吐奶常见，喷射状、绿色、带血或体重不长需就医	〔核〕	以儿科医生建议为准

个体情况，比如喂养困难、持续哭闹、发热、发育落后，请咨询儿科医生或儿童保健科。

第 24 章

6 到 12 个月：爬出去，又回头看你一眼

◆ 一、一个爬远了的孩子

孩子八个月的时候学会了爬。

苏晴发现，家里一下子变大了。他爬到沙发脚，爬到电视柜，爬到垃圾桶旁边，每一处都要摸，要啃，要拍。

有一天她在厨房，听见客厅没了声音。她探出头，看见孩子爬到了客厅另一头，正对着一盆绿萝伸出手。

他没有碰。他回过头，看了她一眼。

她说：“那个不能碰。”

他看着她，手停在半空。过了一会儿，他把手收回去，转身爬向了别处。

她站在厨房门口，愣了一下。

这个“回头看一眼”，是这个月龄最重要的一件事。这一章就从这里讲起。

◆ 二、这半年，孩子在做什么

先看大致的地图。

月龄	孩子常见的样子
6 到 7 个月	坐起来，换手拿东西，咿咿呀呀，对自己的名字有反应
8 到 9 个月	爬行，认生，对和熟人分开会哭，开始玩躲猫猫

月龄	孩子常见的样子
10 到 11 个月	扶着站，用手指指东西，挥手“再见”，听得懂几个简单的词
12 个月前后	可能走第一步，说出第一个有意义的词，用手指，让你看他看的東西

同样，月龄是常见范围，不是考试线。会爬的时间，早的有六个月，晚的有十一个月，也有孩子跳过爬直接走，这都在正常范围里。〔中：参考世界卫生组织的运动发育里程碑研究，个体差异大〕

这半年有三件事值得特别讲：

一，孩子学会了“回头看”。

二，孩子学会了“指”。

三，孩子开始“认生”和“怕分开”。

◆ 三、“回头看”：安全基地

先讲第一件。

孩子爬出去，回头看你，这件事有一个名字，叫“社会性参照”。

意思是：遇到不确定的东西，他会看你的脸，看你的表情，来决定下一步怎么办。

有一个很有名的实验，叫“视觉悬崖”。研究者做了一个看起来像悬崖的玻璃平台，让十一个月左右的孩子爬过去。孩子爬到“悬崖”边，停下来，不敢过。妈妈站在另一头。

如果母亲脸上是害怕或者生气的表情，孩子大多数不敢爬。如果母亲脸上是微笑、鼓励的表情，一部分孩子会慢慢爬过去。〔中：索尔斯比等人，1980 年代的实验，结果有一定的重复，样本不大，具体比例待核〕

这个实验说明什么？

孩子在探索世界的时候，把你当成了“安全基地”。他往外走，是因为知道回头你在。

第 13 章讲过，这就是“安全型依恋”的表现。

所以在这个月龄，做妈妈的一件重要的事是：做那个他一回头就能看到的人。

具体的做法：

一，孩子爬出去的时候，不必一直跟在后面，但要在他能看到你的地方。

二，他回头看你，给他一个回应：点头，微笑，说一句“我在这儿”。

三，如果他碰到了不安全的东西，不要大声尖叫吓他，而是走过去，用平稳的声音说：“那个不能碰，来，我们玩这个。”

四，把家里布置得足够安全：插座加盖，药品、清洁剂放高处，尖锐的东西收起来。这样你就不用每次都说“不”。

最后一条很重要。

一个“到处都是危险”的家，会让妈妈一整天都在说“不能”“别动”。孩子会很烦，你也会很累。

先让环境变得“可以探索”，再谈“跟着他看”。

◆ 四、家里的安全布置清单

前面说，先让环境变得“可以探索”。具体怎么布置，可以照下面这张表，一个房间一个房间地做。

地方	要做的事
客厅	家具的尖角加护角，电线收好，电视柜和大件家具固定防倾倒，插座加盖
厨房	刀具，清洁剂，热锅放高处，锅柄朝内，门口装一道围栏
浴室	浴缸不留水，用完马上放掉，药品和洗剂锁起来
楼梯和窗	楼梯口装护栏，窗户装限位器，窗边不放椅子和凳子
卧室	婴儿床里仍然只有床垫，高的柜子固定在墙上
小物件	纽扣电池，硬币，磁珠，小零件，塑料袋，收到他够不着的地方

跌落，烫伤，溺水，吞下异物，是婴幼儿意外伤害的常见原因。〔强：儿科和安全机构一致提醒〕

纽扣电池和磁珠，一旦吞下去，要马上去医院，不要等。〔强：儿科急诊的共识〕

孩子在水边，哪怕水很浅，大人也不能离开视线。〔强：溺水预防的基本原则〕

有一个很好用的办法：趴到地上，从孩子的高度看一遍屋子。你会发现很多平时看不到的东西。〔解释：本书的建议〕

一次做不完也没关系。每周挑一个房间，一个月就做完了。

◆ 五、“指”：语言的第一步

第二件事是“指”。

第 12 章讲过，一岁左右孩子的指是一个重要的里程碑。

指有两种：

一种叫“要求式的指”：指着他要的东西，意思是“给我”。

另一种叫“分享式的指”：指着一只飞过的小鸟，然后看着你。他不是要这只鸟，他是要你看到。〔中：这个区分，来自发展心理学的研究，托马塞洛等人，对此有大量讨论〕

第二种更重要。因为它说明孩子开始明白：我看到的你也可以看到，我想让你和我看同一个东西。

这是语言的根，也是社交的根。

你可以这样回应他的“指”：

顺着他的手指看过去，说出那个东西的名字，再加一点点：“哦，小鸟。小鸟飞走了。”

一个很简单的原则：他指，你看，你说。

◆ 六、认生，和怕分开

第三件事是最让父母头疼的：认生。

八九个月，孩子忽然开始怕陌生人。昨天还让邻居阿姨抱，今天一见就哭。你一离开视线，他就大哭。

很多父母觉得孩子变得“黏人”，是不是惯坏了？

不是。

这是孩子认知发展的一个标志：他已经能区分“熟悉的人”和“陌生的人”，也开始明白“你不在我眼前，不等于你不存在”。可是他还不知道你什么时候回来。

这种状态常常在九个月到十八个月之间最强，然后慢慢缓解。〔中：分离焦虑，在这个年龄段，是普遍的发展现象〕

怎么帮他？

第一，和他告别，不要偷偷溜走。

很多父母怕孩子哭，就趁他不注意偷偷离开。这样做会让孩子更没有安全感，他不知道你什么时候会“消失”。

更好的做法是明明白白地说：“妈妈去上班，晚上回来。”亲一下，抱一下，然后走。孩子可能会哭，可是他学到的是：妈妈走，是会回来的。

第二，告别的仪式要短、要固定。

固定的几句话，固定的一个动作，比如击一下掌。不要来回反复，不要磨蹭，越磨蹭越难。

第三，你回来，要让他看到。

回来时蹲下来，抱抱他，说：“我回来了。”

第四，玩“躲猫猫”。

这是一个很古老，也很有意义的游戏。你用手捂住脸，又拿开，说“咦——”，孩子会笑。

躲猫猫在“教”什么？它在教：看不见不等于不在。你躲起来，还会回来。

每天玩几次，不需要别的玩具。

第五，给他一个“过渡物”。

一个小毯子，一只小玩偶，孩子常常会特别依恋。这是很正常的事，不需要强行拿走。它是孩子在你不在的时候用来安慰自己的东西。〔中：温尼科特提出的“过渡性客体”概念，很多发展心理学家，认同〕

◆ 七、辅食：不只是“吃”

这个阶段另一个大事是辅食。

世界卫生组织建议满六个月开始添加辅食。〔强〕

辅食不仅仅是营养，它还是另一种很重要的“来回”。

孩子对食物会有反应：喜欢的，张大嘴；不喜欢的，扭头，推开，吐出来。

这是他的“显露”。你要看到，也要尊重。

一个重要的原则是“回应式喂养”：

孩子张嘴你就喂，孩子闭嘴、扭头就停。不要强迫，不要追着喂，不要用手机哄着他把嘴张开。

研究发现，回应式喂养和孩子较好的自我调节食欲的能力有关。强迫喂食可能让孩子对吃饭有负面的情绪，也不利于他学会判断自己的饱和饿。〔中：多项观察研究和综述，指向这个方向，因果，较难证明〕

还有，让孩子自己抓，自己玩，自己弄脏。

这是一个混乱的过程，地板会很脏。可是孩子是在用手和食物“来回”：软的，硬的，滑的，烫的。

这是触觉 SDE 的延续。

◆ 八、辅食起步清单

辅食怎么开始，很多家庭不知道从哪下手。下面是一张简单的清单。

先看孩子准备好了没有。常见的信号是：能在支撑下坐稳，对大人的食物有兴趣，会张嘴迎接勺子。〔中：参考世界卫生组织等机构的喂养指南，个体差异大〕

再看怎么开：

一，一次加一种新食物，让他试几天，再换下一种。

二，从很软很细的泥糊开始，慢慢过渡到小块的软食。〔中：质地逐步过渡是常见指南建议〕

三，一岁以内，少放盐和糖。〔中：多数喂养指南的建议〕

四，奶还是主要的，辅食是在“学吃”。

五，他吃多少，让他自己定。他闭嘴，就停。

六，饭后擦干净，不要把“吃得多不多”当成成绩单。

如果孩子一连几次都不肯吃，不必焦虑。隔几天再试，是常见的做法。
〔解释：本书的建议，呼应回应式喂养〕

遇到体重增长、吞咽或过敏方面的担心，请问儿保医生。〔核〕

◆ 九、读书，和一个小游戏

第 12 章讲过读书的好处。

这一阶段的孩子读书有几个特点：

他不会坐着听你读完。他会抓书，咬书，翻页。

这都没有关系。

选硬纸板的、边角圆的、图大字少的书，让他抱着啃也行。

你指着一幅图，说一两个词：“这是一只猫。喵——”

孩子指，你说。孩子翻，你跟着。

十分钟就够了。

还有一个很简单的游戏，叫“藏东西”。

拿一个小玩具，当着孩子的面用布盖上，问：“咦，球去哪儿了？”

孩子会伸手，把布掀开。

这个游戏在测试一个叫“客体永久性”的能力：东西看不见了，还存在。

它和躲猫猫是一对。

◆ 十、什么时候，需要看医生

这个阶段需要留意的信号：

九个月，不发出咿咿呀呀的声音，对名字没有反应。

十二个月，不会用手指指东西，不挥手，不会用任何手势和人交流。

十二个月，不看你指的方向，也不看你的脸。

任何时候，已经会的能力不会了。

对于孤独症这样的神经发育差异，一岁前后是可以开始留意的时候。早期干预对孩子更有帮助，第 16 章讲过。〔核：参考美国儿科学会和疾控中心的发育监测建议，大意如此〕

如果你有这样的担心，不要等“再看看”，也不要因为亲戚说“某某也是两岁才说话”而自我安慰。请尽早去儿童保健科做一次评估。

评估没有坏处。

◆ 十一、各月龄“可以玩什么”

月龄	可以玩
6 到 7 个月	拍打，摇响，拿东西换手，对着镜子
8 到 9 个月	躲猫猫，把东西放进盒子再倒出来，爬过一堆软枕头
10 到 11 个月	推着小盒子走，用布盖住玩具再掀开，翻硬纸板书
12 个月前后	滚球，叠两块积木，拿勺子，学着挥手“再见”

〔中：参考发育里程碑，个体差异大〕

玩的时候，你的角色很简单：在旁边，他做什么你就跟着说一句。

◆ 十二、一天的来回：9 个月左右的样子

时段	大概在做什么	放进去的“来回”
早上	起床，喝奶，辅食	回应式喂养，他闭嘴就停
上午	爬行，探索，小睡	他回头，你点头
中午	辅食，睡午觉	睡前固定一句话

时段	大概在做什么	放进去的“来回”
下午	外出，玩躲猫猫	他指，你看，你说
傍晚	容易黏人	抱一会儿，不急着做事
睡前	洗澡，喝奶，读书	十分钟书，固定的晚安

这是本书的示例，不是时间表。〔解释：个体差异大〕

如果你要上班，把“告别”和“回来”这两个时刻看得重一点。其余的时间，按你家的节奏走。

◆ 十三、做不到的时候：降级版本

这个阶段，最容易累垮的是你的体力。家里一直要有人盯着。

“最低版”是这样的：

一，安全布置先做最要紧的三样：楼梯和窗，药品和清洁剂，纽扣电池和小零件。

二，每天有一次“他指，你看，你说”。

三，告别时说清楚，回来时抱一下。

四，辅食吃得少，不必焦虑。奶仍然是这个阶段的重要营养来源。〔中：6 到 12 个月，奶仍是主要营养来源之一，个体差异大〕

做到这四条，就已经够了。

◆ 十四、奶奶被推开的那天

孩子九个月的时候，奶奶来住了一个星期。

奶奶一进门就伸手要抱。孩子看了她一眼，把头埋进苏晴的肩窝，哭起来。

奶奶的脸有点挂不住。她说：“我是你奶奶呀，怎么不认我。”

苏晴没有说“他不懂事”。她说：“妈，他现在只是认生，不是不喜欢您。您先别抱，坐在旁边，玩您自己的，让他自己看您。”

奶奶半信半疑，在地毯上坐下，拿起一只拨浪鼓，自己摇着玩。她不看孩子。

二十分钟以后，孩子从苏晴腿上滑下去，一点一点爬到奶奶脚边。

他伸手摸那只拨浪鼓。

奶奶没有去抱他。她只是轻轻说了一句：“这个给你。”

孩子拿过去，摇了一下，抬头看她。

奶奶笑了，眼眶有点红。

这件事想说的是：认生不是对谁的评价。它是孩子在分辨熟悉和陌生。

让他先看，让他自己走过来，比硬抱容易得多。〔解释：本书的建议，符合认生是发育现象的理解〕

◆ 十五、常见的几个问题

问：认生特别厉害，陌生人看一眼就哭，要不要“练胆子”？

答：不用。这个月龄认生是常见的发育现象。〔中：分离焦虑和认生在这个阶段普遍〕硬让陌生人抱，只会让他更怕。让他在你怀里先观察，熟悉了再

靠近。如果长期严重影响日常生活，再请教儿保医生。〔核：以儿科医生建议为准〕

问：他不爬，直接站起来走，要紧吗？

答：有的孩子跳过爬行，仍在正常范围里。〔中：运动发育的个体差异大〕要看的是两边手脚用得差不多，身体不是特别僵或特别软。到一岁半还不会独立走，或者两边明显不对称，请去儿童保健科。〔核：参考发育监测建议，大意如此〕

问：辅食的过敏风险，怎么办？

答：近年的指南倾向于不再刻意推迟鸡蛋，花生这类常见致敏食物。一次加一种，从少量开始。〔中：指南趋势，请以医生为准〕如果孩子湿疹较重，或家里有人有严重的食物过敏，请先问儿科医生或过敏科。〔核〕

吃后嘴唇肿，反复呕吐，起疹子，呼吸费力，要马上就医。〔强：严重过敏反应的基本识别，呼吸费力请拨急救电话〕还有一条：一岁以前不要给蜂蜜。〔强：肉毒杆菌风险，儿科共识〕

问：什么都往嘴里放，是不是不卫生？

答：啃咬是他在探索，也和出牙有关。〔中：婴儿口腔探索是常见发育行为〕先把小零件收起来，常用的玩具定期洗一洗。可以给他干净的、一整块的牙胶。不要给他戴出牙项链，有勒住脖子的风险。〔核：儿科学会等机构的提醒，大意如此〕

问：学步车能帮他学走路吗？

答：不能。研究没有发现学步车能让孩子走得更早。〔中〕学步车和摔下楼梯，烫伤这类受伤有关，儿科学会建议不用。〔强〕想帮他，可以给他一块宽敞的地垫，让他扶着稳的家具走，或者推一个稳的小推车。〔解释：本书的建议〕

问：怎么预防吃东西噎到？

答：吃饭时让他坐直，大人在旁边看着，不要边跑边吃。整颗的葡萄，坚果，硬糖，爆米花，这个阶段不给。〔强：婴幼儿哽噎预防的常见建议〕食物切小，压扁。可以去参加医院或红十字会的婴儿急救课，学一学噎住时怎么办。〔核：以当地急救培训为准〕

◆ 十六、放回日子里

孩子十个月的时候，有一天，苏晴在客厅叠衣服。

他扶着沙发站着，看着她。

她叠一件小衣服，放一边。他伸手去拿。

她没有阻止。他把衣服拿到手里，看了看，塞进嘴里。

她笑了：“哎，那是衣服，不是吃的。”

他把衣服拿出来，看着她，又塞了回去。

她伸手，轻轻把衣服从他嘴里拿出来，换了一块布质的小积木给他：“这个可以啃。”

他接过去，啃。

她继续叠衣服，他继续啃积木，偶尔抬头看她一眼。

她也偶尔抬头看他一眼。

没有一句教育的话。

可是这一下午，他在探索，她在旁边。他每一次回头，都看到了她。

带走的话

孩子爬出去，是因为知道回头有你。他指，你看，你说。他怕分开，你说清楚，再回来。环境先布置得“可以探索”，再谈“跟着他看”。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
社会性参照：孩子遇到不确定情境，看照料者的表情	〔中〕	视觉悬崖等实验，样本不大，比例待核
要求式的指与分享式的指	〔中〕	托马塞洛等的讨论
分离焦虑在 9—18 个月最强	〔中〕	发展心理学共识
过渡性客体	〔中〕	温尼科特概念，被广泛接受
WHO 建议满 6 个月添加辅食	〔强〕	长期建议
回应式喂养与较好的食欲自我调节相关	〔中〕	观察研究和综述，因果难证
躲猫猫、藏东西游戏与客体永久性	〔解释〕	皮亚杰以来的发展心理学解释
发育里程碑警示信号	〔核〕	参考 AAP、美国疾控中心，以最新版本为准
跌落、烫伤、溺水、吞入异物是婴幼儿意外伤害的常见原因	〔强〕	儿科和安全机构一致提醒
纽扣电池、磁珠吞下后需马上就医	〔强〕	儿科急诊共识
水边大人不离开视线	〔强〕	溺水预防基本原则

说法	证据级别	说明
趴到地上从孩子高度看屋子	〔解释〕	本书的建议
各月龄“可以玩什么”	〔中〕	参考发育里程碑，个体差异大
9 个月左右的一天示例、降级版本	〔解释〕	本书示例
6—12 个月奶仍是主要营养来源之一	〔中〕	个体差异大，请听儿保医生
让孩子自己靠近陌生人比硬抱容易	〔解释〕	本书的建议
认生是常见发育现象	〔中〕	发展心理学共识
跳过爬行仍可在正常范围；一岁半不会走需评估	〔中〕 〔核〕	以儿保医生评估为准
近年指南倾向不刻意推迟常见致敏食物	〔中〕	指南趋势，以医生为准
高风险孩子加致敏食物前先问医生	〔核〕	以医生建议为准
严重过敏反应要马上就医	〔强〕	基本识别常识
一岁以前不给蜂蜜	〔强〕	肉毒杆菌风险，儿科共识
啃咬是常见探索和出牙行为	〔中〕	发育常识
不戴出牙项链	〔核〕	儿科机构提醒，大意如此
学步车不促进走路	〔中〕	研究有限
学步车与受伤相关，儿科学会建议不用	〔强〕	AAP 建议
坐直、有人看着、避免整颗坚果葡萄等	〔强〕	哽噎预防常见建议
参加婴儿急救课	〔核〕	以当地培训为准
辅食起步信号与质地过渡	〔中〕	参考喂养指南，个体差异大
一岁以内少放盐和糖	〔中〕	多数喂养指南的建议
吃得不好不必焦虑、隔几天再试	〔解释〕	本书的建议
体重、吞咽、过敏的担心问儿保医生	〔核〕	以医生建议为准

个体情况，比如辅食添加、过敏风险、发育落后、不指不看人，请咨询儿科医生或儿童保健科。

第25章

1到2岁：走，说，和第一个“不”

◆ 一、超市里的一场哭

孩子十八个月的时候，在超市里发生了第一次“大战”。

他看中了货架上一盒彩色的饼干，伸手去抓。苏晴说：“不买，家里
有。”

他不依，一把抱住盒子，不肯放。苏晴去掰他的手，他“哇”地一声哭起来，一屁股坐在地上，蹬腿，打滚，嗓门大到整个超市都能听见。

旁边一位老太太看了一眼，说：“这孩子，被惯坏了。”

苏晴的脸一下子红了。

她蹲下来想抱他，被他推开。她站起来想走，他哭得更凶。

最后她把他夹在胳膊下，推着车匆匆结账，逃出了超市。

坐在车里，她的手在抖。

这一章就从这场“战争”讲起。它不是孩子“被惯坏了”，也不是你“做错了什么”。它是这个年龄段最典型的一件事。

◆ 二、这一年，孩子在做什么

先看地图。

月龄	孩子常见的样子
12 到 14 个月	学会走，开始说出第一批词，指东西，用手势
15 到 18 个月	走得稳，会爬楼梯，能说十来个词，听得懂简单的指令，开始说“不”和“我的”
19 到 24 个月	会跑，能说两个词的短句，比如“妈妈抱”“还要”，词汇量快速增加，开始玩简单的假装游戏

同样，个体差异大。说话早晚相差好几个月，都在正常范围里。〔中：参考发育里程碑研究，词汇量的个体差异极大，约 18 个月时，正常儿童的词汇量，可以从几个到上百个〕

这一年里，孩子有一个巨大的变化：

他发现了“我”。

◆ 三、“我”的诞生：为什么孩子开始说“不”

大约一岁半到两岁，孩子开始频繁地说“不”，说“我的”，说“我自己来”。

这不是孩子变坏了。这是他在发展一个很重要的东西：自我意识。

有一个经典的实验，叫“点红鼻子”。大人趁孩子不注意，在他鼻子上点一个红点，然后让他照镜子。如果孩子看到镜子里的红点，伸手去摸自己的鼻子，说明他认出了镜子里的是“我”。〔强：1970 年代起，被反复使用，大约十八到二十四个月的孩子，开始通过这个测试〕

认出“我”以后，下一步就是“我要”“我不要”。

在 SDE 的语言里，这是一件很重要的事：

孩子开始把“我”从“世界”里分出来。

分出来以后，他要试试“我”能不能改变“世界”。

“不”是他第一个、最有力的改变世界的工具。

你对他说“来，吃饭”，他说“不”。你说“不，我们不买”，他大哭。每一次，他都在试：我说话，有没有用？

所以对这个阶段的父母，最重要的认识是：

“不”不是对你的对抗。它是孩子在练习当一个“人”。

◆ 四、发脾气：不是任性，是“大脑还没长好”

那么发脾气怎么理解？

先看一个神经科学的事实。

大脑里有一个区域叫前额叶，负责计划、抑制冲动、调节情绪。这个区域是大脑里发育最晚的部分，要到二十几岁才成熟。〔强：神经科学的共识〕

一个两岁的孩子，前额叶几乎还没有开始工作。

他想要一块饼干，得不到，那种“我要”的感觉就像一场风暴，把他整个人淹没。他没有办法自己停下来。

所以发脾气不是故意的，是他被情绪淹没了。

这时候他需要的是一个“外置的前额叶”，也就是你。

第 11 章讲过，“共同调节”是自我调节的前身。孩子通过一次次被你安抚，慢慢学会自己安抚自己。

那么具体怎么做？

给你一个很简单的四步。

第一步，先稳住自己。

孩子在尖叫的时候，你也很想大喊。先深呼吸一次。你是他的“稳定的岛”。

第二步，蹲下来，到他的高度，用平稳的声音说出他的感受。

“你很想要那盒饼干。你很生气，因为妈妈说不买。”

这样做不是认同他的要求，而是帮他给情绪起名字。研究者发现，给情绪命名有助于孩子平静下来，也有助于他学会情绪的词汇。〔中：这是情绪教养的基本方法，有一定的研究支持，直接的证据，大多来自较大的儿童〕

第三步，守住界限。

“不买就是不买。可是我陪着你。”

不要因为他哭得太凶就妥协，买了。这样做，他学到的是：哭得越大声越有用。

可是守界限不等于冷着脸。可以既抱着他，又不买。

第四步，等。

风暴一般几分钟就会过去。你不需要让他立刻停止，只需要陪着。

风暴过去以后，抱抱他，说一句：“好了，没事了。”

这样的循环经历几十次，孩子就学会了：我可以生气，可是风暴会过去；有人在；界限还在。

这就是“足够好的回应”在两岁孩子身上的样子。

◆ 五、超市之前，先做好预案

超市里那一场战争，其实可以在出门之前就打一半的仗。下面是一份简单的预案。

出门前，做三件事：

一，让他吃饱，睡足，再出门。饿和困的时候，孩子最容易失控。〔中：疲劳和饥饿会让幼儿更容易发脾气，是常见的育儿经验和观察〕

二，在门口说好规则：“今天只买菜，不买饼干。”说一遍就够了。〔解释：本书的建议，提前说好比现场争更省力〕

三，带一样他喜欢的小东西，比如一本小书，或者一个小玩具。

在现场，按前面讲的四步走：

一，先稳住自己。

二，蹲下来，说出他的感受：“你很想要饼干。”

三，守住界限：“今天不买。可是我陪着你。”

四，等。风暴过去以后，抱一下。

如果他闹得太厉害，抱起他，走到安静的地方，比如车里或者店门口。这不是惩罚，是给他一个安静的角落。〔解释：本书的建议〕

最后说说旁人的目光。你可以在心里默念一句：“他在学，我在陪。”

这句话不用说给别人听。它只是让你在脸红的那一刻站得稳一点。

◆ 六、界限：温柔，也要稳定

提到“界限”，很多父母会纠结。

太严怕伤害，太松怕惯坏。

研究者把父母的教养方式分成几种。其中被认为对孩子最有利的叫“权威型”：既温暖、回应，又有清楚的规则和期待。〔中：鲍姆林德的教养风格研究在多个文化里有支持，不同文化里效果略有差异，因果关系难以证明〕

对一到两岁的孩子，“界限”有几个原则：

一，少而清楚。

在这个年龄段，只需要守住几条：危险的事不能做，比如碰插座、跑到马路上。伤害别人的事不能做，比如打人、咬人。其他的，能让就让。

二，一致。

今天不让，明天让，后天又不让，孩子就不知道规则是什么，会反复试探。

家里的大人尽量对关键的几条规则保持一致。

三，说“能做什么”，比说“不能做什么”更有用。

“不能扔”，不如“球可以滚着玩”。

孩子的大脑对“不要……”这样的句子不太容易理解。给他一个可以做的事。

四，不打，不吼。

研究发现，体罚和孩子后来的攻击行为、心理健康问题有关联，并且没有长期的、更好的服从。〔强：多项荟萃分析，包括一项汇总了几十年研究的分析，结论比较一致；美国儿科学会，反对体罚〕

这不是在指责曾经打过孩子的父母。它是在说：如果你想找一个更有效的办法，有。

◆ 七、说话：词，像爆炸一样长出来

这一年另一个最令人惊喜的变化是说话。

大约十八到二十四个月，很多孩子会经历一个“词汇爆发期”：每天学会好几个新词。〔中：个体差异大，不是所有的孩子，都有明显的爆发〕

这个阶段你可以做的事，还是第 12 章那几条：

他指，你说。

扩展一点点：他说“车”，你说“大车，开走了”。

不要考他。

读书，每天十到二十分钟。

唱歌，念儿歌。

尽量少用屏幕。

还有一个容易被忽略的：

不要纠正他的发音。

他说“我要吃饭饭”，你说“好，吃饭”，就行。不用说“不对，是‘吃饭’，不是‘吃饭饭’”。孩子听到你说对的版本，会慢慢自己调整。

◆ 八、假装游戏：智慧的新台阶

大约两岁前后，孩子开始出现一种新的游戏：假装。

他拿起一个积木，放在耳朵边，说：“喂？”

他拿起一个空杯子，喂娃娃“喝水”。

他把香蕉当作电话，当作汽车。

这种“假装”在发展心理学里是一个很重要的里程碑。

因为它说明，孩子开始能够在“眼前的东西”和“脑子里的意思”之间建立一个新的联系：香蕉可以是电话。

这就是“符号思维”的开始，也是语言、数学、想象力的共同根源。

怎么回应？

加入他。他用香蕉打电话，你也拿起另一根：“喂？”

不需要教，不需要纠正，不需要说“这是香蕉，不是电话”。

只是跟着他的假装往前走一小步：“喂，宝宝，你吃饭了吗？”

这就是“你来我往”在两岁孩子身上最有趣的样子。

◆ 九、关于屏幕和玩具

这一阶段很多家庭会遇到：要不要让孩子看屏幕，要不要买很多玩具？

第 12 章讲了屏幕的原则：两岁以前尽量少，视频通话除外。

关于玩具，有一个很有意思的发现：

有研究者对比了一个只有四个玩具的房间和一个有十六个玩具的房间，发现玩具少的房间里，孩子玩得更久，更专注，玩法更有创意。〔中：Dauch 等 2018 年，小样本，需要更多重复，但方向和很多教育者的经验一致〕

所以不要买太多玩具。

最好的“玩具”常常是：锅，碗，盒子，勺子，积木，布，球，书，和你。

◆ 十、可以直接说出口的几句话

这个年龄的孩子听得懂短句。一句话只放一个意思。下面几句可以直接用。

一，他要饼干：“你很想要。今天不买。我陪着你。”

二，他要打人：“不可以打。他会痛。”

三，他乱扔：“球可以扔，勺子不扔。”

四，他说不吃：“你不想吃。我们一会儿再试。”

五，风暴过去以后：“好了，没事了。”

六，出门前：“我们去超市，只买菜。”

七，你吼了他以后：“妈妈刚才声音太大了，对不起。”

〔中：对幼儿用简短，具体的话，更容易被理解〕

句子越短，你自己也越容易在着急的时候说出口。

◆ 十一、各月龄“可以玩什么”

月龄	可以玩
12 到 14 个月	滚球，把东西放进盒子再倒出来，推小车，翻硬纸板书
15 到 18 个月	叠两三块积木，拿笔涂鸦，玩水，学动物叫
19 到 24 个月	简单的拼图，过家家，跟着音乐跳，追着泡泡跑

〔中：参考发育里程碑，个体差异大〕

玩具不用多。一个盒子，几块布，一只勺子，就能玩很久。

◆ 十二、一天的来回：18 个月左右的样子

时段	大概在做什么	放进去的“来回”
早上	起床，吃早饭	给两个小选择：“香蕉还是苹果？”
上午	户外，玩	他指，你说，再多说一点点
中午	午饭，午睡	午睡前固定一首歌
下午	玩，也许发脾气	出门前把规则说好
傍晚	容易累，容易闹	提前吃点东西，降低要求
睡前	洗澡，读书，睡觉	读书十分钟，固定的晚安

这是本书的示例，不是时间表。〔解释：个体差异大〕

给两个小选择，是这个年龄很好用的一招。他有了“我选”的感觉，“不”就会少一些。〔解释：本书的建议〕

◆ 十三、做不到的时候：降级版本

一到两岁的孩子，累起来是真的累。你的“最低版”是：

一，只守三条规则：危险的事不做，伤害别人的事不做，其余的能让就让。

二，他发脾气的时候，只做两件事：稳住自己，陪着。

三，每天读一本书，不管多短。

四，晚上给自己十五分钟。

其余的，比如说话要多扩展，玩具要多讲究，都可以放。

不打，不吼，这条尽量守住。万一吼了，回来修复，见第 26 章。〔强：体罚相关的证据见前文；修复的说法见第 11、13 章〕

◆ 十四、周女士和公园里的那一推

孩子十九个月的时候，在小区的公园里推了另一个小朋友。

对方一屁股坐在地上，哭了起来。

苏晴的心一下子提到了嗓子眼。她快步走过去，蹲在自己孩子旁边，用平稳的声音说：“不可以推。他会痛。”

然后她转向那个哭的孩子，轻轻扶他起来，问：“摔疼了吗？”

那个孩子的妈妈正好是周女士。

周女士笑了笑：“没事，他们这个岁数就是这样。我家那个，以前还咬过人呢。”

苏晴很不好意思。周女士看着她，接着说：“我最后悔的，是当时当着一堆人吼了他一顿。后来我发现，他只是更爱咬了。”

“那你后来怎么办？”

“我就说一句：‘不可以咬，会痛。’然后把他带走，抱一会儿。再也没有多说。”

过了一两个月，孩子慢慢就不咬了。〔中：1 到 2 岁咬人推人是常见现象，多数随语言发展减少〕

这件事想说的是：孩子推人，咬人，不是坏。他是语言不够用，也还不懂别人会痛。

你要做的，是一句话，一个动作：说清楚，走开，抱一会儿。

◆ 十五、常见的几个问题

问：他咬人，打人，怎么办？

答：这个年龄很常见，多半是因为话还说不清楚，或者太兴奋，太累。

〔中：多数随语言发展减少〕

立刻拉开他，用平稳的声音说一句：“不可以咬，会痛。”去照顾被咬的孩子。不要咬回去，不要吼。〔强：体罚和吼叫没有长期的益处，见本章讲界限的那一节〕

观察是在什么时候发生的，饿，累，人多的时候最常见。如果很频繁，影响到入托，请问儿保医生。〔核〕

问：他总是乱扔东西，怎么办？

答：扔东西常常是在试验：东西掉下去会怎样。这是他探索的一种方式。

〔解释：发展心理学对幼儿探索的常见解释〕给他可以扔的东西：软布球，沙包，球。不能扔的东西，轻轻拿走，说：“勺子用来吃，球用来扔。”

问：他只会说“爸爸妈妈”，别的不会，要紧吗？

答：这个年龄说话的个体差异很大。〔中〕比说几个词更要紧的，是他听不听得懂简单的话，会不会指，会不会看你的脸。如果到 18 个月说话很少又不指，不理解简单的指令，或者到 24 个月还不会把两个词连起来，或者原来会说的词不说了，请去儿童保健科，也要查一查听力。〔核：参考发育监测建议，大意如此〕

问：动画片能看多久？

答：本书和第 12 章一样，两岁以前尽量不看，视频通话除外。〔核：世界卫生组织和美国儿科学会对两岁以下的建议都倾向于不看或极少看〕

如果实在做不到，可以这样降级：选节奏慢，内容简单的，大人一起看，一起聊。每次短一点。不在吃饭和睡前看，不当成哄孩子的工具。〔中：和大人一起看比自己看，对学习更有帮助，这是较一致的观察〕

问：爷爷奶奶总是妥协，怎么办？

答：先在最关键的几条上统一口径：危险的事不做，伤害别人的事不做。其他的事，让老人保留他们自己的做法。不要当着孩子的面争。〔解释：本书的建议，呼应“一致”这条原则〕如果实在谈不拢，就把孩子单独在你身边的时间做稳。

问：在公共场所发脾气，怎么办？

答：事先做预案，见前面的“超市之前”。现场先稳自己，必要的时候带他离开。旁人的目光会让你难受，这是真的。不过这一刻，孩子比旁人重要。

问：他什么都说“不”，怎么办？

答：这是他在练习当一个“人”，本章前面讲过。少问“要不要”，多给二选一：“红杯子还是蓝杯子？”他有了选择，“不”会少很多。〔解释：本书的建议〕

◆ 十六、放回日子里

超市那场战争过去了一个星期。

孩子又一次在家里发脾气。他要把一个勺子扔到地上，被苏晴拦住了。

他倒在地上，开始哭，蹬腿。

苏晴这次没有慌。她深呼吸，蹲下来，在他旁边坐下，也不说话，就坐着。

哭了三分钟，他停了一下，偷偷看了她一眼。

她伸出手，说：“你很想扔勺子，对不对？可是勺子不能扔。来，我们一起扔球。”

他爬起来，扑进她的怀里。

她把他抱起来，拿起一个小球放到他手里：“扔。”

他把球扔了出去。球在地板上滚了几圈。

他笑了。

她也笑了。

晚上她跟江远说起这件事：“我终于觉得，有点‘会了’。”

江远说：“你一直都会。”

带走的话

孩子说“不”，是在练习当一个“人”。发脾气，是大脑还没长好。你是他“外置的前额叶”：稳住自己，说出他的感受，守住界限，陪着等。少而清楚的规则，加上不打不吼，是对一到两岁的孩子最好的“界限”。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
18—24 个月开始通过镜子自我识别（点红鼻子）	〔强〕	1970 年代起反复使用
前额叶是大脑发育最晚的部分，要到二十几岁才成熟	〔强〕	神经科学共识
给情绪命名有助于孩子平静	〔中〕	证据多来自较大儿童
权威型教养（温暖加清晰规则）与较好的孩子结果相关	〔中〕	鲍姆林德研究，跨文化略有差异，因果难证
体罚与孩子的攻击行为、心理健康问题相关，没有长期更好的服从	〔强〕	多项荟萃分析，AAP 反对体罚
18—24 个月可能出现词汇爆发	〔中〕	个体差异大
假装游戏是符号思维的开始	〔强〕	发展心理学共识
玩具少的房间孩子玩得更专注	〔中〕	Dauch 等，2018，小样本，待核
四步法：稳住自己、说出感受、守住界限、等	〔解释〕	本书的方法论概括
对幼儿用简短具体的话更易被理解	〔中〕	发展心理学常见观察
关键规则统一口径、其余让老人保留做法	〔解释〕	本书的建议
饥饿和疲劳让幼儿更容易发脾气	〔中〕	育儿观察和常见经验
提前说好规则、给两个小选择、带离到安静处		本书的建议

说法	证据级别	说明
	〔解释〕	
各月龄“可以玩什么”	〔中〕	参考发育里程碑，个体差异大
18 个月左右的一天示例、降级版本	〔解释〕	本书示例
不打不吼、体罚没有长期益处	〔强〕	与本章讲界限的一节一致
1—2 岁咬人推人常见，多随语言发展减少	〔中〕	发育观察
咬人打人要观察发生的情境	〔解释〕	本书的建议
频繁咬人影响入托请问儿保医生	〔核〕	以医生建议为准
幼儿扔东西常是在试验因果	〔解释〕	发展心理学的常见解释
说话早晚个体差异大	〔中〕	发育观察
语言发育警示信号及听力检查	〔核〕	参考发育监测建议，大意如此
两岁以下尽量不看屏幕	〔核〕	WHO、AAP 倾向于不看或极少
和大人一起看比独自看更有益	〔中〕	观察研究，较一致

个体情况，比如发脾气特别频繁剧烈、伤害自己或他人、语言明显落后，请咨询儿童保健科或发育行为专科。

第 26 章

2 到 3 岁，和一章写给“做不到完美”的妈妈

◆ 一、一句完整的话

孩子两岁半的时候，有一天晚上，苏晴给他洗完澡，裹着浴巾抱出来。

他看着她，突然说：“妈妈，我今天在幼儿园看见了一只大狗。”

苏晴愣住了。

这是他第一次完整地讲一件“过去的事”。有主语，有地点，有对象。

她蹲下来，认真地问：“大狗？它是什么颜色的？”

“黄色的。”他想了想，“它叫我。”

“它叫你？它说什么了？”

“汪汪。”他很严肃，“我不怕。”

苏晴笑得眼泪都出来了。

这一章讲 2 到 3 岁。这是“基础和平台”这个说法里最后的一块砖，也是这一编的最后一章。所以我们不止讲这个年龄，还要说一些对你更重要的话。

◆ 二、这一年，孩子在做什么

月龄	孩子常见的样子
24 到 30 个月	说三四个词的句子，会问“这是什么”，会跑、跳、上下楼梯，假装游戏变丰富，开始有“我的”
	能讲简单的事，会说“为什么”，有了朋友的概念，能轮流玩，情绪更能表达

月龄 孩子常见的样子

30 到 36 个
月

这一年里有三件事值得讲：

一，孩子开始讲“故事”。

二，孩子开始有“同伴”。

三，孩子要进入一个新的环境：幼儿园，或者托班。

◆ 三、讲故事：回忆，是一种新的“来回”

两岁以后，孩子开始会说“今天”“昨天”“明天”。

一开始常常说错：“昨天我们要去公园。”慢慢地才学会。

这和第 12 章讲的“话轮”一脉相承，只是孩子从“眼前的东西”走向了“过去的事”。

有一个很重要的发现：

父母和孩子聊“过去的事”的方式，会影响孩子后来记忆和叙事的能力。

研究发现，那些在聊天时用“详细的、开放式的提问”去引导孩子回忆的母亲，孩子后来讲述自己的经历会更丰富、更连贯。〔中：Reese 等人，在新西兰做的纵向研究，有一定的重复，样本不大，待核〕

“开放式提问”是什么意思？

不是：“你今天在幼儿园开心吗？”（孩子只需要说“开心”）

而是：“你今天在幼儿园做了什么呀？”“然后呢？”“她说了什么？”“你是什么感觉？”

这样的问题让孩子自己把一件事从头到尾讲出来。

在 SDE 的语言里，这是在做一件事：

帮孩子把一个个分散的“不同”接成一条“路”。

而且这是一条跨越时间的路。

你可以每天晚上睡前花五分钟，和孩子聊一聊今天发生了什么：

“今天有什么最好玩的？”

“有什么不太高兴的？”

“明天你想做什么？”

不需要太多。五分钟，每天。

◆ 四、同伴：来回，不只是和你

两三岁，孩子开始对别的孩子感兴趣。

一开始他们只是“平行玩”：两个孩子在同一个地方各玩各的，偶尔看一眼对方。

慢慢地，他们会抢玩具，会推，会笑，会一起跑。

这个阶段会发生很多“冲突”：抢玩具，打人，咬人。

这是很正常的。他们在学习一件很难的事：怎么和另一个同样有“我”的人相处。

你可以这样做：

一，不要急着介入。如果只是小的争抢，先在旁边看着。很多时候孩子会自己解决。

二，如果有伤害，就介入。蹲下来，用平稳的声音说：“不可以打人，他会痛。”然后关心被打的孩子。

三，不要强迫孩子“分享”。

很多父母会对孩子说：“把玩具分给小朋友。”不过这个年龄的孩子还没有真正的“分享”能力，强迫只会让他更护着。

可以说：“你玩完了再给他，好吗？”让他学会“轮流”。

四，给孩子创造和别的孩子玩的机会：公园，社区，亲戚朋友的孩子。不需要上什么课程，随意地玩就好。

◆ 五、第一次，进入集体

大多数孩子在两岁半到三岁会进入托班或者幼儿园。

这是他第一次离开家庭，长时间处在一个有很多孩子、很多陌生人的环境里。

这对孩子、对你，都是一个很大的考验。

第 13 章讲过，托育本身对孩子没有明显的伤害，关键是质量，以及你在家里和他的“来回”。

怎么让这个过渡更顺利？

第一，提前熟悉。

入园前带孩子去参观几次，让他看到教室、老师、别的孩子。

第二，慢慢来。

如果可以，先从半天开始，再延长。很多幼儿园有“适应期”。

第三，固定告别的仪式。

和第 24 章一样：短，固定，明确，会回来。

“妈妈送你到门口，抱一下，然后你进去玩。下午我来接你。”

不要偷偷溜走。

第四，接他的时候，给他一点“重新连接”的时间。

不要一见面就问：“今天乖不乖？”给他一个大大的拥抱，让他在你怀里待一会儿。很多孩子在幼儿园会忍着不哭，一回到妈妈这里就“崩”。这是正常的，是因为他在你这里才觉得安全。

第五，前几周孩子回来会更黏，更爱发脾气，睡得更不好。给他更多的耐心。

第六，如果孩子一直很抗拒，哭闹一两个月仍然没有好转，就和老师沟通，必要时推迟入园。没有规定说孩子必须三岁准时入园。

◆ 六、入园前后的清单

入园这件事，提前准备一点，会顺很多。下面这张表按时间排。

时间	做什么
入园前 2 周	带他去园里玩 2 到 3 次，认识老师，看看教室，厕所和午睡的地方
入园前 1 周	把作息往园里的时间靠一靠，告诉他“你要去上学了，下午我来接”

时间	做什么
前一天	准备换洗衣服，他的小毯子或小玩偶，早点睡
入园当天	短短告别，不偷偷走，说好几点接
前 2 周	尽量缩短在园的时间，接早一点，不安排别的大事

〔解释：本书的建议，各园的做法不同，以园里的安排为准〕

另外，把孩子的小习惯写在一张纸上，交给老师。比如睡觉要抱毯子，害怕什么，用什么方式说“要尿尿”。

这样老师认识的，不只是“一个新来的孩子”，而是“这个孩子”。〔解释：本书的建议〕

◆ 七、如厕：不要急

很多家庭在这个年龄开始训练如厕。

怎么做，怎么不做？

一个被很多研究和指南推荐的原则：看孩子是不是“准备好了”。

“准备好了”的信号包括：

能保持尿布干燥两个小时以上；

对别人上厕所感兴趣；

能听懂简单的指令；

能用语言或者动作表示“要尿尿”；

不喜欢湿的、脏的尿布。

大多数孩子在 18 个月到 3 岁之间会出现这些信号。〔中：美国儿科学会等机构的指南，大意如此，个体差异大〕

如果孩子还没有准备好就硬“练”，往往反而拖得更久，还会引起冲突。

所以：

不要因为别人家的孩子已经不用尿布了而焦虑。

不要惩罚、羞辱尿湿裤子的孩子。

每一次成功，给一个小小的鼓励。失败了，淡淡地说一句：“没关系，我们下次试试。”

◆ 八、一天的来回：入园之后的样子

入园以后，一天里最要紧的，是晚上那一段。

时段	大概在做什么	放进去的“来回”
早上	起床，吃饭，送园	固定的告别，不偷偷走
白天	在园里	他在外面“用力”，你也要吃饭休息
接他时	重逢	先抱，让他在你怀里待一会儿
傍晚	容易累，容易闹	吃点东西，降低要求
晚饭后	玩，洗澡	一起玩十来分钟，不看手机
睡前	读书，聊今天	五分钟“今天有什么好玩的”

这是本书的示例，不是时间表。〔解释：个体差异大〕

入园的头几周，傍晚的“重逢”可以放得再长一点。〔中：入园初期孩子回家后更黏人，是常见现象〕

◆ 九、各月龄“可以玩什么”

月龄	可以玩
24 到 30 个月	过家家，画涂鸦，搭积木，玩水玩沙，唱儿歌
30 到 36 个月	简单的拼图，轮流玩，讲小故事，跑跳，和别的孩子一起玩

〔中：参考发育里程碑，个体差异大〕

玩的时候，你可以做“旁白”：他在搭，你说“搭得高高的”。你不用教他怎么搭。

◆ 十、常见的几个问题

问：入园哭闹，会持续多久？

答：多数孩子几天到几周会慢慢适应，个体差异很大。〔中：入园适应期是常见现象〕回家以后更黏，脾气更大，睡得更差，也很常见。如果哭闹一两个月都没有好转，或者吃睡明显变差，请和老师沟通，必要时请教儿保医生。

〔核：以医生建议为准〕

问：已经不用尿布了，又开始尿裤子，是倒退了吗？

答：入园，家里有新生儿，搬家，这些变化之后，孩子突然又尿裤子，是常见的。〔中：发育过程中的暂时回退，较常见〕不批评，淡淡地换掉，说一句“没关系”。过几周通常会回来。如果孩子排尿时哭，疼，尿得特别频繁，或者尿的颜色不对，请看医生。〔核〕

问：家里有了二宝，老大开始吃醋，怎么办？

答：老大退回到婴儿的样子，抢奶瓶，要抱，是常见的。〔中：手足出生后，大孩子行为的暂时变化较常见〕

每天给老大十分钟“专属时间”，只有他和你，不带弟弟妹妹。〔解释：本书的建议〕不要说“你是哥哥，要让着弟弟”。让他做小帮手，但不强迫。不要把婴儿单独留给大孩子。〔强：幼儿还不懂分寸，婴儿单独在一起有安全风险〕

问：他说看见了不存在的事，或者有“假想朋友”，是说谎吗？

答：这个年龄，幻想和现实还混在一起，说的话往往不是故意骗人。

〔中：发展心理学的常见观察〕所以别当成撒谎来审问。可以说：“这是你想出来的故事吧。”想象中的小朋友，多数是无害的。〔中〕如果想象让他很害怕，或者他明显分不清现实，请教儿保医生。〔核〕

问：睡前总是拖，要水，要抱，要上厕所，怎么办？

答：这个年龄很常见。固定一套顺序：洗澡，刷牙，读书，关灯。每天一样，不用多。〔中：固定的睡前程序对入睡有帮助，是较一致的建议〕给他两个小选择，比如读哪本书。如果怕黑，可以留一盏小夜灯。〔解释：本书的建议〕

问：他总说“我自己来”，穿衣服要半小时，怎么办？

答：这是“我”的诞生在继续。〔解释：呼应第 25 章〕你可以早出门十分钟，把时间留给他。有些事他做不了，就帮一点点，不要全包。

◆ 十一、一章，写给“做不到完美”的妈妈

现在要说一些话，是这一章最重要的部分。

写在这儿，本书已经写了二十五章“为什么”和“怎么做”。

你可能有一个感觉：

“这么多事，我哪一样都没做好。”

“书里说要回应，我那天累得没理他。”

“书里说不要看手机，我今天看了一个小时。”

“书里说要稳，我今天吼了他。”

请你在这里停一下。

请你对自己说这四句话。

第一句：我做不到完美，这是正常的。

第 11 章讲过特罗尼克的研究：即使是最好的母婴关系，也只是一小部分的时间是“对上”的。大部分的时间是“没对上”和“修复”。

第 13 章讲过温尼科特的“足够好的母亲”：一个母亲会慢慢地“不完美”。这些不完美是孩子成长的材料。

没有一个完美的妈妈。本书也不需要你成为那样的人。

第二句：我吼了他，可以回来修复。

每一个母亲都有失控的时候。你大声吼了孩子，之后孩子吓哭了。

这时候最重要的不是“我怎么这么差”，而是修复。

你可以蹲下来，抱着他，说：

“妈妈刚才吼你，是妈妈不对。你吓到了，对不对？妈妈很抱歉。妈妈刚才太累了，很烦，可也不应该吼你。我爱你。”

孩子不一定懂每一个字。可是他会感觉到：吼过之后，有人回来了。

这是他学习“关系可以出问题，也可以修好”的最好的材料。

第三句：我也需要被照顾。

一个被掏空的母亲，是给不了孩子持续的回应的。

照顾自己不是自私，而是让“来回”可以持续下去的前提。

具体的：

每天保证一段属于自己的时间，哪怕只有十五分钟。

每周至少一次和朋友聊聊天。

让孩子和别的可靠的人待一会儿，你出去走走。

感觉撑不住的时候，说出来。

第四句：我如果持续低落，我需要帮助。

这是最重要的。

第 17 章讲过，产后抑郁不只会出现在产后头几周，在孩子两三岁的时候，母亲也会出现抑郁。

下面这些信号，如果持续两周以上，请一定告诉医生：

大部分时间情绪低落，或者什么都没兴趣。

睡不着，或者睡太多。

没有胃口，或者吃得特别多。

对孩子没有感觉，或者特别内疚。

觉得自己是孩子的累赘，觉得孩子没有我会更好。

有伤害自己、伤害孩子的念头。

这些不是“想太多”，不是“矫情”，是一种需要治疗的病。

治疗是有效的。心理治疗，药物，或者两者结合，大多数人会好转。

如果你现在就有伤害自己或者孩子的念头，请立刻告诉你身边信任的人，打当地的急救电话，或者心理援助热线，或者去最近的医院。〔强：这是，所有，精神卫生指南，一致的建议〕

请你现在就把这句话记在你手机的备忘录里。

◆ 十二、一个关于“没做到”的真实比例

最后，用一个很有意思的数字来结束这一部分。

有一项很有名的观察研究，让母亲和孩子在家里自然地互动。研究者记录母亲对孩子信号的回应，发现大多数“好”的母亲，对孩子的信号作出及时、合适回应的比例，大约不到一半。〔中：一些早期的母婴互动观察给出的数字是三到五成，不同研究差别很大，数字待核〕

可是这些孩子大多数发展得很好。

这个数字想要说明的只有一件事：

“足够好”的门槛，比你想象的低得多。

你不需要每一次都对上。你只需要大部分时候，在没对上以后回来。

这就够了。

◆ 十三、做不到的时候：降级版本

这一章最后，再给你一份“降级版本”。它分三档。

满格的日子，你做完整的三步法。这样的日子不会太多。

半格的日子，只做两件事：每天有一次不看手机的陪伴，晚上有五分钟聊今天。

最低格的日子，只做一件事：睡前抱一下，说：“今天我也爱你。明天见。”

三档都是“足够好”。你可以在一个星期里，自由地在三档之间换。

如果你发现，连续两周都只能做到最低格，同时有本章写给“做不到完美”的妈妈那一节里说的那些信号，请去看医生。这是身体在提醒你。〔强：持续两周以上的抑郁信号需就医，精神卫生指南共识〕

◆ 十四、入园第一天，江远去送

孩子入园的第一天，是江远送的。

苏晴那天有一个必须参加的会，她提前请了假，可是临时被叫回了公司。

老师在门口接过孩子。孩子扭头看江远，嘴一瘪，哭了。

江远蹲下来，说：“爸爸现在走。下午来接你。”

孩子哭得更大声。老师抱着他，对江远摆摆手：“您走吧，他一会儿就好。”

江远转身往外走。他走到楼梯拐角，停下来，靠着墙，站了好几分钟。

他听见楼上的哭声慢慢小下去。

下午他去接。孩子一看见他，扑过来，哭得比早上还凶。

江远没有问“今天乖不乖”。他把孩子抱在怀里，蹲在走廊里，一句话都没说。

回家的路上，孩子趴在他肩上，忽然说：“爸爸，你回来了。”

“嗯，我回来了。”

这件事想说的是：孩子在园里忍着，到你这里才敢哭。

这不是倒退，是他觉得这里安全。

清楚的告别，才有踏实的重逢。

◆ 十五、放回日子里

孩子三岁生日那天，苏晴没有办很大的派对。

只请了几个亲戚，和两个幼儿园的小朋友。

蛋糕是江远做的，不太好看，歪的。

孩子对着蜡烛吹了三次才吹灭。

蜡烛灭了，他转过头，看着苏晴，说：“妈妈，我三岁了。”

“嗯，三岁了。”

“我长大了。”

“是啊。”

他想了想，说：“妈妈，你也长大了吗？”

苏晴愣了一下，笑了：“妈妈早就长大了。”

“那你为什么还哭？”

苏晴没有说话。

那天她确实哭过。孩子一岁半的那一阵，她崩溃过一次，偷偷躲在卫生间里哭。她以为他不知道。

可是他知道。

她蹲下来，把他抱在怀里。

“妈妈有时候会哭。”她说，“有时候累了，会哭。可是你一哭，妈妈就来了，对不对？”

“对。”他说。

“妈妈哭了，也一样会来的。”

他把头靠在她肩上，没有再说话。

那一刻，苏晴忽然觉得，这三年所有的累都值得。

不是因为他会说话了，会背诗了，会认字了。

而是他知道她在。他也知道她会累，会哭，可是会回来。

这就是三年的所有“基础和平台”。

◆ 十六、本编小结

第七编五章，到这里可以收起来：

第 22 章，把三步法带到出生以后：给差异，看显露，稳环境；回应的四个动作：看，猜，做，再看。

第 23 章，讲 0 到 6 个月：抱，喂，哄，睡，第一个微笑；绝不摇晃。

第 24 章，讲 6 到 12 个月：回头看，指，认生，辅食，躲猫猫。

第 25 章，讲 1 到 2 岁：走，说，第一个“不”，发脾气，界限，假装游戏。

第 26 章，讲 2 到 3 岁：讲故事，同伴，入园，如厕；以及一章写给“做不到完美”的妈妈。

下一编是本书最后一编，讲 E 里的父亲。

带走的话

你不需要每一次都对上。你只需要在没对上以后回来。你也需要被照顾。撑不住的时候，说出来，找人，找医生。这三年所有的“基础和平台”，其实只是一个孩子知道：妈妈在，会回来。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
父母与孩子聊过去事件的方式，影响孩子后来的记忆叙事能力	〔中〕	Reese 等人纵向研究，样本不大，待核
2—3 岁孩子“平行玩”，逐渐发展为互动游戏	〔强〕	发展心理学共识
如厕训练应看“准备好了”的信号	〔中〕	AAP 等指南，个体差异大
母婴互动中“对上”的比例远低于一半，而孩子多发展良好	〔中〕	早期观察研究，数字各研究差别大，待核
修复比不犯错更重要	〔中〕	第 11、13 章已讲
持续两周以上的抑郁信号需就医	〔强〕	精神卫生指南共识
心理治疗、药物或两者结合对多数人有效	〔强〕	指南共识

说法	证据级别	说明
入园前后的清单、孩子小习惯写给老师	〔解释〕	本书的建议，以园里安排为准
入园初期孩子回家后更黏人	〔中〕	常见现象
一天的来回（入园后）、三档降级版本	〔解释〕	本书示例
各月龄“可以玩什么”	〔中〕	参考发育里程碑，个体差异大
入园适应期多为几天到几周	〔中〕	个体差异大
哭闹一两个月无好转需沟通和评估	〔核〕	以医生建议为准
如厕后出现暂时回退较常见	〔中〕	发育观察
排尿疼痛、频繁、颜色异常需看医生	〔核〕	以医生建议为准
手足出生后老大行为暂时变化较常见	〔中〕	发育观察
不把婴儿单独留给大孩子	〔强〕	安全常识
专属时间、早出门十分钟	〔解释〕	本书的建议
3 岁前后幻想与现实混在一起，假想朋友多无害	〔中〕	发展心理学观察
想象令孩子害怕或分不清现实需咨询	〔核〕	以医生建议为准
固定睡前程序有助入睡	〔中〕	较一致的建议

个体情况，比如产后抑郁、持续情绪低落、有伤害自己或孩子的念头，请立即就医，或联系当地急救电话和心理援助热线。入园和如厕的个体情况，请咨询儿童保健科。

第 八 编

父亲在 E 里：两个位置，各种家庭

这一编四章，讲父亲在这条回路里的位置，以及各种不同的家庭怎么办。

第 27 章讲父亲的两个位置：在母亲的 E 里，在自己的回路里。第 28 章讲怎么成为母亲的 E，给出一张每日清单。第 29 章讲怎么成为孩子的另一条回路。第 30 章讲单亲、祖辈、远行、收养等各种家庭的变通，并收束全书。

四章走完，你会看到：妈妈和爸爸，是位置，不是身份。

第 27 章

父亲在哪里：两个位置，一个不能少，一个不能替

◆ 一、一个问题

孩子出生后的第四个月，江远问了苏晴一个问题。

那天晚上，孩子睡了。两个人坐在沙发上，苏晴在看手机，江远在看她。

他说：“我最近在想一件事。”

“什么事？”

“这本书我们读了这么多，里面写的都是你和孩子。”他顿了顿，“那我呢？我到底算什么？”

苏晴放下手机，看着他。

他的表情很认真，不像在开玩笑。

“你在家里的時候，我知道我是在帮忙。”他说，“可是帮忙是什么意思？我是你的助理？还是他的……什么？”

苏晴想了想，说：“我也不知道。”

这一章，就要回答江远的这个问题。

这也是很多父亲心里有的问题。

◆ 二、先把话说在前头

在回答之前，本书要先把话说清楚。

本书前二十六章反复说的，是“智慧最先在母子之间发生”。

这句话常常被误读成“父亲不重要”。

这是一个很大的误读，我们要澄清。

本书从来没有说过父亲不重要。

本书说的，只是一个事实上的先后：

孩子在子宫里只和母亲有来回。这是一个生物学上无法改变的事实。出生以后的头几个月，在很多家庭里，母亲是主要的照料者，所以母子之间的“来回”最多。

可是这只是“先后”，不是“高低”，更不是“只有”。

第 13 章讲过：

孩子可以对多个人形成依恋。

父亲承担照料工作的时候，孩子和他也会形成安全依恋。

“母亲”是一个位置，不是一个身份。

所以父亲不是“在旁边”的人，他也在“来回”里。

只是他有两个不同的位置。

◆ 三、第一个位置：成为母亲的 E

先说第一个位置。

E 是 SDE 里“环境”的意思。第 4 章以来一直在说：孩子在子宫里，最大的环境是母亲。出生以后，在很长一段时间里，母亲仍然是孩子最重要的环境。

那么，母亲的环境是什么？

是父亲，是家庭，是工作，是社会。

所以父亲可以做的第一件事是：

成为母亲的环境，让她被稳稳地托住。

不妨问一句：一个母亲需要被托住的是什么？

本书归纳成五件事，我们叫它们“五个 E”。

第一个 E：睡眠。

孕期和产后，母亲最缺的是睡眠。一个长期睡眠不足的人，情绪更容易崩溃，对孩子的信号也更迟钝。

第二个 E：情绪。

孕期和产后，母亲情绪波动很大。她需要有人听，有人接。

第三个 E：安全。

身体上的安全，是孕期不被伤害，不被冒险。心理上的安全，是在家里不会被指责，不会被羞辱，不会被威胁。

第四个 E：家务。

孩子出生以后，家务会成倍增加。如果家务仍然主要由母亲承担，她没有时间休息，更没有余力和孩子“来回”。

第五个 E：钱和时间。

生育和养育要花钱。母亲可能因为生育暂时中断工作，收入下降。如果家庭的经济压力很大，她会焦虑。父亲需要承担更多经济上的责任，同时也要给她时间。

这“五个 E”不是要你“替”母亲做事，而是要你让她有余力。

◆ 四、有证据吗

有。

第 7 章、第 17 章讲过，社会支持，特别是伴侣的支持，和孕期、产后较低的焦虑、抑郁有关。〔中：多项研究，第 7 章已讲〕

更具体的研究发现，父亲在产后参与更多的育儿和家务，母亲产后抑郁的风险更低，夫妻关系也更好。〔中：观察研究为主，不能完全排除，“关系好的夫妻，父亲本来就更愿意参与”这种可能〕

反过来，如果父亲自己也处在焦虑、抑郁中，他的支持会减弱。

研究发现，大约有百分之八到十的父亲，在孩子出生后的第一年出现抑郁，其中一部分在孕期就已经有了。〔中：第 17 章已讲，数字待核〕

而且父亲的抑郁和母亲的抑郁常常同时出现，互相影响。

这提醒我们：

父亲要托住母亲，同时也要留意自己。

后面第 29 章还会讲。

◆ 五、第二个位置：成为自己的回路

现在说第二个位置。

很多父亲对“成为母亲的 E”没有异议：“好，我多做点家务，多让她睡觉。”

可是做完这些，他还是觉得“和孩子没有关系”。

因为他只是在“帮忙”，没有在“来回”。

所以需要第二个位置：

成为孩子自己的一条回路。

什么意思？

意思是，你和孩子之间也要有自己的“你来我往”。

这条回路和母亲与孩子之间的不一样，也不是母亲的“辅助”，更不是“替代”。

它是独立的另一条路。

研究发现，父亲和孩子之间有一些独特的互动方式：

父亲更常和孩子玩身体的游戏：举高、翻转、追逐。这种带点“冒险”意味的玩法，可能有助于孩子学会控制兴奋、应对不确定。〔中：拉姆等人的研究和后来的研究指出了这种倾向。不是所有的父亲都这样，母亲也会这样玩，不要把它当成性别的“规定”〕

父亲说话的方式有时和母亲不同：更少用高音调的“妈妈语”，更多用平常的词汇。有研究认为，这可能让孩子接触到更丰富的词汇。〔中：个别研究，细节有争议，待核〕

更重要的是，父亲和孩子之间形成的依恋。

一项汇总了三十年研究的元分析发现，父亲的“敏感性”和孩子对父亲的安全依恋之间有关联，不过关联比较小。〔中：卢卡森等 2011 年的元分析，发现相关系数在 0.1 左右，待核〕

这个“小”怎么理解？

一个可能的解释是：在很多家庭里，父亲和孩子单独相处的时间较少，所以他的“敏感性”对依恋的影响也较小。

也就是说，想成为孩子真正的一条回路，关键是时间，和单独。

◆ 六、不替代，也不缺席

现在，我们可以用一句话概括父亲的两个位置：

位置一，在母亲的 E 里：不替代母亲，让她被托住。

位置二，在自己的回路里：不缺席孩子，成为他的另一条路。

这两个位置有一个常见的陷阱。

陷阱是“守门人”。

什么是守门人？

在一些家庭里，母亲会不自觉地“守着”孩子：觉得只有自己才能把孩子带好，对父亲的做法不满意，当面纠正，甚至把孩子接回去。久而久之，父亲就退出了。

这样的现象，在研究里叫“母亲的守门行为”。研究发现，它和父亲较低的参与度有关联。〔中：多项研究，因果关系，是双向的〕

反过来，也有“父亲的守门”：

父亲不愿意做某些事，用“我不会”“我做得不好”躲开，或者用“你比较会”把所有的照料推给母亲。

这两种，本质上是同一个循环：

母亲不放手，父亲就不学。父亲不学，母亲就更不放手。

怎么打破？

对母亲：

允许父亲做得和你不一样。只要安全，就让他用他的方式。

不要当面纠正。如果需要沟通，等事后用“我觉得……”的方式，而不是“你怎么又……”。

对父亲：

不要说“我不会”。没有人生来就会。你和母亲一样，也是边做边学。

主动承担一块完整的责任，不是“帮忙”。比如每天晚上，孩子的洗澡、哄睡，全部由你负责。

被纠正的时候，不要立刻反驳，先听。

◆ 七、一份自查：我现在站在哪个位置

下面八个问题，你可以在心里答“是”或“不是”。不计分，只是帮你看见自己。

- 一，今天有没有一件事，是我不用她提醒就做了的？
- 二，这周有没有一段时间，是我和孩子单独待着的？
- 三，我知道孩子现在每天吃几次，睡几次吗？
- 四，我知道她这周最累的是哪一件事吗？
- 五，我最近一次问她“你还好吗”，是哪一天？
- 六，我有没有给自己留一个出口：朋友，运动，睡觉？
- 七，孩子哭的时候，我是先看她，还是先试着自己哄？
- 八，这个月我们有没有对过一次账？

答“是”越多，说明你离“负责”越近。答“不是”的，挑一条，这周先做。

这份自查不是评分表，不能说明你是不是一个“好爸爸”。〔解释：本书自拟的提醒清单，没有经过检验〕

◆ 八、帮忙和负责，五个 E 里各是什么样

第 28 章会细讲“帮忙”和“负责”。这里先放一张对照表，让你一眼看出差别。

五个 E	帮忙	负责
睡眠	她说太困了，你才去抱孩子	你和她商量好哪几晚归你，到点就接班

五个 E	帮忙	负责
情绪	她哭了，你说“别哭了”	你每天问一句，听完说“我在”
安全	她要去产检，你说“你自己去吧”	你把产检记进自己的日历，能去就去
家务	她说碗没洗，你去洗	晚饭后的碗是你的，不用提醒
钱和时间	她问钱够不够，你才去算	你每月主动对一次账，也把周六上午留出来

右边一列有一个共同点：不用她开口。

左边一列也不是坏。很多人是从左边开始的。

从左走到右，是一个慢慢学会的过程，没有人一步就到。〔解释：本书的对照，不是测验〕

一个简单的办法：每周挑一行，从左边换到右边。一个月以后，你就有了四行。

◆ 九、开口的三句话

很多事卡住，不是不想做，是不知道怎么开口。

下面三句话，可以直接拿去用。

第一句，对她说，用在你想接下一块事的时候：

“从这周起，每晚的洗澡和哄睡归我。你不用管，我做完告诉你。”

第二句，对她说，用在你需要空间试一试的时候：

“我可能做得和你不一样。只要孩子安全，你先别纠正，事后我们再聊，好吗？”

第三句，对自己说，用在你想退出的时候：

“我不会，所以我要学。她也是这样学的。”

三句话有一个共同点：说的是“我要做什么”，不是“你该怎么样”。

这样的说法更不容易让对方先防备起来。〔中：伴侣沟通里常见的建议，效果因人而异〕

◆ 十、工作日也有办法：一周的样子

很多父亲会说：“这些道理我懂，不过我每天要上班。”

这是实话。所以本书给一张“上班族的一周”示例。假设你早上九点出门，晚上七点半到家。

星期	固定动作	大约多久
周一	进门先抱孩子十分钟；晚饭后洗碗	三十分钟
周二	孩子洗澡归你	三十分钟
周三	孩子洗澡归你；睡前读一本书	四十分钟
周四	晚饭后洗碗；问她“今天最累的是什么”	二十分钟
周五	孩子洗澡归你；和她对一次家里的账	四十分钟
周六	上午带孩子出门，她睡觉或做自己的事	三小时
周日	开十五分钟的家庭会议，安排下周	十五分钟

这张表加起来，一周大约六小时。

六小时不算多，却足够让你有属于自己的一块事。

这只是示例，不是标准答案。你的班次、孩子的月龄、家里的人手都不一样。把它当成草稿，改成你家的样子。〔解释〕

◆ 十一、做不到的时候：降级版本

有的周，你一定会做不到。出差，赶项目，自己生病。

这时候不要“全有或全无”。本书建议，每件事都准备一个小一号的版本。

原来的做法	降级以后
孩子洗澡归你	视频里给孩子唱一首晚安歌
周六上午单独三小时	周日单独一小时
夜里接班	只接一个晚上，提前说好是哪一晚
每天问“你最累的是什么”	发一条消息：“今晚我想听你说说。”
家庭会议十五分钟	五分钟，只问“下周哪件事最重”

最小的一条是：进门先抱孩子十分钟。

连这个都做不到的日子，发一条消息说清楚：“今晚我真的回不去，明天我早点到家。”

说清楚本身，就是一种托住。

原则是：宁可小，也不断。固定的小事，比偶尔的大事更容易被孩子和伴侣“接成路”。〔解释：本书的建议；规律胜过时长的理由见第 19 章〕

◆ 十二、父亲的位置，也是一个“功能”

最后，用本书一贯的说法来收束：

“父亲”和“母亲”一样，是一个位置，不是一个身份。

一个家里，如果没有生物学上的父亲，别的人也可以承担这个位置：祖父、舅舅、养父、伴侣、朋友。

“父亲的功能”是什么？

是托住那个主要照料者。

是成为孩子的另一条回路。

谁做这件事，谁就是那个位置上的人。

这一点，第 30 章会更详细地讲。

◆ 十三、老周的一句话

江远的同事老周，三十八岁，做销售，常年出差。

有一次中午吃饭，老周说：“我在家的时间一个月才十来天。带孩子的事，我是插不上手的。”

江远想了想，说：“你出差的时候，晚上跟孩子视频过吗？”

“偶尔。她睡得早，我时差对不上。”

“那你回家的那几天呢？”

老周愣了一下：“回家了就想睡觉。”

江远没有劝他。他只是说了自己的做法：每周六那三个小时，什么都不看，就带孩子出门。

过了两个月，老周来找江远。他说，他定了一个规矩：出差在外，每晚八点前，给孩子录一段十秒的语音，说一句晚安。回家那几天，每天早上由他负责给孩子穿衣服。

“很小的事。”他说。

“小的事，才做得久。”江远说。

这一幕里有一个道理：

常出差的父亲不是没有位置，只是位置要缩得更小、更固定。〔解释：本书的读法；第 30 章还会讲远行〕

◆ 十四、周三晚上的加班

有一个周三，江远下午四点收到通知：晚上要开一个紧急会议。

周三是他给孩子洗澡的日子。

他看着日历，想了一分钟。

他没有直接回“好”。他先给苏晴发了一条消息：

“今晚要加班，大概九点到家。洗澡我周四补上。你先吃饭，不用等我。我回来接夜里的第一班。”

苏晴看到消息，回了一个字：“好。”

过了一会儿，她又发了一句：“谢谢你提前说。”

那天晚上，江远九点二十到家，换了衣服，接过孩子，让苏晴去睡。

第二天，他把洗澡补上了。

后来苏晴对朋友说，她在意的不是他加不加班，是他有没有“记着”。

这一幕里有一个道理：

“负责”不是永远不出差错，而是出了差错的时候，先想办法补上，而不是消失。

◆ 十五、一个“不一样”的晚上

江远接手洗澡的第二周，苏晴站在浴室门口，差点又伸手。

他给孩子洗澡的顺序和她不一样。他先洗头，她先洗脚。他的歌也唱得跑调。

她咬了咬嘴唇，想起那天晚上说好的话，退后了一步。

孩子在水里拍着水花，笑得很大声。

苏晴发现，孩子笑不笑，和顺序没有关系。

洗完，江远用大毛巾把孩子裹起来，抱出来给她看。

“你看，”他说，“我洗得对吧。”

她说：“水有点烫，下次凉一点。其他都很好。”

江远点头：“好。”

事后她心里有一个小小的变化：她不用再一个人想着“水温对不对”，因为现在有两个人想着。

这一幕里有一个道理：

只要安全，“不一样”就是孩子多拿到的一条路，不是错。

◆ 十六、常见的几个问题

问：爸爸是不是只能做“帮手”？

答：不是。“帮手”是很多父亲的起点，不是终点。你把一块事从头到尾接过来，比如每晚的洗澡和哄睡，你就从帮手走到了位置上。〔解释：本书的读法〕

问：妈妈比我更懂孩子，我是不是多余？

答：不多余。妈妈熟悉得多，常常是因为陪的时间多。研究里，独自照料孩子的时间越多，父亲对孩子的信号越敏感。〔中：第 29 章已讲，因果可能双向〕熟悉是练出来的。

问：我工作太忙，怎么办？

答：先看上面的一周示例和降级版本。固定比长更重要。如果连固定也做不到，请和伴侣坦率谈一次，一起想办法，不要默默缺席。〔解释〕

问：孩子先叫“妈妈”，不叫我，我是不是输了？

答：这不是比赛。孩子早期发出的“ba”“ma”一类的音都很常见，先叫谁，常常和谁的称呼被重复得多有关。〔待核：个别观察，细节待核〕先叫谁，不能说明谁更重要。

问：妻子不放手，什么都要自己来，怎么办？

答：先别争。选一件小事，比如洗澡，对她说：“这件我想试着全包，你先不要管，做完我们再聊。”放手需要信任，信任来自你一次又一次做成。

〔解释：守门行为的因果是双向的，见本章第六节〕

问：我是继父，不是孩子的亲生爸爸，也有这个位置吗？

答：有。位置看的是你做什么，不看血缘。你稳定地在，敏感地回应，出了偏差就回来，孩子就会把你当成一条回路。〔中：孩子可以对多个照料者形成依恋，第 13 章已讲〕

问：她在旁边盯着我带孩子，我很紧张，怎么办？

答：紧张是正常的，被人看着，谁都容易手忙脚乱。可以约定：你带的时候，她去另一个房间，或者出门一小时。需要帮忙时，你主动叫她。这样你练习的是自己的节奏。〔解释〕

问：老人说“男人不用带孩子”，我该听吗？

答：老人的话里常有一份心疼，也有一个时代的习惯。你可以先说一句“您说得对，您那时候辛苦”，再说你的决定：“我想自己带一块，学一学。”这不是和老人作对，是在做你的事。〔解释：各家情况不同〕

问：我带孩子的时候，常常觉得无聊，是不是我不爱他？

答：不是。照料婴儿本来就有重复、安静的一面，很多照料者都有过无聊的时刻。〔中：照料者的这种感受并不少见，细节待核〕无聊不等于不爱。试着把无聊的时间用来说话：说你在做什么，看到什么。

◆ 十七、放回日子里

那天晚上，苏晴对江远说了她这些天想的事。

“你问我你算什么，我想了想。”

她坐直了一点：“你有两件事，是别人没法替你做的。”

“哪两件？”

“第一件，我累的时候，你托着我。让我睡觉，吃饭，哭，也有人接着。”

江远点头。

“第二件，”她说，“你和他单独待着。就你和他，我不在。”

“可是我怕我做不好。”

“你肯定会做得不一样。”她说，“可是不一样没关系。”

江远沉默了一会儿，说：“我每个周六上午带他出去，三个小时。你睡觉，或者随便干嘛。”

“好。”

“我不看手机。”

“好。”

苏晴笑了：“你这就有了一个位置。”

带走的话

父亲有两个位置：在母亲的 E 里，托住她；在自己的回路里，成为孩子的另一条路。不替代，不缺席。“帮忙”不算位置。“负责一块完整的事”才算。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
伴侣支持与较低的孕期、产后焦虑抑郁相关	〔中〕	多项研究，第 7、17 章已讲
	〔中〕	观察研究，不能排除选择效应

说法	证据级别	说明
父亲更多参与育儿和家务，与母亲产后抑郁风险更低相关		
约 8%—10% 的父亲在第一年出现抑郁，母亲抑郁常与之同时出现	〔中〕	第 17 章已讲，数字待核
父亲更常进行身体游戏，对孩子学会控制兴奋可能有帮助	〔中〕	拉姆等人的研究，非性别规定，部分结论有争议
父亲与母亲说话方式不同，可能让孩子接触更多词汇	〔中〕	个别研究，待核
父亲敏感性与孩子对父亲的安全依恋有较小的关联	〔中〕	卢卡森等，2011 元分析，数字待核
母亲的守门行为与父亲较低的参与度相关	〔中〕	多项研究，因果双向
“五个 E”：睡眠、情绪、安全、家务、钱和时间	〔解释〕	本书的方法论归纳
父亲的两个位置：成为母亲的 E，成为自己的回路	〔解释〕	本书的理论读法
带孩子时觉得无聊并不少见，无聊不等于不爱	〔中〕	细节待核
约定“你带的时候她走开”，让你练自己的节奏	〔解释〕	本书的建议
自查八问	〔解释〕	本书自拟的提醒清单，未经检验，不是评分表
常出差的父亲把位置缩小、固定	〔解释〕	本书的读法，第 30 章还会讲
帮忙与负责在五个 E 里的对照表	〔解释〕	本书的对照，不是测验
“开口的三句话”：说“我要做什么”，更不易引起防备	〔中〕	伴侣沟通中的常见建议，效果因人而异
上班族的一周示例，合计约六小时		示例，按各家情况修改

说法	证据级别	说明
	〔解释〕	
降级版本，“宁可小，也不断”	〔解释〕	本书建议，规律胜过时长的理由见第 19 章
独自照料时间越多，父亲对信号越敏感	〔中〕	第 29 章已讲，因果可能双向
孩子可以对多个照料者形成依恋，不看血缘	〔中〕	第 13 章已讲
孩子早期发“ba”“ma”类音，先叫谁与称呼重复多少有关	〔待核〕	个别观察，细节待核
出了差错先补上、提前说清楚，对伴侣是一种托住	〔解释〕	本书的读法
洗澡、哄睡的顺序不同，只要安全，对孩子是多一条路	〔解释〕	本书的读法

个体情况，比如夫妻关系中的暴力和威胁、父亲的抑郁焦虑，请及时寻求专业帮助。

第 28 章

成为母亲的 E：一张父亲的每日清单

◆ 一、一个“帮忙”的下午

孩子五个月大的时候，有一个周日下午，苏晴在卧室睡觉，江远在客厅带孩子。

他很努力。孩子哭，他抱着走。孩子吐奶，他换衣服。孩子闹，他放音乐。

到下午四点，他累得满头大汗，孩子也终于睡着了。

他在沙发上坐了一会儿，想：“我今天做得不错吧。”

苏晴睡醒，从卧室走出来，看到客厅一团糟，奶瓶、衣服到处都是。她没说话，去厨房倒水。

江远看着她的背影，说：“我今天一直带着他。”

苏晴回头看了他一眼，说：“我知道，谢谢。”

她声音很平。

那天晚上，江远有点不舒服。他觉得自己做了很多，却没有得到“应该有的”认可。

后来他才明白：

他是在“帮忙”，他等着被夸。而苏晴每天做的是“负责”。

“帮忙”和“负责”不一样。

这一章讲怎么从“帮忙”变成“负责”，具体做什么。

◆ 二、“帮忙”和“负责”的区别

先把这个区别讲清楚。

“帮忙”的意思是：这件事本来是她的，我来搭把手。

“负责”的意思是：这件事是我的，我从头到尾管。

举几个例子：

“帮忙”：她说“孩子的尿布没了”，你去买。

“负责”：你知道孩子的尿布还剩多少，什么时候要买，没了之前就买好了。

“帮忙”：孩子哭了，她在忙，你去哄。

“负责”：晚上孩子的洗澡、哄睡是你的事，每天不用她说，你就做。

“帮忙”：你对她说，“你需要我做什么，告诉我。”

“负责”：你自己看家里有什么事没人做，就去做。

“帮忙”是把“管理”留给她，你只是执行。

“负责”是把“管理”也接过来。

这叫“心理负荷”，或者“隐形劳动”：不是做了多少件事，而是在“记着”这些事。

研究发现，在很多家庭里，即使父亲做了不少具体的家务，“记着”“规划”“安排”的这部分，仍然主要落在母亲身上。这部分常常是母亲疲惫的重

要来源。〔中：关于家务中的“认知劳动”，有一些社会学研究，质量参差，结论大体一致〕

所以，成为母亲的 E，最关键的一步是：

把“管理”接过来一部分。

◆ 三、孕期，父亲的每日清单

先说孕期。

孕期，母亲需要被托住的，主要是身体和情绪。

下面是一张每日、每周的清单。不是必须全做，而是让你有具体的东西可以做。

频率	做什么	对应的 E
每天	陪她做“十分钟”：把手放上去，说几句话	情绪
每天	问她一句：“今天睡得怎么样？有什么让你不舒服吗？”	情绪
每天	晚饭后你洗碗、倒垃圾	家务
每天	孕晚期陪她数一次胎动，或者听她说结果	安全，情绪
每周	陪她散步，至少两次，每次三十分钟	情绪，安全
每周	安排一个晚上不加班，让她早点睡	睡眠
每周	和她一起查看下周的产检、安排	安全
每次产检	能去就去，记医生的话，问她想问的问题	安全
每月	和她对一次家里的钱：开销、计划、有没有压力	钱

这里有一条需要特别说：

产检尽量陪。

研究发现，父亲参与产检，可以增加父亲对孕期的了解，增强对胎儿的情感联系，也让母亲更有被支持的感觉。〔中：观察和一些干预研究，具体证据，有限〕

可是更重要的不是数据，而是在场。

她在候诊室坐着，你在她旁边。医生说了一个她听不懂的词，你帮她问。她紧张，你握着她的手。

这些没有一样是“大事”。可是加在一起，就是“稳”。

◆ 四、产后，父亲的每日清单

产后需求更大。

频率	做什么	对应的 E
每天	负责一个固定的“班”：比如晚上十点到凌晨两点，孩子归你，她睡	睡眠
每天	负责孩子的洗澡，或者哄睡	家务，睡眠
每天	回家后不看手机，先抱孩子十分钟，让她歇一下	睡眠，情绪
每天	问她一句：“今天你最累的是什么？”	情绪
每天	负责一餐饭，或者买饭，保证她吃好、喝够水	家务
每周	带孩子单独出去两到三个小时，让她一个人待着	睡眠，情绪
每周	做一次“家庭会议”：十五分钟，说这一周谁累了，下周怎么分	家务，情绪
每月	带她出去吃一次饭，只有两个人，让她感到自己不只是“妈妈”	情绪
随时	留意她的状态，如果持续低落两周，陪她去看医生	安全

这张表里有几条，值得多说几句。

一，“班”。

夜里是新手父母最难熬的时候。很多家庭，夜里是母亲一个人起来。

一个很好用的办法是“分班”。比如晚上十点到凌晨两点，你负责孩子，她戴耳塞睡觉。凌晨两点以后，换她。

如果母亲在母乳喂养，夜里需要喂奶，你的“班”可以是这样：孩子醒来，你先起来，换尿布，抱给她。喂完，你再接过去，拍嗝，哄睡。这样她只需要醒来十五分钟，而不是一个小时。

研究发现，产后母亲睡眠被打断得越多，抑郁的风险越高。保证她有连续几个小时的睡眠，是很有价值的。〔中：睡眠剥夺与产后抑郁的关系，有较多观察研究，因果关系，较难证明〕

二，“不看手机，先抱孩子”。

这一条听起来很小，可是很多母亲说，这一条最有用。

她一整天没有任何喘息。你一进门就把孩子接过去，哪怕十分钟，让她去洗个脸，喝杯水。这传达的是：我看见你了。

三，“你今天最累的是什么？”

这个问题比“你今天累不累”更好。“累不累”只能回答“累”或“不累”。“最累的是什么”，让她有机会具体地说出来。

你只需要听，不需要解决。

听完，说一句：“嗯，那确实很累。”

这就够了。

◆ 五、家庭会议怎么开：十五分钟，五步

“家庭会议”听起来很正式，其实就是每周十五分钟，两个人坐下来说话。

时间固定，比如周日晚上孩子睡了以后。地点固定，比如餐桌。手机放远一点。

一共五步：

第一步，先说一件对方做得好的事。一句就够。

第二步，各自说这一周最累的一件事。每人一分钟，另一个人不打断。

第三步，把“事”摊开。列出这一周的事：谁做了，谁记着，哪些没人管。

第四步，只改一件。下周只调整一件，改多了做不到。

第五步，约好下次的时间，结束。

会议里不翻旧账，也不比谁更累。

开头可以这样说：

“我想和你花十五分钟，看看这周我们怎么分的。不是要吵，是想让你轻松一点。”

如果谈着谈着火气上来了，先约好一个暂停的办法：一个人说“我需要十分钟”，两个人各自走开，十分钟以后再回来。〔中：伴侣沟通中常用的“暂停”做法，效果因人而异〕

◆ 六、一次没吵起来的会议

第一次家庭会议，是在一个周日晚上。

江远带了一张纸，上面列着他这周做的事。苏晴看了一眼，心里有点不舒服。

她想说：你列的都是“做完了”的事，那些“记着”的事呢？

她忍了一下，按约定先说一句好话：“这周洗澡你每天都做了，我看到了。”

江远愣了一下。他本来准备好了防守。

轮到说累的事，苏晴说：“我最累的是夜里两点以后。还有，每天要想孩子明天要做什么，该买什么。”

江远没有打断。他拿笔记下来：“夜里两点以后。采购。”

他说：“采购我接过来。每周日我列单子，我来买。”

苏晴点头。只改一件。

两个人坐了十四分钟。

散会时，苏晴说：“比我想的轻松。”

江远说：“我也是。我本来以为你会骂我。”

苏晴笑了：“我本来也以为你会生气。”

两个人都以为对方会生气。

这一幕里有一个道理：

很多吵架没有发生，是因为有人先说了一句好话，又给了谈话一个固定的形状。〔解释：本书的读法〕

◆ 七、怎么说话：有用的，和没用的

很多父亲做了很多，可是说的话抵消了做的事。

下面是一些常见的“没用”的话，和替代的说法。

没用的话	为什么	换成
“你别想太多。”	否定了她的感受	“你这么想，我听着。”
“不是都挺好的吗？”	把她的难处说成“不存在”	“我不太懂，你能再说说吗？”
“你需要我做什么，告诉我。”	把“管理”留给了她	“我今晚把孩子接过去，你睡。”
“我妈那时候也这样带的。”	在比较	“我再想想怎么能让你轻松点。”
“你怎么又哭了？”	指责	“我在这儿。”
“别人家都这样啊。”	在比较	不说
“你在家不用上班，多轻松。”	否定她的劳动	“我知道你一天很不容易。”

这张表不是要你每一句都背下来。

它只想告诉你一件事：

在她累的时候，她需要的不是“解决方案”，不是“道理”，不是“比较”。

她需要被听见。

◆ 八、听她说话：三个小练习

“听”听起来简单，做起来不容易。下面三个小练习，每个一分钟。

练习一，复述。她说完以后，你用自己的话说一遍：“你是说，今天最难的是下午孩子一直不睡。”说对了，她会点头。

练习二，只问不答。她说完，你问一句：“还有吗？”再问一句：“那时候你是什么感觉？”先不给办法。

练习三，放下手里的东西。她开口的时候，放下手机，转过身，看着她。

这三件事，每一件都不需要你多聪明。

需要的，只是在那一分钟里，你的注意力在她身上。〔解释：本书的建议；“被听见”的重要性见上面“怎么说话”一节〕

◆ 九、一张分工表：谁记着，谁做

会议上最有用的，是一张写下来的分工表。重点是“谁记着”，不只是“谁做”。

事项	谁记着	谁做	备注
孩子洗澡、哄睡	江远	江远	每晚固定
采购：尿布、奶粉、湿巾	江远	江远	每周日列单子
预约和陪同产检、体检	两人	两人	记进双方日历
晚饭后的碗	江远	江远	不用提醒
孩子的衣物换季	苏晴	两人	下个月再议
家里的账	两人	每月对一次	周日会议后

表里最关键的一列是“谁记着”。

只有“做”的人换了，“记着”的人没换，累的那个人还是累。〔中：本章第二节已讲“认知劳动”〕

表可以每个月改一次。改不是因为谁做错了，是因为孩子在长，日子在变。

◆ 十、工作日和周末的十分钟清单

工作日的晚上，时间很紧。把要做的压缩成几件十分钟以内的小事。

时段	十分钟里做什么
进门后	先洗手，抱孩子十分钟，让她去洗个脸
晚饭时	问一句“今天最累的是什么”，只听
晚饭后	洗碗，顺手看一眼尿布、奶粉、湿巾还剩多少
睡前	孩子洗澡或哄睡，看她今晚要不要早点睡
最后	看一眼明天的安排，有没有哪件事需要你记着

周末有更多时间，可以做得慢一些。

时段	做什么
周六上午	单独带孩子三小时，她休息
周六下午	两个人做一件事，比如散步，不谈孩子的“问题”
周日白天	做一次采购，备好下周要用的东西
周日晚上	十五分钟的家庭会议

这两张表都是示例。你家怎么排，自己定。〔解释〕

◆ 十一、家里的长辈

在很多家庭里，除了夫妻两个，还有长辈。

对父亲来说，这里有一个很特别的位置：夹在中间。

一边是母亲，一边是你的妈妈。

很多婆媳矛盾，实际上是两种育儿观念的碰撞，加上“谁说了算”的争夺。

这个时候，父亲有一个很重要的角色：

挡在前面。

什么意思？

不是替母亲去吵架，而是做一个明确的“边界”：

对你的妈妈说：“妈，这是我们两个人商量的决定。”

你妈妈批评苏晴的时候，你要当面维护：“妈，她已经很辛苦了。”

事后再私下对你妈妈说：“您累了，我知道您是为我们好。可是这个我们想自己试试。”

这不是“站在哪一边”，这是在保护你的小家。

研究发现，对新手母亲来说，来自丈夫的支持，比来自其他家人的支持，对她的心理健康影响更大。〔中：一些研究支持，不同文化里结果略有差异，待核〕

当然，长辈不是“敌人”。在第 17 章，苏晴的婆婆让她睡了四个小时。长辈常常是最有力的帮手。

关键是：让他们帮在“稳”上，而不是帮在“规矩”上。

◆ 十二、对长辈说的几句话

上一节讲了“挡在前面”。这里给几句具体的话。

长辈批评的时候，先说谢意，再说决定：

“妈，您带孩子经验多，我们知道。这件事我们商量过了，想先这样试试。”

长辈想插手喂养或睡觉安排的时候：

“这个我们想自己来。您要是想帮忙，周六下午帮我们看两个小时孩子，让我们出去走走，那就最好了。”

长辈拿“我们那时候”来比较的时候：

“您那时候很不容易，我知道。现在医生的建议有些不同，我们按现在的来。”

有一个提醒：对自己的父母，由你来说，不要让妻子去说。

对岳母同样：由苏晴来说，江远在旁边明确支持。

这样做，是为了不让它变成“婆媳之争”，而是“我们和长辈商量”。

〔解释：本书的建议，各家情况不同〕

不过，有几件事要说死，不留余地：婴儿不能被摇晃，不能被打骂，睡觉要仰睡在平整的床面上。〔强：第 23 章已讲摇晃的危险；婴儿安全睡眠的通行建议〕

其他的事，可以放宽。

◆ 十三、你自己，也要稳

最后，一个提醒：

要托住别人，先稳住自己。

你也会累，会烦，会焦虑。你可能有工作的压力、经济的压力。你可能也不知道怎么当爸爸。

这些都是真的。

所以，请也给自己一些出口：

跟朋友聊一聊。

运动。

睡觉。

如果持续情绪低落、易怒、失眠，对孩子没感觉，酒喝得越来越多，请也去看医生。

父亲也会抑郁。第 17 章说过，这不是软弱。

◆ 十四、岳母的一碗汤

苏晴的妈妈来住了一个星期。

第三天，老太太看见江远在给孩子洗澡，站在门口说：“水温试了没有？男人手重，别烫着。”

江远手停了一下。他有点想回一句。

他想起了那几句话，擦干手，走过去，说：“妈，您说得对，我每次都用手腕试。您坐，我洗完陪您说话。”

老太太没再说什么。

晚上，苏晴小声问他：“你刚才怎么没生气？”

江远说：“她是怕孩子烫着，这个心是对的。我只要把水温试给她看就行了。”

第二天，老太太炖了一锅汤，盛了一碗给江远，说：“你也辛苦。”

这一幕里有一个道理：

长辈的话常常藏着一份担心。先接住担心，再说你的做法，比争对错更省力。〔解释：本书的读法，各家情况不同〕

◆ 十五、做不到的时候：降级版本

清单不是考试。做不到的日子，用小一号的版本。

原来	降级
一个完整的夜班	只接夜里的一次喂奶，先起来换尿布
每天问“你最累的是什么”	一周问三次
十五分钟家庭会议	五分钟，只说“这周最难的一件事”
负责一餐饭	买现成的，或叫外卖，你来付款、摆桌
带她出去吃饭	在家点一份她爱吃的，孩子睡后一起吃

最小的版本，是进门抱孩子十分钟。

把降级的事提前告诉她，是关键。她知道你做不到，和她以为你忘了，心里的感觉完全不同。〔解释〕

◆ 十六、常见的几个问题

问：怎么跟妻子谈分工，才不会吵起来？

答：用上面的家庭会议。先说一句好话，各说一件累的事，只改一件。吵起来，多半是因为一次想谈太多。如果当面还是容易吵，可以先写下来，用文字谈。〔中：伴侣沟通的常见做法，因人而异〕

问：她说我做得不对，我很受伤，怎么办？

答：先别反驳，先问一句：“你希望我下次怎么做？”很多时候，“不对”背后是“我累了”。把话听完，再决定改不改。如果每次都被批评到失去信心，选一个平静的时候，说说你的感受。〔解释〕

问：我妈或者她妈插手太多，怎么办？

答：见上面对长辈说的话。分工很简单：谁的父母，谁去沟通。目标是让长辈帮在“稳”上，不帮在“规矩”上。

问：她情绪很低落，我该怎么陪？

答：先陪着，少讲道理。可以问：“你想说，还是想让我在旁边坐着？”如果低落持续两周以上，或者她说出不想活、想伤害自己或孩子的念头，请马上带她去看医生，或拨打当地的心理援助热线。这不是靠陪伴就能解决的事。〔中：产后抑郁并不少见，早发现早治疗，第17章已讲〕

问：夜里到底谁起来？

答：没有唯一答案。母乳喂养的家庭，常见的做法是你先起来换尿布，抱给她，喂完你再接过去哄睡。奶粉喂养的家庭，可以按“班”轮流。关键是提前说好，不靠半夜临时商量。〔解释：本书的建议〕

问：是不是我该“替她做主”，让她什么都不用想？

答：不是。让她“不用想”，是指你接过来一块事，不是替她做所有决定。孩子的大事，仍然两个人商量。〔解释〕

问：我加班太多，清单一样也做不了，怎么办？

答：先做降级版本，再和她谈。谈的时候不要找借口，只说事实：“这个月我加班多，我想想哪几件事能保住。”保住一件，就比一件也没有强。〔解释〕

问：我们两个都累坏了，一说话就吵，怎么办？

答：先睡觉。睡眠不足的时候，人更容易发火，也更容易把一句话听成指责。〔中：睡眠不足与易激惹、情绪调节变差相关，观察研究较多〕先把一个人的觉保住，等睡过一轮再谈。

问：她夜里总是比我先醒，我睡得太沉怎么办？

答：可以把闹钟放在你那一侧，或者约好“班”，到点由你起。很多母亲对孩子的动静更警觉，这和激素、习惯都有关系，不是你不关心。〔待核：个体差异大，机制待核〕重要的是有一个事先约好的办法。

◆ 十七、放回日子里

江远在那个“帮忙”的周日之后，做了几个改变。

他在手机上设了一个闹钟，每天晚上八点是孩子的洗澡时间。从那时起，一直到孩子睡着，是他的“班”。

他做了一张小小的表，贴在冰箱上，写着每天、每周要做的几件事。

他开始每天回家先抱孩子十分钟。

苏晴一开始没说什么。

两个星期以后，有一天晚上，孩子睡着了，她靠在他肩上，说：“我好像没那么累了。”

江远问：“为什么？”

她想了想，说：“因为我不用再一个人‘记着’了。”

他没有说话，只是把她的手握紧了。

带走的话

“帮忙”是执行，“负责”是管理加执行。做五个 E：睡眠、情绪、安全、家务、钱和时间。每天、每周有清单。她累的时候，需要的不是办法，是被听见。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
家务中的“认知劳动”仍主要落在母亲身上	〔中〕	社会学研究，质量参差，大体一致
父亲陪产检增强对胎儿的情感联系，母亲更有被支持感	〔中〕	观察和少量干预研究，证据有限
产后睡眠被打断越多，抑郁风险越高	〔中〕	观察研究，因果难证
来自丈夫的支持，对新手母亲心理健康的影响，大于来自其他家人的支持	〔中〕	部分研究，文化差异，待核

说法	证据级别	说明
每日、每周、每月清单，“分班”“不看手机先抱孩子”	〔解释〕	本书的方法论建议，没有整套检验
睡眠不足时更容易发火，也更容易把话听成指责	〔中〕	观察研究较多，因果难证
母亲夜里更易先醒与激素、习惯有关	〔待核〕	个体差异大，机制待核
一张分工表：写清“谁记着”“谁做”	〔解释〕	示例，认知劳动的背景见本章第二节
“听她说话”三个小练习：复述、只问不答、放下手机	〔解释〕	本书的建议
先接住长辈话里的担心，再说自己的做法	〔解释〕	本书的读法，各家不同
家庭会议：每周十五分钟，先说一件好事，只改一件	〔解释〕	本书建议，沟通研究中有类似做法
“暂停十分钟”再谈	〔中〕	伴侣沟通中的常用做法，效果因人而异
工作日、周末的十分钟清单	〔解释〕	示例，按各家情况修改
对长辈的几句话；谁的父母谁沟通	〔解释〕	本书建议，各家不同
婴儿不可摇晃、不可打骂、仰睡平整床面	〔强〕	第 23 章已讲；婴儿安全睡眠的通行建议
降级版本与提前告知	〔解释〕	本书建议
低落持续两周以上或有伤害自己、孩子的念头，应看医生或求助热线	〔中〕	第 17 章已讲；产后抑郁并不少见，早发现早治疗
夜里分班办法（母乳、奶粉两种情形）	〔解释〕	本书建议，没有整套检验

个体情况，比如夫妻关系中的暴力和威胁、母亲或父亲持续情绪低落，请及时寻求专业帮助。

第 29 章

成为自己的回路：父亲和孩子之间的那条路

◆ 一、周六上午的三个小时

江远第一次带孩子单独出门，是孩子六个月的那个周六。

他早上起来，把孩子的东西一样一样往包里装：尿布、湿巾、奶粉、水、替换的衣服、一块小毯子。苏晴在旁边，想说点什么，忍住了。

他抱着孩子到门口换鞋。

孩子看着他，忽然哭了。

苏晴的手已经伸出去了。江远说：“我来。”

他把孩子抱得紧了一点，在门口站了几分钟，轻轻地晃，说：“爸爸在，爸爸在。”

孩子慢慢安静了。

他们出了门。

三个小时后，他们回来了。孩子在他怀里睡着了。江远满头是汗，衬衫湿了一块，是孩子吐的奶。

苏晴一个人在家里睡了两个半小时。

她醒来的时候，看着他们从门口进来。

她没说话，笑了。

这一章就讲这个“周六上午”意味着什么，怎么做。

◆ 二、为什么“单独”很重要

第 27 章讲过：要成为孩子的一条回路，关键是时间和单独。

为什么“单独”这么重要？

因为只要母亲在场，孩子就会找母亲，大人也会不自觉地把“管理”交给母亲。

父亲在母亲在场的情况下，常常是“二把手”：孩子哭，看母亲。父亲不知道该怎么办，看母亲。母亲伸手，接过去。

只有母亲不在，父亲才会被迫自己去读孩子的信号，自己去猜，自己去试，自己去修复。

这个过程很难，很笨拙，很容易让人沮丧。可是这恰好是学习的过程。

研究发现，父亲独自照料孩子的时间越多，他对孩子的信号越敏感，参与度也越高。〔中：一些研究发现，“独自照料”是父亲敏感性和投入度的重要预测因素，因果关系可能是双向的〕

所以，本书对父亲最重要的一个建议是：

每周至少有一段固定的时间，你和孩子单独。

不是“母亲在旁边，你在带”，而是母亲不在，只有你和他。

◆ 三、从孕期开始

回到孕期。

父亲在孕期能做的第一条回路是：

在“十分钟”里加入你的声音和你的手。

第 19 章讲过具体做法，这里只强调几点：

一，每天固定同一个时间。

二，手放上去，等一等。孩子如果踢，你轻轻压一下。

三，说你平时说话的声音。不要故意压低，也不要刻意用“童声”。

四，说你的日子：“今天我开了一个很长的会。”

五，念同一本书，或者哼同一首歌。孩子出生以后，如果你再哼这首歌，他可能会更熟悉。〔中：第 6 章，第 19 章已讲〕

很多父亲觉得对着肚子说话很傻。

没关系。刚开始觉得傻是正常的，坚持几个星期，就自然了。

有一个很有意思的研究发现，孕期父亲参与产前活动，比如产检、听胎心、看超声，对胎儿有“更多的想象”，产后也更多参与育儿。〔中：观察研究为主，因果关系，难以排除，选择偏差〕

不管因果怎么回事，这样做对你有一个确定的好处：

让你从孩子出生之前，就开始成为这个“来回”里的一部分。

◆ 四、出生后的第一条回路：皮肤、声音、气味

孩子出生以后，父亲有几件很具体的事可以做，是别人替代不了的。

第一，袋鼠式护理。

第 9 章讲过，不只是母亲，父亲也可以。

脱掉上衣，只穿一件背心，或者直接赤膊。把只穿尿布的孩子贴在你的胸口，用一块毯子盖住你们两个。

每次二三十分钟，到一个小时。

这样孩子会听到你的心跳，闻到你的气味，感到你的体温。

研究发现，父亲做过皮肤接触，对孩子体温、心率的稳定有帮助，也让父亲更觉得自己是孩子的重要的人。〔中：第 9 章已讲〕

第二，洗澡。

这是很多家庭里父亲最容易接手的一件事。

洗澡的时候，水是温的，孩子被轻轻地托着。你一边洗，一边说话，一边看着他的脸。

有一个很好的习惯：每天同一个时间，按同一个顺序洗，说同一些话。

比如从脚开始，一边洗一边说：“这是小脚丫。这是小腿。这是小肚子。”

这是触觉加声音的“来回”，也是一个稳定的仪式。

第三，哄睡。

孩子睡前需要一个固定的仪式：洗澡，换衣服，关灯，抱着唱一首歌，放下。

父亲可以把这一整套接过来，每天晚上由你负责。

孩子会慢慢地把这套仪式和你联系在一起。

第四，换尿布，喂奶瓶。

这两件事也是父亲可以做的重要的“面对面”时间。

不要一边换一边看手机。看着孩子的脸说话，等他回应。

◆ 五、孩子哭的时候：一个简单的排查顺序

不会哄，是很多父亲的第一道坎。本书给一个顺序，从最常见的原因查起。

顺序	看什么	怎么做
一	饿了吗	看上一次喂奶的时间，该喂就喂
二	尿布湿了吗	换
三	冷了还是热了	摸后颈，加或减一件
四	困了吗	抱着，光线调暗，轻声哼歌
五	想要抱吗	贴在胸口，慢慢走，轻轻拍背
六	都不是	哭个不停，或者发烧、不吃、没精神，请联系医生

婴儿有时找不到明显的原因也会哭，这并不少见。查完一遍还不知道，不是你做错了。〔中：婴儿哭泣常没有明确原因，细节待核〕

婴儿发烧、拒食、精神很差，需要及时就医。〔强：婴儿就医的通行建议〕

◆ 六、玩：父亲常常是那个“玩”的人

孩子大一点，三四个月，开始会笑，会咯咯地发出声音。

这时候，父亲的“玩”开始发挥作用了。

一些简单的玩法：

“飞机”：把孩子面朝下，托在你的前臂上，轻轻晃，说“嗡——”。

“举高高”：把孩子从胸前轻轻举起，又放下，注意要托稳头颈。

“躲猫猫”：和第 24 章一样。

“拍手，唱歌”：握着孩子的手拍。

“追”：孩子会爬，你也趴在地上，跟着他爬。

这些玩法让孩子笑得很大声。研究发现，这种有些“冒险”意味的身体游戏，在一些研究里，和孩子学习控制兴奋、调节情绪有关。〔中：第 27 章已讲，不是所有研究结果都一致〕

不过有一件事必须强调：

任何时候都不要猛烈地摇晃孩子，不要把婴儿抛到空中再接住。婴儿的颈部很弱，头部很重。游戏的时候，要始终托住头颈。

第 23 章讲过“婴儿摇晃综合征”。这里再说一遍，因为父亲的“玩”恰好是更容易出事的地方。

游戏也要“看显露”。

孩子笑，伸手要更多，就继续。孩子扭头、闭眼、皱眉、哭，就停。

玩是为了孩子高兴，不是为了让你觉得“我是个有趣的爸爸”。

◆ 七、不同月龄，父亲可以怎么玩

下面是一张常见的玩法表。孩子的发育快慢差别很大，这里只是参考。

大约月龄	可以玩什么	要留意什么
0 到 3 个月	近距离看脸，说话，唱歌，袋鼠式护理	动作要慢，时间要短
3 到 6 个月	躲猫猫，拍手，趴着抬头，轻轻举高	托住头颈，孩子扭头就停
6 到 12 个月	滚球，爬行追逐，藏玩具，拍鼓	地面清理，小物件拿开
12 到 18 个月	垒积木，蹲在水坑边看，推小车，指认东西	跟在身后一米，随时能扶

玩的核心不变：跟着孩子的显露走。他笑，就继续。他躲，就停。〔解释：本书对常见玩法的整理，发育有个体差异〕

小物件要拿开，是因为幼儿容易把东西放进嘴里，有窒息的风险。〔强：儿童安全的通行建议〕

◆ 八、玩的边界：能做的，和不能做的

下面这张表，请父亲和所有陪孩子玩的大人都看一遍。

可以	不可以
轻轻举高，始终托住头颈	把婴儿抛起来再接
轻轻晃着哄睡，动作小而慢	用力摇晃，哪怕只是想让他安静
趴在地上陪孩子趴着玩，大人始终在旁边	让孩子独自趴着睡
抱着孩子在屋里走，唱歌	抱着孩子的时候喝热饮，或者抱着骑车
躲猫猫，拍手，追着爬	用力拉着孩子的手臂把他拽起来

几条补充：

婴儿的头相对身体很重，颈部肌肉还没发育好。猛烈的摇晃，可能造成严重的脑损伤。〔强：第 23 章已讲〕

婴儿睡觉要仰睡在平整的床面上，不是趴着睡。〔强：婴儿安全睡眠的通行建议〕

刚吃饱就做大幅度的玩耍，孩子可能吐奶。可以等半小时再玩。〔待核：经验性建议，没有统一的时间标准〕

幼儿的手臂关节还不稳，用力拉拽可能让关节脱位。〔中：儿科常见的提醒，细节待核〕

所以每次玩之前，先问自己一句：这个动作，头颈托住了吗。

◆ 九、读，说，唱

除了玩，还有三件安静的事：

读。每天晚上睡前十分钟，读一本书。你的声音通常比母亲低，这对孩子是另一种声音的“不同”。

说。在家里做什么说什么。“爸爸在煮面。水开了。你看，冒泡泡。”

唱。不用会唱，哼也行。

这三件不需要任何设备，加起来一天二十分钟。

第 12 章讲过面对面、话轮、共同注意。这些对父亲一样适用。

研究发现，父亲和孩子共读，对孩子的语言发展同样有帮助。〔中：多项研究，包括一些针对父亲的阅读干预，发现了积极的效果，样本不大，待核〕

◆ 十、凌晨三点的四十分钟

孩子八个月的时候，有一个夜里，苏晴去外地出差，江远一个人在家。

孩子半夜醒了，哭。

江远抱着他走，唱歌，换尿布，喂奶瓶。孩子还是哭。

四十分钟过去，江远的手开始发抖。他听见自己的心跳。他忽然有一个念头：想把孩子用力晃一晃，让他停下来。

他被自己的这个念头吓了一跳。

他马上把孩子放进婴儿床，让他躺平，自己退到门口。

他在走廊里站了两分钟，深呼吸，用凉水洗了一把脸。

孩子在床里哭着，不过很安全。

两分钟以后，他回来，把孩子抱起来，贴在胸口，慢慢走。

又过了二十分钟，孩子睡了。

第二天，他把这个晚上告诉了苏晴，没有隐瞒那个念头。

苏晴说：“谢谢你告诉我。下次你可以先给我打电话，哪怕我在外地。”

这一幕里有一个重要的道理：

有那个念头，很多照料者都有过。〔中：疲惫的照料者在孩子哭闹时出现失控的冲动，并不少见〕

要紧的是念头出现的时候，把孩子放到安全的地方，自己走开几分钟。

〔强：儿科和儿童保护机构的通行建议〕

如果你发现自己总是在失控的边缘，请马上找人帮忙，联系医生、心理咨询师，或者当地的求助热线。

◆ 十一、七次递回去

江远的邻居阿杰，三十五岁，做配送。他的孩子十个月，只要妈妈。

阿杰抱着孩子，孩子伸手找妈妈。他递回去。过一会儿再抱，又递回去。

他数过，一个周末递回去七次。

后来他听了江远的办法，换了一个做法：妈妈出门买菜，只出去四十分钟，他和孩子留在家。

第一天，孩子哭了二十分钟。阿杰抱着，一边走一边说：“妈妈去买菜了，爸爸在这儿。”

第二周，孩子哭了十分钟。

第四周，妈妈出门的时候，孩子对着门口挥了挥手，转头去玩积木。

阿杰对江远说：“我以前以为是孩子不要我。”

“现在呢？”

“现在我觉得，是我们之前很少给过彼此机会。”

这一幕里有一个道理：

孩子偏爱妈妈，不等于不要爸爸。多给几次单独的机会，孩子会慢慢多出一个可以靠的人。〔中：第 29 章已讲，大多数孩子几周内适应，个体差异大〕

◆ 十二、一个人带孩子的一天：一张示例表

有时候，母亲出差、生病，或者回娘家，你要一个人带孩子一整天。

下面是一个六个月孩子的示例。

时间	做什么
七点	起床，换尿布，喂奶，先给自己喝口水
九点	孩子小睡，你收拾一下，吃早饭
十点	出门晒太阳，推车走二十分钟
十二点	喂奶或加辅食，你也吃饭
下午一点	午睡，你也休息，不做大事
三点	地上玩：躲猫猫，拍手，读一本书
五点	轻松的时间：放音乐，抱着走
七点	洗澡，换睡衣，关灯，唱同一首歌
八点	孩子睡了，你把明天要用的东西备好

孩子的作息各家不同，这只是一个骨架。

四个提示：

一，不求完整，求节律。吃，玩，睡，大致有个顺序，孩子会更安心。

〔中：规律的日常常被认为有助于婴儿的安全感，细节待核〕

二，孩子睡，你也休息。不要把孩子睡着的时间全拿来做家务。

三，提前备好东西。奶瓶、尿布、替换衣服放在顺手的地方。

四，如果撑不住，打电话给能帮你的人。这不丢人。

◆ 十三、不要模仿母亲

很多父亲在做这些事的时候，有一个心理负担：

“我应该做得像她一样。”

不需要。

你可以有你的方式。

你可能说话声音更低，动作更大更快，不那么爱唱歌，不太会“妈妈语”。

没关系。孩子会发现你和她不一样，也会慢慢爱上这种“不一样”。

重要的是三个东西：

在场：不是身体在，是心也在。

敏感：对他的信号有反应。

修复：没对上，回来。

这三样，和母亲一样，也是你唯一需要的。

◆ 十四、你可能遇到的几个困难

有一些困难，是很多父亲会遇到的。

困难一：孩子只要妈妈，不要我。

在孩子六个月到两岁之间，很多孩子会有“偏爱”，对母亲更黏。你抱他的时候，他哭着找妈妈。

这不是对你的否定。这是因为母亲是他最熟悉的“安全基地”。

你需要做的是坚持。多和他单独待着。孩子哭，不要马上把他交回去，先试着哄几分钟。

大多数孩子在几周之内会适应。

困难二：我做不好，母亲在旁边总是纠正。

这个要和母亲沟通。可以说：“我需要一些空间，让我自己试。你可以先不要纠正，等我做完，我们再聊。”

困难三：我工作太忙，没有时间。

这是最现实的问题。可是要问自己一个诚实的问题：我每天刷手机多久？

很多父亲发现，只要把一小时的手机时间挪出来，就有足够的时间陪孩子。

如果工作真的特别忙，那至少保证每周有一段固定的时间：周六上午三小时。固定比时长更重要。

困难四：我自己小时候没有被好好对待过，我不知道怎么当爸爸。

这是一个很重要的问题。

很多父亲从自己的父亲那里得到的是疏远、冷漠，甚至暴力。他们对“好的父亲”没有范本。

好消息是：第 17 章讲过“获得性安全依恋”。一个人在童年没有得到足够好的回应，可是在后来，通过伴侣、朋友、心理咨询，他仍然可以学会。

你现在正在做的事，本身就是在学。

如果你在和孩子相处时，会被自己童年的阴影困扰，比如特别容易暴怒，请去找一位心理咨询师。这对你，也对孩子，都是很有价值的。

◆ 十五、他睡着以后：给自己的十分钟

很多父亲带完孩子，自己已经没有力气了，却不觉得自己“值得休息”。

孩子睡着以后，请给自己十分钟。不收拾，不刷工作消息。

可以喝杯水，站在窗口看一会儿，或者给一个朋友发一句话：“今天我一个人带了一整天。”

照顾孩子是一件耗力气的事，不是你软弱。

你自己的状态，会直接影响你对孩子信号的耐心。〔中：照料者的疲劳与敏感度、耐心相关，细节待核〕

如果这样的疲惫持续很久，伴随失眠、情绪低落、易怒，请去看医生。

〔中：第 17 章已讲父亲也会抑郁〕

◆ 十六、做不到的时候：降级版本

原来	降级
周六上午单独三小时	一小时，就在家，抱着孩子读书
每晚洗澡和哄睡	每周三晚洗澡，其余晚上负责哄睡的最后五分钟
每天读书十分钟	一周读四天，每次五分钟
出门带孩子	在家，你们两个在地板上待一小时

出差的时候：视频，晚安歌，读一页书。

最低的版本：每天抱他一次，叫他的名字，看着他的脸说一句话。〔解释：本书的建议〕

◆ 十七、常见的几个问题

问：我不会哄孩子，怎么办？

答：先用上面的排查顺序。哄孩子是练出来的，每个人都是从手忙脚乱开始的。头几次哭得久，一点也不奇怪。〔解释〕

问：孩子一抱就哭，只要妈妈，怎么办？

答：先别把孩子递回去。让妈妈出门一小段时间，你和孩子留在家，抱着哄几分钟。见上面阿杰的例子。大多数孩子在几周内会适应。〔中：第 29 章已讲，个体差异大〕

问：我怕摔着孩子，手不敢用力，怎么办？

答：很多新手父亲有这种感觉。先坐在沙发上抱，一只手托住头颈，另一只手托住臀部。熟悉以后，再站起来走。〔强：托住头颈是通行的抱婴儿建议〕

问：爸爸陪玩，有没有安全边界？

答：有，见上面的表。不摇晃，不抛，始终托住头颈。孩子扭头、闭眼、哭，就停。

问：一个人带孩子一整天，怎么过？

答：看上面的示例表。不求完整，只求有节律，并且给自己留休息。

问：我带孩子的时候总想看手机，怎么办？

答：把手机放到另一个房间，或者只在孩子睡着时看。孩子最需要的，是你看着他的脸，等他回应。〔中：第 12 章已讲面对面的“来回”〕

问：我越来越烦，怕自己做出不好的事，怎么办？

答：先把孩子放到安全的地方，自己走开几分钟。然后给伴侣、亲友打电话，或者联系医生、当地求助热线。这一条，请你一定记住。〔强：儿科和儿童保护机构的通行建议〕

◆ 十八、放回日子里

孩子一岁半的时候，有一天，江远带着他去公园。

孩子走在前面，跌跌撞撞。江远跟在后面，一米远。

孩子走到一个水坑旁边，停下来，蹲着看。

江远没有说“不要”，也没有把他抱走。他只是在旁边蹲下来，也看。

水坑里有一片树叶，在转。

孩子伸出一根手指，戳了一下水。水溅起来，溅到他的脸上。

他愣了一下，转过头，看着江远。

江远笑了：“水凉不凉？”

孩子咯咯地笑了，又戳了一下。

两个人在水坑边蹲了十分钟。

回家的路上，孩子趴在他肩上睡着了。

江远抱着他慢慢走。

那一刻，他忽然想起那个晚上，他问苏晴：“那我算什么？”

他现在有答案了。

带走的话

父亲要有自己的回路：每周一段单独的时间，你和他。皮肤、声音、洗澡、哄睡、玩、读、说、唱。不用像母亲，只要在场、敏感、修复。孩子偏爱妈妈是暂时的。坚持，就好。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
父亲独自照料孩子的时间越多，越敏感，参与度越高	〔中〕	因果可能双向
孕期父亲参与产前活动，与产后更多育儿参与相关	〔中〕	观察研究，有选择偏差
父亲的袋鼠式护理，对婴儿稳定和父亲的联结有帮助	〔中〕	第 9 章已讲
父亲的身体游戏与孩子情绪调节相关	〔中〕	不是所有研究一致
父亲共读对孩子语言发展有帮助	〔中〕	样本不大，待核
获得性安全依恋	〔中〕	第 17 章已讲
在场、敏感、修复三件事	〔解释〕	本书的方法论归纳
不同月龄的玩法表	〔解释〕	本书整理，发育有个体差异
小物件易被放进嘴里，有窒息风险，应拿开	〔强〕	儿童安全的通行建议
照料者疲劳会影响对信号的耐心和敏感度	〔中〕	细节待核
父亲也会抑郁，持续失眠低落易怒应就医	〔中〕	第 17 章已讲
排查哭闹的顺序：饿、湿、冷热、困、想抱、其他	〔解释〕	本书整理的常见顺序，非诊断
婴儿有时没有明确原因也哭	〔中〕	细节待核
婴儿发烧、拒食、精神差需及时就医	〔强〕	通行的就医建议
摇晃婴儿可能造成严重脑损伤；不抛、始终托头颈	〔强〕	第 23 章已讲
婴儿应仰睡在平整的床面上	〔强〕	婴儿安全睡眠的通行建议
刚吃饱不宜立刻大幅度玩耍，可等半小时		

说法	证据级别	说明
	〔待核〕	经验性建议，没有统一的时间标准
幼儿手臂关节不稳，不要用力拉拽	〔中〕	儿科常见提醒，细节待核
疲惫照料者在孩子哭闹时出现失控冲动并不少见	〔中〕	细节待核
失控冲动出现时，把孩子放到安全处，自己走开几分钟	〔强〕	儿科和儿童保护机构的通行建议
孩子偏爱母亲多在几周内缓和，多给单独机会	〔中〕	第 29 章已讲，个体差异大
一个人带孩子一天的示例表；规律日常有助安全感	〔中〕	示例；规律与安全感的细节待核
降级版本；最低版本“抱一次，叫名字，说一句话”	〔解释〕	本书的建议
坐着抱，托住头颈和臀部	〔强〕	通行的抱婴儿建议

个体情况，比如父亲有暴怒、情绪失控、酗酒等问题，请及时寻求专业帮助。

第 30 章

每个家都不一样：单亲、祖辈、远行、收养，和这本书的最后一句话

◆ 一、“我家不是这样的”

写到这里，本书的读者可能已经有一半想说：

“你写的都是一对夫妻、一个孩子住在一起。可是我家不是这样的。”

你说得对。

很多家庭不是这样的。

有的是一个人带孩子。有的是爷爷奶奶带孩子。有的父亲常年在外面。有的孩子是收养的。有的是两个妈妈，或者两个爸爸。有的父母离婚了。

本书用苏晴和江远做主角，是为了讲得具体。可是本书要讲的，从来不是一种家庭的样子，而是一件事：

孩子需要有人稳定地在，敏感地回应，没对上的时候回来。

这件事在任何一种家庭里都可以发生。

这一章把前面讲的放到不同的家庭里，看一看怎么调整。

◆ 二、一个人带孩子：单亲妈妈，单亲爸爸

先说一个人带孩子。

这是最辛苦的一种情况。

没有另一个人分担睡眠、情绪、家务、钱。所有的“五个 E”都压在一个人身上。

本书对单亲家长有三句话：

第一句：你不需要一个人做所有的事。

第 27 章讲过，“父亲”和“母亲”是位置，不是身份。

一个单亲妈妈，需要找到那个“托住你”的人：你的母亲、姐妹、朋友、邻居、同事、社区的志愿者。一个两个就够了。

一个具体的建议：找一个“固定的人”，每周固定一个时间，帮你带孩子两三个小时。固定比多更重要。

第二句：你需要找到一条“第二条回路”。

孩子最好除了你，还有另一个稳定的成年人，和他有规律的“来回”：外婆、叔叔、姨妈、朋友、老师。

不需要是爸爸或者妈妈。可是要稳定，要敏感，要长期。

第三句：你也需要被照顾。

第 26 章讲过，母亲也要被照顾，单亲更是。

如果你长期累到撑不住，请不要硬扛。去社区，去求助，去看医生。这不是失败。

研究发现，在条件类似的家庭里，单亲家庭的孩子和双亲家庭的孩子，在发展上平均有一些差异。不过大部分差异可以用经济压力和家庭的不稳定来解释，而不是“单亲”本身。〔中：多项研究，一些在控制了收入和母亲的心理健康之后，差异明显缩小〕

这是一个好消息：

一个孩子的发展，主要取决于回应和稳定，不取决于家里有几个大人。

◆ 三、找第二条回路：三步

“第二条回路”听起来很大，做起来可以很小。

第一步，先列名单。拿一张纸，写下身边可能的五个人：亲人，邻居，朋友，同事，老师。不用先想对方会不会答应。

第二步，只请一件小事。不要一上来就说“你帮我带孩子”。可以说：“周三下午四点到六点，你能不能来陪他玩两个小时？”小而具体，更容易得到答应。

第三步，保持固定。同一个人，同一个时间，连续几周。孩子对这个人熟悉起来，他就成了一条回路。〔解释：本书的建议，没有整套检验〕

身边实在没有合适的人，也不必慌。社区的托育服务，图书馆的故事时间，育儿互助小组，都可能遇到稳定的成年人。各地资源不同，需要你自己去了解。

第二个人不是来替代你的。他是来和你一起，让孩子的路多一条。

◆ 四、林敏和楼下的老陈

林敏三十六岁，一个人带三岁的女儿，在超市做收银。

最难的是每个周三晚上。她下班晚，女儿在托管班等到最后一个。

她列过名单，写了五个人。四个人她不好意思开口，剩下一个是楼下的老陈，退休教师，六十八岁，经常在楼道里碰到。

她鼓起勇气，说：“陈叔，每周三下午，您能不能带孩子在小区里玩一小时？我付您一点辛苦费。”

老陈说：“不要钱。我正愁没人说话。”

第一个月，女儿躲在林敏身后。第二个月，女儿开始拉着老陈的手去看鱼。

后来，周三成了女儿最盼的一天。

有一次林敏加班晚了，老陈把孩子领回自己家吃了晚饭，打电话告诉她：“放心，在我这。”

林敏在电话这头，眼泪掉了下来。

她不再是一个人了。

这一幕里有一个道理：

第二条回路不一定是亲人。一个稳定的、敏感的、愿意长期在的成年人，就够了。〔解释：本书的读法〕

◆ 五、爷爷奶奶带孩子

在中国，很多家庭的孩子主要由祖辈带。

这有优势：祖辈有时间，有经验，有感情。

也有挑战：精力有限，观念不同，有的更重视“吃饱穿暖”，对“来回”不太留意。

第 13 章讲过，祖辈只要能稳定地、敏感地回应，孩子可以发展得很好。

对父母来说，要做的不是“要求祖辈变成另一个人”，而是：

一，把几件最重要的事说清楚。比如：安全睡眠，不摇晃，不打骂，少看屏幕，多说话，多抱。

二，每天下班后和周末，尽量亲自带，让孩子仍然和你有足够的“来回”。

三，不要在孩子面前和祖辈争吵。对教养不一致的地方，私下沟通。

四，肯定祖辈做得好的地方。

五，给祖辈一些休息：他们也会累，也会生病。

第 13 章苏晴那个小办法，“每天下午孩子睡醒，在旁边坐着二十分钟”，也适用。

还有一个很重要的提醒：

如果孩子被祖辈带，而父母长期不在身边，比如外出务工，这对孩子是一个需要认真对待的情况。

研究发现，留守儿童在情绪、行为、学业等方面出现问题的风险平均更高。不过不同的研究差异很大，和留守的年龄、时间、代养人的质量都有关。

〔中：国内外有不少研究，结果不完全一致，待核〕

怎么办？

如果必须外出：

尽量在孩子三岁以前不要长期分开。如果可能，把孩子带在身边，或者其中一方留在孩子身边。

每天视频通话，哪怕五分钟。固定时间，固定开头，固定结尾。

回家要有质量的陪伴，而不是只带礼物。

选一个稳定的代养人，不要频繁更换。

◆ 六、写给祖辈的五句话

把重要的事说清楚，不用长篇大论。下面五句话，可以直接念给爷爷奶奶听，也可以写在一张纸上贴在冰箱上。

第一句：“孩子睡觉，请让他仰着睡在平整的床上。”

第二句：“孩子哭得厉害的时候，千万不要摇晃他。”

第三句：“您抱着他、跟他说话，比任何玩具都好。”

第四句：“屏幕少给一些，您陪他看书，比看电视好。”

第五句：“您累了就告诉我，我下班就接手。”

前两句是安全底线，请说得清清楚楚。〔强：安全睡眠和不摇晃的通行建议〕

后三句是请求，用商量的口气说。

第四句背后的理由，是屏幕里没有对你回应的人，第 12 章讲过。〔中：第 12 章已讲，细节有争议〕

说完以后，记得谢谢他们。

◆ 七、苏晴的婆婆，和那张冰箱贴

苏晴和江远把那五句话写在一张纸上，贴在冰箱门上。

婆婆第一天看见，念了一遍，说：“我带过三个孩子，你们还教我。”

江远没有顶回去，他说：“妈，您带得好，我们都知道。这几条是因为医生这几年特别强调，我们才写下来。”

婆婆没再说什么，转身去择菜。

过了几天，江远看见她抱着孩子，嘴里在念：“不晃，不晃，奶奶不晃。”

她把那张纸，用透明胶带又贴了一遍，贴得平平整整。

这一幕里有一个道理：

把安全的事写下来，比当面一次次提醒，更不容易伤人。〔解释：本书的读法，各家情况不同〕

◆ 八、父亲常出差，或者在远方

有些家庭，父亲因为工作需要经常出差，或者长期在外：远洋、驻外、施工、军人。

第29章讲，“单独”是关键。

出差的父亲可以这样做：

一，把“固定”做在回来的时候。每次回家那几天，有一个固定的仪式：比如一进门，先抱孩子十分钟。

二，在外面也要有规律的联系。视频每天固定时间。给孩子读书、唱歌，哪怕隔着屏幕。

第12章讲，视频通话是屏幕里的例外，因为有回应。

三，录一些声音和视频：读一本书，唱一首歌，孩子可以反复听。

四，回家以后，不要一回来就“抢”孩子。孩子可能一开始会躲，会认生。先坐下，让孩子靠近你。

五，对母亲表达感谢和理解：她一个人扛着家，是真的不容易。

◆ 九、远行家庭的一周联系表

距离远的时候，固定比长更重要。下面是一张示例。

星期	联系方式	大约多久
周一	视频，孩子睡前，唱同一首晚安歌	五分钟
周二	语音，读一页绘本，录下来也行	五分钟
周三	视频，看孩子玩，问他今天吃了什么	十分钟
周四	发一段你自己的声音或短视频	三分钟
周五	视频，和代养人说几句话，问她累不累	十分钟
周六	视频，较长，和孩子一起玩一个小游戏	十五分钟
周日	休息，或者随孩子需要打	不定

孩子年纪小的时候，每天几分钟的固定联系，往往比偶尔的长聊更合适。

〔解释：本书的建议；屏幕里要有回应，见第 12 章〕

对代养人，要常说谢谢，也要问她需要什么。她是这条回路里最累的人。

不要把通话变成“审问”。少问“你乖不乖”，多说“我今天看到一只鸟，像你画的那只”。

回家的前三天，先让孩子靠近你，不要急着抱，不要急着带出去。

做不到的时候，降级版本是：每周三次，每次三分钟，固定的开头，固定的结尾。

◆ 十、阿强的晚安歌

阿强是一名远洋船员，一次出海六个月。他的儿子一岁半。

出海之前，他在手机里录了十二段声音：读绘本，唱一首很短的歌，叫孩子的名字。

在船上，信号时有时无。有信号的时候，他固定在晚上七点半视频，孩子睡前。没有信号的时候，孩子妈妈放他的录音。

六个月以后，他回家。孩子站在门口，看着他，没有扑过来。

阿强没有伸手去抱。他在门口蹲下来，轻轻唱起了那首短歌。

孩子歪着头听了一会儿，慢慢走过来，把手放在他的膝盖上。

阿强后来说：“我那一刻才明白，他记得。”

这一幕里有一个道理：

隔着距离，固定的声音也是一条回路。回来以后，先让孩子靠近你，而不是你去抢。〔中：幼儿对熟悉的声音有反应，个体差异大〕

◆ 十一、收养的孩子

收养的家庭有特别的位置。

收养大致有两种：

一种是婴儿出生不久就被收养。这样的孩子和养父母形成安全依恋的比例，和亲生家庭相近。〔中：第13章已讲〕

另一种是较大的孩子被收养，甚至是在经历过机构照料或者不良的环境之后。这样的孩子需要更多的耐心和时间。

第 14 章讲了罗马尼亚孤儿的研究：被稳定的家庭收养之后，大多数孩子有很大恢复。

对收养的父母，有几条建议：

一，不要期待孩子一开始就“爱你”。信任需要时间。

二，用第 22 章的“看、猜、做、再看”，一遍一遍回应。

三，对孩子的问题和行为保持耐心，不要把它们当成对你的“考验”。

四，如果孩子在早期有创伤或者剥夺的经历，寻求专业的帮助。

五，从孩子小时候起，就用适合他年龄的方式，让他知道自己被收养的故事，不要隐瞒。

另外，第 15 章讲过：基因是器具。收养的孩子的器具，可能和你的不一样。这没关系，要看的是“来回”。

◆ 十二、两个妈妈，两个爸爸

有一些家庭是同性伴侣抚养孩子。

在这个话题上，研究发现了什么？

多项研究发现，在同性伴侣家庭长大的孩子，总体上和异性伴侣家庭长大的孩子没有明显差异。包括心理健康、学业和社会适应。其中有一些是规模较大的追踪研究。〔中：这个领域研究不多，样本有选择性，不同研究结论大体一致，也有争议，待核〕

对本书来说，这个结果不意外。

因为本书说的“妈妈”和“爸爸”是位置。两个妈妈，或者两个爸爸，可以一个做主要照料者，一个做“托住”的人。也可以轮流，或者一起都做“来回”。

关键不变：稳定、敏感、修复。

◆ 十三、离婚，和家里有冲突

还有一些家庭经历离婚，或者长期的夫妻冲突。

研究发现，对孩子影响最大的不是“离婚”本身，而是父母之间持续的、激烈的冲突，尤其是在孩子面前。〔强：多项研究，结论，比较一致〕

所以，对处在这样的家庭里的父母，有几条建议：

一，不要在孩子面前吵架，尤其是在婴幼儿面前。孩子对大人的情绪很敏感。

二，不要让孩子听到你说另一方的坏话。

三，离婚后尽量让孩子和双方都保持稳定的联系，只要安全。

四，不要让孩子当“传话筒”或者“出气筒”。

五，如果有家庭暴力，首先要保证母亲和孩子的安全。请寻求专业的帮助，和当地的妇女援助热线。第 17 章讲过，母亲不是一个人要扛着这些。

◆ 十四、对孩子说“我们不住在一起了”

孩子小的时候，说话要简短，平静，重复。可以参考这几句：

“爸爸和妈妈以后不住在一起了。”

“这不是因为你。”

“爸爸妈妈都爱你，这个不会变。”

“你住在哪里，什么时候见谁，我们会告诉你。”

说完以后，准备好重复。孩子可能隔几天又问同样的问题。每次都平静地回答一遍。

孩子太小，听不懂话也不要紧。语气和抱着他的手，他听得懂。〔中：幼儿对大人的情绪和语气很敏感，第 12 章已讲〕

过渡的这段时间，尽量让孩子的日常不变：同样的睡前仪式，同样的玩具，同样的照料者。〔中：稳定的日常对家庭变动中的孩子有帮助，多项研究和临床建议一致，细节待核〕

如果你自己撑不住，请去找心理咨询师。你稳一些，孩子也会稳一些。

◆ 十五、早产和住院的孩子的父亲母亲

最后回到第 8 章，早产儿。

对在新生儿科住院的孩子的父母，有一个特别的位置。

你可能不能抱孩子，只能隔着保温箱看。这很难受。

可是第 8 章、第 9 章讲过：

有一些事你仍然可以做：

把手伸进保温箱，轻轻放在孩子头上，不动。

和医护人员商量袋鼠式护理。

对孩子说话、唱歌，哪怕隔着箱子，声音也可以传进去。

把你的衣物，或者一块小布，放在孩子身边，让他闻到你的气味。〔中：一些新生儿科会这样做，证据有限，需要和医护商量〕

照顾自己。你也需要睡，需要吃，需要被听见。

◆ 十六、有了第二个孩子

第二个孩子来了，家里的“来回”要重新分。

大孩子可能退回去：要抱，要奶瓶，夜里醒。这很常见，不是变坏。

〔中：学龄前孩子在弟妹出生后出现退行表现并不少见，多数会随时间缓和，细节待核〕

几条办法：

一，给大孩子“单独时间”。每天十分钟，只有他和一个大人，不被打断。

二，让大孩子参与，不是“帮忙”，是“有自己的事”：拿尿布，唱歌给弟弟妹妹听。

三，夫妻分工：一个主要照顾小的，另一个主要陪大的，每周换一次。

四，不要让大孩子总听到“你要让着弟弟妹妹”。

五，睡眠仍是第一位。有了第二个孩子，更需要分“班”。〔解释：本书的建议〕

◆ 十七、一页纸：各种家庭的“最小动作”

如果你只想记住一张表，就记这一张。

家庭	最小动作	对应的位置
单亲	每周一个固定的人，帮你两三个小时	托住你
祖辈带	你每天下班后亲自带一小时	你的回路
常出差	每天固定时间，五分钟视频或语音	你的回路
收养	每天同一件事：同一个睡前仪式	稳定
同性伴侣	分好“班”，轮流主带	托住，回路
离异	孩子的日常，两边尽量一致	稳定
住院、早产	把手放在孩子头上，不动	在场
二胎	给大孩子每天十分钟单独时间	稳定

每一格都小到你今天就能做。〔解释：本书的归纳〕

◆ 十八、常见的几个问题

问：我是单亲，怎么找第二条回路？

答：照上面的三步：列名单，请一件小事，保持固定。不需要对方是亲人，需要的是稳定。

问：我常年在在外，孩子留守，怎么保持联系？

答：用联系表。固定比长重要。长期分开确实可能带来风险，不过稳定的代养人和规律的联系，可以把影响减小。〔中：风险和个体差异都很大，研究结果不完全一致，待核〕

问：离婚以后，孩子怎么办？

答：让他的日常尽量稳定，不当传话筒，不听你说另一方的坏话。有家庭暴力的话，先保证安全，再寻求专业帮助。〔强：持续的激烈冲突对孩子影响最大，上面“离婚，和家里有冲突”一节已讲〕

问：二胎来了，怎么办？

答：看“有了第二个孩子”一节。要点是大孩子的单独时间，和夫妻的下班。

问：再婚以后，孩子不接受继父或继母，怎么办？

答：不要急着当“爸爸”或“妈妈”。先做一个稳定的、友善的大人，慢慢来。〔中：继亲家庭的关系建立常需要较长时间，细节待核〕

问：祖辈和我们的观念不同，吵得很凶，怎么办？

答：把安全的底线说死：不摇晃，不打骂，仰睡平整床面。其他的放宽。
〔强：安全底线见第 23 章及安全睡眠建议〕底线之外，让他们有自己的方式。

◆ 十九、这本书最后的话

好，现在到了全书最后一节。

我们回头看一看这一路走过的地方。

第一编说，智慧不是从睁眼开始的。在睁眼之前，孩子已经在触和听里，和母亲有很久的来回。

第二编说，在子宫里，来回在连神经都没有的时候就开始了。从触到听，孩子不是被动的。

第三编说，出生是一次换场。孩子带着预习好的本事来，需要一个人接着。

第四编说，0 到 3 岁是回路最宽的三年。被回应，话是泡出来的，依恋是位置不是身份，最糟的也补得回。

第五编说，基因给器具，不同的器具可以发生同样的智慧。0 到 3 岁是地基，不是命，社会要接住母亲。

第六编说怀孕的九个月怎么做：把回路稳住。三步：给差异，看显露，稳环境。

第七编说出生后三年怎么做：同样三步，加四个动作：看、猜、做、再看。足够好，就好。

第八编说，父亲有两个位置：母亲的 E 和自己的回路。不替代，不缺席。

把这些收成一句话，就是：

智慧不是一个人生来带着的东西，也不是一个人从睁眼那一天开始学的东西。

它是在一个人和另一个人之间，一次一次来回里发生的。

这个“发生”从子宫开始，在 0 到 3 岁最密。以后每一天，仍然可以继续。

我们每一个人的智慧，都是这样来的。

我们每一个人，都有一个人曾经这样和我们来回过。

这也意味着，我们每一个人现在都可以成为别人的那个“人”。

◆ 二十、放回日子里

孩子三岁半的一个晚上。

苏晴一个人在客厅整理他的旧玩具。在一个纸箱里，她翻到一张很小很旧的纸片。

那是孩子一岁多的时候第一次“画”的一条线。弯弯曲曲，从纸的一端到另一端。

她看着那条线，看了很久。

这条线从哪里来？

从他在肚子里用手去碰脐带。从他第一次睁开眼睛，看到她的脸。从她每一个凌晨起来，抱着他。从江远每个周六上午的三个小时。从奶奶每天下午坐在他旁边搭积木。

这条线是很多人的很多次来回画出来的。

她把纸片轻轻放回纸箱，然后走到卧室门口。

孩子睡着了，小手攥着被角。

她站在门口看了一会儿。

然后她轻轻说了一句：

“晚安。”

没有人回答。

可是她知道，他听到了。

带走的话

每个家都不一样。要紧的只有三件事：稳定地在，敏感地回应，没对上以后回来。谁做这件事，谁就是孩子的“妈妈”和“爸爸”。我们每一个人的智慧，都是被人这样来回出来的。现在，轮到我們，成为别人的那个人。

◆ 本章证据账

说法	证据级别	说明
单亲家庭孩子的差异，主要可由经济压力和家庭不稳定解释	〔中〕	多项研究，控制收入和母亲心理健康后差异缩小
留守儿童情绪行为问题风险平均更高，但个体差异很大	〔中〕	研究结果不完全一致，待核
早期被收养的婴儿与养父母形成安全依恋的比例相近	〔中〕	第 13 章已讲
同性伴侣家庭长大的孩子，总体发展与异性伴侣家庭相近	〔中〕	研究数量有限，样本有选择性，有争议，待核
对孩子影响最大的是父母之间持续激烈的冲突，而非离婚本身	〔强〕	多项研究较一致
气味布放在保温箱中	〔中〕	一些新生儿科采用，证据有限，需与医护商量
全书的总概括	〔解释〕	本书的理论读法
写给祖辈的五句话：前两句安全底线，后三句商量的请求	〔解释〕	本书建议；安全部分见第 23 章
婴儿屏幕里缺少回应，少给屏幕、多亲自陪	〔中〕	第 12 章已讲，细节有争议
把安全的事写下来，比当面反复提醒更不易伤人	〔解释〕	本书的读法

说法	证据级别	说明
找第二条回路的三步：列名单、请小事、保持固定	〔解释〕	本书建议，没有整套检验
远行家庭的联系表；固定比长更重要	〔解释〕	示例；屏幕里要有回应，见第 12 章
幼儿对熟悉的声音有反应，回家后先让孩子靠近	〔中〕	个体差异大
向孩子说明分居、离婚时，用简短平静的话，重复回答	〔解释〕	本书建议
幼儿对大人的情绪和语气敏感	〔中〕	第 12 章已讲
稳定的日常对家庭变动中的孩子有帮助	〔中〕	多项研究和临床建议一致，细节待核
弟妹出生后，大孩子出现退行表现并不少见，多数会缓和	〔中〕	细节待核
二胎的五条办法；各种家庭的“最小动作”表	〔解释〕	本书的归纳
稳定的代养人和规律的联系，可减小长期分开的影响	〔中〕	研究结果不完全一致，待核
继亲家庭的关系建立常需较长时间	〔中〕	细节待核
安全底线：不摇晃、不打骂、仰睡平整床面	〔强〕	第 23 章及安全睡眠的通行建议

个体情况，比如家庭暴力、严重的亲子冲突、孩子有创伤经历，请及时寻求专业帮助或联系当地妇女援助热线。

附录一

全书核心说法的证据账

下面按证据强弱，把全书最要紧的说法收在一起。每一条后面注明所在章节。想核对原始文献的读者，可以从这里入手。

◆ 一、证据较强的说法〔强〕

说法	章
新生儿视力很弱，出生时远不能“看见世界”	1
胎儿触觉最早，孕 7—8 周口周已有反应	3
胎儿运动缺乏会导致关节挛缩、肺发育不良	5
胎儿声音习惯化（重复刺激后反应减弱，换声音后恢复）	6
新生儿偏爱母亲的声音	3、9
袋鼠式护理降低低出生体重儿的死亡和感染风险	9
静止脸实验：婴儿期待回应，打断会不安，恢复后多数能回来	11
大脑发育有先增后剪的规律；前额叶发育最晚	11、25
孩子可以对多个照料者形成依恋	13
随机对照：寄养组的机构儿童认知明显好于继续机构照料组	14
人类多为敏感期，而非严格关键期	14
遗传率是群体统计量，不等于不可改变；弗林效应	15
盲人读盲文时视觉皮层被激活；失聪儿童在有手语时语言正常发展	16
孕期吸烟、饮酒的风险；补叶酸降低神经管缺陷	18
哭的高峰在 6—8 周；绝不摇晃婴儿；婴儿安全睡眠要点	23

说法	章
体罚与孩子的攻击行为和心理健康问题相关	25
对孩子影响最大的是父母之间持续激烈的冲突，而非离婚本身	30

◆ 二、证据中等的说法〔中〕

这一类最多。它们大多来自观察研究、小样本研究或综述，方向一致，可是因果和效应大小还没有定论。全书凡标〔中〕的地方，都请读者把它当作“有一定依据的看法”，不要当成定论。

比较关键的几条：

说法	章
孕晚期胎儿对母亲声音的心率反应更明显	3、6
孕期反复听同一故事，新生儿偏好该故事；新生儿哭声带有母语旋律	6
孕期长期焦虑抑郁与孩子情绪行为风险略增相关，效应不大	7
母胎依恋与产后互动相关	7
分娩方式对智力和性格的长期影响很小	8
敏感回应与安全依恋的关联为中等程度	13
话轮比词数更能预测语言脑区的激活	12
考艾岛研究：至少一个稳定、有回应的成年人是韧性的核心因素	17
父亲独自照料时间越多，越敏感、参与度越高	29
同性伴侣家庭长大的孩子，总体发展与异性伴侣家庭相近	30

◆ 三、有争议的说法〔有争议〕

本书明确不倚仗它们：

说法	章
新生儿天生偏爱脸样图案	10
新生儿天生会模仿吐舌	10
哈特与里斯利的“三千万词差距”	12
贫困家庭中智力遗传率较低（Turkheimer 等）	15

◆ 四、本书的理论读法〔解释〕

下面这些，是本书对事实的“读法”，不是实验直接测出来的结论。读者可以接受，也可以保留：

1. “智慧”的最小单位是“分出不同，接成路，回应并改变下一步遇到的不同”。（第 1 章）
2. “看”是后来的一种侧重显露，不是智慧的源头。（第 3 章）
3. 受精卵与母体之间的化学来回，是“智慧的前身”。（第 4 章）
4. 触觉 SDE 参与塑造身体，是身体地图的来源之一。（第 5 章）
5. 听觉 SDE 是“听一分一回一再听”的圈。（第 6 章）
6. 胎动与母亲回应构成最早的 SDE 回路。（第 5、7 章）
7. “器具的差异不等于智慧的差异”。（第 15 章）
8. “把回路稳住，不是给胎儿加料”，三步法，“看、猜、做、再看”。（第 18—22 章）
9. 父亲的两个位置，“五个 E”。（第 27—28 章）

◆ 五、本书明确不这样说的话

不说	章
受精卵已经有触觉和听觉	4
听莫扎特、用胎教仪、上胎教班可以提高孩子智商	6、21
三岁定终身	11、17
“黄金一小时”决定孩子长期的智力和母子关系	9
胎儿的每个动作对应某种情绪	20
抱多了会宠坏孩子（头六个月）	10、23
母亲要为孩子的一切负责	17

附录二

尚待核对的事项

本书写作时，下面这些事项，只做了二手核对，请在正式出版前，对照原始文献逐条核实。

第一编（第 1—3 章）：笛卡尔《哲学原理》第 71 节的编号；笛卡尔致沙尼的 1647 年信件；莫扎特效应元分析的具体数据；羊水气味、胡萝卜汁研究的细节；胎儿对光和面孔的 2017 年研究。

第二编（第 4—7 章）：已故母亲体内发现男性细胞的个别研究；意大利双胞胎超声研究的具体文献；母胎心率同步的研究；孕前 GDF15 水平的研究；Hoekzema 等 2017 年灰质研究的细节。

第三编（第 8—10 章）：Varendi 等气味偏好研究；乳房爬行最早的研究；袋鼠式护理起源的年份和人物；WHO 2021 年 iKMC 试验的具体数字。

第四编（第 11—14 章）：突触“每秒数十万连接”的出处；特罗尼克“对上约三成”的具体数字；Kuhl 等外语语音实验；Romeo 等 2018 年的样本和干预研究；AAP 2014 年共读政策声明和 WHO 2019 年屏幕时间指南的原文；De Wolff & van IJzendoorn 的相关系数；ERA 与 BEIP 的具体数字，包括“42 个月时智商 109、81、73”。

第五编（第 15—17 章）：Haworth 等 2010 年遗传率数字；多基因分数的解释比例；van IJzendoorn 等 2005 年收养元分析；Turkheimer 2003 及

其重复；考艾岛研究的具体数字；父亲抑郁的比例；我国产假和育儿补贴的最新规定。

第六编（第 18—21 章）：孕期能量增加的具体数字；ACOG 2020 年运动意见；Cronin 等 2019 年仰卧入睡研究；十次法和一小时法胎动计数的出处；各机构对商业超声的措辞；孕期用药和抗抑郁药的最新指南。

第七编（第 22—26 章）：视觉悬崖实验的重复数据；Dauch 等 2018 年玩具数量研究；Reese 等关于母亲回忆谈话的研究；发育里程碑的最新版本（美国疾控中心、AAP）；AAP 安全睡眠 2022 年的最新要点。

第八编（第 27—30 章）：Lucassen 等 2011 年父亲敏感性元分析；母亲守门行为的研究；父亲独自照料与敏感性的研究；留守儿童和同性伴侣家庭研究的综述。

附录三

“个体情况请遵医嘱”总说明

本书讲的，是一般性的科学证据和一般性的做法。每个孕妇、每个孩子、每个家庭的情况都不一样。

凡涉及下面这些问题，请以你的医生、助产士、儿科医生、儿童保健科医生或心理健康专业人员的意见为准：

1. 孕期用药、补充剂、饮食、运动的具体方案。
2. 孕期并发症、出血、腹痛、规律宫缩、胎动减少。
3. 孕期和产后的情绪低落、焦虑、抑郁，以及任何伤害自己或孩子的念头。
4. 早产儿、低出生体重儿、住院婴儿的护理。
5. 婴儿的喂养、睡眠安全、发育迟缓、听力视力问题。
6. 孩子的社交沟通、行为和情绪方面的明显异常。

如果你或家人有伤害自己或孩子的念头，请立刻告诉身边信任的人，联系当地急救电话、心理援助热线，或前往最近的医院。

本书的建议，不能代替专业的医疗和心理服务。

附录四

几个词的小词典

SDE 本书使用的一个思路。S 是显露，D 是差异，E 是纠缠。简单说：世界通过显出差异被分出来，差异之间接成路，路上的东西互相牵连，才有了“发生”。

智慧（本书的用法） 分出不同，把不同接成路，回应并改变下一步遇到的不同。最小单位是“一来一回”。

显露 一件事把自己的“不同”显出来，让另一个人有机会分出它。孩子的哭、笑、动，都是显露。

E 环境。本书里特指孩子身边的人和日子，对母亲来说，就是家庭、工作和社会。

触觉 SDE、听觉 SDE 用触觉和听觉做通道，发生的那一套来回。

回路 一个人和另一个人之间，反复的来回。

足够好 不是每一次都对，而是大多数时候在，没对上就回来。

敏感期 大脑对某类经验特别敏感的一段时间。过了，也可以补，只是更费力。

依恋 孩子与特定照料者之间的情感纽带，在害怕、受伤、疲惫时，靠近这个人，得到安慰。

安全基地 孩子从照料者那里出发去探索，累了、怕了，回来充电。

话轮 说话时的一来一往，算一个话轮。

共同注意 大人和孩子同时看着同一件东西，并且知道对方也在看。

附录五

版权页补充说明

本书中的苏晴、江远、周女士、林女士、陈女士，以及他们的孩子和亲友，都是虚构人物。故事里的情节，为说明道理而设，不对应任何真实的人。

书中引用的科学研究，均注明了证据级别。凡标〔待核〕〔核〕的，都需要在正式出版前对照原始文献核实。

作者 王德生

智慧不是从睁眼开始的。



孩子睁眼之前，已经在触和听里，同妈妈走了很久的来回。

一本写给怀孕的妈妈、0 到 3 岁孩子的妈妈，也写给爸爸的书。

从子宫里的九个月讲到 3 岁：每天十分钟，一只手，一把嗓子；先给差异，再看显露，再稳住环境。每个科学说法都标明证据有多硬。

来回，是智慧最早的样子。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 227 号

定价 US\$25.00

ISBN 979-8-90690-415-7



9 798906 904157